患者与家属的循证治疗科普

双相障碍治疗

从躁狂抑郁到心境稳定与长期管理

13 个模块 · 64 篇 · V1.0 / 2026-10

本资料库仅用于科普学习，不能替代精神科医生面诊、诊断与处方。

出现自杀念头、意识障碍、严重过敏、胸痛晕厥等情况，请立即拨打 120 或前往急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

使用边界与安全声明

这是一本写给患者和家属的治疗科普书。它把双相障碍治疗拆成 13 个模块，覆盖从初诊、选药、心理治疗、物理治疗，到疗程、停药、复发和危机应对的完整路径。

它不能替代面诊、诊断和处方。所有具体用药、剂量、减量、住院与特殊人群决策，都必须由具备资质的精神科医生结合个体情况作出。

请先记住三件事

- 心境稳定剂和抗精神病药的起效时间不同，躁狂控制可能较快，但维持稳定和预防复发需要更长时间。
- 不要自行突然停药、减量、换药或叠加药物；停药需要在医生指导下缓慢进行。
- 出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、严重过敏、胸痛、晕厥、抽搐，立即拨打 120 或去急诊。

版本与引用

版本 V1.0，最后更新 2026-10。指南、药物适应证、医保政策与热线号码会变化；与面诊医生或最新指南不一致时，以医生和最新指南为准。引用请注明《双相障碍治疗资料库》V1.0，并附具体篇目。

书中案例均为合并、改写后的示意，不对应任何真实个人。

总目录

按模块顺序排列。每篇正文都可独立阅读；书末附 60 个术语与主要指南来源。

使用说明

00 使用说明与免责声明

模块 1：基础与总论

1.1 双相障碍是什么：躁狂、轻躁狂与抑郁

1.2 分类与诊断谱系：双相 I 型、II 型与环性心境

1.3 流行病学、起病年龄与预后

1.4 常见名词与误区

模块 2：临床表现与评估

2.1 躁狂发作

2.2 轻躁狂与双相 II 型

2.3 双相抑郁

2.4 混合特征与快速循环

2.5 疾病分期与病程

2.6 精神检查与评估工具

模块 3：病因与机制

3.1 遗传与家族风险

3.2 神经生物学：单胺、昼夜节律与线粒体

3.3 脑结构与神经可塑性

3.4 环境与生活事件：睡眠剥夺、季节、物质

3.5 研究局限与争议

模块 4：就医与诊断

4.1 就诊渠道与首诊时机

4.2 初诊准备与病史采集

4.3 诊断流程与鉴别诊断

4.4 共病筛查与躯体检查

模块 5：药物治疗

5.1 心境稳定剂总览

5.2 锂盐

5.3 丙戊酸盐

5.4 拉莫三嗪

5.5 卡马西平与其他抗惊厥药

5.6 非典型抗精神病药

5.7 抗抑郁药的使用与转躁风险

5.8 急性躁狂与混合发作的用药

5.9 双相抑郁的用药

5.10 维持治疗、联合用药与停药

模块 6：心理社会治疗与康复

6.1 心理社会干预总览

6.2 心理教育

6.3 CBT 与 DBT 情绪调节

6.4 人际与社会节律治疗 IPSRT

6.5 家庭聚焦治疗

6.6 职业康复、同伴支持与个案管理

模块 7：物理与其他治疗

7.1 无抽搐电休克 ECT

7.2 rTMS 与 tDCS

7.3 光照治疗、睡眠剥夺与补充剂证据

模块 8：特殊人群

8.1 儿童青少年双相障碍

8.2 老年双相障碍

8.3 孕产期双相障碍

8.4 躯体疾病与物质使用共病

模块 9：风险管理

9.1 自杀风险

9.2 躁狂混合状态与冲动风险

9.3 锂中毒

9.4 药物急症：NMS、血清素综合征与 SJS

模块 10：复发预防与长期管理

10.1 复发预警信号

10.2 维持治疗与依从性

10.3 昼夜节律与生活方式管理

10.4 康复目标与生活质量

模块 11：危机、住院与法律

11.1 急性躁狂混合发作的现场处理

11.2 住院指征与自愿非自愿

11.3 精神卫生法与权益

11.4 监护、残疾、病假与医保

模块 12：家庭、社会与污名

12.1 家属照护手册

12.2 沟通与边界

12.3 病耻感与社交

12.4 工作、学习与社区融入

模块 13：误区、问答与工具

13.1 心境日记与复发预警表

13.2 常用量表：YMRS、HAMD、MDQ、CGI-BP

13.3 复诊沟通单与用药记录

13.4 常见误区与高频问答

附录：术语与参考文献

A 术语表

B 参考文献与指南版本

使用说明

00 使用说明与免责声明

> 这是一套写给双相障碍患者和家属的治疗科普资料，共 13 个模块、64 篇。它想帮你把“双相”这件事看清楚：躁狂、轻躁狂、抑郁、混合状态分别是什么，心境稳定剂和抗精神病药怎么用，心理社会治疗和长期管理怎么做，什么时候必须急诊。它**不能替代面诊、诊断和处方**。

这套资料想解决什么问题

双相障碍最容易被两件事耽误：一件是把躁狂当成“状态好、不用治”，另一件是把抑郁当成单相抑郁、只吃抗抑郁药。前者可能拖到严重失控，后者可能诱发转躁、混合或快速循环。

这套资料想把治疗拆成可以理解、可以讨论、可以执行的小块：

- **知道疾病是什么**：双相 I 型、II 型、环性心境、混合特征、快速循环的区别。
- **知道治疗的全貌**：锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪、抗精神病药、抗抑郁药的边界，以及心理社会治疗和康复。
- **知道药怎么用、怎么监测**：血药浓度、甲状腺和肾功能、体重和代谢、皮疹、震颤、脱水。
- **知道怎么预防复发**：睡眠与昼夜节律、早期信号、维持治疗、依从性。
- **知道什么时候危险**：自杀、混合状态、锂中毒、恶性综合征、严重皮疹、冲动与暴力风险。
- **知道家庭和社会怎么参与**：沟通、边界、病耻感、工作学习、法律权益。

它不是什麼

- 不是诊断工具。对照症状给自己或家人“确诊”，可能把单相抑郁、边缘型人格、ADHD、物质所致情绪障碍、甲状腺问题误当成双相。
- 不是处方集。本资料刻意不写起始剂量、加量速度和减量方案，这些必须由医生结合诊断、年龄、体重、肝肾功能、合并用药、既往反应决定。
- 不是“保持好心情就能好”的励志手册。双相障碍需要规范治疗和长期管理，情绪稳定不是靠意志力。
- 不是“躁狂很有创造力、不用治”的浪漫化材料。轻躁狂可能带来短暂效率，但代价常常是抑郁、失控和关系破裂。
- 不是法律或保险意见。非自愿住院、监护、残疾、病假、医保，以现行法律和当地政策为准。

三种读法

第一种：从头读。 适合刚被诊断、时间比较充裕的人。按模块 1 → 2 → 4 → 5 → 10 的顺序，先理解疾病，再看诊断、治疗和长期管理。

第二种：带着问题查。 适合已经在治疗中的人。直接看总目录里“这一页解决什么”，找到对应篇目；每篇都能独立阅读。

第三种：只看最要紧的。 如果现在正被躁狂、混合状态、失眠或药物副作用困住，先读三页：

1. 11.1 急性躁狂/混合发作的现场处理
2. 9.1 自杀风险
3. 9.3 锂中毒

五种内容标签

标签	含义	你该怎么用
【指南】	NICE、CANMAT/ISBD、中国双相障碍防治指南等有明确推荐	可以作为和医生讨论的依据
【研究】	随机对照试验、系统综述支持，但未必进入所有指南	可以了解，别当成唯一答案
【临床经验】	临床常见做法，个体差异大，证据等级较低	参考，不要照搬
【待验证】	机制推测、小样本研究、争议观点	保持开放，别当结论
【个人体验】	康复者或家属的主观感受	共情用，不代表普遍规律

标签不是“真假”的判决，而是提醒你：**这条信息有多硬，适不适合拿来指导自己的治疗。**

安全声明（请先读）

双相障碍治疗里，有些情况不能等：

- **出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：**不要独处，联系信任的人陪着，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- **躁狂或混合状态：**连续几天几乎不睡、话多停不下来、冲动消费/投资、危险驾驶、性行为失控、伤人威胁——尽快精神科急诊评估，必要时拨打 120 或 110。
- **服锂盐后出现严重手抖、走路不稳、呕吐腹泻、意识模糊、抽搐：**可能是锂中毒，立即急诊查血锂。
- **服丙戊酸盐后出现严重腹痛、呕吐、意识改变：**警惕高氨血症或肝损伤，立即就医。
- **服拉莫三嗪后出现皮疹，尤其伴发热、口腔溃疡、眼红、皮肤起疱脱皮：**立即停药并急诊，警惕 Stevens-Johnson 综合征/中毒性表皮坏死松解症。
- **出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：**可能是恶性综合征，立即急诊。
- **同时使用多种增加 5-羟色胺的药物后出现高热、震颤、反射亢进、腹泻、躁动：**警惕血清素综合征，立即急诊。
- **孕产期出现严重失眠、幻觉、妄想、行为紊乱：**可能是产后精神病，立即急诊。

如果你不确定“算不算严重”，按严重处理。**宁可白跑一趟，不要赌。**

关于治疗：三句最重要的话

1. **双相障碍的核心是长期稳定，不是“把抑郁治好”。** 单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合或快速循环，必须由医生评估。
2. **心境稳定剂需要监测。** 锂盐看血锂、甲状腺、肾功能；丙戊酸盐看肝功能、血氨、血常规和体重；拉莫三嗪要警惕皮疹。监测是治疗的一部分。
3. **睡眠和昼夜节律是治疗的一部分。** 熬夜、倒班、跨时区旅行、睡眠剥夺都可能诱发躁狂；规律作息不是“养生建议”，而是复发预防。

关于心理社会治疗

药物不是全部。心理教育、CBT、人际与社会节律治疗（IPSRT）、家庭聚焦治疗、DBT 情绪调节、职业康复和同伴支持，都能帮助患者识别早期信号、稳定节律、改善关系。它们不能替代药物，但能降低复发和改善生活质量。具体见 6.1 心理社会干预总览。

关于隐私与案例

文中出现的“小 A”“一位来访者”等，都是合并、改写后的示意案例，不对应任何真实个人。诊断、用药、住院记录属于敏感信息，分享给医生之外的人之前，先想清楚边界。

如何纠错与更新

- 本资料版本：V1.0，最后更新 2026-10。
- 指南会更新，药物适应证会变化，法律和地方政策会调整。看到与医生说法不一致时，**以面诊医生的个体化判断和最新指南为准**，并把差异告诉医生。
- 如果发现事实错误、失效链接、表述可能误导，请在资料库维护记录里标注“待核”，不要直接照用。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 1：基础与总论

先理解双相障碍不是“情绪化”，而是有明确诊断标准的疾病；再谈治疗。

1.1 双相障碍是什么：躁狂、轻躁狂与抑郁

如果你刚被诊断为双相障碍，或者家里有人刚拿到这个诊断，最先冒出来的问题往往是“这到底是什么病”。这一页把双相障碍的四种基本状态——躁狂、轻躁狂、抑郁、混合状态——拆开讲清楚，也解释为什么它不是“情绪化”或“性格问题”。读完你大概能带走三样东西：一张能对上自己经历的状态对照表、一个判断“这算不算一次发作”的思路、一句更准确的话——双相障碍可以治疗，但需要长期管理。

一、先把四个词说清楚

“双相”这个名字来自“两个极端”：情绪会朝偏高的方向和偏低的方向摆动。偏高的那一端叫躁狂或轻躁狂，偏低的那一端叫抑郁发作。很多人以为双相就是“情绪忽高忽低、像坐过山车”，但日常的忽高忽低和双相的发作不是一回事，关键差别在持续时间、伴随的生理变化，以及对工作、学业、关系和财务的实际影响。【指南】

状态	本人常感到	旁人常看到	大致持续时间
躁狂	精力用不完、脑子转得飞快、什么都不在话下	话多停不下来、睡得极少、同时开很多事、花钱或投资失控、容易发火	至少约一周，严重到需住院时不受此限
轻躁狂	状态特别好、效率高、社交活跃、思路清晰	比平时话多、睡得少但不累、玩笑开得过头、决定变快变大	至少约四天
抑郁发作	提不起劲、什么都没意思、觉得自己是负担	话少、动作慢、回避社交、哭泣或麻木、作息紊乱	至少约两周
混合状态	一边绝望一边停不下来，说不清是“高”还是“低”	又低落又亢奋、坐立不安、冲动和轻生念头同时出现	出现在某次发作之内，持续数天以上

需要强调的是：诊断看的是“一次发作”，不是某一刻的心情。一天里情绪起伏几次、因为一件事高兴或难过几小时，通常不构成发作。发作有相对稳定的起止、有成组的症状、有可以观察到的功能变化。【指南】

二、躁狂与轻躁狂：一线之隔，后果不同

躁狂最容易被误解成“心情特别好”。真正的躁狂不是开心，而是“踩不住刹车”。常见的样子是：睡眠需求明显减少，睡两三个小时第二天仍然不困（这和失眠后疲惫不堪完全不同）；说话比平时

多得多、速度快、别人插不上嘴；思维奔逸，一个念头跳到另一个念头；注意力被外界一点动静就带走；自我评价明显抬高，觉得自己有特殊能力、有重大使命；目标性活动增多，比如突然同时启动好几个项目、连续几天整理房间或工作到凌晨；冲动行为增加，包括大额消费、冒险投资、危险驾驶、性行为失控。【指南】

轻躁狂是同一方向的“轻版本”：变化真实存在，旁人能察觉“像换了个人”，但程度还没到让生活明显崩坏，通常也没有幻觉、妄想这类精神病性症状，不需要住院。它的问题是太容易被漏掉，也太容易被浪漫化。当事人事后回忆，常常只记得“那段时间效率特别高、灵感特别多”，不觉得那是病。可是轻躁狂之后常跟着一段抑郁回落，冲动时做的决定会留下账单、辞职信或破裂的关系，这些后果要由后面几个月甚至几年去承担。【个人体验】

维度	躁狂	轻躁狂
严重程度	明显影响工作、学业、社交，常需住院	有变化，但未严重到功能崩坏
现实检验	可能出现夸大或被害的想法、幻觉	一般保留，能听懂劝
病识感	常坚信自己没问题，抗拒就医	事后才觉得“那阵子不太对”
主要风险	冲动、冲突升级、经济与法律后果	冲动决定、关系摩擦、随后抑郁
治疗紧迫性	需要尽快精神科评估	需要记录、复诊时说明，调整方案

对家属来说，判断轻躁狂最可靠的办法不是问“你觉得自己有病吗”，而是描述具体变化：“你这四天每天只睡四小时，还说要辞职去创业。”具体的观察比抽象的劝说有用。【临床经验】

三、抑郁相与混合状态：最容易被误读的两端

双相障碍里的抑郁发作，和单相抑郁（通常说的“抑郁症”）在症状上可以非常像：情绪低落、兴趣和愉快感减退、乏力、睡眠和食欲改变、自责、注意力下降、反复想到死亡。差别往往藏在这些地方：起病更突然、睡得更多而不是更少、吃得更多、体重增加、四肢像灌了铅一样沉重、对安慰和鼓励反应不大；或者过去有过一段“睡得少但精力旺”的时期，家族里有人得过双相，发作和季节或产后有关。这些只是线索，不是判决，需要医生结合完整病程判断。【研究】

混合状态是双相里最危险、也最容易被当成“情绪不稳定”打发掉的一段。现在的诊断体系不再把“混合”单列成一种发作，而是把它作为躁狂、轻躁狂或抑郁发作的一个特征标注：在一次发作里，同时混进了相反方向的症状。比如抑郁的同时思维飞快、精力突然变多、坐不住、冲动；或者躁狂的同时强烈自责、绝望、反复想死。危险在于两头叠加——抑郁提供了绝望和想死的念头，躁狂提供了行动力和冲动，“想死”和“做得出来”同时在线。混合特征和快速循环的自杀风险、冲动风险要单独评估，不能只当作“情绪波动”。【指南】

四、为什么它不是“情绪化”，也不是“性格问题”

把双相说成“太敏感”“想太多”“玻璃心”，是很多患者最早受到的二次伤害。两者的区别其实可以讲清楚。

比较点	一般的情绪起伏	双相障碍的发作
触发	通常有具体事由，事过境迁会缓解	可以没有明显事由，或小事引发巨大反应
持续时间	几小时到一两天	几天到几周，成组出现
生理变化	不明显	睡眠需求、食欲、体重、精力、性欲明显改变
可控性	能自己踩刹车、能听劝	知道不对也停不下来，劝不住
后果	通常有限	工作、学业、关系、财务、法律后果

还有一点常被忽略：发作期间的“不像自己”，本人往往也感觉得到，只是控制不住。很多患者在抑郁期会说“我知道我该动起来，但我做不到”，在躁狂期会说“我知道这样不对，但停下来更难受”。把这种失控理解为意志力问题，只会增加羞耻感，让人更不敢说真话。【个人体验】

同时也要说清楚另一面：诊断不等于把一个人变成“病人”。性格、能力、幽默感、责任心都还在。双相障碍描述的是情绪调节系统的一段故障，不是对整个人的判决。

五、“可治疗”与“需要长期管理”分别意味着什么

双相障碍是目前精神科里治疗手段比较成熟的一类疾病。规范治疗下，多数人可以做到发作次数减少、发作变轻、间期变长、工作和关系基本维持。但“可治疗”不等于“根治”，也不等于“治好了就再也不用管”。【指南】

阶段	主要目标	时间感
急性期	控制躁狂、抑郁或混合发作，优先处理自杀与冲动风险	数周到数月
巩固期	防止刚稳定的症状反弹，观察疗效与耐受性	症状缓解后数月
维持期	预防新发作，恢复功能、关系和生活质量	往往以年为单位，因人而异

治疗不只是吃药。它通常由几块拼起来：心境稳定剂等药物、血药浓度与代谢监测、睡眠和昼夜节律的稳定、心理教育与人际社会节律治疗等心理社会干预、共病（焦虑、物质使用、甲状腺问题等）的处理、家庭支持，以及一份写好的复发应对预案。【指南】

复发是这类疾病的常态之一，不是“没治好”的证据，也不是患者的失败。把复发当成可以提前发现、提前处理的事情，比追求“永不复发”更实际。

可以照着做的六件事

- ☐ 把过去两年里“睡得特别少但白天不困”的时期写下来，标上大概的年月
- ☐ 请一位信得过的家人也写一份，别只依赖自己的记忆
- ☐ 先固定起床时间，包括周末，这比强迫自己早睡更容易做到
- ☐ 把药盒和手机提醒放在刷牙的位置，不要靠记性
- ☐ 写下自己独有的三个“复发前兆”，交给家人一份
- ☐ 每次复诊带一张纸，只写三件事：这周睡眠、情绪、有没有漏服药

容易踩的坑

“我现在感觉很好，是不是可以不吃药了？” 感觉好可能是药物在起效，也可能是发作刚开始。减药停药要在医生安排下进行，突然停用某些药物可能出现撤药反应或反跳。【指南】

“我只是偶尔情绪低落，怎么就成了双相？” 诊断依据的是完整病程，包括过去有没有过轻躁狂或躁狂。如果你不记得，家属的回忆往往更关键。

“轻躁狂挺舒服的，能不能只治抑郁？” 只治抑郁、不加心境稳定剂，可能诱发转躁、混合或快速循环。这一点需要和医生明确讨论。【指南】

六、什么时候必须联系医生或去急诊

出现下面任何一条，请立即呼叫 120 或去最近医院急诊，不要等到第二天：

- 有自杀念头、具体计划，或已经伤害自己
- 连续几天几乎不睡、话停不下来、行为失控，或出现幻觉、坚信自己有特殊能力
- 混合状态下同时感到绝望和“停不下来”，冲动明显
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、呕吐腹泻、意识模糊
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗
- 出现皮疹并伴发热、口腔溃疡、眼红、皮肤起疱脱皮

下面这些情况，建议在一到三天内联系医生：

- 连续三晚睡眠明显减少，白天却不困
- 情绪比平时明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 抑郁加重、对什么都没兴趣，持续两周以上
- 漏服药超过两三天，或出现新的、让人难受的副作用

不确定算不算严重时，按严重处理。也可以拨打 12356 心理援助热线，或当地精神卫生中心公布的热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接

- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. 链接

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.2 分类与诊断谱系：双相Ⅰ型、Ⅱ型与环性心境

“你是双相 I 型还是 II 型？”这句话常让刚确诊的人一头雾水，也常被误解成“I 型重、II 型轻”的等级排序。这一页讲清楚双相谱系里几个主要类型——双相 I 型、双相 II 型、环性心境，以及物质或药物所致的、躯体疾病所致的情绪问题——各自靠什么区分。读完你能看懂病历上的诊断名称，知道分类是用来选治疗、判断预后的工具，而不是给人贴的标签。

一、分类看的是“有没有过躁狂”，不是“现在有多重”

双相谱系的分类有一条主线：**这个人有没有出现过一次完整的躁狂发作**。有过，就是双相 I 型；从来没有过躁狂、只有轻躁狂加抑郁，是双相 II 型；两者都够不上、但长年反复在轻躁狂和抑郁的边缘摆动，是环性心境。至于某一次发作是抑郁还是躁狂、有没有混合特征、一年发作几次，这些是“当前发作类型”和“病程标注”，不改变主诊断。【指南】

所以诊断不是看某天的状态，而是回顾整段病程。一个人可能因为抑郁来就诊，看起来完全是“抑郁症”，但医生问到“有没有一段时间睡得很少却特别有精神”，才把几条线索串起来。这也是双相最容易被漏诊的地方。

二、双相Ⅰ型与Ⅱ型：差在一次躁狂，不等于差在轻重

双相 I 型的核心条件，是至少有过一次躁狂发作。躁狂可以严重到需要住院，可以出现夸大或被害的想法、幻觉，可以在几周内把工作、存款和关系全部搅乱。抑郁发作在 I 型里非常常见，但不是诊断的必要条件——也就是说，有的人第一次发作就是躁狂，此前从没抑郁过。【指南】

双相 II 型的核心条件，是至少有过一次轻躁狂发作，同时至少有过一次抑郁发作，并且从来没有过完整的躁狂发作。这里最关键的一句是：**只要出现过一次躁狂，诊断就要改成 I 型**，不管之前被叫作 II 型多少年。类型会随时间改变，这不是医生前后矛盾，而是疾病本身展开了新的信息。

维度	双相 I 型	双相 II 型
必要条件	至少一次躁狂发作	至少一次轻躁狂 + 至少一次抑郁发作
有没有轻躁狂	可以有	必须有
抑郁的负担	常见，但个体差异大	往往更突出，发作更频繁
精神病性症状	躁狂期可能出现	一般不出现在轻躁狂期
常见误诊	被当成精神分裂症、物质所致	被当成单相抑郁、性格问题

关于 II 型，有一个流传很广的误解：它是“轻一点的双相”。从躁狂的破坏性看，II 型确实没有那种戏剧化的失控；但从整体负担看，II 型患者往往抑郁发作更频繁、持续时间更长、复发更多，自杀风险也不低。把 II 型当成“不用太认真”的类型，是危险的理解。【研究】

三、环性心境：长期“差一点”，也是一种病

环性心境（cyclothymic disorder）描述的是这样一种状态：两年以上（儿童青少年为一年以上），反复出现轻躁狂样的症状和抑郁样的症状，但每一次都够不上完整的发作标准；在这两年里，症状存在的时间超过一半，人没有长时间完全正常；同时，这些波动确实带来了痛苦或功能影响。【指南】

它最常被说成“我就是情绪不稳定”“我性格就这样”。区别在于：环性心境的波动是长期、反复、成组的，不是遇到事才有反应；它会影响睡眠、效率、关系，也可能在某一天升级成一次完整的躁狂或抑郁发作——那时诊断就要往上调整。环性心境需要治疗，不是“还没病到要看医生”的状态。

四、物质或药物所致、躯体疾病所致：先排除“别的原因”

有一类情绪发作，看起来和双相几乎一样，但原因是外部的：某些物质的使用、戒断，或某些药物、躯体疾病。这类情况在诊断时被单列，因为处理方式和典型双相不同——首要任务是处理原因。

类型	线索	处理方向
物质或药物所致	症状出现在使用、戒断或接触某种药物之后，停用后改善	处理物质问题，观察症状是否持续
躯体疾病所致	有甲状腺功能异常、脑卒中、多发性硬化、系统性红斑狼疮等病史	治疗原发病，同时评估情绪症状
其他未特定	有双相样表现，但信息不足或不符合上述任何一类	继续观察，补充病史，定期复评

需要提醒的是：类固醇等药物、甲状腺功能亢进、某些神经系统疾病都可能引起躁狂样表现，这在临床上并不少见。【临床经验】因此初诊时医生安排甲状腺功能、血常规、肝肾功能等检查，不是“多此一举”，而是在排除可逆的原因。

还有一个常见情形：长期大量饮酒或使用兴奋剂的人，在戒断期会出现烦躁、失眠、情绪高涨，这既可能是物质所致，也可能是原本就有双相被物质掩盖。两者常常缠在一起，需要医生花时间分辨，不要自己下结论。

五、分类不是贴标签

诊断名称的用处很具体：它提示可能的病程走向、帮助选择药物类别、提醒医生注意哪些风险、让患者和家属能用同一套语言沟通。它的用处不包括给人排座次。【临床经验】

类型会变。 II 型出现躁狂就升级为 I 型；环性心境出现完整发作就升级为 I 型或 II 型。诊断是动态的，需要随病程修正。

分类不预测一个人的全部。 同是 I 型，有人一生只发作两次，有人反复发作；同是 II 型，有人能维持全职工作，有人需要长期病休。类型只是起点，不是终点。

“快速循环”不是一种类型，而是一种病程标注。 它指一年之内出现四次或以上的心境发作（躁狂、轻躁狂或抑郁都算），中间可以有也可以没有完全缓解。快速循环常见于女性、甲状腺功能异常、抗抑郁药使用后，治疗上更棘手，需要医生重新评估方案。【指南】它也不是“情绪变得快”，一天里高低起伏几次不叫快速循环。

“伴混合特征”同样是标注。 它提醒医生：这次发作里同时有相反方向的症状，自杀和冲动风险要格外看。这一点比类型名称更影响当下的处理。

复诊前可以整理的四行字

- ☐ 第一次出现明显异常是哪一年，当时是什么表现（睡少、话多、低落、还是别的）
- ☐ 有没有哪次严重到需要住院、需要人看护，或出现过幻觉、妄想
- ☐ 过去一年里，大概发作了几次，每次持续多久
- ☐ 有没有在发作前后喝酒、用其他物质，或开始服用新的药物（包括激素类）

容易踩的坑

“医生说我是 II 型，是不是说明我不严重？” 类型说的是有没有躁狂，不是严重程度。II 型的抑郁负担和自杀风险需要同样认真对待。

“我被诊断成环性心境，是不是医生在敷衍我？” 环性心境有明确的诊断条件，不是“没病找病”。它需要治疗，也值得被认真记录。

“我是物质引起的，那就不用治了？” 原因要去除，但已经出现的情绪症状、睡眠紊乱和冲动风险仍然需要处理，也需要随访观察是否转为典型双相。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 躁狂或混合状态下行为失控、冲动伤人、危险驾驶、离家出走
- 出现幻觉、坚信自己有特殊身份或能力，无法被劝住
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变，或皮疹伴发热、口腔溃疡、起疱脱皮

建议一到三天内联系医生：

- 睡眠连续三晚明显减少，白天不困
- 情绪明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 一年内发作次数明显变多，或两次发作之间几乎没恢复正常
- 医生提到的诊断类型与你理解的不一致，想弄清楚依据

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.3 流行病学、起病年龄与预后

“得这个病的人多吗？”“我孩子十六岁就发病，是不是太早了？”“为什么我被当成抑郁症治了六年？”这三个问题分别对应流行病学、起病年龄和误诊，也是刚确诊的人最想知道的现实问题。这一页用尽量实在的方式讲这三件事，也讲病程和功能结局大概是什么样。这里不会给你一串看起来很精确的百分比——不同研究、不同诊断标准、不同地区算出来的数字差别很大，写死了反而误导。

一、谁会发生：不是罕见病，也不是“想出来的病”

双相障碍在世界各地、各种文化里都存在，不是某个国家、某种性格、某个阶层的专属。按世界卫生组织的说法，它是造成青壮年残疾的重要原因之一，属于需要长期管理的疾病。【指南】具体到“人群里到底有多少人”，不同调查给出的数字差别不小，主要因为诊断标准宽严不同、调查方式不同（面访、问卷、病历回顾）、以及双相谱系要不要把环性心境和轻躁狂算进去。

能确定的是两点。第一，它并不罕见，你身边很可能就有正在治疗的人，只是没说。第二，它和“想太多”“抗压能力差”没有因果关系——没有人因为不够坚强而得双相，也没有人因为足够坚强就能不得。【指南】

二、起病年龄：多数在青少年晚期到成年早期

双相障碍的首次发作，多数出现在青少年晚期到二十多岁这段时间。这也是它容易被耽误的原因：这个年龄段本来就情绪波动大、作息乱、学业压力重，早期的轻躁狂很容易被解释成“青春期”“最近状态好”，早期的抑郁则被解释成“懒”“不想上学”。【指南】

几个需要留意的情形：

- **儿童期起病**相对少见，但确实存在。儿童双相的表现常不典型，更容易表现为严重易激惹、行为问题、睡眠紊乱，与注意缺陷多动障碍（ADHD）、创伤反应、对立违抗的界限不好分，需要专科医生长期评估。【指南】
- **四十岁以后第一次发作**要更谨慎。晚发的情况需要认真排除躯体疾病（甲状腺功能异常、神经系统疾病）、药物或物质所致，以及早年被漏掉的轻躁狂。【临床经验】
- **产后**是一个特殊的高风险窗口。产后激素剧烈变化、睡眠剥夺、照护压力叠在一起，可能诱发首次发作或复发，严重时出现产后精神病，属于急症。

起病早本身不是一个“判决”，但它提示需要更早开始规范治疗、更注意家庭支持和学业安排。拖延的时间越长，发作次数越多，后面的路通常越难走。【研究】

三、男女差异：不是“女性才得”

一个常见的误会是双相障碍“女性多见”。更准确的说法是：双相 I 型的男女患病比例大致接近；被诊断为双相 II 型的人里女性更多；女性更容易出现快速循环、混合特征、抑郁发作占主导，也更容易合并甲状腺问题、焦虑障碍和偏头痛；男性则更多见物质使用问题，躁狂期的冲动和攻击性表现可能更突出，自杀死亡的比例也更高。【研究】

这些差异有一部分是生物学上的，也有一部分是“谁更愿意来看病”“谁更容易被诊断成抑郁”造成的。所以不要用性别去推断某个人“会不会得”“严不严重”。

对育龄女性还有一个必须提前说的事：丙戊酸盐等药物在孕期有明确的致畸风险，备孕、怀孕、哺乳都需要提前和医生一起规划，不能自己停药，也不能自己继续用。这部分内容在孕产期专题里有详细说明，这里只强调“必须提前讨论”。【指南】

四、最常被误诊成什么

双相障碍最典型的误诊，是被当成单相抑郁。原因不复杂：人通常在抑郁期才去就诊，而轻躁狂的那段“状态好”，本人不会觉得需要看医生，甚至觉得那才是“真正的自己”。医生如果只问“最近心情怎么样”，不问“有没有一段时间睡得特别少却特别有精神”，就会顺着抑郁治下去。【指南】

常被当成	为什么像	提示可能不是的线索
单相抑郁	就诊时正处抑郁期，症状高度重叠	有过轻躁狂/躁狂期；起病突然；睡眠增多；抗抑郁药后转躁
焦虑障碍	坐立不安、心慌、失眠	焦虑背后有持续的高涨、话多、活动增多
注意缺陷多动障碍	注意力差、冲动、话多	症状是阵发性的，有明确起止，而非从小持续
边缘型人格障碍	情绪剧烈波动、自伤、关系不稳	波动以天/周为单位、与事件紧密相关，而非持续数周的发作
精神分裂症	躁狂期出现幻觉、妄想	精神病性症状只出现在情绪发作期，间期恢复
物质或药物所致	饮酒、兴奋剂、激素类药物后出现	停用后症状是否持续，是鉴别的关键

误诊的代价不只是“多吃了几年药”。被当成单相抑郁治疗，可能单用抗抑郁药，从而诱发转躁、混合状态或快速循环；被当成性格问题，则可能拖到严重失控才就医。反过来说，也不能因为“想确认是不是双相”就自己对照条目下诊断——这需要医生结合完整病程判断。【指南】

五、病程与功能结局：不是一条直线

双相障碍的典型病程是“发作—缓解—再发作”。发作可以是躁狂、轻躁狂、抑郁或混合，间期可能完全恢复正常，也可能残留一些症状：睡不好、容易累、注意力差、情绪平淡、对事情提不起兴趣。残留症状很常见，也常被忽略，它既影响生活质量，也是复发的土壤。【研究】

几点关于病程的实话：

- **不治疗的话，发作往往越来越密。** 发作次数增多、间期缩短，是很多患者共同的经历。这也是为什么要重视维持治疗，而不是“扛过去就好”。【指南】
- **季节可能有影响。** 一部分人的发作集中在春夏或秋冬，睡眠时长随日照变化。知道自己的季节规律，可以提前调整复诊频率。
- **复发不等于前功尽弃。** 已经建立的生活秩序、对自己信号的认识、和医生的配合，都还在。
- **功能恢复往往比症状缓解慢。** 情绪稳定了，工作能力、社交信心、家庭关系还需要时间慢慢回来。

方向	与较好结局相关的因素	与较差结局相关的因素
起病	起病较晚、首次治疗及时	起病早、诊断延迟多年
发作特点	发作间期功能恢复好	快速循环、混合特征、精神病性症状
治疗	规律服药、定期监测、不自行停药	反复自行减停、频繁换医生
生活	作息稳定、少酒、家庭支持好	长期熬夜、物质使用、重大持续应激
共病	焦虑、甲状腺问题得到处理	未处理的物质使用、躯体疾病

这张表不是命运清单。它列的是“可以着力去改的地方”，而不是“注定会怎样”。表中任何一条不利因素，都不意味着结果已经写死。

可以照着做的五件事

- ☐ 在日历上标出第一次明确发作的时间，以及此后每次发作的大致起止
- ☐ 记录自己的季节规律：哪几个月更容易高涨，哪几个月更容易低落
- ☐ 记录抗抑郁药使用后有没有出现过“突然特别有精神”的阶段
- ☐ 把“我最长一次完全正常的时间”写下来，复诊时告诉医生
- ☐ 每半年回顾一次：发作次数是变多还是变少，功能是变好还是变差

容易踩的坑

“网上给了个百分比，说双相很罕见，我怎么可能这么倒霉？” 不同调查的数字差别很大，具体百分比不适合拿来判断自己。诊断靠的是你的病程，不是统计数字。

“我确诊时已经三十多岁，是不是晚了？” 晚确诊确实会带来更多发作和功能损失，但从确诊那天开始规范治疗，仍然能改变后面的走向。

“我间期完全正常，是不是可以停药？” 间期正常恰恰是维持治疗在起作用，也可能只是疾病暂时安静。停药要在医生安排下、缓慢进行，并做好复发监测。【指南】

六、什么时候需要联系医生或去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 躁狂或混合状态下行为失控、冲动伤人、危险驾驶、离家出走

- 产后出现严重失眠、幻觉、妄想、行为紊乱（警惕产后精神病）
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变，或皮疹伴发热、口腔溃疡、起疱脱皮

建议一到三天内联系医生：

- 连续三晚睡眠明显减少，白天却不困
- 情绪明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 抑郁加重两周以上，或出现“活着没意思”的念头
- 一年内发作次数明显增多，间期越来越短

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- WHO. Bipolar disorder fact sheet. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. 链接

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.4 常见名词与误区

双相障碍的科普里，最容易出问题的不是复杂的医学知识，而是几个被用乱的词：把“躁狂”当成“精力旺盛”，把“双相”当成“抑郁加暴躁”，把“轻躁狂”当成“灵感来了”。这一页先把你会在病历、文章、家属群里反复遇到的词解释清楚，再逐条拆掉六个最常见的误解：天才病、终身服药、遗传决定、抗抑郁药能治双相抑郁、躁狂不用治、以及“我只是性格不好”。读完你可以拿它当一本小词典，也可以拿它和家人对齐说法。

一、先把最容易混的名词分开

名词	大白话解释	常见的误用
心境发作	一段时间内成组出现的情绪、精力、睡眠、思维改变，有起止	把一天内的情绪起伏叫“发作”
躁狂	情绪高涨或易怒，配合精力、话量、活动明显增加，功能受损	把“今天精神好”叫躁狂
轻躁狂	同方向但程度较轻，旁人能察觉，功能未严重受损	把“效率高的一周”叫轻躁狂
抑郁发作	情绪低落、兴趣减退、精力下降等成组出现	把“心情不好”叫抑郁
混合特征	一次发作里同时有高涨和抑郁两方向的症状	把“又哭又笑”当成混合
快速循环	一年内四次以上心境发作	把“情绪变得快”当成快速循环
环性心境	两年以上反复的轻度高涨与低落，达不到完整发作标准	把“性格不稳定”当成环性心境
心境稳定剂	以预防躁狂和抑郁复发为核心作用的一类药物统称	以为吃了就“永远不再波动”
转躁	使用抗抑郁药等之后，转向躁狂、混合或快速循环	以为“转躁”说明病好了、有精神了
病识感	对自己状态是否异常的判断能力	把“不承认有病”当成故意作对
维持治疗	症状缓解后继续用药和随访，用来预防复发	以为“维持”就是“治不好才一直吃”

这些词之所以要分清楚，是因为它们对应不同的处理：躁狂要尽快控制，轻躁狂要记录和调整方案，混合状态要优先评估自杀与冲动风险，快速循环要重新审视整个用药方案。说错一个词，可能就走错一条路。【指南】

二、“双相”和“抑郁”到底是什么关系

抑郁是一种发作，双相是一种疾病分类。一个人可以只有抑郁发作，那就是单相抑郁；也可以既有抑郁发作、又有躁狂或轻躁狂发作，那就是双相。所以“双相”不是“更严重的抑郁”，也不是“抑郁加暴躁”，它的关键是**有没有出现过躁狂或轻躁狂**。【指南】

这也解释了一个常见困惑：为什么有些人被诊断“抑郁症”多年，后来改成了双相？不是原来的医生看错了，而是当时没有问到、或者本人没想起来那段“睡得少却特别有精神”的时期。信息补齐，诊断就变了。

要提醒的是：不是所有抑郁症都会变成双相，但一部分最初按单相抑郁治疗的人，后来会发现有过轻躁狂。所以初诊时医生反复追问“有没有过高涨的时期”，不是多疑，而是在避免走错方向。【指南】

三、“躁狂”和“精力好”差在哪

这是最容易被浪漫化的一处。精力好是“睡够了，今天状态不错，事情做完还能陪家人”；躁狂是“三天没怎么睡，仍然觉得必须继续，停不下来，谁劝都烦”。差别不在“有没有精神”，而在**睡眠需求、可控性、后果**这三件事上。

比较点	精力好	躁狂
睡眠	睡够后精神好	睡得极少却不困，甚至主动压缩睡眠
可控性	想停能停，能听劝	停不下来，被劝时易怒
思维	清晰、有条理	奔逸、跳跃，别人跟不上
判断	判断力正常	夸大、冒险、低估风险
后果	事情做得更多更好	花钱、投资、辞职、冲突、危险驾驶
事后	记得清楚，觉得充实	常感羞耻、后悔，或记不清细节

一个实用的区分办法：问“这段时间，你有没有做过一件清醒时绝不会做的事？”如果答案是“有，而且不止一件”，就值得和医生认真谈。【临床经验】

“天才病”：浪漫化的代价

“双相的人都有创造力”“梵高就是双相”——这类说法流传很广，因为它给了疾病一点尊严。但它有两个问题。

第一，它把少数人的成就当成了疾病的普遍属性。大多数患者既没有超凡创作，也没有因为患病而获得什么；他们面对的是失业、关系破裂、债务和反复住院。用“天才”去概括，等于让普通患者更难开口。【个人体验】

第二，它可能延迟治疗。当一个人相信“我的灵感来自轻躁狂，治好了就没了”，他会有意不吃药、不睡觉、追逐那种状态。临床上确实有人这样做，代价是更频繁的发作、更重的抑郁，以及不可逆的功能损失。【临床经验】

更接近事实的说法是：有些人在轻躁狂期思维流畅、产出增多，这是真的；但疾病本身不生产才华，治疗也不消灭才华。稳定的情绪、规律的作息、可靠的执行力的组合，对长期创作更有利，而不是靠一次次透支。至于梵高，他是历史人物，无法被现代诊断，用他来做自我判断没有意义。【待验证】

四、“终身服药”“遗传”“抗抑郁药”三个高频误解

误解一：得了双相就要吃一辈子药

更准确的说法是：对反复发作的人，长期维持治疗是减少复发最可靠的手段之一；维持多久、能不能减、减到什么程度，取决于发作次数、严重程度、既往停药后是否复发、家族史、生活稳定性等，由医生判断。【指南】

有两种极端都要避免。一种是“症状好了就自己停”，这在不复发的人里也存在，但反复发作的人这样做，复发风险明显更高；另一种是“反正要终身吃，干脆不开始”，把治疗想成无期徒刑，反而放弃了本来可以争取的稳定期。停药必须是医生安排的、缓慢的、有监测的过程，不是某天早上决定的。【指南】

误解二：家里有人得，我也一定会得

双相有明显的家族聚集性，遗传因素在发病中占重要位置。但“遗传度高”不等于“命中注定”：父母一方患病，子女的风险比一般人高，可大多数人并不会发病。基因像是把门推开了一条缝，睡眠剥夺、重大应激、物质使用、产后这些环境因素才可能把门彻底推开。【研究】

所以家族史的意义是“提高警惕、尽早就医”，不是“提前判刑”。如果家里有患者，值得做的是：注意孩子的睡眠和情绪剧烈变化，出现问题早点看专科，而不是整天担心“哪天会发病”。

误解三：抗抑郁药能治双相抑郁

这条误解最危险。双相抑郁确实需要治，但单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合状态或快速循环，让病程更乱。规范做法通常是在心境稳定剂的基础上评估是否联合抗抑郁药，并密切观察睡眠、话量、活动量的变化。【指南】

“我吃了抗抑郁药以后特别有精神”不是好转的信号，可能是转躁的开始。出现这种情况，应该尽快联系医生，而不是自行加量或继续观察。反过来，也不能因为怕转躁就拒绝所有抗抑郁药——是否使用、用多久、怎么停，是个体化的临床判断，需要和医生讨论，不是自己能定的。

五、一张自查表：分清“我遇到的是哪一种情况”

- ☐ 我最近睡眠明显减少，但白天不觉得困
- ☐ 我说话比平时多，别人插不上嘴
- ☐ 我同时启动了很多事，停不下来
- ☐ 我做了平时不会做的冒险决定（花钱、投资、辞职、开车）
- ☐ 我最近特别易怒，一点小事就爆发
- ☐ 我情绪低落、对什么都没兴趣，持续两周以上
- ☐ 我在低落的同时，脑子转得飞快、坐不住

☐ 我有过“活着没意思”的念头

前五项勾得越多，越要警惕躁狂或轻躁狂；第六项提示抑郁；第七项提示混合特征，风险更高；第八项需要立即求助。这张表只用来提醒你“该不该去看医生”，不能用来给自己下诊断。【临床经验】

容易踩的坑

“我情绪波动大，是不是就是双相？” 情绪波动是所有人都有的，双相看的是成组的、持续的、影响功能的发作。

“吃药后变平静了，是不是被压制了创造力？” 平静不等于迟钝。稳定的状态通常更有利于长期产出，具体感受可以和医生讨论调整方案。

“家里人说是我想太多，我是不是该忍着？” 忍着不会让发作消失，只会让就诊更晚。可以请家人一起看这一页，或者请医生向家属解释。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 躁狂或混合状态下行为失控、冲动伤人、危险驾驶
- 出现幻觉、坚信自己有特殊能力，无法被劝住
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变，或皮疹伴发热、口腔溃疡、起疱脱皮

建议一到三天内联系医生：

- 睡眠连续三晚明显减少，白天不困
- 情绪明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 抗抑郁药使用后出现异常兴奋、话多、睡得少
- 抑郁加重两周以上，或出现“活着没意思”的念头

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. 链接

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 2：临床表现与评估

双相障碍不只有“高涨”和“低落”，混合特征、快速循环和抑郁相往往更危险。

2.1 躁狂发作

这一页讲清楚躁狂发作到底是什么样、和“心情特别好”有什么区别、哪些表现提示危险。它适合刚被诊断的患者、正在观察家人的家属，也适合想分清“躁狂”和“轻躁狂”的读者。读完后，你应当能识别躁狂的核心症状，知道什么时候必须联系医生，什么时候要立刻去急诊。

一、先看整体：一次躁狂发作的轮廓

躁狂发作不是简单的“情绪高涨”，而是一段时间内情绪、精力、思维、睡眠和行为同时发生明显改变。按 DSM-5-TR 的描述，这种改变通常持续至少一周，几乎每天大部分时间都存在；如果严重到需要住院，则不论是否满一周都可以成立。【指南】

判断的关键不是“他最近很开心”，而是这种状态和本人平时的样子相比，是否出现了**持续、成组、失控**的变化。比如平时谨慎的人突然大量投资，平时话少的人连续几个小时不停地讲，平时睡七小时的人只睡两三个小时仍觉得精力充沛。单个症状可能有其他解释，一组症状同时出现、持续数天，就需要精神科评估。

躁狂的严重度可以很不一样。有的人还能勉强上班，只是明显反常；有的人已经出现幻觉、妄想，无法照顾自己，甚至做出危及生命的行为。**躁狂本身是一种需要医疗处理的状态，不是靠意志力“压一压”就能过去。**【指南】

二、七个常见症状群

1. 情绪高涨或明显易激惹

情绪高涨表现为异常兴奋、自信、愉快，甚至觉得“什么都难不倒我”。另一种常见表现是易激惹：一点小事就发火，和家人争吵，觉得别人故意针对自己。躁狂并不总是“开心”，愤怒、烦躁、敌意同样可以是核心表现。

2. 睡眠需求减少

这里说的是**睡眠需求减少**，不是睡不着。患者可能只睡很少，第二天仍然精力旺盛，不觉得困，也不认为有问题。家属常听到“我根本不累”“睡觉是浪费时间”。如果连续几天几乎不睡，同时话多、活动增多，风险会明显上升。

3. 话多、语速快、停不下来

说话比平时多得多，语速快，声音大，别人很难插话。话题可能不断跳转，从工作跳到投资，再跳到童年往事，听者勉强能跟上，患者自己却觉得“思路特别清楚”。严重时会出现“思维奔逸”，即念头一个接一个，语言变得破碎，旁人难以理解。

4. 夸大、自我评价过高

患者可能坚信自己能力非凡、马上要发大财、有特殊使命，甚至认为自己拥有超自然能力。轻一些时表现为过度自信、贬低他人、计划宏大；重一些时可能发展为夸大妄想。此时讲道理、摆事实通常无效，争论只会让关系更紧张。

5. 活动增多、目标导向行为增加

突然同时启动很多项目，熬夜工作、频繁社交、到处旅行、整理房间到凌晨。活动看似“有目标”，但往往虎头蛇尾，计划不断升级，身体却在被透支。也可能表现为坐立不安、来回走动、无法安静。

6. 冲动与冒险行为

这是最需要家属警惕的一组表现：超出承受能力的消费或投资、赌博、危险驾驶、轻率发生性行为、突然辞职、与人冲突、独自远行。患者当下可能觉得“这很正常”“我承担得起”，事后才发现后果严重。冲动行为可能在很短时间内造成难以挽回的损失。

7. 精神病性症状

严重躁狂可能出现幻觉或妄想，例如听到有人议论自己、坚信被监视、认为自己有特殊身份。精神病性症状提示病情更重，通常需要住院评估。此时患者可能因为害怕或兴奋而拒绝帮助，家属不要单独与其对抗，应联系医生或急救人员。

症状群	患者可能怎么说	家属可能观察到什么
情绪	“我状态特别好”“别管我”	异常兴奋、易怒、哭笑无常
睡眠	“我不需要睡”	连续少睡仍精力旺盛
言语思维	“我脑子转得飞快”	话多、抢话、话题跳跃
自我评价	“我马上要干大事”	夸大计划、听不进劝
活动	“我有很多事要做”	同时开很多项目、坐不住
冲动	“这点钱不算什么”	乱花钱、冒险驾驶、轻率性行为
精神病性	“他们在监视我”	对空说话、极度警觉、坚信被害

三、严重度：从“需要调药”到“必须急诊”

躁狂的严重度不是只看“高不高兴”，而要看**现实检验、冲动控制、自理能力和安全风险**。下面的分级只是帮助理解，不能替代医生的判断。

严重度	常见表现	建议处理
轻度至中度	睡眠减少、话多、计划增多，但仍能部分工作，听劝	尽快联系精神科医生，调整评估与治疗
明显影响功能	无法工作、家庭冲突升级、明显乱花钱、驾车冒险	当日或尽快就诊，必要时家属陪同
重度	妄想、幻觉、极度激越、拒绝进食饮水、无法自理	立即急诊，必要时呼叫 120
危急	伤人风险、自杀风险、危险行为、走失、衰竭	立即呼叫 120，必要时 110

需要特别说明：**“还能上班”不等于“不严重”。** 有些患者靠意志力维持表面正常，回家后却完全失控。家属描述“他最近像变了一个人”，往往比患者自己的判断更接近真实情况。

四、家属能做什么，不能做什么

家属最重要的任务不是说服患者“你有病”，而是**降低刺激、减少伤害、把患者带到专业帮助面前**。在躁狂急性期，讲道理、翻旧账、强行辩论通常会火上浇油。

- ☐ 减少环境刺激：避免大型聚会、长时间争论、多人同时劝说。
- ☐ 保管好银行卡、现金、车钥匙、证件和危险物品，必要时设置支付限额。
- ☐ 不嘲笑、不刺激、不激怒，也不轻易承诺无法兑现的事。
- ☐ 用简短、具体的句子表达关心，例如“我很担心你，今晚我陪你去医院”。
- ☐ 记录睡眠、言语、花费、活动和冲动行为，就诊时交给医生。
- ☐ 联系患者信任的医生，询问是否需要提前复诊或急诊评估。
- ☐ 如果患者愿意，可由一两位熟悉的家属陪同，避免多人围堵。
- ☐ 家属也要轮换休息，长期照护需要备用方案。

不要做的事同样重要：不要自行给患者加药、减药或停药；不要用“你再这样我就走”反复威胁；不要在患者持械、极度激动或明确威胁伤人时独自上前；不要因为“家丑不可外扬”而拖延就医。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 连续几天几乎不睡，仍异常兴奋、话多、活动不停。
- 出现幻觉、妄想、坚信被监视或迫害，无法正常交流。
- 有伤人、自杀、危险驾驶、纵火、跳楼等风险。
- 乱花钱到严重影响家庭生活，或准备做出不可逆的重大决定。
- 拒绝进食饮水、极度衰竭、意识模糊、高热、肌肉僵硬。
- 以上情况不要等待“自己冷静下来”，立即联系精神科急诊；有即时危险时呼叫 120，必要时 110。

五、容易踩的坑

坑一：把躁狂当成“状态好”。 真正的躁狂往往伴随睡眠需求减少、冲动和功能受损。只是心情好、效率高，不足以诊断躁狂。

坑二：只盯着“高兴”，忽略易激惹。 不少躁狂发作以愤怒、争吵、攻击性为主，家属容易误以为“脾气变差”。

坑三：等“这阵子过去”。 躁狂可能持续数周，越拖越难处理。冲动行为的代价往往发生在等待期间。

坑四：用争吵证明患者有病。 急性期争论只会增加敌意。把目标从“说服他”改成“保证安全、尽快就医”。

坑五：症状缓解后立刻停药。 躁狂缓解不等于疾病消失，维持治疗和复发预防需要与医生共同决定。

参考来源

- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.2 轻躁狂与双相 II 型

这一页讲轻躁狂为什么容易被忽略，以及双相 II 型到底“轻”在哪里、不轻在哪里。它适合被诊断为双相 II 型的患者、反复抑郁却从没被问过“有没有特别兴奋的时期”的读者，也适合想理解家人变化的家属。读完后，你应当能说清轻躁狂与普通“状态好”的区别，并知道哪些信息值得带给医生。

一、轻躁狂：像换了一个人，但还没完全失控

轻躁狂是一种程度较轻、持续时间较短的躁狂样状态。按 DSM-5-TR 的描述，它通常持续至少四天，几乎每天大部分时间存在，并且可以被身边人观察到。【指南】与躁狂相比，轻躁狂按定义不伴明显的精神病性症状，也不造成需要住院的严重功能损害；但工作、社交和家庭功能仍可能出现具体问题。

问题在于，“没有完全崩掉”不等于“没有代价”。轻躁狂的人可能觉得自己从未这么好过：睡得少却精神百倍，话多、幽默、自信，效率高，灵感多，社交活跃，购物和旅行说走就走。患者本人往往不觉得这是病，甚至会把这段时期当成“真正的自己”。【临床经验】

家属看到的却是另一种画面：这个人突然变得陌生，讲话停不下来，脾气变急，开始做平时不会做的决定。所谓“像换了一个人”，重点不是变好或变坏，而是**和本人平时的基线相比，睡眠、言语、活动、判断和冲动控制同时发生了改变**。

二、轻躁狂的常见表现

轻躁狂不一定表现为兴高采烈。它可以是愉快、自信、精力旺盛，也可以是烦躁、易怒、坐立不安。常见的组合包括：

- 睡眠需求明显减少，睡得很少仍不觉得累。
- 说话比平时多，语速快，喜欢抢话，难以被打断。
- 思维跳得快，同时冒出很多计划，觉得脑子“特别好用”。
- 自我评价升高，觉得自己眼光独到、能力超群。
- 活动增多，社交、工作、兴趣爱好同时加码。
- 花钱、投资、旅行、性行为等方面比平时更冲动。
- 注意力容易转移，一件事没做完又去做另一件。
- 容易发脾气，尤其是别人劝阻或质疑时。

这些表现单独看都可能很正常。判断轻躁狂，需要看它们是否**成组出现、持续数天、与平时不同、被他人注意到**。如果只是周末心情好、睡晚一点、效率高一点，不足以说明是轻躁狂。

三、功能变化：患者说“很好”，家属说“不对劲”

轻躁狂最容易被漏掉的地方，是患者主观体验往往不错，而功能损害是具体的、滞后的。患者可能确实完成了更多工作，但同时也可能签下不合适的合同、透支信用卡、与人发生冲突、开车超速，或者在几天不睡后突然崩溃。

观察维度	轻躁狂时可能发生的变化	需要追问的问题
睡眠	睡得少却精力好，拒绝休息	连续几晚？第二天是否仍不困？
言语	话多、快、抢话、停不下来	别人是否插不上话？是否比平时明显不同？
判断	自信、乐观、低估风险	是否做了平时不会做的决定？
花钱	购物、投资、请客变多	是否超出承受能力？是否隐瞒？
脾气	易怒、好争辩、受不了反对	是否与家人同事冲突增多？
行为	旅行、社交、性行为增加	是否反常、冲动、事后后悔？

家属的观察在这里非常重要。很多患者回忆不起轻躁狂的具体细节，或者认为那段时期“很正常”。如果家属能提供具体时间、具体行为和具体后果，医生更容易拼出完整病程。【临床经验】

四、双相 II 型的诊断要点

双相 II 型并不是“比较轻的双相障碍”。它的诊断需要至少一次轻躁狂发作，以及至少一次重性抑郁发作，并且从来没有过完整的躁狂发作。【指南】换句话说，患者的大部分痛苦可能来自抑郁，而轻躁狂只是短暂插曲；如果只盯着抑郁看，就很容易误诊为单相抑郁。

双相 II 型的几个要点：

1. **必须有轻躁狂，而不是只靠“情绪波动”。** 轻躁狂需要持续数天、成组症状、他人可观察到的改变。
2. **必须有抑郁发作。** 抑郁可以是重度，也可以反复出现，功能损害往往比轻躁狂更明显。
3. **不能有躁狂发作。** 一旦出现完整躁狂，诊断方向通常转为双相 I 型。
4. **不能用抗抑郁药的反应来反推诊断。** 服药后转躁是重要线索，但不是唯一依据。
5. **需要看纵向病程。** 一次面诊很难看清，往往需要追问过去多年、甚至青少年时期的状态。

双相 II 型的抑郁负担并不轻。研究普遍发现，双相 II 型患者处在抑郁期的时间往往多于轻躁狂期，自杀风险也需要认真评估。【研究】因此，“II 型”不代表可以不管，更不代表不需要治疗。

五、和“状态好”的区别

特征	普通的状态好	轻躁狂
睡眠	睡够后精神好	睡得明显少仍不困
持续性	随情境变化，能停下来	持续数天，难以自行刹车
言语	话多但能交流	话多、快、抢话，别人难插嘴
判断	风险意识仍在	过度乐观、低估后果

特征	普通的状态好	轻躁狂
他人感受	觉得你开心	觉得你“像变了一个人”
后果	基本没有损失	花钱、冲突、冒险、事后后悔

一个实用的判断句是：**“如果这段状态持续四天以上，睡眠明显减少，话和活动明显增多，而且身边人觉得你不对劲，就值得让医生听一听。”** 这不是自我诊断，而是提供线索。

六、容易踩的坑

坑一：把轻躁狂当成“病好了”。 抑郁之后的突然兴奋，有时不是康复，而是转向另一极。尤其伴随睡眠减少、话多、花钱变多时，要尽快复诊。

坑二：只报告抑郁，不报告“好时期”。 很多患者觉得兴奋期“不算病”，就诊时只说低落、失眠、没力气。医生如果不知道轻躁狂史，可能按单相抑郁处理。

坑三：把“脾气变差”当成性格问题。 轻躁狂的易激惹常被家人理解为“自私”“脾气坏”，从而错过就医时机。

坑四：自行使用抗抑郁药。 双相 II 型患者单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合状态或快速循环，不能自行加用或停用。【指南】

坑五：认为 II 型不用长期管理。 双相 II 型同样可能反复发作、影响工作和关系，需要系统评估与维持治疗。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 睡眠需求明显减少持续数天，同时话多、活动增多、停不下来。
> - 出现明显冲动：大额消费、投资、危险驾驶、轻率性行为、突然远行。
> - 情绪从抑郁突然转为异常兴奋，或抑郁与兴奋症状同时出现。
> - 出现幻觉、妄想、伤人念头，或明确的自杀计划。
> - 以上情况请尽快联系精神科医生；有即时危险时立即去急诊，必要时呼叫 120，现场有暴力风险时拨打 110。

参考来源

- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.3 双相抑郁

这一页讲双相障碍的抑郁相：它和单相抑郁有什么不同，为什么容易被误诊，哪些信号提示需要重新评估。它适合反复抑郁、治疗效果不理想的患者，也适合被告知“只是抑郁症”但心里不踏实的家属。读完后，你应当能整理出有价值的病史线索，并知道抗抑郁药出现异常反应时该怎么处理。

一、双相抑郁不只是“心情不好”

双相抑郁的核心是一次重性抑郁发作：持续至少两周，几乎每天大部分时间情绪低落，或对原本喜欢的事失去兴趣，并伴随睡眠、食欲、精力、注意力、自我评价、动作迟缓或坐立不安等变化。【指南】严重时会出现无价值感、反复想到死亡、自杀计划，甚至精神病性症状。

双相抑郁和单相抑郁在症状上有大量重叠，单靠“当下这一刻”很难区分。真正的区别往往藏在**过去**：有没有过轻躁狂或躁狂发作，抑郁是第一次出现在什么年龄，发作是否频繁，家族里有没有双相障碍，产后是否出现过严重情绪问题，吃抗抑郁药后有没有异常兴奋或转躁。

这也意味着，医生需要问的不只是“你现在有多难受”，还要问“你以前有没有过一段完全不同的时期”。很多患者会因为羞耻、遗忘，或认为那段“兴奋期”不是病，而漏掉关键信息。

二、双相抑郁常见的“非典型”特征

所谓非典型特征，是指与“典型抑郁”的入睡困难、食欲下降、早醒不完全一样的表现。双相抑郁中较常见的有：

- 睡得很多，仍然起不来，白天嗜睡。
- 食欲增加，尤其想吃甜食或碳水化合物，体重上升。
- 四肢沉重，像灌了铅，想做事情但身体动不了。
- 对拒绝、批评特别敏感，人际关系中小事也会引发强烈反应。
- 情绪反应性保留：遇到好事能短暂开心，但很快又掉下去。
- 抑郁与烦躁、思维加速、活动增多同时出现，形成混合状态。

需要强调的是：**非典型特征提示“要想到双相”，但不能单凭它确诊。** 单相抑郁也可能出现嗜睡或食欲增加；反过来，双相抑郁也可能表现得很“典型”。【研究】这些特征的价值，是提醒医生多问一句，而不是给患者贴标签。

三、差别、误诊与抗抑郁药

线索	更偏向单相抑郁	更偏向双相抑郁
起病年龄	各年龄段均可	较早起病更需警惕
发作史	以抑郁发作为主	曾有轻躁狂或躁狂
睡眠	入睡难、早醒常见	嗜睡、睡不醒也常见

线索	更偏向单相抑郁	更偏向双相抑郁
发作频率	相对稳定	反复、频繁，甚至快速循环
家族史	抑郁家族史	双相、躁狂、自杀家族史
治疗反应	抗抑郁药相对平稳	抗抑郁药后转躁、混合或波动
产后	产后抑郁可能	产后精神病或严重情绪波动需警惕

这张表只能帮助整理线索，不能代替诊断。最关键的一列其实是“有没有过另一极的发作”。如果从来没有被系统询问过，建议主动补充。

误诊的代价

把双相抑郁当成单相抑郁处理，最大的风险不是“药没效”，而是可能让病程更不稳定。双相抑郁患者单用抗抑郁药，可能出现转躁、混合状态、烦躁加剧、睡眠减少或快速循环。【指南】这并不是说抗抑郁药绝对不能用于双相障碍，而是说它需要在明确诊断、联合心境稳定剂、密切监测的前提下由医生决定。

误诊还会带来其他代价：反复换药、反复住院、工作与关系受损、被误解为“想太多”“不配合治疗”。有些患者多年只被当作“难治性抑郁”，直到某次轻躁狂被家属看见，才拼出完整图像。误诊的代价，往往是时间。

抗抑郁药转躁：需要知道什么

转躁不是“性格变了”，也不是“药把人吃坏了”这么简单。它是指使用抗抑郁药后，出现持续的情绪高涨、易激惹、睡眠需求减少、话多、活动增多、冲动等躁狂或轻躁狂表现，有时还会出现抑郁与兴奋并存的混合状态。

需要记住三点：

1. **不要自行停药或减药。** 突然停药可能引起撤药反应或情绪波动，应由医生评估后调整。
2. **尽快记录并复诊。** 记录从哪天开始、睡了多久、话和活动是否增多、有没有冲动行为，这些信息对医生判断很重要。
3. **出现精神病性症状或自杀风险时按急症处理。** 不要等到下次预约。

四、自杀风险：双相抑郁最需要正视的部分

双相障碍的自杀风险高于一般人群，抑郁相和混合状态尤其需要警惕。【指南】危险信号包括：反复说“活着没意思”“没有我大家会更好”，把重要东西送人，突然安排后事，购买或囤积危险物品，从极度痛苦突然变得异常平静，以及抑郁同时伴随烦躁、冲动、失眠。

家属常担心“直接问自杀会不会提醒他”。现有证据并不支持这种担心；温和、直接地询问反而可能让患者感到被理解。【研究】可以这样问：“你最近有没有想过不想活了？有没有想过怎么做？”如果对方承认有计划或已经准备工具，不要让其独处，立即联系医生或急救。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 反复出现自杀念头，或已经有具体计划、准备手段。
- 抑郁同时伴随明显烦躁、坐立不安、失眠、冲动，像“混合状态”。
- 服用抗抑郁药后突然话多、兴奋、睡得少、脾气变大，或出现幻觉、妄想。
- 拒绝进食饮水、木僵、意识模糊，或身体状况迅速变差。
- 有即时自伤、自杀或伤人风险时，立即呼叫 120，必要时 110；不要让患者独处，移开利器、药物等危险物品。

五、就诊准备与常见误区

就诊前可以准备的清单

- ☐ 第一次抑郁发作大约在什么年龄，当时持续多久。
- ☐ 有没有过连续几天睡得少却特别有精神、话多、计划多的时期。
- ☐ 有没有人说过你“像变了一个人”“最近太亢奋”。
- ☐ 每次发作前有没有睡眠减少、跨时区、饮酒、停药等诱因。
- ☐ 用过哪些抗抑郁药，用后有没有转躁、烦躁、失眠或冲动。
- ☐ 家族中是否有人得过双相、躁狂、抑郁或自杀。
- ☐ 产后、青春期、更年期前后有没有明显情绪波动。
- ☐ 目前是否有自杀念头、计划，或自伤行为。

容易踩的坑

坑一：只治抑郁，不问另一极。 这是双相抑郁最常见的漏诊路径。就诊时主动提“有没有过特别兴奋的时期”。

坑二：把抗抑郁药后的兴奋当成“终于好了”。 睡眠减少、话多、花钱变多，是需要复诊的信号，不是康复的证据。

坑三：因为怕转躁就拒绝所有抗抑郁药。 是否使用、如何使用，需要医生根据发作史、严重度、既往反应决定，不能自行一刀切。

坑四：把自杀话题当成禁忌。 直接询问不会“教坏”患者，反而能争取时间。

坑五：症状一好就停药。 双相抑郁缓解后仍需维持治疗和复发监测，具体方案由医生决定。

参考来源

- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022：https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.4 混合特征与快速循环

这一页讲两种最容易被低估、也最需要警惕的病程：混合特征和快速循环。它们常被误认为“情绪化”“脾气差”或“药物没调好”，但背后可能是更高的自杀与冲动风险。读完后，你应当能分清“混合”与“快速循环”不是一回事，并知道出现哪些表现要立即求助。

一、混合特征：抑郁和躁狂同时出现

混合特征是指一次发作中，抑郁症状与躁狂/轻躁狂症状同时存在。按 DSM-5-TR 的框架，躁狂或轻躁狂发作如果同时有至少三项抑郁症状，或抑郁发作同时有至少三项躁狂/轻躁狂症状，就可能标注“伴混合特征”。【指南】这些症状需要足够突出，而不是偶尔一闪而过。

混合状态的危险在于，它把两种相反的力量放在一起：一边是抑郁带来的绝望、无价值感和自杀念头，另一边是躁狂带来的精力、冲动、失眠和行动力。患者可能在极度痛苦的同时，突然有力量去实施自杀计划。【指南】这不是“想开点”能解决的，也不是普通的情绪低落。

常见的混合表现包括：

- 情绪低落、绝望，同时烦躁、坐立不安、容易发火。
- 失眠或睡眠明显减少，脑子却停不下来。
- 反复出现自杀念头，同时有冲动、计划性或攻击性增强。
- 话多、思维快，但内容悲观、自责、绝望。
- 活动增多，却不是为了愉快，而是像“被驱赶着”停不下来。
- 对声音、光线、人际刺激异常敏感，容易崩溃。
- 出现幻觉、妄想，或强烈的被害感。

二、为什么混合状态更危险

纯躁狂的风险常与冲动、冒险、精神病性症状有关；纯抑郁的风险常与自杀念头、动力不足有关。混合状态把两者的风险叠加：**有自杀的想法，也有实施的能量和冲动；有抑郁的痛苦，也有躁狂式的“顾不上后果”。**

混合状态还可能被误判。患者看起来能说会道、活动不少，家属以为“没那么抑郁”；医生如果只看到兴奋，可能忽略底下的绝望；如果只看到抑郁，又可能忽略躁狂症状和转躁风险。因此，混合状态需要更细致的精神检查和安全评估。【临床经验】

混合状态不是“忍一忍就过去”的阶段。出现自杀计划、冲动行为、严重失眠、幻觉或极度激越时，应按照急症处理。

三、快速循环：发作次数多，不等于情绪变得快

快速循环有相对明确的定义：在过去十二个月内，至少出现四次心境发作，包括躁狂、轻躁狂或抑郁发作，且发作之间有缓解期，或直接转向相反极性。【指南】它描述的是**发作频率**，不是一天之内情绪忽高忽低。

很多人把“早上开心、下午难过、晚上暴躁”叫作快速循环，这并不准确。那种短时间的情绪波动更可能与压力、人际关系、睡眠不足、人格特点或物质使用有关。真正的快速循环，需要能清楚地数出一次次发作，每次持续数天到数周，并有功能或症状的明显改变。

概念	核心特征	常见误解
混合特征	同一段时间内抑郁与躁狂症状并存	以为什么都没变，只是脾气差
快速循环	一年内至少四次心境发作	以为是一天内情绪反复
普通情绪波动	随事件起伏，持续时间短	容易自我贴上双相标签

快速循环的诱因和加重因素包括：抗抑郁药使用不当、甲状腺功能异常、饮酒或使用兴奋剂、睡眠节律紊乱、反复停药、生活应激等。【指南】【研究】不同患者的诱因不一样，需要医生逐一排查，不能简单归因于“意志薄弱”。

四、混合与快速循环的处理原则

处理这类情况，第一步不是自行换药，而是**把病程讲清楚**。医生需要知道：每次发作从哪天开始、持续多久、以抑郁还是兴奋为主、有没有混合症状、用过什么药、有没有转躁史、睡眠和物质使用情况。

治疗上，医生通常会重新评估诊断、检查有没有甲状腺或其他躯体问题、审查所有药物（包括非处方药、保健品和酒精），并优先稳定心境、控制失眠和冲动、降低自杀风险。【指南】抗抑郁药在这类患者中尤其需要谨慎，不能自行加用、加量或停用。心理社会干预、规律作息和家属支持也很重要，但它们不能替代急性期的医疗评估。

家属可以做的事：

- ☐ 记录每天睡了多久、情绪高低、话多话少、活动和冲动行为。
- ☐ 把药物、酒精、咖啡因、保健品的使用情况写下来。
- ☐ 观察自杀念头、告别行为、赠送物品、囤积危险物品等信号。
- ☐ 暂时保管危险物品，减少独自驾车、夜间外出和大额支付。
- ☐ 不与其争辩“你到底是不是病了”，先保证安全并联系医生。
- ☐ 复诊时带上记录和一位了解情况的家属。
- ☐ 家属轮换陪护，避免一个人长期熬夜。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 抑郁的同时出现明显烦躁、冲动、失眠、话多，像“混合状态”。
- 有自杀念头，尤其伴随具体计划、准备手段或“突然平静”。
- 出现幻觉、妄想、严重激越、伤人威胁，或无法自控的冲动行为。
- 连续多日几乎不睡，伴极度兴奋、衰竭、拒绝进食饮水。
- 有即时危险时，立即呼叫 120，必要时 110；不要让患者独处，先移开利器、药物、车辆钥匙等危险物品。

五、容易踩的坑

坑一：把混合状态当成“抑郁加重”。 如果抑郁中突然出现话多、失眠、冲动、烦躁，不能只加抗抑郁药，必须重新评估。

坑二：把快速循环当成“性格不稳定”。 快速循环有发作性、持续时间和功能改变，需要纵向记录，不是一句“情绪化”能概括。

坑三：自行停抗抑郁药。 突然停药可能引起撤药反应或情绪反弹。任何调整都应由医生安排。

坑四：只靠“忍”和“陪伴”度过急性期。 混合状态的自杀风险很高，陪伴不能替代急诊评估。

坑五：忽略甲状腺、物质使用和睡眠。 这些因素可能让循环更难控制，需要一并处理。

参考来源

- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder: https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.5 疾病分期与病程

这一页把双相障碍的病程拆成几个阶段：前驱期、急性期、巩固期和维持期，并说明发作间期为什么仍然需要关注。它适合刚确诊、想知道“要治多久”的患者，也适合照顾者理解不同阶段该做什么。读完后，你应当能区分“症状控制”和“真正稳定”，并知道每个阶段最值得记录什么。

一、双相障碍不是一条直线

双相障碍的病程因人而异。有人一生只出现少数几次发作，有人反复发作，有人以抑郁为主，有人躁狂更突出，还有人出现混合特征或快速循环。病程也不是“发作—完全恢复—再发作”这么整齐，很多人在两次发作之间仍有睡眠不稳、注意力下降、易疲劳或情绪脆弱。【临床经验】

把病程分期，不是为了给每个人套一个时间表，而是为了回答三个问题：现在最需要解决什么？什么时候可以减药或调整？怎样减少下一次发作？不同阶段的目标不同，用一个标准要求全程，容易失望，也容易过早停药。

二、前驱期：发作前的细微信号

前驱期指典型症状全面出现之前的一段时间。常见变化包括睡眠减少或增多、情绪变得易怒或低落、话变多或变少、注意力下降、对声音光线敏感、开始回避社交、花钱或活动增多。不是每个人都有清晰的前驱期，也不是每个前驱期都会发展为一次发作。

前驱期最容易被忽略，因为它“还不够像病”。但对已经有过发作的人来说，这些信号往往有个人规律：比如每次躁狂前都会连续几天只睡很少、突然开始整理旧物、讲话变快；每次抑郁前都会早醒、不想接电话、觉得别人讨厌自己。把这些规律写下来，比笼统地记“最近不太好”更有用。【临床经验】

前驱期不等于“马上要发作”，也不等于要自行加药。它的价值是提醒你**提前复诊、稳定作息、减少刺激、把危险物品和支付权限管好**。如果症状在几天内迅速加重，应尽快联系医生。

三、急性期：先控制症状和风险

急性期的目标是控制躁狂、抑郁或混合症状，保证安全，处理躯体问题，并判断是否需要住院。这个阶段通常需要较密集的复诊，医生会评估症状严重度、自杀/伤人风险、精神病性症状、进食饮水、睡眠和药物不良反应。

急性期不要做三件事：不要自行加药减药；不要因为“感觉好一点”就恢复高强度工作；不要独自承担所有照护。躁狂急性期的冲动行为、抑郁急性期的自杀风险，都可能在一两天内变化，家属的观察和陪伴很重要。

阶段	主要目标	患者可以做什么	家属可以做什么
前驱期	识别信号、减少诱因	记录睡眠情绪、提前复诊	留意变化、减少刺激
急性期	控制症状、保证安全	遵医嘱、如实报告副作用	陪诊、保管危险物品
巩固期	防止反弹、恢复功能	不急于满负荷、规律复诊	协助作息、观察波动
维持期	预防复发、恢复生活	长期随访、维持治疗	支持而非监视

四、巩固期与维持期

巩固期：症状好了，但还没稳

巩固期的特点是急性症状已经明显减轻，但疾病仍不稳定。此时最危险的念头是“我已经好了，可以停药了”。双相障碍在症状缓解后仍有较高的复发风险，尤其在前几个月；过早停药、睡眠紊乱、生活应激都可能让症状反弹。【指南】

巩固期的工作包括：继续按医嘱治疗、处理药物副作用、逐步恢复作息和社会角色、识别复发信号、修复发作期间受损的关系和工作。恢复工作或学习通常需要循序渐进，而不是一上来就恢复到病前强度。对患者来说，“能去上班”是进步，但“能持续上班而不崩”才是功能恢复。

维持期：把稳定变成长期的事

维持期的目标是预防复发、减少发作次数和严重度、改善功能和生活质量。维持治疗持续多久，需要看发作次数、严重度、既往停药后是否复发、自杀风险、家族史、孕产计划和躯体状况。有人需要数年，有人需要更长；这不是“意志力”问题，也不是“吃药上瘾”。【指南】

维持期不只是吃药。规律起床、稳定睡眠、管理饮酒和咖啡因、识别早期信号、保持复诊、处理压力和关系问题，都属于长期管理。心理教育、认知行为治疗、人际与社会节律治疗、家庭聚焦治疗等，可以帮助患者和家属更早识别波动、减少复发诱因。【研究】

五、发作间期：没有症状不等于没有影响

很多患者在两次发作之间症状不明显，但仍有“残留症状”：容易疲劳、注意力不如以前、对压力更敏感、社交减少、对未来担心。也可能存在功能损害：工作升迁受阻、学业中断、关系疏远、经济压力。这些不一定达到诊断标准，却真实影响生活。

发作间期的功能恢复，通常比“症状消失”走得更慢。患者可能需要在减少工作量、调整学习节奏、重建社交之间反复试探。家属不要把“看起来正常”当成“什么都不需要管”，也不要把每一次情绪波动都当成复发。更稳妥的做法是：保持基本作息和复诊，遇到持续数天的明显变化再提高警惕。

六、复诊清单与常见误区

复诊时可以带的问题清单

- ☐ 我这次发作属于哪种类型？是躁狂、轻躁狂、抑郁还是混合？
- ☐ 目前处在哪个阶段？急性期、巩固期还是维持期？
- ☐ 这次治疗的目标是什么？症状控制、功能恢复，还是预防复发？
- ☐ 我需要重点监测哪些早期信号？
- ☐ 目前药物的常见副作用有哪些？出现什么情况要联系你？
- ☐ 维持治疗大概需要多久？什么情况下会考虑调整？
- ☐ 我的睡眠、工作节奏和饮酒习惯需要怎么改？
- ☐ 如果再次出现自杀念头，我应该联系谁、去哪里？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 睡眠连续多天明显减少，伴话多、活动增多、冲动或易怒。
- 抑郁加重，出现自杀念头、计划，或开始安排后事。
- 出现幻觉、妄想、严重激越、伤人威胁，或无法自理。
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、严重皮疹、走不稳等。
- 有即时危险时立即呼叫 120，必要时 110；不要等待下次复诊。

容易踩的坑

坑一：症状一好就停药。 缓解不等于治愈，维持治疗是复发预防的一部分，调整必须由医生评估。

坑二：把发作间期当成“完全没事”。 残留症状和功能损害需要关注，但不必把每次情绪波动都当成复发。

坑三：急性期后立刻满负荷工作。 功能恢复需要阶梯式推进，过早起量容易反弹。

坑四：只记录“好/不好”。 睡眠、活动、花钱、言语、冲动和服药情况更能帮助医生判断阶段。

坑五：把维持治疗理解成“终身被判刑”。 维持多久因人而异，可以和医生讨论目标、风险和停药计划，但不要自行决定。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder: https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

- NIMH. Bipolar Disorder：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.6 精神检查与评估工具

这一页讲精神科医生如何通过谈话和观察做出评估，以及 YMRS、HAMD、MDQ、CGI-BP 这些常见工具各自测什么、不能测什么。它适合刚接触量表、想弄明白“分数高是不是就确诊”的读者，也适合准备复诊的患者和家属。读完后，你应当能配合一次完整的精神检查，而不是把某一个分数当成诊断。

一、诊断靠的是完整评估，不是一张问卷

到目前为止，双相障碍没有一项抽血、影像或基因检查可以直接确诊。诊断依赖医生对症状、持续时间、发作史、功能损害、家族史和躯体情况的综合判断，并排除其他可能。【指南】精神检查是这个过程的核心，量表只是辅助。

一次完整的精神检查，既包括医生问什么，也包括医生观察什么：衣着、表情、语速、坐姿、眼神、对问题的反应、能否被打断、是否存在幻觉或妄想。患者自述“我很正常”与医生观察到的“语速飞快、坐不住、说到投资就停不下来”同样重要。家属提供的旁证，往往能补上患者自己没有意识到的部分。

二、精神检查通常看哪些方面

精神检查可以理解为“对当下精神状态的结构化观察”。不同医生的顺序不完全一样，但通常会覆盖以下方面：

- **外观与行为**：衣着是否整洁，动作是否异常增多或迟缓，是否有紧张症样表现。
- **言语**：语速、音量、是否话多、能否被打断、内容是否连贯。
- **情绪与情感**：自述的情绪状态，以及医生观察到的表情、语调是否与内容一致。
- **思维**：思维速度、内容是否夸大、被害、自责，是否存在思维奔逸或破裂。
- **感知**：有无幻听、幻视，是否听到不存在的声音或看到不存在的东西。
- **认知**：注意力、记忆力、定向力，是否明显受情绪或睡眠影响。
- **自知力与判断力**：是否认为自己的状态异常，是否理解治疗的必要性。
- **风险评估**：自杀、自伤、伤人、冲动、走失、物质使用等风险。

这些观察不是“医生主观臆断”，而是诊断所需的信息。比如同样是“话多”，焦虑、轻躁狂、注意力缺陷、物质使用都可能出现，医生需要结合持续时间、睡眠、功能和他人观察来判断。

三、四个常被提到的工具

工具	谁来评	主要用途	主要局限
YMRS	医生	评估躁狂症状严重度，常用于急性期和随访	不能单独确诊，混合状态和抑郁可能干扰评分
HAMD	医生	评估抑郁严重度，常用于抑	不能区分单相与双相，躯体

工具	谁来评	主要用途	主要局限
		郁研究和临床随访	症状可能抬高分数
MDQ	患者自填	筛查双相谱系线索，提示是否需要进一步评估	假阳性不少，不能凭阳性结果确诊
CGI-BP	医生	总体评估双相障碍的严重度和改善程度	偏全局印象，不能替代症状清单和病史

YMRS：躁狂严重度

Young 躁狂评定量表（Young Mania Rating Scale，YMRS）由医生根据访谈和观察评分，关注情绪高涨、活动增多、言语、思维内容、攻击性、睡眠、性兴趣、外观和自知力等。它适合衡量“这次躁狂有多重”“治疗后有没有下降”，也常用于研究。【研究】

YMRS 的局限在于：它是一个严重度工具，不是诊断工具。分数高提示躁狂症状明显，但不能说明一定是双相障碍；焦虑、激越、物质中毒、某些躯体疾病也可能让评分升高。混合状态中，抑郁症状可能让某些条目被低估，医生需要结合整体判断。

HAMD：抑郁严重度

汉密尔顿抑郁量表（Hamilton Depression Rating Scale，HAMD）由医生评分，覆盖情绪低落、兴趣减退、内疚感、自杀、睡眠、食欲、疲劳、注意力、精神运动性改变和躯体症状等。它有不同版本，临床和研究中使用方式不完全一致。【研究】

HAMD 不能区分单相抑郁和双相抑郁。它测的是“抑郁有多重”，不是“抑郁属于哪种病”。此外，失眠、食欲下降、疲劳、体重变化等条目，在躯体疾病、药物副作用或睡眠障碍中也可能得分，因此不能只看总分。

MDQ：双相筛查问卷

心境障碍问卷（Mood Disorder Questionnaire，MDQ）是患者自填的筛查工具，询问是否曾经有一段时期与平时不同，同时出现精力旺盛、话多、思维快、自信、睡眠减少、易怒、冲动等表现，以及这些表现是否同时发生、是否造成问题。【研究】

MDQ 的价值是提高警惕，不是确诊。它的敏感度较高，但特异度有限，意味着不少人会筛出“阳性”却并不是双相障碍。【研究】阳性结果只说明“值得找精神科医生详细评估”；阴性也不能完全排除双相，尤其是患者对轻躁狂缺乏记忆或不愿报告时。

CGI-BP：整体印象

临床总体印象量表—双相障碍版（Clinical Global Impressions scale for Bipolar Disorder，CGI-BP）由医生使用，分别评估抑郁、躁狂和整体病情的严重度，以及相对于基线的改善。它适合快速记录“现在整体怎么样”“治疗后变了多少”，在随访中很实用。【研究】

CGI-BP 的局限是偏全局、偏主观，不能替代详细的症状清单。不同医生的“中度”“明显改善”可能不完全一致，所以它通常与 YMRS、HAMD 或症状记录一起使用。

四、量表能做什么，不能做什么

量表最实用的地方，是**把变化变得可比较**。第一次评估的分数、复诊时的分数、睡眠和功能的记录放在一起，医生更容易判断治疗是否有效、是否需要调整。量表也能帮助研究发现规律，但不能代替临床判断。

量表不能做的事包括：不能凭一次分数确诊；不能区分所有病因；不能替代病史和家属观察；不能预测某个人一定会复发；不能用来给自己贴标签。尤其是网上的“双相测试”，题目、计分和解释都不一定可靠，结果只能当作提醒，不能当作诊断。

五、怎样配合一次高质量的精神检查

- ☐ 提前写下最早一次发作的时间、持续多久、当时的表现。
- ☐ 记录最近两周的睡眠、情绪、活动、花钱和冲动行为。
- ☐ 带上正在服用的所有药物、保健品和既往病历。
- ☐ 如果可能，请一位了解你变化的家属陪同。
- ☐ 如实回答饮酒、咖啡因、烟草和其他物质使用。
- ☐ 不隐瞒自杀念头、自伤行为或幻觉，这些都影响安全评估。
- ☐ 听不懂的量表题目可以请医生解释，不要凭猜测作答。
- ☐ 复诊时带上上次的评分记录，方便比较变化。

六、容易踩的坑

坑一：把 MDQ 阳性当成确诊。 筛查阳性只是“需要进一步评估”，不是诊断结论。

坑二：用 YMRS 或 HAMD 分数自己调药。 分数受很多因素影响，药物调整必须由医生结合整体情况决定。

坑三：为了“看起来正常”而低报症状。 隐瞒自杀念头、幻觉或冲动，会让风险评估失真。

坑四：只做量表，不做访谈。 量表是辅助工具，不能替代完整的精神检查和病史采集。

坑五：拿别人的分数和自己比。 量表分数不是成绩单，不同版本、不同评分者之间不能简单比较。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 评估过程中或评估后出现明确的自杀念头、计划或自伤行为。
- 出现幻觉、妄想、严重激越、伤人威胁，或无法照顾自己。

- 连续多日几乎不睡，伴话多、冲动、行为失控。
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、严重皮疹或走路不稳。
- 有即时危险时立即呼叫 120，必要时 110；不要独自等待评估结果。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- 量表原始文献：Young et al., 1978（YMRS）；Hamilton, 1960（HAMD）；Hirschfeld et al., 2000（MDQ）；Spearing et al., 1997（CGI-BP）.
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 3：病因与机制

双相障碍是遗传、神经生物学、昼夜节律和环境共同作用的结果，不是单一“化学失衡”。

3.1 遗传与家族风险

这一页讲三件事：双相障碍为什么在有些家族里更常见，“遗传度”这个常被引用的数字究竟在说什么，以及家里已经有人患病时，自己和孩子该怎么理解这份风险。它适合刚被诊断、正在担心“是不是我传给了孩子”的读者，也适合想弄懂家族史意义的家属。读完你大概能带走一句话：**遗传抬高的是概率，不是写好的结局；目前也没有哪种基因检测能用来预测或确诊双相障碍。**

一、医生问家族史，问的是什么

精神科初诊几乎一定会问一句：“家里有没有人得过类似的病？”这不是例行公事。家族研究反复看到同一个现象：双相障碍在一级亲属（父母、子女、亲兄弟姐妹）中比在一般人群中更常见，血缘越近，风险越高。【研究】收养研究提供了另一块拼图——被收养的孩子，患病风险更接近亲生父母一方，而不是养父母一方，说明家族聚集不只是“一起生活、一起吃饭”造成的。

但这句话有三层容易被忽略的意思。

第一层，“更常见”不等于“一定会”。 绝大多数有家族史的亲属，终身并不会发展成双相障碍。风险升高是统计层面的事；落到某一个人身上，仍然是“有可能”和“多半不会”并存。把家族史听成“迟早要发作”，既不准确，也会让人过早放弃努力。

第二层，家族史阴性非常常见。 相当多的患者是家里第一个得病的人。原因可能是上一辈的症状被当成“脾气差”“更年期”“酒喝多了”，也可能是因为在这些家庭里，环境与偶然因素占了更大比重。所以“家里没人得过”既不能排除双相障碍，也不该让人怀疑“我是不是想多了、在装病”。

第三层，家族史是诊断线索，不是判决书。 医生问它，是为了在“单相抑郁还是双相”“要不要考虑环性心境”之间多一个参考；它不能替代病史、病程和现症检查。【指南】

你可能听到的说法	更准确的理解
“这病会遗传，孩子肯定跑不掉”	亲属中风险确实升高，但多数亲属并不患病；遗传给的是概率
“家里没人得过，就跟遗传无关”	家族史阴性很常见，首次发病可以完全没有家族史
“抽个血查基因，就知道会不会得”	目前没有用于预测或确诊双相障碍的临床基因检测
“孩子变成这样，是家里没教育好”	养育方式不是双相障碍的病因；家庭氛围影响的是复发与康复

二、遗传度：一个经常被读错的数字

讨论遗传时绕不开一个词：遗传度。它来自双生子研究——同卵双生子共享几乎全部基因，异卵双生子平均共享一半。研究发现，同卵双生子中“两人都患病”的比例明显高于异卵双生子，这支持遗传对双相障碍有实质贡献。但同卵双生子也常常一个患病、一个不患病，说明基因不是全部。遗传度就是在这个背景下被估算出来的一个数。【研究】

这里有三处极容易读错的地方。

第一，遗传度是群体指标，不是个人归因。 它描述的是“在某个特定人群中，患病差异有多少可以归因于基因差异”，而不是“你的病有多少比例来自基因”。把“遗传度很高”翻译成“我这个病是基因决定的”，是典型的概念偷换。同一个疾病，在不同国家、不同年代、不同环境暴露下估出来的遗传度都可能不同——因为环境变了，能被基因解释的那部分比例也就变了。

第二，遗传度高，不等于不可改变。 近视的遗传度很高，但我们照样用眼镜矫正它。遗传度描述的是“差异从哪来”，不是“能不能干预”。双相障碍的遗传研究再深入，也不会改变一个事实：治疗有效，而且越早规范治疗，长期结局通常越好。

第三，遗传度不等于“宿命论”，也不等于“治疗无用”。 这两件事常被混在一起：有人听到“遗传”就觉得自己没救了，有人听到“遗传”就觉得“那治也没用”。前者忽略了环境与治疗的作用，后者把“病因”和“可治疗性”混为一谈。

理解遗传度的正确姿势是：它告诉你“这个病有明确的生物学基础，不是你不够坚强”，同时提醒你“基因只是剧本的一部分，怎么演还取决于别的条件”。

三、多基因：很多小效应叠加，而不是一个“双相基因”

十几年前，媒体常把某个基因说成“抑郁基因”“双相基因”。这类说法大多没有站住。早期候选基因研究样本小、重复性差，很多结果在后来的大样本中没能复制。【待验证】

现在的主流图景是“多基因”：成百上千个常见的基因变异，每一个对风险的作用都极其微小，叠加起来才形成倾向。全基因组关联研究（把大量患者的基因组与健康人比对，寻找统计学上的差异位点）确实找到了一些在不同人群中反复出现的位点，例如与钙通道、神经元结构蛋白相关的基因。【研究】这些发现帮助我们理解“神经元的兴奋性、突触怎么连接”可能参与其中，但距离“解释病因”还有很长的路。

这里要特别提醒两件事。

第一，**位点不等于病因**。找到统计学关联，只说明“这个位置附近可能有点关系”，不说明它怎么致病，更不说明能拿它做治疗靶点。

第二，**多基因风险评分目前不能用于个人**。研究者可以把成千上万个微小效应加成一个分数，在人群层面看到“高分组的患病比例更高”；但这个分数对单个人的区分能力很弱，患者与健康人的分数大量重叠。把它当成“算命”，会同时制造虚假的安心和虚假的绝望。市面上宣称能测“双相基因”的商业检测，多数缺乏临床验证，不建议购买。【待验证】

四、遗传不是命运：基因、环境与时机

最有力的一个观察还是来自双生子：基因几乎完全相同，两人却不一定同时患病。这说明基因之外，还有别的东西在决定“发不发病、什么时候发病”。

目前常用的框架是“素质—应激”：遗传给了易感性，环境决定这种易感性在什么时候、以什么形式被“点燃”。常见的触发因素包括睡眠剥夺、跨时区旅行与倒班、重大生活事件、酒精与兴奋剂、产后睡眠碎片化。这些内容在 3.4 有专门展开。

也有研究关注“表观遗传”——基因的序列没变，但基因的表达被环境、应激、睡眠和药物修饰。【待验证】这条线索很有意思，但目前还停留在研究阶段，不能拿来做检测或指导用药。

对患者和家属来说，这套说法有几个实际含义：

- **不必自责，也不必宿命。** 发病不是你“想不开”，也不是“家族诅咒”。
- **能改的部分值得改。** 睡眠、酒精、压力应对、规律复诊，是少数你能直接影响的因素。
- **早识别、早治疗有意义。** 反复发作与延误治疗和更差的长期结局相关；这不是“治不治都一样”。【指南】
- **生育决定可以讨论，不必独自扛。** 有家族史不构成“不能要孩子”的理由，但值得在孕前做一次专业评估。

五、给家人和自己的实用清单

- ☐ 复诊时主动说明三代以内的家族史，包括抑郁、自杀、酒精使用、明显情绪高涨的时期，而不只是“确诊过双相”的人。
- ☐ 不把家族史当成“注定”的证据，也不拿它当“反正治不好、不用治”的理由。
- ☐ 计划要孩子之前，安排一次孕前或遗传咨询，把药物、睡眠、产后照护一起谈。
- ☐ 孕期与产后优先保证连续睡眠，安排夜间轮班照护，识别早期信号。
- ☐ 家里有人出现连续多日睡眠需求明显减少、话多停不下来、行为突变，尽早精神科评估，不要等“自己缓过来”。
- ☐ 不购买宣称“测双相基因”“预测孩子天赋”的商业检测，也不据此调整药物。
- ☐ 把“家族里谁有过什么表现”写成几行字带去门诊，比临场回忆可靠。

容易踩的坑

- **把“遗传”当成“家教问题”的替身。** 有些家庭为了否认遗传，转而责怪父母管教；这两件事都不是病因解释。
- **把“没有家族史”当成“不用长期治疗”。** 是否需要维持治疗，看的是发作次数、严重度、既往停药后的复发情况，不是家族史。
- **把“基因检测”当成“确诊工具”。** 双相障碍的诊断仍然依靠病史与精神检查，依据 DSM-5-TR 或 ICD-11 的标准。【指南】

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在做计划、交代后事：不要独处，让信任的人陪着，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 家人出现连续数日几乎不睡、话多停不下来、冲动消费或投资、危险驾驶、伤人威胁：尽快精神科急诊评估，必要时拨打 120 或 110。
- 产后出现严重失眠、幻觉、妄想、行为紊乱或伤害婴儿的念头：按急症处理，立即急诊。
- 正在服药期间出现严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊：立即急诊，并带上药盒。

参考来源

- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.2 神经生物学：单胺、昼夜节律与线粒体

这一页解释三个最常被提到的机制：单胺（多巴胺、5-羟色胺、去甲肾上腺素）、生物钟与睡眠—觉醒节律、线粒体与能量代谢。它适合想弄明白“药为什么起效”“为什么一熬夜就容易发作”的读者，也适合被人用“你就是血清素低了”一句话打发过的人。读完你会知道：**机制解释是研究工具，不是化验单；它能帮你理解治疗方向，但不能拿来给自己下诊断，也不能当成“补一补就好”的理由。**

一、单胺假说：从“化学失衡”说起

“抑郁症是大脑里血清素不够”——这句话流传极广，也极其简化。它的源头大致有两条线索：一是早期抗抑郁药能提高突触间隙的单胺浓度，情绪随之改善；二是耗竭单胺的药物（例如老式的降压药利血平）在部分人身上会引起抑郁。【研究】

多巴胺这条线在双相里更显眼：阻断多巴胺受体的抗精神病药能控制躁狂；反过来，用于帕金森病的多巴胺激动剂、以及某些增强多巴胺的药物，可能诱发躁狂或类似躁狂的表现。【研究】这组“正反两面”的观察，是“多巴胺参与躁狂”最直观的证据。

但“血清素低”这个说法有三处不严谨。

第一，**活人的突触间隙递质浓度没法稳定测量**。我们测的是血液、尿液里的代谢产物，或者是脑脊液，这些和外显行为之间隔着好几层，不能直接换算成“你缺多少”。

第二，**药物立刻改变递质，情绪却要等几周**。如果病因只是“浓度不够”，补上就该立刻好转。这个时间差提示：真正起作用的，可能是递质下游的受体适应、信号通路和神经可塑性变化，而不只是“水位”。

第三，**双相不是单向的“低”**。躁狂期的表现更像“系统被踩了油门”：睡眠需求减少、活动增多、奖赏敏感。用一个“缺乏”模型去解释两极，往往讲不通。

机制假说	支持它的观察	它解释不了什么
单胺（5-羟色胺、去甲肾上腺素）	抗抑郁药提高单胺、耗竭单胺可致抑郁	起效延迟；为什么同一套系统既管抑郁又管躁狂
多巴胺与奖赏系统	抗精神病药控躁狂；多巴胺激动剂可诱发躁狂	为什么有些人终生只有抑郁相
谷氨酸与 GABA 平衡	部分抗惊厥药有效；磁共振波谱有异常报告	具体到个人无法测量，无法指导选药
神经可塑性下降	神经营养因子、海马体积研究报告	因果方向不明，多为横断面观察

对患者的意义在于：**你的病不是“意志薄弱”，也不是“补点血清素就好”。** 药物作用于这些系统，但它们不是维生素，不能按“缺多少补多少”来用。

二、生物钟与睡眠—觉醒节律

人体内部有一套约二十四小时的计时系统。主时钟位于下丘脑的视交叉上核，靠光照校准；它再通过体温、皮质醇、褪黑素等信号，把“现在几点”通知全身。研究还发现一组“时钟基因”参与这套节律的分子机制。【研究】

双相障碍和这套系统的关系，是机制研究里相对扎实的一块：

- **相位偏移常见**：不少患者入睡与起床时间偏晚，节律与外界时间表对不上。
- **节律不稳**：睡眠时长、起床时间、日间活动量波动大，社会节律（吃饭、上班、社交的固定时间点）容易被打乱。
- **睡眠剥夺能诱发发作**：这不是民间说法。临床观察和实验研究都报告，通宵或连续熬夜后，易感者可能在数天内出现轻躁狂甚至躁狂。【研究】
- **产后是高风险窗口**：夜间反复被叫醒、睡眠被切碎，与产后精神病性症状相关。【指南】

这也解释了一个常被误解的现象：**“睡眠需求减少”和“失眠”不是一回事。** 失眠是想睡睡不着、白天疲惫；睡眠需求减少是睡三四个小时仍然精力充沛、脑子转得快、不觉得困。后者常常是躁狂或轻躁狂的早期信号，而不是“最近状态好”。

反过来，光照也是杠杆。强光、蓝光在夜间会推迟节律；白天到户外见光、固定起床时间，则有助于把节律往前拉。光照治疗对双相抑郁有一定证据，但也存在诱发转躁的风险，必须在医生安排下进行。【研究】

三、线粒体与能量代谢

神经元是全身最耗能的细胞之一。线粒体负责生产能量分子（ATP）、缓冲细胞内钙离子、调节氧化应激。如果能量供应或质量控制出问题，神经元的兴奋性和存活都会受影响。

这条线索在双相研究里出现得越来越多：

- **磁共振波谱研究**报告患者脑内乳酸、pH、含磷代谢物与健康人存在平均差异，提示能量代谢可能改变。【待验证】
- **外周血与尸检研究**报告线粒体复合体活性、氧化应激标志物的变化，但样本通常不大，结果不完全一致。【待验证】
- **锂的作用**被一些研究认为与线粒体功能、神经营养因子有关，这为“锂为什么不止稳定情绪”提供了可能的解释。【待验证】

必须说清楚边界：这些都是群体层面的平均差异，效应量不大，研究之间也有矛盾。**它们不能用来诊断，更不能推出“吃某种线粒体营养素就能治双相”的结论。** 市面上打着“修复线粒体”“给大脑供能”旗号的补剂，多数没有在双相患者中做过像样的试验。把钱花在规律睡眠、按时复诊和必要的心理治疗上，性价比高得多。

四、机制解释的局限

理解机制的价值，和机制的局限，值得一起讲。

第一，相关不等于因果。 研究发现患者组某项指标偏高，可能是疾病造成的，也可能是药物、睡眠不足、吸烟、体重增加造成的。横断面研究（在同一时间点比较两组人）没法分辨先后。

第二，药物是最强的混杂因素。 大多数患者的脑影像和血液指标，是在服药状态下采集的。想把“疾病效应”和“药物效应”分开，需要从未用药的首发患者入手，而这样的样本很难找、往往很小。

第三，双相障碍异质性很大。 双相 I 型、II 型、快速循环、以混合发作为主的人，可能对应不同的生物学通路。把所有患者放在一起求平均，容易把彼此相反的变化互相抵消。

第四，机制很少立刻改变处方。 从“发现某个通路异常”到“开发出可用靶点”，中间要经过很多年。真正指导今天用药的，仍然是发作类型、既往反应、身体状况和指南推荐。【指南】

所以，看到“科学家发现双相障碍的新机制”这类新闻，合理的反应是：“有意思，但它会不会改变我现在的治疗？”多数时候答案是不会。这不算坏消息——说明现有的治疗框架虽然粗糙，但确实抓住了某些关键环节。

五、把机制变成日常能做的事

机制讲完，落到可操作的部分其实不多，但每一条都不难：

- ☐ **固定起床时间**，比固定入睡时间更容易做到；周末与工作日的差距尽量控制在一小时左右。
- ☐ **记录睡眠**：上床时间、入睡大概用时、夜间醒几次、起床时间、白天是否困。复诊时带上，比“最近睡得还行”有用得多。
- ☐ **跨时区或倒班前先和医生商量**，尽量按目的地时间作息，白天多到户外见光，夜间减少强光。
- ☐ **不把通宵当常态**，尤其是赶工、打游戏、追剧这类“主动熬夜”。
- ☐ **不自行用褪黑素、补剂或酒精来“调睡眠”**；需要助眠时和医生讨论。
- ☐ **区分“累”和“不困”**：连续几天睡得很少却越来越有劲，是要警惕的方向，不是好转。
- ☐ **把“最近一次发作前两周的睡眠”写下来**，很多人会发现规律。

常见问题

问：既然机制还没搞清楚，吃药是不是在“试”？ 一定程度上是。精神科用药目前仍以临床评估和试错调整为主，这也是为什么需要复诊、需要记录反应。但“机制未完全清楚”不等于“无效”；很多有效治疗的作用机制，是在使用之后才逐步被理解的。

问：是不是把睡眠调好就能减药？ 不能这样类推。规律作息能降低复发风险，是治疗的一部分，但不等于可以替代药物。减药、停药必须由医生评估，自行减量后的复发往往来得更快。

问：家里人说“你就是想太多，脑子里的化学物质乱了”？前半句是误解，后半句是过度简化。双相障碍有生物学基础，但不是“某种物质低了”这么简单，也不是靠“别想太多”能解决的。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 连续数日几乎不睡，同时话明显变多、精力异常旺盛、冲动消费或冒险行为：尽快精神科就诊，必要时急诊。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 服用抗精神病药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 突然出现剧烈头痛、肢体无力、说话含糊、抽搐：立即拨打 120，不要在家观察。

参考来源

- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.3 脑结构与神经可塑性

这一页讲影像研究在双相障碍里到底看到了什么，“神经可塑性和炎症”是怎么回事，以及一个非常重要的边界：**这些研究说的是“一群人平均而言的差异”，不能拿来给某一个人做诊断。** 它适合拿到过脑部 MRI 报告、看到“脑室扩大”“白质改变”而心里发紧的读者，也适合想弄懂“脑子是不是坏掉了”这个恐惧的家属。

一、影像研究看到的，是“平均差异”

结构性核磁共振（MRI）能在活人身上测量脑区体积、皮层厚度、白质完整性。把几十上百位患者与健康人放在一起比较，研究者报告了一些平均层面的差异：

- **侧脑室**：患者组平均略大，提示脑组织体积的相对减少。
- **前额叶与海马**：部分研究报告灰质体积或皮层厚度平均略低，海马的结果在不同研究间不太一致。
- **杏仁核**：有的研究报增大，有的报减小，方向不统一。
- **白质**：白质高信号（影像上发亮的斑点）在部分患者中更多，但这类改变与年龄、血压、血糖、吸烟、饮酒关系更密切，特异性很低。

国际上的大样本协作（把多个中心的数据合并分析）让这些结果比过去的小样本研究可靠一些，但整体效应量仍然偏小。【研究】

效应量小意味着什么？意味着患者组与健康组的分布**大量重叠**。用身高打个比方：篮球队的平均身高确实高于普通人，但你没法靠身高判断一个人是不是篮球运动员。影像指标也是这样——它能描述群体趋势，不能把某一个人“归入”患者或健康人。到目前为止，没有任何一个脑影像指标被批准用于诊断双相障碍，也没有任何“生物标志物”能替代面诊。【指南】

你可能听到的说法	实际情况
“你的 MRI 显示脑室扩大、脑萎缩”	群体平均差异很小，多数患者的数值仍在正常范围；报告需结合年龄、用药与临床一起解读
“脑区变小了，就治不好了”	体积差异与功能结局的关系并不明确；药物、睡眠、运动、训练都可能影响可塑性
“这是脑部发炎引起的”	部分患者炎症指标平均升高，但因果方向未定，也不能据此用药
“做个 PET 或功能核磁就知道有没有双相”	这些是研究工具，不用于个体诊断
“补脑的营养品能修复损伤”	没有可靠证据支持这类产品能改变双相障碍的脑改变

还有一层容易被忽略：横断面研究（在同一时间点比较两组人）**分不清原因和结果**。脑区体积偏小，可能是疾病本身造成的，也可能是长期睡眠不足、饮酒、体重增加、药物作用的结果。要分清，需要长期随访同一个人的研究，而这类研究数量有限、脱落率高。

二、神经可塑性：大脑一直在改线路

“神经可塑性”是近二十年最热也最容易被滥用的词。它的本意是：神经元之间的连接不是固定的，会随经验、学习、练习而增强或减弱。具体机制包括突触强度的变化（长时程增强与长时程抑制）、树突棘的增减、轴突髓鞘的改变，以及成年脑内是否存在新的神经元生成——最后这一条在人类身上的证据仍然有限。【待验证】

在双相研究中，可塑性这条线索主要出现在三个地方：

1. **神经营养因子**：脑源性神经营养因子（BDNF）参与神经元存活与突触生长。有研究报告患者外周血 BDNF 水平与健康人不同，且随发作状态变化，但结果并不一致。【待验证】
2. **药物与可塑性**：一些研究提示锂盐可能与灰质体积或神经营养因子水平的变化相关，这被用来解释“长期维持治疗为什么重要”。【待验证】
3. **“神经进展”假说**：认为反复发作会造成功能与结构的累积改变，发作次数越多，恢复越慢。这个假说解释了一部分临床现象，但也有研究没看到同样的趋势，属于有争议的框架。【待验证】

必须把话说透：**“神经可塑性”不是“想开点就能重塑大脑”，也不是保健品和器械的宣传依据。**它有生物学基础的部分，主要是规律运动、充足睡眠、学习与社交活动、心理治疗和药物治疗；这些都不是玄学，但也都不是速效的。

三、炎症与免疫：一条有希望但未定论的路

免疫系统与大脑之间有持续的对话。小胶质细胞是脑内的免疫细胞，能释放炎症因子，影响突触修剪与神经元功能。

研究方向大致是：急性发作期，部分患者的血液炎症指标（如 C 反应蛋白、白细胞介素-6、肿瘤坏死因子）平均升高；发作缓解后可能回落；有研究用 PET 观察脑内小胶质细胞激活，报告了差异。【待验证】

但这条线索的混杂因素特别多：

- **体重与代谢**：脂肪组织本身会分泌炎症因子，而双相患者超重比例较高。
- **生活方式**：吸烟、睡眠不足、久坐都会抬高炎症指标。
- **感染与应激**：近期感冒、牙周炎、重大压力都能改变指标。
- **药物**：部分药物本身影响免疫与代谢。

抗炎药物作为辅助治疗的试验，结果有好有坏，样本通常不大，还不足以支持“常规抗炎治疗”。【研究】更不要自行长期服用激素、抗生素或大剂量抗炎保健品——它们有实实在在的副作用。

一个常被拿来说的例子是：某些自身免疫病患者的精神症状发生率较高，提示免疫与精神症状可能相关。这类观察支持“存在一个亚组”，但**不意味着大多数双相患者的问题出在免疫上**。

四、为什么这些发现不能用于个体诊断

这一节是本文最重要的部分。

第一，诊断依据不是影像。 双相障碍的诊断依靠病史、病程、发作形式、功能变化和精神检查，标准写在 DSM-5-TR 与 ICD-11 里。【指南】影像和化验的作用是**排除其他疾病**（如脑肿瘤、甲状腺疾病、自身免疫性脑炎），不是“确认双相”。

第二，群体差异不能推个体。 一个指标在两组间的平均值不同，不代表它能分类个体。诊断试验需要敏感度、特异度、阳性预测值，而目前没有一个候选指标达到可用水平。

第三，过度解读有实际伤害。 因为“脑室扩大”而认定自己“脑子坏了、没救了”，会削弱治疗动机；因为“炎症”而自行吃抗炎药，可能伤肝伤肾；因为一份商业检测报告而换药停药，可能直接导致复发。

第四，研究报告不等于医疗建议。 论文讨论部分常写“这提示未来可能……”，这句话被媒体一转，就成了“科学家证实”。读的时候要盯住“未来可能”四个字。

五、你能做的：把注意力放在可改变的地方

- ☐ 拿到影像报告，先问放射科医生：这个发现属于正常变异、年龄相关改变，还是需要随访？
- ☐ 不因为一份“脑室扩大”“白质改变”的报告自行停药、减药或加药。
- ☐ 不购买宣称“修复脑损伤”“促进神经再生”“清除脑内炎症”的器械、补剂或疗程。
- ☐ 把有氧运动、规律睡眠、社交与认知活动当作康复的一部分，每周落实，而不是等“有心情”再做。
- ☐ 管好血管风险：血压、血糖、血脂、吸烟、饮酒。这些对大脑的影响比多数“补脑产品”确凿得多。
- ☐ 复诊时主动说记忆、注意力、反应速度的变化，让医生分辨是症状、药物、睡眠还是其他躯体问题。
- ☐ 看到“新研究”先问一句：它改变了我今天的治疗吗？多数时候答案是否定的。

容易踩的坑

- **把“研究发现”当成“我的检查结果”。** 论文里的“患者组平均”不是你的个人报告。
- **把“神经可塑性”当成“不用吃药也能自愈”。** 可塑性是机制，不是替代治疗的承诺。
- **把“炎症”当成“吃消炎药就行”。** 这里的炎症不是嗓子发炎那种炎症，用药逻辑完全不同。
- **把“脑改变”当成“智力下降”。** 多数患者的功能变化与发作、睡眠、药物副作用、社会处境的关系，比与影像指标的关系更直接。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**

- 突然出现剧烈头痛、喷射性呕吐、一侧肢体无力、说话含糊、视物成双、抽搐或意识不清：立即拨打 120，按卒中或急性神经系统急症处理，不要等门诊。
- 发热、颈项强直、畏光、意识模糊：立即急诊，警惕中枢神经系统感染。
- 服用抗精神病药后出现高热、全身肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：警惕恶性综合征，立即急诊并告知用药清单。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.4 环境与生活事件：睡眠剥夺、季节、物质

这一页讲那些“看得见、摸得着”的诱因：睡眠剥夺、跨时区与倒班、季节变化、重大生活事件，以及酒精、兴奋剂和大麻。它适合反复发作、想弄明白“这次到底为什么又犯了”的读者，也适合被家人质问“是不是你自己作出来的”的人。读完你会知道：**这些是风险因素和触发器，不是单一病因；把能改的部分管好，能降低发作概率，但不能替代治疗，也不该成为责怪谁的理由。**

一、睡眠剥夺：证据最硬的一个触发器

在各种环境因素里，睡眠与双相发作的关系是最扎实的。临床上反复看到同一条时间线：先有几晚睡不好或干脆没睡，接着情绪抬升、话变多、计划变多，然后发作。【研究】

这条线不只在观察中被记录，也被实验研究支持过——在易感者中，睡眠剥夺可以诱发轻躁狂或躁狂样表现。反过来，抑郁期常见的是睡眠增多、白天嗜睡。也就是说，**睡眠改变既可能是前兆，也可能是发作的一部分**。

要把两个容易混淆的现象分开：

现象	具体表现	意味着什么
失眠	想睡睡不着，躺很久，白天疲惫、注意力差	常见于焦虑、抑郁、药物副作用，也可能是发作前兆
睡眠需求减少	只睡三四个小时仍精力充沛，不觉得困，脑子转得快	躁狂或轻躁狂的典型信号，不是“状态好”
睡眠节律紊乱	入睡和起床时间每天差很多，白天补觉，夜间活动	节律不稳，是复发风险因素
嗜睡	睡很久仍起不来，白天大部分时间在床上	常见于抑郁相，也可能是药物镇静

产后是一个特殊的窗口：夜间反复被叫醒、睡眠被切成碎片，与产后精神病性症状相关。家里有新生儿、又有人有双相病史时，安排夜间轮班照护不是“娇气”，而是风险管理。【指南】

二、跨时区、倒班与光照

生物钟靠光照校准，也靠固定的社会时间表（吃饭、上班、社交）稳定。当外界时间表突然改变，节律要花几天到两周去适应。

- **向东飞行**通常比向西更难适应，因为需要把生物钟往前拨，而人体天然倾向于往后延。
- **倒班**，尤其是频繁轮换的夜班，会让“白天该清醒、夜里该睡”的信号反复错位。
- **夏令时切换**这类一小时的改变，对多数人影响有限，但对节律脆弱的人可能是触发点。
- **夜间强光**（手机、电脑、加班灯）会推迟节律；白天户外光照不足则让节律“抓不住”锚点。

实践上的原则很简单：**固定起床时间优先于固定入睡时间**，因为起床时间更容易人为控制，而它又能反过来拉动入睡时间。出差或旅行时，尽量按目的地时间安排第一天的起床与早餐，白天多到户外见光。

光照治疗在双相抑郁中有一定证据，但也有诱发转躁的风险，必须在医生指导下进行，不能自己买灯照。【研究】

三、季节与重大生活事件

季节模式：部分患者的发作有明显季节性，春季躁狂、秋冬抑郁的报告较多，但不是每个人都有。如果你连续几年都在同一季节出现波动，值得写进病史告诉医生。【研究】

生活事件：丧失亲友、失业、离婚、经济压力、搬迁、考试、官司——这些都可能成为触发点。有一个被广泛讨论的框架叫“点燃”（kindling）：早期发作往往需要明显的应激，随着发作次数增加，后来可能不需要那么大的刺激也能发作。【待验证】这个假说解释了一部分临床现象，但证据并不统一，不要把它理解成“发作会自己越来越容易，所以没救了”。

童年逆境：研究较一致地报告，童年期遭受忽视、虐待、家庭功能严重紊乱的人，起病更早、共病更多、病程更差。【研究】这里要特别强调：**这是风险因素，不是指责父母的证据，更不是“你小时候的事造成了这一切”的单一因果。** 讨论它的意义在于：这类经历值得被治疗（心理治疗有明确作用），而不是被拿来追责。

还有一个常被忽略的中介：**生活事件往往通过打乱睡眠来起作用。** 熬夜赶工、守夜、失眠，才是那条把压力转化成发作的常见通路。所以应对压力的具体动作，常常就是“先把睡觉保住”。

四、酒精、兴奋剂与大麻

酒精是最容易被低估的一个。它看似助眠，实际上破坏后半夜的睡眠结构，导致早醒和睡眠碎片化；它本身是中枢抑制剂，却可能加重抑郁、增加冲动和自杀风险；它还与多数精神药物相互作用，影响肝代谢和镇静程度。【指南】“喝一点好睡觉”是双相患者最常踩的坑之一。

兴奋剂包括处方药（如治疗注意缺陷多动障碍的药物）和非法兴奋剂（冰毒、可卡因等）。它们能提高多巴胺活性，可能诱发躁狂、混合状态甚至精神病性症状。处方兴奋剂不是绝对禁忌，但需要医生在双相诊断明确、心境稳定方案到位的前提下权衡。【指南】

大麻：研究较一致地报告，使用大麻与更早发病、发作更频繁、结局更差相关；高效价产品（THC含量高）风险更大。它不是“天然就安全”，也可能诱发焦虑、偏执和精神病性症状。【研究】

咖啡因与能量饮料：半衰期长，下午之后摄入容易推迟入睡；能量饮料常含大剂量咖啡因加糖，对睡眠和代谢都不友好。

面对物质使用，有用的态度不是道德审判，而是把它当成治疗的一部分：**如实告诉医生用了什么、多久一次、多少量**。隐瞒的代价是医生按“没在用”来调药，风险由患者承担。

五、风险因素叠加，不是单一病因

写到这里，最需要说清的一句话是：**没有哪一件事“害了你”。**

目前的理解是“多因素叠加”：遗传给了易感性，神经发育和节律系统决定了脆弱点，环境因素在特定时间点把风险推过阈值。同一个人在不同时期，可能因为不同原因发作；同一次发作，也可能同时有几条线索在起作用。

这也意味着两件事：**第一，不必找“罪魁祸首”**，包括不必怪自己、怪父母、怪某次熬夜；**第二，不必因为找不到原因就放弃管理**，因为可干预的因素确实存在。

- ☐ 连续两周记录：上床时间、起床时间、夜间醒几次、饮酒量、咖啡因量、白天活动量。
- ☐ 出差、旅行、考试、换班前，先把作息方案写下来，而不是到了当地再说。
- ☐ 把“这次发作前三个月发生了什么”写成一页纸，复诊时带给医生，找个人化的规律。
- ☐ 减少夜间饮酒，不用酒精助眠；需要助眠时与医生讨论。
- ☐ 下午之后不喝咖啡、浓茶、能量饮料。
- ☐ 不隐瞒物质使用，包括“偶尔抽一点”“周末喝几杯”。
- ☐ 春节、长假、婚礼、考试季这类作息容易崩的时段，提前和家里人约定“几点必须睡”。
- ☐ 若已经形成依赖，不要自行硬戒，尤其是酒精——突然停酒可能引起震颤、幻觉、抽搐，需要医疗支持。

容易踩的坑

- **“这次是因为跟人吵架，所以不用吃药。”** 触发因素和疾病本身是两回事，去掉诱因不等于不需要治疗。
- **“我熬夜没事，说明我好了。”** 熬夜后感觉良好，可能正是轻躁狂的开始。
- **“大麻是天然的，比药安全。”** 天然不等于无害，尤其对双相病程。
- **“只要作息规律，就能不吃药。”** 规律作息降低风险，但不能替代维持治疗。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 连续数日几乎不睡，同时话多、冲动消费、危险驾驶、性行为失控或出现伤人威胁：尽快精神科急诊评估，必要时拨打 120 或 110。
- 饮酒后出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 减少或停止长期大量饮酒后出现手抖、大汗、心慌、幻觉、抽搐：警惕酒精戒断，可能危及生命，立即急诊。
- 使用兴奋剂或大麻后出现幻觉、被害感、极度兴奋伴失眠：立即就医，不要独自观察。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.5 研究局限与争议

这一页不教你新的医学知识，而是给你一把尺子：看到“科学家发现双相障碍的病因”“某种营养素能修复大脑”“基因检测可提前十年预警”这类标题时，怎么判断它值不值得信。它适合想读懂研究新闻、又不想被带节奏的读者和家属。读完你会知道：**遗传、影像、炎症三类研究各自卡在哪里，以及判断一条研究含金量的几个硬指标。**

一、遗传研究：从候选基因到全基因组

遗传研究的路线换过好几代，每一代都有各自的坑。

第一代是“候选基因”研究。 研究者先认定某个基因（比如与 5-羟色胺转运体、多巴胺受体有关的基因）在生物学上说得通，然后比较患者与健康人的基因型。这类研究在本世纪初大量发表，但样本往往只有几十到几百人，重复性差；后来的大样本研究多数没能复制出稳定结果。【待验证】当年的“抑郁基因”“双相基因”新闻，大多出自这一批。

第二代是全基因组关联研究（GWAS）。 它不再预设哪个基因重要，而是把全基因组的常见变异都扫一遍，需要数万人的样本才能在统计上站住。它确实找到了一批在不同人群中反复出现的位点，效应也都很小。【研究】

GWAS 的局限同样明显：

- **效应小**：单个位点对风险的贡献极小，单独拿出来几乎没有解释力。
- **样本代表性**：绝大多数研究的参与者是欧洲血统，结果迁移到东亚人群时，位点和效应都可能不同。
- **只覆盖常见变异**：罕见变异、结构变异、非编码区的调控变化，很多没被覆盖。
- **统计显著不等于临床有用**：一篇论文能发表，不代表它能进医院。

第三代是“多基因风险评分”。 把成千上万个微小效应加成一个分数。它在研究中有价值——可以看人群层面的分层、可以做因果推断的工具——但对个人的预测力很弱。两个分数相近的人，可能一个患病一个不患病；患者与健康人的分数分布也大面积重叠。把它当算命，会同时制造虚假的安心和虚假的绝望。【待验证】

你看到的标题	研究实际说了什么	该怎么读
“发现双相障碍的致病基因”	找到一个统计学关联位点，效应极小	离“致病”和“检测”都很远
“基因检测可预测患病风险”	多基因评分在群体中有信号，个体预测力弱	目前不用于临床，不建议自费购买
“家族史阳性者风险高数倍”	相对风险升高，但绝对风险仍有限	相对风险不等于“一定会得”
“表观遗传解释了为什么同卵双生子不同”	机制假说，人体证据有限	有意思，但还不能用

二、影像研究：小样本、混杂与发表偏倚

影像研究好看、好传播，也最容易过度解读。它的问题集中在三处。

第一，样本小。 单中心研究常常只有几十人。在样本这么小的情况下，个别极端值就能把平均值拉偏。近年来国际协作（把多中心数据合并）改善了这一状况，但多数仍是横断面设计——只拍一次，无法回答“谁先谁后”。

第二，混杂因素太多。 患者组与健康组在用药、体重、吸烟、饮酒、睡眠、共病上往往系统性地不同。药物对脑结构和功能有实实在在的影响，而这些影响很难从“疾病效应”里剥离出来。理想的设计是招募从未用药的首发患者，但这样的样本稀少，随访脱落率也高。

第三，发表偏倚。 阳性结果更容易被发表，阴性结果常躺在抽屉里。这意味着你读到的文献整体上“效果”被高估了。再加上媒体偏好“突破”，一个效应量很小的研究，标题可以写成“改写教科书”。

结果是：**我们能说“双相障碍与某些脑区和连接的群体平均差异相关”，但不能说“某个影像指标可以诊断双相”。** 后者需要敏感度、特异度、阳性预测值都过关，目前没有候选指标达到这个门槛。【指南】

三、炎症研究：相关不等于因果

炎症与精神症状的关联，是近十年最热的方向之一。研究者在部分患者身上看到炎症指标升高、脑内小胶质细胞激活的迹象，也看到某些免疫性疾病患者的精神症状发生率较高。【待验证】

但这条线索的因果链条还没接上：

- **方向不明**：是炎症促成发作，还是发作、失眠、酗酒、体重增加导致炎症升高？横断面研究回答不了。
- **混杂太多**：脂肪组织本身分泌炎症因子；吸烟、感染、压力、药物都能改变指标。
- **指标不稳**：同一个人的 C 反应蛋白可以因一次感冒大幅波动，单次抽血的意义有限。
- **干预试验结果不一**：抗炎药作为辅助治疗的试验，有的报阳性，有的报阴性，样本普遍不大，还不足以支持常规使用。【研究】
- **可能的亚组**：真正受益的也许是某个特定亚群（比如伴自身免疫问题的人），把所有患者一起治，效果就被稀释了。

所以，“炎症假说”值得研究，但**不值得你现在去吃抗炎药、抗生素或大剂量保健品**。这类自行尝试有真实的肝肾功能风险。

四、怎么判断一条“新研究”的含金量

下面这张表可以直接拿去对照新闻标题。

层次	常见形式	能说明什么	分量
个案与专家观点	一位医生的经验、一个病例	提供假设	最低
动物与细胞实验	小鼠、培养皿	提示机制，不能直接推人	低
小样本横断面	几十人，只测一次	发现关联，不能定因果	偏低
大样本队列	数千人，随访多年	关联更可靠，仍非因果	中
随机对照试验	随机分组、设对照	能支持因果与疗效	高
系统综述与 meta 分析	汇总多项试验	估计总体效应	高
指南推荐	NICE、CANMAT/ISBD、中国指南	已经过专家评估与整合	最高

具体到阅读时，可以按这几个问题过一遍：

1. **样本多大、是什么人？** 二十个人的研究，和两万人的研究，能说的话完全不同。
2. **有没有对照？** 没有对照，就无法排除时间、安慰剂、回归均值的影响。
3. **有没有被重复？** 一项孤立的发现，尤其在小样本领域，很可能是偶然。
4. **效应有多大？** 统计显著（p 值小）不等于效应大；临床上有意义的差别才重要。
5. **测的是“替代指标”还是“真实结局”？** 炎症指标下降、脑区体积变化，不等于复发减少、生活质量改善。
6. **发表在哪、谁出钱？** 同行评议的期刊、声明清楚的资助方，比“某机构内部报告”可靠。
7. **是预印本吗？** 预印本没经过同行评议，可以看，但别当定论。
8. **作者有没有过度承诺？** 论文里写“未来可能”，新闻里变成“已经证实”，这是最常见的失真。

五、几条实用的怀疑与行动清单

- ☐ 先找原始论文，而不是二手转述；找不到原文的“研究”基本可以跳过。
- ☐ 看摘要里的样本量、对照设置、随访时间，再看结论。
- ☐ 记住一句口诀：**动物实验不等于人体证据，相关不等于因果，统计显著不等于临床有用。**
- ☐ 对“突破”“根治”“改写指南”“科学界震惊”这类词保持警惕。
- ☐ 看到“某补剂或某仪器改善双相症状”，先问有没有随机对照试验、有没有独立重复。
- ☐ 把感兴趣的研究带给医生讨论，**不要据此自行加药、减药或停药**。
- ☐ 关注指南更新（NICE CG185、CANMAT/ISBD、中国双相障碍防治指南），而不是单篇论文。
- ☐ 允许“目前不知道”这个答案存在；医学里很多问题的正确答案就是“证据不足”。

容易踩的坑

- **把“机制合理”当成“治疗有效”。** 一个药在理论上应该管用，和它在试验中真的管用，是两件事。
- **把“没有证据”当成“证明无效”。** 这两者不同；有些问题只是还没人好好研究。
- **把“专家说”当成“指南推荐”。** 指南是系统评估后的共识，专家观点是个体经验。

- **把“国外最新”当成“更适合你”。** 人群、医疗体系、药物可及性都不同。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 因为看到某篇研究而想停药、减药、换药：先联系开药的医生，**不要自行调整**。突然停药可能诱发躁狂、混合状态或抑郁加重。
- 已经自行停药后出现睡眠明显减少、情绪高涨、冲动行为：尽快精神科就诊，必要时急诊。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 自行服用来源不明的“补剂”“排毒方案”后出现黄疸、尿色加深、乏力、恶心：立即停用并急诊查肝功能。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 4：就医与诊断

双相障碍最常被误诊为单相抑郁。诊断的关键是主动追问“有没有过高涨/轻躁狂的时期”。

4.1 就诊渠道与首诊时机

这一页讲怀疑双相障碍时该去哪里看、什么情况要立即去急诊、如何选择适合自己的医生。它适合第一次求助、不知道该挂精神科还是心理科的患者，也适合面对家人情绪失控却不知道往哪送的家属。读完后，你应当能根据紧急程度选对渠道，少走弯路，也不把急症拖成门诊问题。

一、先判断：这是门诊问题，还是急症

双相障碍的求助场景大致分三类：**需要立即处理的安全风险、需要尽快评估的明显症状、需要长期随访的稳定期管理。** 三类对应的渠道不同，先判断紧急程度，比先纠结“挂哪个专家”更重要。

如果患者有明确的自杀计划、正在自伤、威胁伤人、持械、纵火、跳楼跳桥、极度兴奋到无法控制、出现幻觉妄想并因此恐惧或攻击、连续多日不睡不食、意识模糊或高热肌肉僵硬，这些都不是“等明天门诊”的情况。应立即呼叫 120，必要时拨打 110，或由家属陪同前往最近医院的急诊。【指南】

如果没有即时危险，但已经出现持续数天的睡眠减少、话多、冲动消费、易怒、抑郁加重或功能明显下降，应尽快看精神科，而不是先观察几周。双相障碍越早识别、越早规范评估，越有可能减少发作带来的功能损害。

二、不同渠道分别能做什么

场景	更适合的渠道	大致时机
自杀计划、伤人风险、严重兴奋或木僵	医院急诊、120/110	立即
首次出现疑似躁狂/轻躁狂	精神科门诊	尽快，数日内
抑郁反复、治疗不理想	精神科门诊	尽快预约
病情稳定、需要开药和随访	精神科门诊、社区精防	按医嘱
只有情绪困扰、无诊断需求	心理咨询/心理治疗	可预约，但不能替代诊断
想先了解资源、情绪支持	12356 心理援助热线	随时

精神科门诊是双相障碍诊断和处方的主要入口。精神科医生有诊断权和处方权，能安排必要的化验、心电图和量表评估，也能判断是否需要住院。第一次就诊不一定要找“最有名的专家”，能挂上号、能把病史讲清楚、能持续随访，往往更重要。

急诊处理的是即时安全风险。急诊医生会先保证生命安全、控制严重激越或精神病性症状，再决定是否留观或转精神科病房。不要因为“怕被贴标签”而拒绝急诊；也不要指望急诊一次就完成完整的双相诊断，急诊的首要任务是稳住危险。

社区精神卫生服务在部分地区承担随访、服药管理、康复指导和危机转介。各地资源差异很大，具体能提供什么，以当地社区卫生服务中心或精防机构公布的信息为准。社区医生不一定做首次诊断，但可以成为长期管理的支点。

心理咨询/心理治疗适合处理压力、关系、情绪调节和康复适应，但心理咨询师通常不能做医学诊断，也不能开药。如果咨询中发现明显的躁狂、精神病性症状或自杀风险，应转介精神科。把心理咨询当作“替代精神科”的路径，可能耽误诊断。

12356 心理援助热线可以提供情绪支持、危机干预和资源指引，但不能替代面诊、诊断和处方。适合在不知道该去哪、夜间情绪崩溃、需要有人听你说时使用；有即时身体危险时，仍应拨打 120。

三、什么情况要立即就诊

以下情况建议当日或尽快就诊，不要等“自己好起来”：

- 睡眠需求明显减少，连续数天仍精力旺盛，话多、活动增多。
- 突然大额消费、投资、赌博、危险驾驶、轻率性行为。
- 情绪异常高涨或易怒，与家人同事冲突明显升级。
- 抑郁加重，出现“活着没意思”、安排后事、赠送物品。
- 出现幻觉、妄想、坚信被监视或迫害。
- 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变、走路不稳。
- 饮酒或使用兴奋剂后情绪、睡眠、行为明显失控。

四、如何选择医生

选择医生时，可以看以下几个实际因素，而不是只看头衔：

1. **是否有精神科执业资质。** 双相障碍的诊断和处方需要精神科医生，不是所有“心理专家”都可以。
2. **是否有心境障碍诊疗经验。** 可以问“您平时看双相障碍多吗”，不必觉得冒犯。
3. **是否能持续随访。** 双相障碍需要长期观察，固定医生比每次换人更容易看清病程。
4. **沟通是否让你能说清楚。** 好医生会追问睡眠、冲动、发作史，也会解释为什么问这些。
5. **是否愿意纳入家属信息。** 在患者同意的前提下，家属的观察对诊断很重要。
6. **就诊是否方便。** 长期复诊的可行性，比一次“名医”更重要。

如果对诊断有疑问，可以寻求第二意见。第二意见不是“不信任医生”，而是对复杂疾病负责。带上既往病历、用药记录和家属观察，比只凭一次谈话更容易得到有价值的意见。

五、首诊前可以准备的清单

- ☐ 证件、医保卡、既往就诊卡和病历。
- ☐ 正在服用的药物清单，包括剂量、开始时间和副作用。
- ☐ 最近两周的睡眠、情绪、活动、花钱记录。
- ☐ 第一次发作的大致时间、持续多久、当时的表现。
- ☐ 家族中是否有双相、抑郁、自杀或精神疾病史。
- ☐ 饮酒、吸烟、咖啡因和其他物质使用情况。
- ☐ 一位了解情况的家属或朋友，必要时陪同。
- ☐ 想问医生的问题，写在纸上，避免当场忘记。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 有自杀计划、正在自伤，或已经准备好危险物品。
- 威胁伤人、持械、纵火、跳楼跳桥，或严重失控。
- 出现幻觉、妄想并因此极度恐惧、拒食、拒水。
- 连续多日几乎不睡，伴衰竭、意识模糊、高热或肌肉僵硬。
- 以上情况立即呼叫 120，必要时 110；不要独自运送有暴力风险的人。

六、容易踩的坑

坑一：只找心理咨询，不做精神科评估。 咨询可以帮助你，但不能替代诊断和处方，尤其是出现躁狂或精神病性症状时。

坑二：认为“不严重就不用看”。 轻躁狂也可能带来难以挽回的财务、法律和关系后果，早评估更划算。

坑三：频繁换医生。 双相障碍需要纵向观察，频繁更换会让每个人只看到片段。

坑四：因为病耻感拖到急诊。 越早求助，越可能在后果发生前把风险降下来。

坑五：把 12356 当成急诊。 热线能提供支持，但不能替代 120 和医院急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）：https://flk.npc.gov.cn/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.2 初诊准备与病史采集

这一页讲第一次看精神科前可以准备什么，以及医生问睡眠、花钱、冲动、性行为、家族史时到底在了解什么。它适合即将初诊的患者，也适合要陪家人就诊的照顾者。读完后，你应当能整理出一份具体、可用的病史时间线，而不是只带着一句“我最近情绪不好”走进诊室。

一、初诊不是考试，准备是为了少漏信息

精神科初诊通常时间有限，医生要在较短时间里了解现在的症状、过去的发作、功能变化、用药和风险。患者常因为紧张、羞耻或不知道什么重要，只讲了最近几天；家属则容易把多年积怨一股脑倒出来。两种都不理想。

更好的做法是提前写一份“病史摘要”：按时间顺序列出几次关键发作，每次持续多久、以什么表现为主、有没有诱因、有没有造成后果、用过什么治疗。不需要写成作文，几行字、一张表就可以。医生会根据它继续追问，而不是指望你一次说全。

二、带什么去

- 身份证件、医保卡、既往就诊卡。
- 既往病历、出院小结、检查报告、心理测评结果。
- 正在服用的所有药物：药名、剂量、每天怎么吃、从什么时候开始。
- 保健品、中草药、助眠药、减肥药，也要列出来。
- 最近两周的睡眠、情绪、活动、花钱记录。
- 一位了解你情况的家属或朋友，必要时陪同。
- 你想问的问题清单。
- 如果是复诊或转诊，带上前一位医生的诊断和用药调整记录。

如果记不清药名，可以拍药盒照片；如果记不清时间，可以查手机支付记录、聊天记录、就诊记录来帮助回忆。具体到“哪天开始睡不好”“哪个月刷了多少信用卡”，比“最近一直不好”有用得多。

三、医生会问什么，为什么问

问题	医生想了解什么	可以怎么准备
第一次不对劲是什么时候	起病年龄、早期表现	问家人、翻旧照片和记录
有没有特别兴奋的时期	轻躁狂/躁狂史	回忆睡眠、话多、花钱、冲动
每次持续多久	发作持续时间与诊断阈值	按时间线列出大致天数
有没有诱因	睡眠、应激、产后、药物	记录发作前一周的变化
平时功能怎么样	工作、学习、关系、自理	用具体事例说明变化
有没有自杀或伤人念头	风险评估	如实说，医生会评估安全
用过什么药，反应如何	治疗史、转躁史、副作用	带药盒、处方、病历

问题	医生想了解什么	可以怎么准备
家族里有没有类似情况	遗传与家族聚集	问父母、长辈，不猜测

关于睡眠，医生不只会问“睡几个小时”，还会问“睡了以后是否觉得恢复”“是否比平时明显少睡仍精力旺盛”。关于花钱，不只是问“有没有乱花钱”，还会问是否超出承受能力、是否隐瞒、是否造成债务。关于性行为，医生问的是冲动、风险和保护措施，不是评判道德。关于物质使用，酒精、大麻、兴奋剂、镇静催眠药都可能影响情绪和诊断，需要如实说。

四、把发作讲成一条时间线

可以按下面的结构整理：

1. **起点**：第一次明显异常大约在什么年龄、什么阶段（上学、工作、产后、换城市）。
2. **表现**：那一阵子睡眠、情绪、话量、活动、花钱、脾气、性行为、社交有什么变化。
3. **持续时间**：几天、几周还是几个月；是否几乎每天都有。
4. **功能**：还能不能上班上学，有没有请假、休学、辞职、住院。
5. **后果**：有没有债务、冲突、违法、伤害自己或别人。
6. **间隔**：两次发作之间是完全正常，还是有残留的疲劳、注意力差、情绪脆弱。
7. **治疗**：看过谁、吃过什么、有没有转躁、有没有停药。

如果只能记住一件事，就记住：**具体行为、持续时间、与平时的差别、造成的后果。** 例如“去年五月连续五天只睡两小时，讲话停不下来，刷信用卡买了两台电脑，和家人大吵，后来自己好了”比“去年有过一段亢奋”信息量大得多。

五、家属怎么补充，才不变成控诉

家属的观察对诊断很重要，尤其是患者自己不记得或不愿说的轻躁狂。补充时尽量说事实，不说人格评价：

- 把“他就是自私”换成“他以前很节省，这半年开始频繁请客，还借了钱”。
- 把“她疯了”换成“她连续三晚不睡，说要完成一个大项目，讲话比平时快很多”。
- 把“他不听话”换成“他拒绝复诊，说自己没病，我们不知道该怎么办”。

家属也可以带自己的记录：睡眠时间、消费记录、聊天截图、请假记录、既往住院材料。不要在诊室里翻旧账、互相指责，这会让患者更防御。可以提前和患者约定：“今天只讲事实，不吵架，目的是把病看清楚。”

如果患者不愿意让家属旁听，医生通常会先单独询问患者，再在患者同意的情况下获取家属信息。保密和安全需要平衡；如果存在明确的自杀或伤人风险，医生会按专业和法律要求处理。

六、初诊提问与常见误区

初诊时可以问医生的问题

- ☐ 目前最可能的诊断是什么？还有哪些可能？
- ☐ 需要做哪些检查来排除躯体原因？
- ☐ 这次是躁狂、轻躁狂、抑郁还是混合状态？
- ☐ 有没有自杀或冲动风险，需要怎么防范？
- ☐ 目前建议的治疗包括哪些部分？
- ☐ 药物可能有哪些副作用，出现什么情况要联系你？
- ☐ 下次复诊什么时候，期间出现什么情况要提前来？
- ☐ 家属可以怎样配合，哪些做法会帮倒忙？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 初诊前或等待就诊期间出现自杀念头、计划或自伤行为。
- 出现幻觉、妄想、严重激越、伤人威胁，或无法照顾自己。
- 连续多日几乎不睡，伴话多、冲动、行为失控。
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、严重皮疹或走路不稳。
- 有即时危险时立即呼叫 120，必要时 110；不要为了“等初诊”而拖延。

容易踩的坑

坑一：只讲最近几天。 双相障碍的诊断依赖纵向病程，过去的轻躁狂往往是关键。

坑二：因为羞耻隐瞒性行为、物质使用或自杀念头。 这些信息直接影响诊断和安全评估，医生需要的是事实，不是道德评判。

坑三：家属在诊室里争吵。 这会让患者更防御，也让医生难以获取信息。提前分工，一人主诉、一人补充。

坑四：带着“必须确诊双相”的目标去。 诊断需要排除其他可能，带着预设答案可能误导信息收集。

坑五：忘记带药盒和病历。 药物名称、剂量和既往反应是治疗决策的重要依据。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）：https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.3 诊断流程与鉴别诊断

这一页讲精神科医生怎样从一次次谈话、观察和检查中拼出双相障碍的诊断，以及为什么需要排除单相抑郁、环性心境、边缘型人格、ADHD、物质使用和躯体疾病。它适合刚被诊断、想理解“为什么不能靠一张表确诊”的读者，也适合被不同医生给出不同说法、感到困惑的患者。读完后，你应当能看懂诊断的基本逻辑，并知道怎样提供有用的信息。

一、双相障碍没有“一锤定音”的检查

双相障碍的诊断是临床诊断。医生依据症状、持续时间、发作性、功能损害、家族史和排除其他原因来综合判断，常用的分类系统是 DSM-5-TR 或 ICD-11。【指南】目前没有一项化验、脑影像或基因检测可以单独确诊双相障碍。做检查的目的，主要是排除甲状腺疾病、贫血、电解质紊乱、药物或物质影响等“看起来像双相”的原因。

这也解释了为什么诊断有时需要时间。一次面诊只能看到当下，而双相障碍的关键信息常常在过去：有没有过轻躁狂、每次持续多久、是否有完全缓解期、抗抑郁药后有没有转躁。医生可能需要多次随访、家属补充、既往病历，甚至观察治疗反应，才能把图像拼完整。

二、诊断流程通常包括什么

1. **主诉与现病史**：现在最困扰的是什么，持续多久，睡眠、情绪、活动、思维、冲动有什么变化。
2. **纵向病程**：第一次发作在什么时候，之后有几次，分别以抑郁、轻躁狂、躁狂还是混合为主，间隔多久。
3. **精神检查**：言语、情绪、思维、感知、认知、自知力和风险。
4. **功能评估**：工作、学习、家庭、社交、自理能力受了多大影响。
5. **家属/旁证**：他人观察到的变化，尤其是患者自己没有意识到的轻躁狂。
6. **躯体与物质排查**：甲状腺、血常规、电解质、肝肾功能、心电图等，根据情况安排。
7. **量表辅助**：YMRS、HAMD、MDQ、CGI-BP 等，用来量化严重度或筛查，不用于单独确诊。
8. **鉴别诊断**：逐一排除其他更符合的解释。
9. **形成诊断与计划**：包括分期、严重度、风险、共病和治疗目标。

诊断不是贴完标签就结束。医生通常会在病历里写明“目前考虑”“需要随访排除”，随着时间推移修正。诊断发生变化不一定意味着前面的医生“错了”，有时是因为新信息出现，或者疾病本身在演变。

三、需要鉴别的常见情况

情况	容易混淆的地方	更支持它的线索	医生会怎么做
单相抑郁	抑郁症状几乎一样	从无轻躁狂/躁狂，抗抑郁药	追问过去、家族史、治疗反

情况	容易混淆的地方	更支持它的线索	医生会怎么做
		无转躁	应
环性心境	长期情绪起伏	成人两年以上、儿童青少年一年以上，多次轻躁狂样和抑郁样期，未达完整发作	纵向记录、随访观察
边缘型人格	情绪不稳、自伤、冲动	关系、身份、被抛弃恐惧突出，波动常在数小时内	详细人格与关系史，评估共病
ADHD	话多、坐不住、冲动	童年起持续存在，非发作性，睡眠需求通常正常	童年史、量表、家属补充
物质/药物所致	兴奋、失眠、精神病性症状	与酒精、兴奋剂、激素等时间相关，停用后改善	物质史、尿检、观察停药
躯体疾病	躁狂样或抑郁样表现	甲状腺功能异常、神经系统疾病、感染等	体检、化验、影像（按需）
精神分裂症谱系	幻觉、妄想、思维紊乱	精神病性症状在情绪发作之外持续较久	纵向精神检查、功能评估
创伤后应激障碍（PTSD）	易激惹、失眠、情绪低落	明确创伤史、闪回、回避、过度警觉	创伤史、症状群评估

单相抑郁

这是最常见的鉴别对象。单相抑郁和双相抑郁在“当下”可以几乎一样，区别在于有没有过另一极。医生会追问：有没有一段时间睡得很少却特别有精神、话多、思维快、计划多、花钱多、脾气大？有没有人说过你“像变了一个人”？有没有在抗抑郁药后出现异常兴奋？如果答案都是“没有”，仍不能完全排除，因为轻躁狂可能被遗忘或被视为正常。

环性心境

环性心境不是“性格起伏大”，而是长期、反复的轻躁狂样和抑郁样症状，持续时间很长，但每次不一定达到完整发作的标准。它可能被误认为“情绪化”，也可能后来发展为完整的双相 I 型或 II 型。诊断需要长期观察，不能凭一次谈话确定。

边缘型人格障碍

边缘型人格障碍（BPD）以关系不稳定、自我形象不稳定、强烈被抛弃恐惧和冲动行为为特征，情绪波动可能非常快，常在人际冲突后出现。它与双相障碍可以共病，也可能被互相误诊。BPD 的“波动”常常在数小时到数天内随事件变化，而双相的发作通常持续数天到数周，并有睡眠、精力、活动的成组改变。两者都不是道德缺陷，需要专业评估，不宜互相贬低。

ADHD

ADHD 的注意力不集中、话多、坐不住、冲动，与轻躁狂有重叠。关键区别是：ADHD 往往从童年持续存在，表现相对稳定，不是“某一段时间突然变了”；轻躁狂是发作性的，常伴睡眠需求减少和情绪高涨。两者也可能共病，需要分别评估。

物质使用与药物

酒精、大麻、兴奋剂、可卡因、部分激素和抗抑郁药都可能引起躁狂样表现。医生会问使用时间、剂量、停用后的变化，必要时安排尿检。物质所致的精神障碍与双相障碍可以同时存在，不能因为“他喝酒”就忽略真正的双相，也不能因为“他有双相”就不处理物质问题。

躯体疾病

甲状腺功能亢进可表现为心悸、失眠、易激惹、活动增多；甲状腺功能减退可表现为抑郁、疲劳、注意力下降。贫血、电解质紊乱、肝功能异常、神经系统疾病、感染、睡眠呼吸暂停等也可能影响情绪和精力。医生会根据病史和体检安排化验，而不是给每个人都做一套“全套检查”。

四、诊断需要时间，也需要你提供线索

如果医生暂时没有给出明确诊断，不代表在敷衍。双相障碍的诊断需要纵向证据，尤其是轻躁狂。你可以做的是：

- ☐ 记录每次发作的起止时间、主要表现和持续时间。
- ☐ 记录睡眠、活动、花钱、冲动、性行为的变化。
- ☐ 列出所有药物、保健品和物质使用。
- ☐ 请家属补充他们观察到的“像换了一个人”的时期。
- ☐ 带上既往病历、化验、量表和外院诊断。
- ☐ 询问医生目前的诊断假设、还需要排除什么。
- ☐ 如果诊断长期不明确，寻求第二意见，而不是频繁换医生。
- ☐ 在诊断未定时，先处理最紧迫的安全和症状问题。

五、容易踩的坑

坑一：认为“量表高分就是确诊”。 量表是辅助工具，诊断需要病史、功能和排除其他原因。

坑二：把边缘型人格当成“假双相”。 两者可以共病，也可以互相误诊；贬低任何一方都不利于治疗。

坑三：因为一次“没有轻躁狂”就排除双相。 患者可能遗忘、否认，或把轻躁狂当成正常。需要家属补充和长期随访。

坑四：忽略甲状腺、物质和药物。 这些因素既可能模仿双相，也可能让双相更难控制。

坑五：诊断一变就否定全部治疗。 诊断修正后，医生会重新评估方案，既往的治疗经验仍然有价值。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 诊断等待期间出现自杀念头、计划或自伤行为。

- 出现幻觉、妄想、严重激越、伤人威胁，或无法自理。
- 连续多日几乎不睡，伴话多、冲动、行为失控。
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、严重皮疹或走路不稳。
- 有即时危险时立即呼叫 120，必要时 110；不要等诊断明确后再处理。

参考来源

- American Psychiatric Association. *DSM-5-TR*, 2022.
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.4 共病筛查与躯体检查

这一页讲双相障碍常合并哪些问题、为什么初诊和用药前要做躯体检查，以及这些检查结果该怎么理解。它适合刚被诊断、拿到一叠化验单不知道看什么的患者，也适合担心“吃药伤身体”的家属。读完后，你应当能分清“诊断双相”和“排查躯体原因”是两件事，并知道哪些基线信息值得长期保存。

一、为什么双相障碍还要查身体

双相障碍是精神科诊断，但情绪、睡眠、精力和思维的变化，也可能由躯体疾病或物质引起。甲状腺功能异常、贫血、电解质紊乱、感染、神经系统疾病、睡眠呼吸暂停、酒精或兴奋剂使用，都可能让人看起来像躁狂、抑郁或混合状态。医生安排检查，不是为了“证明你想太多”，而是为了排除这些可治疗的原因。

另一方面，双相障碍的常用药物可能影响体重、血糖、血脂、肝功能、肾功能、甲状腺、心脏电活动或血细胞。用药前建立一个基线，之后才知道变化是药物引起的，还是本来就存在。基线不是“走形式”，而是长期安全监测的起点。【指南】

需要说明：目前没有一项化验能确诊双相障碍。甲状腺功能正常，不代表没有双相；甲状腺功能异常，也不代表一定不是双相。检查结果是拼图的一块，不是判决书。

二、常见的精神科共病

双相障碍与其他精神障碍共病并不少见。共病会让症状更复杂、自杀风险更高、治疗更困难，但并不意味着诊断错了。关键是把每个问题都评估清楚，而不是用一个诊断解释全部。

共病	可能的重叠表现	评估重点
焦虑障碍	紧张、失眠、心悸、回避	是否发作性、是否与情绪发作同步
ADHD	注意力差、话多、冲动	童年起是否持续、是否发作性
创伤后应激障碍（PTSD）	易激惹、失眠、闪回、警觉	创伤史、回避、过度警觉
物质使用	失眠、兴奋、抑郁、冲动	使用种类、频率、停用后的变化
进食障碍	暴食、催吐、体重波动	进食行为、体像、电解质
强迫症	反复思维、重复行为	是否自我不协调、是否耗时间
人格障碍	关系不稳、自伤、冲动	起病、持续性、人际模式

焦虑

焦虑和双相抑郁经常同时出现。焦虑可能表现为担心、坐立不安、心慌、出汗、回避社交。需要区分的是：焦虑是独立的持续问题，还是只在情绪发作时加重。治疗上，某些抗焦虑药可能有依赖风险，需要医生评估，不能自行长期使用。

ADHD

ADHD 与轻躁狂都可能话多、坐不住、冲动。区别在于 ADHD 通常从童年持续存在，表现相对稳定；轻躁狂是发作性的，常伴睡眠需求减少、情绪高涨和功能突然改变。两者可以共病，评估时需要童年史和家属补充。

创伤后应激障碍（PTSD）

创伤后应激障碍会出现闪回、噩梦、过度警觉、回避和易激惹，容易被误认为双相的情绪波动。询问创伤史需要安全和信任，患者不必在第一次就诊时讲出所有细节，但可以告诉医生“我有过创伤经历，有些事我还不想说”。

物质使用

酒精、大麻、兴奋剂、镇静催眠药都可能影响情绪和睡眠。物质使用既可能诱发躁狂或抑郁，也可能掩盖症状、干扰治疗。医生问得细，不是为了指责，而是因为酒精戒断、兴奋剂作用和药物相互作用都会影响安全。

三、常见的躯体检查

检查方向	为什么考虑	常见项目	注意
甲状腺	甲亢可似躁狂，甲减可似抑郁	甲状腺功能、抗体（按需）	锂盐长期使用也需监测
血常规	贫血、感染、血小板	血红蛋白、白细胞、血小板	丙戊酸盐等需关注血小板
代谢	体重、血糖、血脂	身高体重、腰围、血压、空腹血糖、血脂	抗精神病药需定期复查
肝肾功能	药物代谢与安全	转氨酶、肌酐、尿素氮、电解质	有肝病、肾病者需个体化
心脏	心悸、晕厥、心脏病史	心电图（按需）、心率血压	有心脏电活动异常风险或心脏病史时更重要
神经系统	震颤、走路不稳、意识改变	神经系统查体，必要时影像	排除器质性原因和药物反应
孕产相关	育龄女性用药安全	妊娠试验（按需）、孕产计划	丙戊酸盐有致畸风险，必须讨论
睡眠	打鼾、白天嗜睡	睡眠史、睡眠监测（按需）	睡眠呼吸暂停可加重疲劳

这些项目不是每个人都全部做。医生会根据年龄、性别、症状、既往史、用药计划和当地条件选择。比如没有心脏病史的年轻人，不一定需要常规心电图；有晕厥、心悸或家族史的人，则需要更积极评估。反过来，即使检查正常，也不能排除双相障碍。

四、用药前基线：值得长期保存的资料

- ☐ 身高、体重、腰围、血压、心率。
- ☐ 血常规、肝功能、肾功能、电解质。
- ☐ 空腹血糖、糖化血红蛋白、血脂（根据年龄和风险）。

- ☐ 甲状腺功能，尤其是计划使用锂盐或已有甲状腺问题。
- ☐ 心电图（根据心脏史、年龄、合并用药）。
- ☐ 育龄女性的妊娠试验和孕产计划讨论。
- ☐ 既往药物过敏、副作用和不良反应史。
- ☐ 饮酒、吸烟、咖啡因和其他物质使用。
- ☐ 家族中的甲状腺、糖尿病、心脏病、肾病和精神病史。

把结果拍照或存进一个文件夹，复诊时带上。不同医院、不同时间的化验单放在一起，医生才容易看出趋势。不要因为一次结果正常就认为以后都不用查；也不要因为一次轻微异常就自行停药。

五、共病与躯体问题该怎么处理

原则是：**先保证安全，再分清主次，最后整合治疗。** 如果甲状腺功能明显异常，需要先处理甲状腺问题；如果存在酒精戒断风险，不能简单劝“别喝了”；如果抑郁伴自杀风险，共病评估不能拖延危机干预。

治疗上，医生会考虑药物相互作用、代谢风险、肝肾功能、心脏风险和孕产计划。患者可以主动提供信息，但不要自行调整药物。心理治疗、物质戒治、睡眠管理、运动与营养支持，也属于整体方案的一部分。

几类常用药的安全底线

- **锂盐**：需要按医嘱监测血锂、甲状腺和肾功能；脱水、持续呕吐腹泻、发热、低盐饮食或合并用药都可能增加中毒风险。出现严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识改变，应立即急诊。
- **丙戊酸盐**：可能影响肝功能、血氨、胰腺、血小板和体重；育龄女性及孕期有致畸风险，不能自行使用或停药，孕前必须与医生讨论。
- **拉莫三嗪**：皮疹可能进展为严重皮肤反应；出现发热、口腔溃疡、眼红、起疱或脱皮，应怀疑严重药物反应，立即停药并急诊；加量必须由医生缓慢安排。
- **抗精神病药**：可能引起锥体外系反应、迟发性运动障碍、代谢问题、心电图改变或神经阻滞剂恶性综合征；不要自行突然停药。

六、容易踩的坑

坑一：认为“化验正常就没有精神病”。 双相障碍没有确诊性化验，正常结果只排除部分躯体原因。

坑二：认为“有甲状腺问题就不是双相”。 两者可以同时存在，甲状腺异常也可能加重情绪症状。

坑三：忽略物质使用。 酒精和兴奋剂会干扰诊断、治疗和预后，需要如实告知。

坑四：用药前不查基线。 没有基线，之后出现体重、血糖、肝功能变化时很难判断原因。

坑五：看到说明书上的副作用就自行停药。 副作用需要监测和处理，突然停药可能引起复发或撤药反应。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、严重皮疹、眼红、口腔溃疡或起疱脱皮。
> - 出现严重手抖、走路不稳、反复呕吐、腹泻、明显乏力或意识模糊。
> - 心悸、胸痛、晕厥、呼吸困难，或心跳异常快而不规则。
> - 自杀念头、自伤行为、伤人威胁，或极度兴奋无法控制。
> - 以上情况立即联系医生或去急诊；有即时危险时呼叫 120，必要时 110。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder：https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 5：药物治疗

双相障碍的药物治疗核心是心境稳定，而不是“只治抑郁”。抗抑郁药的使用尤其需要谨慎。

5.1 心境稳定剂总览

这一页把双相障碍最常用的几类药放在同一张地图上：锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪、卡马西平、抗精神病药，各自擅长什么、最需要盯什么、在什么阶段出场。它适合刚拿到处方、想弄明白“为什么给我开这个”的患者和家属。读完你会知道：**它们不是同一种药的不同牌子，选择取决于发作类型、病程、身体状况和既往反应；个体差异很大，具体用药以面诊医生的处方为准。本页不写任何剂量。**

一、“心境稳定剂”是一组角色，不是一类化学结构

“心境稳定剂”这个说法容易让人误会，以为它们属于同一类药、作用方式类似。实际上，被归入这个称呼的药物，化学结构、作用靶点、副作用谱差别很大：锂是一种元素离子，丙戊酸盐和卡马西平原本是抗癫痫药，拉莫三嗪也是抗惊厥药，而多种抗精神病药在双相障碍中被证明有“稳定情绪、预防复发”的作用。

更麻烦的是，“稳定”这两个字本身就有争议。理想中的心境稳定剂应该能**治疗急性躁狂、治疗急性抑郁、预防躁狂复发、预防抑郁复发**这四件事都做到。现实中没有哪种药四项全优：

- 有的药抗躁狂强，抗抑郁弱；
- 有的药主要防抑郁复发，对急性躁狂几乎无效；
- 有的药急性期好用，长期维持的证据相对薄；
- 有的药要靠联合用药才能覆盖两极。

所以医生开药时，脑子里想的不是“哪个药最强”，而是“这个人的发作模式是什么、现在处于哪个阶段、最怕哪种风险”。【指南】

二、五种角色的分工

药物 / 类别	主要角色	最需要盯的安全问题	一句话提醒
锂盐	急性躁狂（可单用或联用）、长期维持、自杀风险降低	血锂浓度、肾功能、甲状腺、脱水与中毒	治疗窗窄，监测是治疗的一部分
丙戊酸盐	急性躁狂、混合发作、部分人的维持治疗	肝功能、血氨、胰腺、血小板、体重、致畸	育龄女性必须提前讨论
拉莫三嗪	双相抑郁、预防抑郁复发	皮疹（可进展为重症药疹）	加量必须慢，由医生安排，不能自己加
卡马西平	急性躁狂、维持、部分快速	药物相互作用、血常规、肝	强肝酶诱导剂，会影响很多

药物 / 类别	主要角色	最需要盯的安全问题	一句话提醒
	循环	功能、低钠、皮疹	其他药
抗精神病药	急性躁狂与混合、双相抑郁、维持治疗	代谢（体重、血糖、血脂）、锥体外系反应、迟发性运动障碍、心电图 QT、恶性综合征	有效，但不能突然停

几条读表时容易漏掉的信息：

锂盐是少数被反复证明能降低自杀风险的药物之一，这也是它在指南里长期占据重要位置的原因。【指南】但它的治疗窗窄——有效浓度与中毒浓度离得近，所以必须定期抽血，并在脱水、发热、呕吐腹泻时特别小心。

丙戊酸盐对急性躁狂和混合发作起效较快，临床上用得多；代价是肝功能、血氨、胰腺、体重、血小板这一串需要盯的项目，以及育龄女性与孕期的高致畸风险。这部分在 5.3 会详细展开。

拉莫三嗪的位置比较特殊：它对急性躁狂基本无效，甚至可能让躁狂加重，但对双相抑郁和抑郁复发预防有价值。它的核心风险是皮疹，极少数会发展成 Stevens-Johnson 综合征或中毒性表皮坏死松解症，因此加量必须非常缓慢。**这一点没有捷径，也不能因为“想快点好”而自行加量。**

卡马西平是老牌抗惊厥药，对躁狂有效，但它是强力的肝酶诱导剂，会加速很多药物（包括口服避孕药、部分抗凝药、其他精神药物）的代谢，导致“别的药突然不管用了”。此外要关注血常规（粒细胞缺乏）、肝功能、低钠血症和皮疹；在汉族人群中，用药前通常会做 HLA-B*1502 基因筛查以评估重症药疹风险。【指南】

抗精神病药在双相障碍里不是“只治精神病”，而是实实在在的心境稳定治疗组成部分：急性躁狂、混合发作、双相抑郁、长期维持都有适应证。代价是代谢副作用、锥体外系反应和迟发性运动障碍、QT 间期延长、恶性综合征等，需要定期称体重、查血糖血脂、评估不自主运动。

三、按分期选药：医生脑子里在想什么

阶段	治疗目标	常见选择方向
急性躁狂	尽快控制兴奋、冲动、失眠，防止伤人毁物	抗精神病药为主，可联用锂盐或丙戊酸盐；极严重者考虑住院或电休克
混合发作	同时压住躁与郁，重点防自杀与冲动	丙戊酸盐、抗精神病药常用；抗抑郁药通常避免
双相抑郁	改善抑郁，同时不诱发转躁	锂盐、拉莫三嗪、部分抗精神病药；抗抑郁药慎用并需联合稳定剂
维持期	预防两极复发，恢复功能	锂盐仍是重要选项；拉莫三嗪偏重防抑郁；按既往反应个体化
快速循环	减少发作频率，避免加重循环	常需联合用药，尽量避免抗抑郁药；证据整体偏弱

这张表只是“方向”，不是处方。同样是急性躁狂，一个人可能用抗精神病药单药就稳定，另一个人可能需要联合；同样是维持期，有人用锂盐多年平稳，有人因为肾功能或甲状腺问题改用别的方案。**分期决定思路，个体决定具体药物。**

四、个体差异：为什么不能照抄别人的方案

“我同事吃这个特别好，我也想吃”——这是门诊里最常见也最危险的要求之一。药物选择要考虑的因素至少有这些：

- **发作类型与既往反应**：过去哪种药有效、哪种药引起过转躁或严重副作用，比任何理论都重要。
- **发作频率与严重度**：一年发作多次的人，维持治疗的强度要求不同。
- **身体状况**：肾功能、肝功能、甲状腺、心脏（心电图）、体重与代谢指标。
- **年龄**：老年人对镇静、跌倒、低钠、锂中毒更敏感，通常需要更保守的策略。
- **合并用药**：降压药、利尿剂、止痛药、抗生素都可能与心境稳定剂相互作用。比如某些止痛药和利尿剂会影响锂的排泄。
- **生育计划**：育龄女性用丙戊酸盐需要特别谨慎；孕期用药要精神科与产科共同评估。
- **物质使用**：酒精、大麻、兴奋剂会改变病程和药物代谢。

还有一点常被忽略：**药物基因组学目前能常规用的场景很有限。** 除了卡马西平前的 HLA-B*1502 筛查这类明确有指南支持的检测，其他“基因选药”多数还停留在研究阶段，不建议据此自行换药。【待验证】

五、开始治疗前后，可以照做的事

- ☐ 记住自己吃的每一种药的**通用名**（不是商品名），写下来或拍照存手机。
- ☐ 复诊时带上药盒或用药清单，包括保健品、中药、止痛药。
- ☐ 不自行加量、减量、隔天吃或停药；漏服后按医生事先交代的办法处理，不要一次补双倍。
- ☐ 按医生安排做基线检查：体重、腰围、血压、血糖血脂、肝肾功能、甲状腺、心电图（按需）。
- ☐ 记录副作用：手抖、困倦、体重变化、月经变化、皮疹、腹泻、心悸，写清出现时间。
- ☐ 准备怀孕或已经怀孕，第一时间告诉医生，不要自行停药。
- ☐ 不把“别人吃得好”当成换药理由，也不用“别人吃坏了”吓自己。
- ☐ 给药物一点时间：多数心境稳定剂需要数周才能看出维持效果，副作用往往先出现。

常见问题

问：是不是一旦开始就要吃一辈子？不一定。但“要不要长期吃”取决于发作次数、严重度、停药后复发的历史，而不是个人意愿。反复停药是复发最常见的诱因之一。减停必须在医生指导下缓慢进行。【指南】

问：副作用这么大，能不能先只吃一种？单药治疗是很多人的起点，也是合理的策略。但是否能单药，取决于发作模式和控制情况；联合用药不等于治疗失败，而是覆盖不同环节。

问：中药或保健品能不能替代？不能。目前没有可靠证据支持任何保健品可以替代心境稳定剂；部分中药成分还可能影响肝酶或与西药相互作用。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 服锂盐后出现严重手抖、走路不稳、反复呕吐腹泻、意识模糊、抽搐：可能是锂中毒，立即急诊查血锂。
- 服丙戊酸盐后出现眼黄、尿色加深、右上腹痛、持续呕吐、极度乏力、意识改变：警惕肝损伤或高氨血症，立即就医。
- 服拉莫三嗪后出现皮疹，尤其伴发热、口腔溃疡、眼红、皮肤起疱或脱皮：立即停药并急诊，警惕重症药疹。
- 出现高热、全身肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.2 锂盐

锂盐是双相障碍治疗里最老、也最特殊的一个药：它便宜、证据厚、能降低自杀风险，同时治疗窗窄、需要长期抽血监测，一不小心就可能中毒。这一页讲清楚它适合谁、监测什么、哪些日常情况会把安全的人推向中毒，以及“长期吃到底值不值”。它适合正在服锂盐、准备开始服锂盐，或家里有人在服锂盐的读者。**本页不写剂量，也不写血锂浓度目标，这些必须由医生个体化决定。**

一、锂盐是什么，谁适合

锂是一种天然存在的元素。二十世纪中期，澳大利亚医生 Cade 偶然发现锂盐能让躁狂的动物安静下来，随后它被用于精神科，成为第一个真正意义上的心境稳定剂。今天临床上用的是碳酸锂、枸橼酸锂等盐类，起作用的都是锂离子。

锂盐在双相障碍里的位置，主要有四块：

- **急性躁狂**：可以单用，也常与抗精神病药联用。对典型的情感高涨型躁狂，效果往往比混合状态好。【指南】
- **长期维持**：这是锂盐最强的证据所在。多项随机试验和汇总分析显示，维持期使用锂盐能显著降低复发风险，对躁狂和抑郁两个相位都有预防作用。【指南】
- **双相抑郁的辅助治疗**：单用起效较慢，但常作为“打底”的稳定剂，防止抗抑郁治疗引发转躁。
- **自杀风险降低**：这是锂盐区别于其他药物的一点，后面单独讲。

哪些人更容易从锂盐获益？临床上观察到一些“反应好”的特征：发作呈典型的“躁狂—抑郁—缓解”节律、发作间期功能恢复较好、有双相家族史、没有快速循环、没有物质使用问题。【临床经验】反过来，快速循环、混合发作频繁、有明显肾或甲状腺问题、难以配合抽血监测的人，医生可能会优先考虑别的方案。

还要说清一点：**锂盐不是“最后的选择”，也不是“过时的老药”。** 在多个国际指南里，它仍然是一线维持治疗选项之一。【指南】

二、血锂监测与身体监测：这不是可选项

锂盐最需要被理解的一点是：**它的有效浓度和中毒浓度离得很近。** 换句话说，能治病的量，和能伤人的量，中间的安全余量不大。这就是为什么服锂盐的人必须定期抽血。

血锂监测。 抽血有时间要求——通常在末次服药后一段时间采血，测的是谷浓度（下一次吃药前的最低点）。如果抽血时间不对，结果会误导医生。医生会为每个人设定一个目标区间，并根据发作情况、副作用、年龄、肾功能调整。**这个区间因人而异，不要拿别人的数值对照自己。**【指南】

监测频率大致是：开始服药或调整剂量后需要较密集地复查，稳定之后转为定期复查，通常每几个月一次；出现脱水、发热、呕吐腹泻、加用新药时，要提前复查。具体节奏由医生安排。

肾功能。 锂完全经肾脏排泄。长期使用可能影响肾小管的浓缩功能，表现为**多尿、夜尿增多、总是口渴**；少数人长期下来会出现肾功能的缓慢下降。因此需要定期查肌酐、估算肾小球滤过率，也要避免长期同时使用可能伤肾的止痛药。

甲状腺。 锂会干扰甲状腺激素的合成，可能引起甲状腺功能减退、甲状腺肿大，表现为怕冷、乏力、便秘、体重增加、情绪低落、反应变慢。这些症状容易和抑郁复发混淆，所以定期查促甲状腺激素（TSH）很重要。发现甲减通常可以通过补充甲状腺素处理，不必因此停锂，但需要医生判断。

其他：血钙（锂可能引起甲状旁腺功能亢进、血钙升高）、体重、心电图（尤其老年人或有心脏病的人）、育龄女性的妊娠试验。

监测项目	多久看一次（大致）	主要想发现什么
血锂浓度	起始与调量后较密，稳定后定期	是否在安全区间、是否接近中毒
肌酐 / eGFR	定期	肾功能下降、浓缩功能受损
TSH、甲状腺	定期	甲减、甲状腺肿大
血钙	定期或按需	高钙血症、甲状旁腺问题
体重、血压	每次复诊	体重增加、代谢变化
妊娠试验	育龄女性按需	孕期用药需要重新评估

三、脱水、发热与锂中毒：最需要记住的一课

锂靠肾脏排出，而肾脏排锂的速度，受体内**水和盐**的状态影响很大。当身体缺水或缺钠时，肾脏会拼命回收钠，顺带把锂也回收了——血锂就升上去了。

常见的“推手”包括：

- **发热、出汗多：**感冒发烧、夏天户外工作、桑拿、热瑜伽。
- **呕吐、腹泻：**胃肠炎、食物中毒、旅行者腹泻。这是最常见的诱因之一。
- **吃得太淡或突然严格限盐：**低盐饮食、减肥断食、只喝白水不进食。
- **大量出汗后只补水不补盐：**马拉松、长时间高温作业。
- **合并用药：**某些止痛药（如布洛芬等非甾体抗炎药）、部分降压药（如普利类、沙坦类）、利尿剂、某些抗生素，都会抬高血锂。
- **肾功能变化：**脱水、老年、原有肾病。

中毒的表现是有层次的，越早识别越安全：

阶段	常见表现	该怎么做
早期	明显口渴、多尿、食欲差、恶心、腹泻、**细颤变成粗大的手抖**	停用下一次锂盐并尽快联系医生，查血锂
进展	走路不稳、说话含糊、头晕、嗜睡、肌肉抽动、呕吐加重	立即就医，不要在家补水观察
急症	意识模糊、抽搐、高热、少尿、昏迷	立即拨打 120，按急症处理

要特别区分两种手抖：**细小的、拿杯子时轻微抖**，可能是常见的副作用；**粗大的、幅度明显、影响写字和端碗**，尤其伴随走路不稳、呕吐、反应变慢，就要按中毒处理。宁可白跑一趟。

还有一个容易被忽视的场景：**夏天旅游**。高温、出汗、喝水不规律、饮食变咸变淡、时差打乱服药时间，几件事凑在一起，是锂中毒的高发组合。出门前和医生对一遍“发热、腹泻、吃不下饭时怎么办”，比临时慌张有用得多。

四、长期获益与自杀预防：证据有多硬

锂盐最值得说的，是它在**降低自杀风险**上的证据。多项汇总分析报告，长期使用锂盐的人群，自杀死亡和自杀未遂的比例低于不用锂盐的对照人群；一些在地区层面做的生态学研究也观察到，与锂的可得性相关的指标变化，与自杀率变化相关。【研究】

但要把证据的分量说准：

- 这些研究很难做到完美的随机对照（不可能让人随机“不吃锂”多年），所以存在选择偏倚的可能。
- 效果在不同研究间大小不一，但方向比较一致。
- 它**不能理解成“吃锂就不会自杀”**。自杀风险来自多方面，需要配合随访、心理治疗、手段限制和家庭支持。【指南】

除了自杀预防，锂盐的长期价值还体现在：减少复发次数、延长发作间期、可能降低发作后的功能损害。有研究提示长期锂治疗与较低的痴呆风险相关，但这属于观察性研究的发现，不能当成“吃锂防痴呆”的依据。【待验证】

代价也要摆出来：手抖、口渴多尿、体重增加、痤疮、甲状腺功能减退、肾功能影响，以及“必须定期抽血”这件麻烦事。很多人因为这些副作用自行停药，结果在几个月内复发。**停药的决定要在医生指导下缓慢进行，不能突然停。** 突然停锂后复发（尤其躁狂）的风险是明确存在的。【指南】

孕期是另一个必须提前讨论的问题。锂在孕早期与某些先天性心脏畸形（如 Ebstein 畸形）的风险升高相关，虽然绝对风险不高，但需要精神科与产科共同评估，权衡“停药复发的风险”和“继续用药的风险”。**不能自行停药，也不能自行继续。**【指南】

五、日常清单与就医边界

- ☐ 随身携带一张卡片或手机备忘录，写明“我在服锂盐”、剂量、开药医生和紧急联系人。
- ☐ 固定时间服药，用手机闹钟；漏服后按医生事先交代的办法处理，**不要一次吃双倍**。
- ☐ 每天喝够水，不要等到口渴才喝；高温、运动、出汗多时更要主动补水，并适当补充电解质。
- ☐ 不自行严格限盐、断食减肥或长期只喝白水。
- ☐ 发烧、呕吐、腹泻、吃不下饭时，**先联系医生**，通常需要暂停下一次服药并尽快查血锂。
- ☐ 加任何新药（包括止痛药、抗生素、中药、保健品）之前，告诉医生或药师你在服锂盐。

- ☐ 按预约抽血，抽血时间按医生要求，不要随意改动。
- ☐ 记录手抖、口渴、夜尿、体重、怕冷乏力等变化，复诊时逐条说。
- ☐ 不因为“最近感觉挺好”就自行减量或停药。
- ☐ 准备怀孕、已经怀孕或正在哺乳，第一时间告知医生。

容易踩的坑

- **“多喝水就行”**：光补水不补盐，在大量出汗后反而可能稀释性低钠，间接抬高血锂。补水要配合正常饮食。
- **“手抖是正常的，忍忍就好”**：细颤可以观察，粗颤加走路不稳必须就医。
- **“血锂正常就没事”**：抽血时间不对、近期脱水、肾功能变化，都可能让单次结果失真。
- **“锂盐伤肾，早点停”**：不监测才伤肾；规范监测下，多数人可以长期安全使用。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现粗大手抖、走路不稳、说话含糊、反复呕吐腹泻、嗜睡或意识模糊：**立即急诊查血锂**，不要在家观察。
- 高热、抽搐、少尿、昏迷：立即拨打 120。
- 发热、呕吐、腹泻、明显吃不下饭超过一天：尽快联系开药医生，按医嘱暂停或调整。
- 出现严重甲状腺症状（明显怕冷、水肿、极度乏力）或肾功能异常报告：尽快复诊。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.3 丙戊酸盐

丙戊酸盐在双相障碍里出场频率很高，尤其在急性躁狂和混合发作时；它起效相对快，但也带着一串需要认真对待的风险：肝损伤、高氨血症、胰腺炎、体重增加、血小板下降，以及育龄女性绕不开的致畸问题。这一页把这些风险讲清楚，帮你在复诊时知道该问什么、该盯什么。**本页不写剂量；所有用药调整必须由医生决定，不能自行加减或停药。**

一、丙戊酸盐是什么，用在哪

丙戊酸盐（包括丙戊酸、丙戊酸钠、双丙戊酸钠等不同盐型）原本是抗癫痫药，后来被发现对躁狂有效，逐渐成为心境稳定剂的一种。它同时用于偏头痛预防，所以在神经内科也很常见。

在双相障碍里，它的位置大致是：

- **急性躁狂**：对情感高涨、活动增多、话多、易激惹有较好的控制作用，起效速度常快于锂盐。【指南】
- **混合发作**：这是它比较有优势的场景。抑郁与躁狂症状同时存在、冲动与自杀风险高时，丙戊酸盐是常用选项之一。【指南】
- **维持治疗**：有一定证据，但整体不如锂盐扎实；很多情况下是“急性期用得好，就继续用”，或与锂盐、抗精神病药联用。【研究】
- **双相抑郁**：不作为首选，单用对抑郁相的效果有限。

它不适合所有人：有肝病、尿素循环障碍、不明原因的脑病、血小板明显偏低、胰腺炎病史的人，通常要避免或格外谨慎。【指南】

二、肝功能与高氨：两条不同的危险路径

丙戊酸盐最严重的风险在肝脏和氨代谢，而这两条路径**不是一回事**，容易被混为一谈。

第一条：肝损伤。 丙戊酸盐经肝脏代谢，转氨酶轻度升高很常见，多数是一过性的，不需要立刻停药。但极少数人会发生严重的药物性肝损伤，甚至肝功能衰竭。风险较高的情况包括：婴幼儿（尤其两岁以下）、先天性代谢病（如线粒体病、尿素循环障碍）、同时使用多种抗癫痫药、原有肝病、严重营养不良。【指南】

肝损伤的早期信号不典型，容易被当成“感冒”或“胃肠炎”：**持续恶心、食欲明显下降、极度乏力、右上腹不适、尿色变深像浓茶、眼白或皮肤发黄**。出现这些，不要等下次复诊。

第二条：高氨血症。 丙戊酸盐会干扰氨的代谢，使血氨升高。关键在于——**血氨升高时可以没有肝功能异常**，转氨酶可能是正常的。这解释了为什么有些人“肝功能报告挺好”，却出现反应变慢、嗜睡、说话含糊、走路不稳、性格改变。严重时会出现意识模糊甚至脑病。

高氨血症的诱因包括：剂量偏高、同时使用其他抗癫痫药、肉碱缺乏、营养不良或长期素食、合并感染、尿素循环障碍（很多人终生不知道自己有）。【研究】

风险	早期信号	该做什么
肝损伤	恶心、食欲差、极度乏力、右上腹痛、尿色深、眼黄	立即停用并急诊查肝功能，不要等复诊
高氨血症	嗜睡、反应慢、说话含糊、走路不稳、性格改变、呕吐	立即就医查血氨，即使肝功能正常也要查
胰腺炎	上腹剧痛、向背部放射、反复呕吐、发热	立即急诊，禁食，不要自行吃止痛药硬扛
血小板下降	容易淤青、牙龈出血、鼻血、皮肤瘀点	尽快查血常规，避免自行服用阿司匹林等
体重增加	食欲增加、腰围变大、体重上升	记录体重，复诊讨论饮食与运动方案

三、胰腺炎、体重、血小板与其他常见问题

胰腺炎是罕见但可能致命的并发症，儿童和青少年风险相对更高。典型表现是上腹部持续剧痛、向背部放射、弯腰时稍缓解、伴恶心呕吐。它可以在用药几个月甚至几年后才出现，所以“吃了很久都没事”不代表可以放松警惕。一旦怀疑，处理原则是立即停药并急诊。

体重增加是最影响长期依从性的副作用之一。丙戊酸盐常带来食欲增加、体重上升、腰围变大，进而影响血糖、血脂和胰岛素敏感性。这不是“意志力问题”，而是药物作用。可以做的：定期称体重和量腰围、减少含糖饮料、保持规律运动、复诊时把体重变化如实说出来，由医生判断是否需要调整方案。

血小板减少与剂量相关，表现为容易淤青、刷牙出血、流鼻血、皮肤出现小红点。需要定期查血常规；如果同时服用影响凝血的药物（如阿司匹林、部分止痛药），要提前告知医生。做手术、拔牙、胃肠镜活检前，也要说明自己在服丙戊酸盐。

其他常见副作用：手抖（震颤）、困倦、头晕、恶心、脱发（多为弥漫性，停药后常可恢复）、月经改变、多囊卵巢样表现。这些多数可以管理，但不建议自己忍着了事——记录下来，复诊时逐条说。

药物相互作用里有两条特别重要：

1. **与拉莫三嗪联用**：丙戊酸盐会显著抬高拉莫三嗪的血药浓度，使重症药疹（Stevens-Johnson 综合征、中毒性表皮坏死松解症）的风险上升。因此两药联用时，拉莫三嗪的加量必须更慢，由医生严格安排。**这是“不能自己加量”的典型场景。**【指南】
2. **与碳青霉烯类抗生素联用**：这类抗生素会让丙戊酸盐的血药浓度大幅下降，可能诱发抽搐或情绪不稳。需要抗感染治疗时，务必告诉医生你在服丙戊酸盐。

四、育龄女性与孕期：最需要提前谈的风险

这是丙戊酸盐最需要被反复强调的部分。

丙戊酸盐是已知致畸风险最高的心境稳定剂之一。 孕期暴露与神经管缺陷、先天性心脏畸形、唇腭裂、尿道下裂等风险升高相关；更值得注意的是，孕期暴露还与子代神经发育问题相关，包括认知发育水平偏低、孤独症谱系障碍风险升高。【指南】【研究】

因此，多个国家的监管机构与指南都提出了严格的使用条件：**育龄女性除非没有其他合适选择，否则不应使用丙戊酸盐；使用前必须充分告知风险，采取有效的避孕措施，并由专科医生定期复核。** 这套要求常被称为“孕期预防计划”。【指南】

对中国的读者，具体做法上可以记住这几条原则：

- **计划怀孕前就要谈**，而不是怀上了才说。理想情况是在备孕阶段由精神科与产科共同评估，看是否可以换成其他药物、如何缓慢过渡。
- **不要自行停药**。突然停用丙戊酸盐可能导致躁狂复发，而复发本身对母亲和胎儿同样危险。
- **不要自行继续**。是否继续用、用多久、孕期如何监测（如产科超声、母血筛查等），需要个体化决策。
- **意外怀孕要尽快就诊**，不要因为害怕被责怪而拖延。
- **避孕是治疗的一部分**。使用丙戊酸盐的育龄女性，应与医生讨论可靠的避孕方式；丙戊酸盐本身不降低口服避孕药效果（这一点与卡马西平不同），但仍需个体化确认。
- **男性用药**：目前证据不支持父亲使用丙戊酸盐会显著增加子代风险，但仍建议在备孕时告知医生。【待验证】

五、日常清单与就医边界

- ☐ 记住自己用的是哪种盐型（丙戊酸、丙戊酸钠、双丙戊酸钠），不同盐型的实际含量不同，换药时不能想当然等量替换。
- ☐ 开始用药前完成基线检查：肝功能、血常规、体重、必要时血氨；育龄女性做妊娠试验。
- ☐ 按医生安排定期复查肝功能、血常规、血氨（按需）和体重。
- ☐ 不饮酒，或至少把饮酒量降到最低——酒精与丙戊酸盐叠加，会增加肝损伤风险。
- ☐ 不自行服用其他抗癫痫药、止痛药、抗生素、中药或保健品；新增任何药物前先问医生或药师。
- ☐ 手术、拔牙、侵入性检查前，主动告知医生在服丙戊酸盐（涉及出血风险）。
- ☐ 记录体重与腰围，每月一次，复诊带上。
- ☐ 育龄女性：与医生讨论避孕方案；一旦计划怀孕或发现怀孕，尽快就诊。
- ☐ 出现嗜睡、反应变慢、说话含糊，即使肝功能正常，也要想到血氨。
- ☐ 不因为“体重涨了”“手抖”就自行停药，先和医生讨论替代方案。

容易踩的坑

- **“肝功能正常，就说明没问题。”** 高氨血症可以独立于肝功能出现，这是最容易被漏掉的一种情况。

- **“吃了两年都没事，以后也不会有事。”** 胰腺炎、肝损伤可以在长期用药后出现。
- **“怀孕了赶紧把药停掉最安全。”** 突然停药带来的复发风险，可能比药物风险更直接；必须在医生指导下决策。
- **“别人吃这个没事，我也加一点。”** 丙戊酸盐与拉莫三嗪等药物的相互作用很强，自行加量可能带来重症药疹。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现眼黄、尿色深如浓茶、右上腹持续疼痛、反复呕吐、极度乏力：警惕肝损伤，**立即停用并急诊查肝功能**。
- 出现嗜睡、反应迟钝、说话含糊、走路不稳、性格明显改变：警惕高氨血症，立即就医查血氨。
- 出现上腹剧痛并向背部放射、频繁呕吐、发热：警惕胰腺炎，立即急诊，不要自行服用止痛药掩盖症状。
- 出现不明原因的淤青、牙龈出血、鼻血不止、皮肤瘀点：尽快查血常规。
- 服药期间发现怀孕，或计划怀孕：尽快联系精神科与产科，**不要自行停药**。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.4 拉莫三嗪

拉莫三嗪是一种常被用来“守住下限”的心境稳定剂：它对正在发作的躁狂几乎没有控制力，却比较擅长减少双相障碍的抑郁复发。这一页讲清它适合谁、为什么必须慢慢加量、皮疹到底该怎么判断，以及它和哪些药、哪些情况会“打架”。读完你至少能和医生讨论三件事：我为什么用这个药、我该盯哪些副作用、出现皮疹时第一步做什么。

一、它在双相障碍里的位置

拉莫三嗪最早是抗癫痫药，后来被发现能减少双相障碍的抑郁发作，于是成为心境稳定剂家族的一员。所谓心境稳定剂，是指能让情绪的高峰和低谷都不那么容易出现的一类药，它们的作用方式是“降低发作概率、减轻发作幅度”，而不是“立刻让人开心”。这一点对拉莫三嗪尤其重要：它起效慢，通常要几周甚至更久才能看出对情绪的稳定作用，不能拿它当救急药。【指南】

它的主要位置是**维持期预防抑郁复发**。CANMAT/ISBD 2018 指南把拉莫三嗪列为双相障碍维持治疗的一线选择之一，特别适合那些“躁狂不重、但抑郁反复来”的人，例如不少双相 II 型患者。【指南】对急性双相抑郁，它有一定辅助作用，但单靠它把一次正在进行的抑郁发作拉起来，效果通常不如喹硫平等抗精神病药，所以更多是“配合使用”。【研究】

反过来，急性躁狂和混合发作不是它的战场。没有可靠证据支持用拉莫三嗪单药去压住一次躁狂，医生也不会这样安排。如果有人说“吃拉莫三嗪能治躁狂”，这句话至少是不准确的。

使用场景	拉莫三嗪的位置	说明
预防抑郁复发	一线选择之一	需要长期服用才体现价值【指南】
急性双相抑郁	辅助、二线	起效慢，单药力度有限【研究】
急性躁狂或混合发作	不用它单药控制	没有可靠证据【指南】
快速循环	证据有限	可试用，但不能承诺效果【待验证】
双相 II 型抑郁反复	常见选项	需与医生讨论获益与皮疹风险【临床经验】

二、为什么一定要慢慢加量

拉莫三嗪最让人紧张的不良反应是皮疹，而皮疹风险和“加得太快”直接相关。身体需要时间适应这个药，血药浓度一下子升得太高，免疫系统更容易出现皮肤反应。所以医生会从一个很小的剂量开始，隔比较长的时间才往上加一次，整个加量过程可能持续数周甚至更久。这个节奏不是医生保守，而是用无数例严重药疹换来的经验。【指南】

以下几件事会明显增加皮疹风险，值得逐条对照：

- **加量过快、起始量偏高**：自己觉得“效果不够”就多吃半片，是最常见的诱因。

- **同时使用丙戊酸盐**：丙戊酸盐会让拉莫三嗪在体内的浓度明显升高，皮疹和手抖的风险都上升，医生通常会因此把加量节奏放得更慢。
- **以前吃别的药起过药疹**，或有药物过敏史。
- **漏服一段时间后，自己按原来的量接着吃**：这一点最容易被忽略。停药几天后身体对药物的耐受已经下降，直接恢复原剂量相当于“快速加量”。如果漏服超过几天，先问医生要不要重新从小剂量开始，不要自己补。
- **合并病毒感染**（比如感冒、发热）期间开始加量，皮疹更容易和感染疹混在一起，判断变难。

还有一个现实问题：拉莫三嗪起效慢，很多人吃到第二三周觉得“没感觉”，就想加快速度。这时最该做的是把感受告诉医生，而不是自己调整。**慢，是这个药安全使用的一部分。**

三、皮疹：普通药疹还是危险信号

吃拉莫三嗪的人里，出现某种皮疹的并不算少，其中绝大多数是良性的、可以消退的药疹。但少数会进展为 Stevens-Johnson 综合征（SJS）和中毒性表皮坏死松解症（TEN）——这两种是可能危及生命的严重皮肤反应，皮肤会像被烫伤一样大片起疱、剥脱。早期表现常常只是发热、口腔溃疡、眼睛发红，很容易被当成“上火”或感冒。区别它们，是每个服药者和家属都该掌握的一课。

表现	普通药疹	需要立即急诊的药疹
分布	躯干、四肢散在红点或小丘疹	面部、口腔、眼睛、生殖器等黏膜部位也受累
形态	红斑、丘疹，可能有痒	水疱、大疱、皮肤成片发暗、开始脱皮
伴随症状	一般没有明显发热	发热、咽痛、眼红畏光、口腔溃烂、面部或嘴唇肿胀
进展	几天内相对稳定或逐渐消退	数小时到一两天内迅速扩大、疼痛明显

还有一种需要认识的反应叫 DRESS（药物反应伴嗜酸性粒细胞增多和全身症状），通常在用药后几周出现，表现为发热、皮疹、面部水肿、淋巴结肿大，还可能累及肝、肾、血液系统。它不像 SJS 那样“看起来吓人”，但同样可以很重。

处理原则要记牢：

- **只是少量皮疹、没有发热、没有黏膜受累**：尽快联系开药医生，由医生判断是否停药、是否需要查血。不要自己一边吃一边观察一两周。
- **出现发热、口腔溃疡、眼红、起疱、脱皮、面唇肿胀、呼吸困难中的任何一项**：立即停用拉莫三嗪，直接去急诊，并告诉接诊医生“我在吃拉莫三嗪、什么时候开始加的量”。不要等预约、不要先吃抗过敏药顶着。
- **不要自行把药加回去**。严重药疹后是否能再次使用，必须由专科医生评估，很多人会就此禁用。

四、相互作用：哪些药会让浓度升高或降低

拉莫三嗪本身不太干扰肝脏代谢酶，所以它对其他药的影响相对小，这是它的优点。但反过来，很多药会影响拉莫三嗪的浓度，其中最重要的几个必须知道。

合用的药或情况	对拉莫三嗪的影响	需要注意什么
丙戊酸盐	浓度明显升高	皮疹、手抖、头晕风险上升，医生会放慢加量
卡马西平、苯妥英、苯巴比妥、利福平	浓度下降	可能疗效不足，需要医生评估
含雌激素的避孕药、激素替代治疗	浓度可能下降	停药间歇期浓度会回升，情绪和副作用可能波动
锂盐、奥氮平	影响较小	仍要观察镇静、头晕等叠加效应
酒精、大麻	不改变浓度，但叠加镇静和判断力下降	治疗期尽量不用

对女性来说，还有两个绕不开的话题。**避孕药**：含雌激素的复方口服避孕药会加快拉莫三嗪的清除，让浓度偏低；而在每盒药的停药间歇期，浓度又会回升。有些人会发现“吃药那三周情绪稳、停药那几天反而烦躁或起疹”，这值得和医生讨论，而不是自己换药。**怀孕与哺乳**：孕期拉莫三嗪的清除率会逐渐上升，血药浓度可能下降到孕前的几分之一，产后又迅速回升，所以孕前、孕期和产后都需要重新评估和监测，不能沿用孕前的方案不变。哺乳期进入乳汁的量相对不多，但早产儿、新生儿的情况特殊，需要儿科和产科一起看。【指南】

五、日常怎么吃、怎么记

拉莫三嗪一天吃一次还是分两次、饭前还是饭后，按医生和说明书的安排执行即可，关键是**固定**。固定时间吃药，能减少血药浓度的大起大落，也让你更容易发现“漏了没有”。

可以照做的清单：

- ☐ 把服药时间绑在一个每天必做的动作上，比如刷牙后、早饭时。
- ☐ 在手机里设提醒，并准备一份“漏服了怎么办”的书面说明，是医生或药师写的。
- ☐ 加量期间，每周拍一次皮肤照片存档，出现变化时能说清“从哪天开始、哪里先起”。
- ☐ 记录睡眠时长和情绪走向，尤其是“话变多、睡得少还很有精神、易怒”这类信号。
- ☐ 每次看诊带上所有正在吃的药、保健品和避孕药，让医生核对相互作用。
- ☐ 换厂家、换剂型时告诉医生，并在换后几周留意皮疹和情绪变化。
- ☐ 计划怀孕、已经怀孕或准备哺乳，提前说，不要等到产检时才提。
- ☐ 不自行加量、减量、停药；不把拉莫三嗪当成“情绪不好就加半片”的救急药。

常见副作用大多是轻微和暂时的：头晕、看东西重影、嗜睡或失眠、头痛、恶心、手抖。手抖在合用丙戊酸盐时更常见。少数人会出现易激惹、坐立不安，这类变化常被误认为“病情本身”，其实可能是药物反应，值得记录后反馈。极少数情况下会出现无菌性脑膜炎（头痛、发热、脖子发硬、怕光）、血液系统异常或肝功能异常，出现相应症状要就医查因。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 皮疹同时有发热、口腔溃疡、眼睛红痛、皮肤起疱或脱皮、面唇肿胀、呼吸困难；
- 剧烈头痛伴发热、脖子发硬、怕光、呕吐（警惕无菌性脑膜炎）；
- 意识模糊、抽搐、尿量明显减少、皮肤或眼白发黄；
- 出现自杀念头、自伤行为，或情绪突然转向极度兴奋、整夜不睡、行为失控。

尽快联系开药医生（当天或次日）：

- 新出现皮疹，但没有上面这些危险信号；
- 加量后头晕、复视、手抖明显，影响走路或工作；
- 连续几天漏服，或不确定该怎么恢复；
- 情绪变得易怒、话多、睡得少但精力旺盛（可能是转躁的早期信号）；
- 开始或停用避孕药、抗癫痫药、抗生素等可能相互作用的药；
- 计划怀孕、已怀孕或准备哺乳。

常见问题

“起疹子是不是就一定很严重？” 不是。多数是良性药疹，但“多数”不等于“可以自己赌”。判断权在医生，你要做的是及时报告、及时就诊，并把危险信号记牢。

“起过一次疹子，以后还能再用吗？” 由医生判断。轻微药疹在密切观察下有时可以再用，严重药疹（SJS/TEN、DRESS）通常终身禁用。不要自己试着“再吃一点看看”。

“情绪稳定了，能不能停？” 拉莫三嗪的价值就在长期维持，突然停可能让抑郁复发。停药要由医生安排，通常需要逐渐减量，并配合睡眠和复诊计划。

“为什么医生让我和丙戊酸盐一起吃？” 这个组合在临床上有使用，但丙戊酸盐会抬高拉莫三嗪浓度，所以加量要更慢、观察要更密。不是不能一起用，而是不能按常规速度加。

“漏了一两天怎么办？” 偶尔漏一次，想起来就补，但不要一次吃双份。漏了几天，不要自己按原量恢复，先问医生。**这条规则比“补不补”更重要。**

“吃了两个月还没效果，是不是没用？” 它的作用是减少未来的抑郁发作，不是立刻提升情绪。评估需要时间，也需要看整个疗程里发作的频率和严重度，而不是某一天的心情。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.5 卡马西平与其他抗惊厥药

卡马西平是最早被用来治疗双相障碍的药物之一，但今天它更多出现在“二线”“特殊情况”和“药物相互作用”的讨论里。这一页讲清卡马西平现在还能做什么、为什么它几乎和所有药都“打架”、需要查哪些指标，以及奥卡西平和其他抗惊厥药到底有没有位置。读完你能判断：医生给我开这个药，是出于什么考虑；我该盯哪些风险。

一、卡马西平现在的位置

卡马西平原本是抗癫痫药，20 世纪后半叶被用于躁狂和维持治疗，曾经是锂盐之外的主要选择。它通过稳定神经细胞的钠通道，降低异常放电和过度兴奋，对躁狂、混合状态有一定控制作用，对部分快速循环的人也可能有帮助。但和锂盐、丙戊酸盐相比，它的证据基础薄一些，副作用和相互作用又多，所以今天的指南通常把它放在二线，或用在锂盐、丙戊酸盐效果不好、不能耐受的时候。【指南】【临床经验】

它和拉莫三嗪的分工不太一样：拉莫三嗪偏向“防抑郁”，卡马西平偏向“控躁狂、稳混合”，但它对抑郁发作的预防作用不如锂盐和拉莫三嗪。对混合特征明显、情绪像“又烦又冲动”的人，有些医生会考虑它，但这属于个体化判断，不是标准答案。

场景	卡马西平的位置	说明
急性躁狂、混合状态	二线	有效，但起效和耐受性不如一线方案【指南】
维持治疗、预防复发	二线	对抑郁复发的预防弱于锂盐【指南】
快速循环	可考虑	证据有限，个体差异大【待验证】
锂盐或丙戊酸盐无效/不耐受	替代选项	需要评估相互作用和监测条件
双相抑郁急性期	不作为首选	抗抑郁作用证据不足

二、为什么它几乎和所有药都“打架”

卡马西平是肝脏药物代谢酶的强力“诱导剂”。可以把肝脏想象成一条处理药物的流水线，卡马西平会让这条流水线加速运转，于是很多同时吃的药被更快地分解掉，血药浓度下降，疗效跟着打折。受影响的范围非常广：避孕药、抗凝药、部分抗精神病药、部分抗抑郁药、抗癫痫药、抗生素、免疫抑制剂，甚至一些中草药。这也是它今天使用减少的主要原因。

更麻烦的是“自身诱导”：刚开始吃药的头几周，卡马西平会诱导自己的代谢，血药浓度自己往下掉。所以早期查浓度看起来“够”，过一阵可能就不够了，医生需要重新评估。这不是药“失效”，而是体内处理它的速度变了。

同时使用的东西	可能发生什么	怎么办
复方口服避孕药	避孕效果下降，可能突破性出血	需要额外避孕方式，和医生/妇科一起

同时使用的东西	可能发生什么	怎么办
		定
华法林等抗凝药	抗凝效果下降	必须监测凝血指标，不能自己调
多种抗精神病药、抗抑郁药	对方浓度下降，疗效变差	由医生评估是否调整，不要自行加量
锂盐	神经系统毒性风险增加	有手抖、走路不稳、意识改变要急诊
红霉素、部分抗真菌药、葡萄柚	卡马西平浓度升高，头晕、复视、走路不稳	避免同用或由医生调整
丙戊酸盐	相互影响，浓度和副作用都变复杂	需要更密切的临床观察
酒精、大麻	镇静叠加、判断力下降	治疗期尽量不用

这张表说明一件事：**吃卡马西平的人，任何新加的药、保健品、草药，都应该先让医生或药师过一遍。** 包括药店随手买的感冒药、止痛药和“助眠”产品。

三、必须盯的检查

卡马西平的问题常常不是“吃下去马上不舒服”，而是悄悄发生的。所以规律复查不是走形式。

- **血常规**：最需要警惕的是粒细胞缺乏和再生障碍性贫血，虽然罕见，但可以很凶险。持续发热、咽痛、口腔溃疡、反复感染，要立刻查血常规，不要当成普通感冒。
- **肝功能**：卡马西平可以引起肝酶升高和药物性肝损伤。出现乏力、恶心、食欲下降、皮肤或眼白发黄、尿色变深，要尽快就诊。
- **血钠**：它会引起抗利尿激素分泌异常，导致低钠血症，老年人更常见。表现是头痛、恶心、乏力、注意力差、走路不稳，严重时会抽搐、意识模糊。很多人以为是“年纪大了”或“抑郁加重”，其实是血钠低了。
- **心电图**：卡马西平可能影响心脏传导，有心脏病、晕厥史、心跳慢的人，用药前和用药中要评估。
- **血药浓度**：在怀疑不依从、疗效变化、加用新药、出现毒性表现时，查浓度很有价值。
- **骨密度与维生素 D**：长期使用可能影响骨代谢，绝经后女性、老年人、长期不晒太阳的人要和医生讨论。
- **HLA-B*1502**：这是和卡马西平严重皮肤反应（SJS/TEN）相关的基因标记，在汉族人群中携带率相对较高。国内外药品说明书和专业共识建议汉族等东亚人群在开始卡马西平前做这项检测，阳性者通常应避免使用。【指南】

清单：

- ☐ 用药前确认是否做过 HLA-B*1502 检测，结果记在用药本上。
- ☐ 记下最近一次血常规、肝功能、血钠、心电图的日期。
- ☐ 发热、咽痛、口腔溃疡超过两天，先查血常规，不要硬扛。
- ☐ 新加任何药、保健品、中草药前，问一句“和卡马西平有没有相互作用”。
- ☐ 女性用复方避孕药时，和医生确认避孕方案是否可靠。
- ☐ 记录走路不稳、复视、头晕加重的出现时间，复诊时说明。

- ☐ 不自行加量、减量、停药；癫痫患者突然停药还可能诱发抽搐。

四、奥卡西平和其他抗惊厥药

奥卡西平是卡马西平的“后代”，结构相近，但诱导肝酶的作用弱得多，所以药物相互作用比卡马西平少，这是它的主要优势。代价是：它引起低钠血症的比例更高，皮疹风险仍在，而且和卡马西平存在交叉过敏——对卡马西平起过严重皮疹的人，通常也不宜用它。它在双相障碍中的证据比卡马西平更少，指南里很少把它列为常规心境稳定剂，更多是“需要抗癫痫作用、又想减少相互作用”时的个体化选择。【临床经验】【待验证】

加巴喷丁和普瑞巴林常被用于焦虑、失眠、神经痛，有些人吃了觉得“情绪平稳”，但它们没有被证实是心境稳定剂，不能替代锂盐、丙戊酸盐或抗精神病药。普瑞巴林还有滥用和依赖风险，尤其在有物质使用史的人身上要谨慎。

托吡酯有时被用来对抗抗精神病药引起的体重增加，或辅助控制冲动，但它本身不是心境稳定剂，常见副作用是认知变慢、找词困难、手脚麻、肾结石和代谢性酸中毒。把它当成“减肥药”长期自行服用，不划算。

药物	在双相中的位置	主要监测与风险
卡马西平	二线心境稳定剂	血常规、肝功能、血钠、心电图、HLA-B*1502
奥卡西平	个体化替代，证据有限	血钠、皮疹、交叉过敏
加巴喷丁/普瑞巴林	不作心境稳定剂	镇静、水肿、滥用风险
托吡酯	辅助减重或控制冲动	认知减慢、肾结石、酸中毒

五、特殊人群要单独讨论

育龄女性与孕期：卡马西平有致畸风险，包括神经管缺陷和颅面部畸形，风险低于丙戊酸盐，但绝不是“安全”。奥卡西平的数据更少。计划怀孕的人要在孕前就和精神科、产科一起评估，讨论是否换药、如何补充叶酸、孕期是否监测浓度，**不能自己停药，也不能自己换药**。哺乳期同样需要个体化评估。【指南】

老年人：低钠血症、跌倒、认知影响、心脏传导问题都更突出，合并用药也更多，开始用药和调整时宜更慢，复查更勤。

肝肾功能不全：卡马西平主要经肝代谢，肝功能差的人风险更高；奥卡西平及其代谢物经肾排泄，肾功能不全时要特别注意低钠和蓄积。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即去急诊或拨打 120：**

- 皮疹伴发热、口腔溃疡、眼红、皮肤起疱或脱皮、面唇肿胀（警惕 SJS/TEN）；
- 高热、咽痛、口腔溃烂、皮肤瘀点瘀斑、牙龈或鼻子出血（警惕粒细胞缺乏或血小板减少）；
- 皮肤或眼白发黄、尿色深、持续呕吐、意识模糊（警惕肝损伤）；
- 剧烈头痛、恶心呕吐、走路不稳、抽搐、意识改变（警惕严重低钠血症）；
- 心悸、胸闷、晕厥、心跳很慢（警惕心律失常）；
- 手抖加重、走路不稳、说话含糊，尤其在同时使用锂盐时。

尽快联系医生（当天或次日）：

- 新出现皮疹但没有上述危险信号；
- 持续发热、乏力、食欲明显下降；
- 血钠、肝酶、血常规复查结果异常；
- 需要加用任何新药（包括抗生素、止痛药、中草药）；
- 月经紊乱、突破性出血，或怀疑避孕失败；
- 计划怀孕、已怀孕或准备哺乳；
- 情绪转向兴奋、话多、睡得少，或抑郁明显加重。

常见问题

“卡马西平是不是被淘汰了？” 没有。它在特定情况下仍然有用，尤其是在需要同时控制癫痫、或对其他心境稳定剂不能耐受时。但它需要更多的监测和更小心地管理相互作用，所以不再是首选。

“为什么医生让我先查基因再吃药？” 查的是 HLA-B*1502，用来评估严重皮肤反应的风险。这个检测只需要抽一次血，但对汉族人来说很有价值。

“血钠低是不是多喝水就好？” 不是。低钠血症的处理要看原因和程度，严重时需要限制液体甚至静脉用药。自己猛喝水或猛喝盐水都可能出事，先就医。

“能不能用卡马西平代替锂盐？” 两者作用谱不同。卡马西平对躁狂有效，但对抑郁复发和自杀风险的预防证据不如锂盐。替换要由医生根据你的发作类型决定。

“吃药期间能喝酒吗？” 不建议。酒精会加重镇静、影响走路和判断，也可能诱导或抑制代谢，让浓度更不稳定。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.6 非典型抗精神病药

非典型抗精神病药是双相障碍治疗里用得最多的一类药，从急性躁狂到双相抑郁、从发作期到维持期都能见到它们。但“常用”不等于“随便吃”：体重、血糖、血脂、手抖、坐立不安、心脏节律，都是需要长期盯住的事。这一页按类别讲清它们各自的特点、常见副作用怎么识别，以及什么时候必须停下来找医生。读完你能看懂处方上为什么是这一个药，而不是另一个。

一、它们不是“镇静药”：作用与类别比较

“非典型抗精神病药”这个名字容易误导。它们不是把人镇住的安眠药，而是通过调节多巴胺和5-羟色胺等神经递质，降低躁狂的兴奋度、减少幻觉妄想、稳定情绪。所谓“非典型”，是相对于老一代抗精神病药而言，指锥体外系反应相对少一些，但并不等于没有副作用。它们起效不像镇静药那样“一片就困”，控制躁狂通常需要几天到一两周，预防复发则需要长期服用。【指南】

在双相障碍里，它们的位置大致有三块：**急性躁狂和混合发作**（可以单用，也常和锂盐或丙戊酸盐联用）、**双相抑郁**（部分药物有明确证据）、**维持治疗**（减少复发，尤其是躁狂复发）。不同药物的证据和副作用谱差别很大，不能互相随意替代。

药物	双相中的主要场景	代谢/体重风险	EPS 与催乳素风险
喹硫平	躁狂、双相抑郁、维持	中到高	较低
奥氮平	躁狂、维持、与氟西汀联用治双相抑郁	高	较低
利培酮	躁狂、混合	中	较高，催乳素升高明显
阿立哌唑	躁狂、维持、抑郁辅助	较低	中等，可有静坐不能
齐拉西酮	躁狂	较低	中等，QT 间期风险需注意
鲁拉西酮	双相抑郁（部分地区获批）	较低	中等，静坐不能

表格只是大致倾向，个体差异很大，以处方和你的实际反应为准。还有一些药在部分地区可用，可及性因城市和医院而异；氯氮平在双相障碍中不是常规用药，只在难治性病例由专科医生评估，并且必须定期查血常规。

二、代谢：最容易被忽视的长期代价

抗精神病药最常见的长期代价不是“手抖”，而是体重增加、血糖升高和血脂异常。奥氮平和喹硫平的代谢风险相对突出，阿立哌唑、齐拉西酮、鲁拉西酮相对轻一些，但这种“相对”不能当成保证——有人吃阿立哌唑也长体重，有人吃奥氮平变化不大。

为什么这件事重要？因为体重、血糖、血脂异常会实实在在增加糖尿病、脂肪肝、心血管疾病的风险，而双相障碍患者本来就更少运动、更容易有不良饮食和睡眠问题。更麻烦的是，这些变化早期没有

感觉：体重涨几公斤、腰围大一圈，人不会痛；血糖慢慢升高，也不会立刻不舒服。等到口渴、多尿、视力模糊出现，往往已经不只是“轻微异常”。

需要说明的是，代谢风险不是“意志力问题”。药物会改变食欲、饱腹感和能量消耗，单靠“少吃多动”有时不够。可以和医生讨论换药、减量、联合代谢干预，而不是自己停药。**自行停药带来的复发风险，通常大于体重问题本身。**

三、EPS、迟发性运动障碍与“坐不住”

锥体外系反应（EPS）是一组由药物影响运动系统引起的不自主运动，包括手抖、肌肉发僵、走路小碎步、面部表情减少，也包括突然脖子歪向一边、眼睛往上翻、舌头往外伸这类“急性肌张力障碍”。后几种看起来吓人，但通常可以处理，关键是别拖。

比 EPS 更容易被忽略的是**静坐不能**：一种从身体内部涌上来的坐立不安，腿像装了弹簧，站也不是坐也不是。它常被误认为“焦虑加重”“躁狂前兆”，甚至被当成“病情没好”，结果医生加药，症状更重。静坐不能和自杀念头之间也有关联，出现严重坐立不安时要主动告诉医生，而不是忍着。

迟发性运动障碍（TD）是长期用药后可能出现的不自主运动，比如舌头在嘴里转动、嘴唇抽动、手指像弹琴一样动。它可能在减药或停药后出现或加重，有时不可逆。早期发现、早期调整很关键，所以复诊时医生会让你伸舌头、做几个动作，不是走过场。

处理原则：出现 EPS 或 TD，不要自己停药，也不要自己吃“抗胆碱能药”顶着；告诉医生，由医生评估是减量、换药还是加用对症药物。突然停药可能诱发撤药性运动障碍，反而更难受。

四、QT、镇静、体位性低血压与恶性综合征

QT 间期是心电图上的一段，延长后发生严重心律失常的风险增加。齐拉西酮、喹硫平、氟哌啶醇等都有不同程度的 QT 影响；如果同时用其他延长 QT 的药、血钾或血镁偏低、有心脏病，风险会叠加。有晕厥、心悸、家族中有人年轻时就猝死，要主动告诉医生，可能需要做心电图。

镇静在喹硫平、奥氮平上比较常见，尤其在加量初期。镇静本身不危险，但会影响开车、操作机器、考试和上班，也会增加老年人跌倒和误吸的风险。如果白天困到影响生活，应该和医生讨论服药时间或换药，而不是靠大量咖啡硬撑。

体位性低血压表现为从躺到坐、从坐到站时眼前发黑、头晕、差点摔倒，喹硫平、利培酮较常见。起床分两步、避免热水澡后突然站起、保证喝水，能减少发生。反复晕倒要就医。

恶性综合征（NMS）是罕见但致命的急症：高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳快、血压不稳。它可以在加量过快、换药、脱水、合并其他药物时出现。**出现高热加肌肉僵硬，不要在家观察，立即去急诊**，并带上所有正在吃的药。

五、监测清单与日常注意

- ☐ 用药前记录体重、腰围、血压，查空腹血糖或糖化血红蛋白、血脂。
- ☐ 用药后前几个月密切复查代谢指标，稳定后也要定期查，不要只查一次。
- ☐ 每月同一时间称体重、量腰围，记在同一张纸上。
- ☐ 出现特别口渴、尿多、夜里频繁起夜、体重下降但吃得很多，尽快查血糖。
- ☐ 复诊时主动说“有没有坐不住、手抖、走路发僵、舌头不听使唤”。
- ☐ 有心脏病、晕厥史、电解质紊乱、同时用其他延长 QT 的药，提前告知医生。
- ☐ 老年人注意跌倒、吞咽困难、过度镇静，夜间起身要开灯。
- ☐ 不自行加量、减量、停药；换药由医生安排过渡。
- ☐ 注射长效针剂的人，按时复诊，不要因为“最近挺好”就拖延。

长效针剂（长效注射剂）是这类药的一种剂型，适合记不住每天吃药、或反复因为停药复发的人。它不是“病情重才用”，而是一种依从性工具，具体是否适合要和医生讨论。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 高热、肌肉僵硬、意识模糊、大汗、心跳很快、血压忽高忽低（警惕恶性综合征）；
- 突然脖子歪斜、眼睛上翻、牙关紧闭、吞咽困难或呼吸困难（急性肌张力障碍）；
- 晕倒、心悸持续不缓解、胸闷胸痛；
- 极度口渴、尿多、呕吐、腹痛、呼吸有烂苹果味、意识不清（警惕糖尿病酮症酸中毒）；
- 出现自杀念头、自伤行为，或躁狂失控、伤人威胁；
- 大面积皮疹伴发热、面唇肿胀。

尽快联系医生（当天或次日）：

- 坐立不安到无法静坐、来回走动停不下来；
- 手抖、走路发僵、动作变慢，影响写字或吃饭；
- 舌头、嘴唇、手指出现不自主动作；
- 白天困到影响工作学习，或反复眼前发黑；
- 体重短期内明显增加、血糖或血脂复查异常；
- 月经紊乱、乳房胀痛、性功能变化（可能与催乳素有关）；
- 准备怀孕、已怀孕或哺乳。

常见问题

“抗精神病药是不是吃上就停不掉？” 不是。很多人会在维持一段时间后，由医生评估逐渐减量。但突然停药的复发风险很高，尤其是躁狂。能不能停、什么时候停，要看发作次数、严重度、维持时间和目前状态。

“副作用这么大，能不能自己先停几天看看？” 不建议。突然停药可能出现失眠、烦躁、撤药性运动障碍，甚至诱发复发。想调整，先联系医生。

“两种抗精神病药一起吃是不是更有效？” 多数情况下不推荐常规联用，副作用和代谢负担会叠加。只有在专科医生评估难治性病例时才考虑，并需要更密的监测。

“为什么医生给我开抗精神病药，我明明不是精神病？” 这类药在双相障碍中的作用是稳定情绪、控制躁狂，不是“因为你疯”。药名带来的羞耻感很常见，可以和医生讨论怎么向家人解释。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.7 抗抑郁药的使用与转躁风险

很多双相障碍患者第一次吃药，吃的不是心境稳定剂，而是抗抑郁药——因为最初被当成单相抑郁。问题在于，抗抑郁药对双相抑郁并非“不能用”，而是“不能随便单用”：它可能把情绪从低谷推向高峰，诱发混合状态或快速循环。这一页讲清背后的原因、转躁长什么样、哪些人风险更高，以及什么情况下医生会考虑联合使用。读完你就能分辨：哪些担心是必要的，哪些恐惧是被夸大的。

一、为什么双相抑郁不能单用抗抑郁药

要理解这件事，先要理解双相障碍的“摆动”。单相抑郁更像一直往低处走，抗抑郁药的作用是把情绪往上托；双相障碍则是在高低之间摆动，抗抑郁药把情绪往上托的同时，也可能把摆动幅度拉大——从抑郁直接冲到轻躁狂甚至躁狂，或者卡在“又低落又烦躁”的混合状态里。

这种“药物诱发的转躁”不是罕见传说。不同研究报告的比例差异很大，和药物种类、患者是双相 I 型还是 II 型、过去有没有被抗抑郁药“推高”过都有关系，所以不能用一个数字概括所有人。【研究】但方向是清楚的：单用抗抑郁药的双相抑郁患者，转躁、混合和快速循环的风险高于联合心境稳定剂的人；而混合状态和快速循环，恰恰是自杀与冲动风险最高的时候。【指南】

指南因此把抗抑郁药放在很靠后的位置。CANMAT/ISBD 2018 和中国指南都建议：双相抑郁的一线治疗是喹硫平、锂盐、拉莫三嗪等，抗抑郁药不作为单药首选；只有在特定条件下，才与心境稳定剂联合、短期使用。【指南】NICE 的态度更保守，强调对双相障碍患者使用抗抑郁药要警惕转躁，并优先考虑心理治疗和心境稳定剂。【指南】

还有一层容易被忽略：抗抑郁药可能“治好了抑郁，却弄坏了病程”。有人吃药后抑郁确实轻了，但接着出现易怒、失眠、冲动，发作变得更频繁，几年后回看，才发现转折点就是那次加药。这种代价不会立刻显现，所以更需要提前知道。

二、转躁是什么样：早期信号清单

转躁很少是“某天突然疯掉”，更多是几天到一两周内逐渐变化。最早、最可靠的信号往往是睡眠：不是“睡不着”，而是**睡得明显少了，却不觉得困，白天精力反而更好**。这时候人常常觉得“我终于好了”，家属也觉得“气色不错”，恰恰是最容易错过的时候。

可以对照的信号：

- ☐ 睡眠需求减少：只睡三四个小时甚至更少，仍精神很好。
- ☐ 话明显变多，语速变快，别人插不上嘴。
- ☐ 脑子转得飞快，想法一个接一个，注意力跳来跳去。
- ☐ 突然特别自信，觉得自己能力超群，开始做平时不会做的决定。
- ☐ 花钱、投资、赌博、刷信用卡明显增加。

- ☐ 易怒、一点就炸，和家人冲突变多。
- ☐ 性欲增强、社交活动突然增多、半夜还在联系别人。
- ☐ 坐不住、停不下来，同时心里又烦又空。
- ☐ 抑郁没完全好，却出现上面这些“高”的表现——这更像混合状态，风险更高。

家属常问：“怎么区分转躁和心情变好？”一个实用的判断是：**心情变好通常是“睡得够、吃得下、能听进别人的话”；转躁常常是“睡得少、停不下来、听不进劝、还觉得自己没问题”。** 如果变化来得快、幅度大、伴随冲动，宁可当成转躁的早期信号处理。

三、哪些人风险更高

不是每个双相患者吃抗抑郁药都会转躁，但有些情况需要格外小心。

情况	风险	说明
双相 I 型，有过躁狂发作	较高	单用抗抑郁药更易诱发躁狂【指南】
过去被抗抑郁药“推高”过	很高	再次使用要非常谨慎
混合特征明显	较高	抗抑郁药可能加重激越和自杀风险
快速循环（一年多次发作）	较高	可能让循环更快【研究】
双相 II 型、无转躁史	相对较低	仍需联合心境稳定剂并监测
同时使用锂盐、丙戊酸盐或抗精神病药	较低	有“保护”，但不能完全消除风险

药物种类也有差别。三环类（如阿米替林、氯米帕明）转躁风险相对高；文拉法辛等双重作用的药物在一些研究中风险也偏高；SSRI 类相对低一些，但不等于安全；安非他酮的转躁风险研究结果不一致。【研究】这些差异只是概率，不是命运，具体选药仍要由医生结合你的病史决定。

四、什么情况下可以联合使用

抗抑郁药不是双相障碍的禁区。对一部分人——尤其是抑郁严重、持续时间长、一线方案效果不好的人——在**充分的心境稳定剂保护下**短期联合抗抑郁药，可能是合理的。关键在于“保护”和“监测”两个词。

所谓保护，通常指同时使用锂盐、丙戊酸盐或抗精神病药，让情绪不至于被抗抑郁药单方向推高。所谓监测，是指从加药第一天起就记录睡眠、情绪、冲动和花钱，复诊频率比平时更密，一旦出现转躁信号立刻反馈。

医生通常会考虑联合的情况包括：已经用过喹硫平、锂盐、拉莫三嗪等一线方案，抑郁仍然明显；抑郁严重到影响进食、工作和安全；过去有过“联合使用有效且没有转躁”的经历。反过来，如果正在混合状态、快速循环，或过去有明确的药物诱发躁狂史，医生通常会避免加抗抑郁药，转而考虑调整心境稳定剂或物理治疗。【指南】【临床经验】

还有一条常被忽略：**抗抑郁药不应该“吃上就一直吃下去”**。在双相障碍里，它通常是阶段性的，情绪稳定一段时间后由医生评估逐渐减量。长期单用、长期不复查，是最危险的做法之一。

五、血清素综合征、停药反应与其他风险

抗抑郁药的风险不只有转躁。

血清素综合征是 5-羟色胺过多引起的急症，表现为高热、震颤、肌肉抽动、反射亢进、出汗、腹泻、躁动、意识改变。它常发生在同时使用两种以上增加 5-羟色胺的药物时，比如抗抑郁药联合曲马多、曲普坦类偏头痛药、利奈唑胺、亚甲蓝、圣约翰草，或与 MAOI 类合用。**出现高热加肌肉抽动、意识改变，立即停药并去急诊。**

停药反应在突然停用 SSRI 或文拉法辛时很常见：头晕、像坐船、恶心、流感样不适、失眠、易怒、触电感。它不是“成瘾”，但确实难受，也可能被误认为复发。减药要慢，由医生安排。

早期自杀风险：抗抑郁药在部分人身上，尤其是青少年和年轻成人，用药初期可能增加自杀念头和激越。这不是说不能用药，而是说开始用药和加量后的头几周需要有人留意，家属的观察很重要。

与其他药的相互作用：抗抑郁药和抗凝药、止痛药、其他精神科药物都可能有相互作用；圣约翰草这类草药会诱导肝酶，影响多种药物浓度，还可能诱发转躁，治疗期间不建议自行服用。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 高热、肌肉抽动或僵硬、震颤、大汗、腹泻、意识模糊（警惕血清素综合征）；
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划；
- 突然极度兴奋、整夜不睡、行为失控、冲动消费或危险驾驶；
- 抽搐、晕厥、心悸持续不缓解；
- 大面积皮疹伴发热、面唇肿胀。

尽快联系医生（当天或次日）：

- 睡眠明显减少但精力旺盛，话变多、易怒；
- 抑郁没好转，却出现坐不住、烦躁、冲动；
- 吃药后情绪“突然全好了”，好得不太真实；
- 漏服、停药后出现头晕、恶心、触电感；
- 需要加用止痛药、偏头痛药、抗生素或中草药；
- 计划怀孕、已怀孕或哺乳；
- 想自行减药或停药。

常见问题

“医生给我开抗抑郁药，是不是诊断错了？” 不一定。有些情况下，抗抑郁药是作为联合方案的一部分短期使用。你可以直接问医生：为什么给我用、和什么药一起用、准备用多久、怎么监测转躁。

“我以前吃抗抑郁药转躁过，是不是这辈子都不能再吃？” 不是绝对，但属于高风险，医生通常会尽量避免，或只在有充分保护、密切监测的条件下短期使用。

“抑郁太难受了，能不能自己加半片？” 不能。加量不会让起效更快多少，却可能让转躁和副作用来得更早。难受的时候联系医生，比加药安全。

“抗抑郁药会让人上瘾吗？” 不会成瘾，但突然停药会有停药反应。这两件事不一样，别混为一谈。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.8 急性躁狂与混合发作的用药

急性躁狂是双相障碍里最需要快速处理的阶段：人可能几天不睡、话停不下来、冲动消费、开车飙速、和人起冲突，甚至出现幻觉和被害想法。混合发作更麻烦，抑郁和躁狂的症状同时出现，自杀和冲动风险都高。这一页讲急性期医生会怎么用药、为什么常常要“两种药一起上”、激越时怎么处理，以及什么情况下必须住院。读完你能判断事情的紧急程度，也能在医生给出方案时知道每一步在解决什么。

一、急性期的目标不是“讲道理”

躁狂发作时，大脑的“刹车”是坏的。家属最容易犯的错，是试图用讲道理、摆事实、算账来让患者停下来——这几乎不会成功，还容易激化冲突。急性期的医学目标很具体：**保证人身安全、降低兴奋度、恢复睡眠、控制精神病性症状、防止脱水和体力耗尽，然后把情绪拉回可维持的范围。**

这意味着用药的思路和抑郁期不同。抑郁期是“慢慢托起来”，躁狂期是“先压住火”，所以起效速度被放在很重要的位置。医生通常会在急诊或病房先评估：有没有伤人风险、有没有自杀风险、有没有脱水或感染、有没有用酒精或兴奋剂、有没有怀孕可能、肝肾功能如何。这些信息直接决定用药选择，不是走流程。

还要接受一个现实：急性躁狂的完全缓解通常需要几天到几周，不是吃一次药就安静下来。家属的期待如果放在“今天就必须正常”，很容易失望，也容易逼着医生加药。

二、药物策略：心境稳定剂加抗精神病药

目前的主流做法是：**心境稳定剂（锂盐或丙戊酸盐）联合一种非典型抗精神病药**，作为中重度急性躁狂的一线方案；部分情况下，单用抗精神病药也有效，尤其是躁狂程度重、需要快速控制时。【指南】这么搭配的理由是：抗精神病药控制兴奋、精神病性症状和激越更快；锂盐或丙戊酸盐负责把情绪的地基稳住，为后续维持治疗铺路。

临床情景	常见思路	需要留意
首次躁狂、无明显精神病性症状	心境稳定剂为主，必要时短期联用抗精神病药	先查基线化验，评估肾功能、甲状腺、血常规
躁狂严重、有幻觉妄想或明显激越	抗精神病药为主，联合心境稳定剂	监测镇静、体位性低血压、EPS
混合发作	丙戊酸盐或抗精神病药常被优先考虑	自杀风险评估要放在最前面
快速循环背景	尽量避免抗抑郁药，调整现有方案	起效慢，需要耐心和随访
躁狂伴紧张症、拒食、脱水	考虑电休克治疗	不能拖，属于急症
孕期或备孕	由精神科与产科共同评估	锂盐、丙戊酸盐都有胎儿风险，不能自行处理

具体选哪个药，会看既往发作对什么药有效、有没有不能耐受的副作用、有没有合并躯体病、是否在备孕。**“别人吃这个好”不是选药依据**，个体差异很大，以处方为准。

有几个常见误区值得提前说清。第一，**急性躁狂不用抗抑郁药**，包括“看他抑郁得难受，加点抗抑郁药”。混合发作里加抗抑郁药，可能让激越和自杀风险更糟。第二，**不要自行叠药**。有人觉得“医生开的量不够”，把家里的旧药翻出来一起吃，这会显著增加恶性综合征、心律失常和过度镇静的风险。第三，**锂盐起效相对慢**，急性期常需要抗精神病药先顶上去，等情绪稳定后再评估锂盐的位置，这不是“锂盐没用”。

三、混合发作：更危险的一种“躁”

混合发作的表现很矛盾：人一边情绪低落、觉得活着没意思，一边又坐立不安、脑子转个不停、容易暴怒、睡得很少。DSM-5-TR 把这种情况描述为抑郁发作伴混合特征，或躁狂/轻躁狂发作伴混合特征。它最危险的地方在于：**抑郁带来的绝望，加上躁狂带来的冲动和能量，可能同时存在。** 这正是自杀风险最高的组合之一。【指南】

所以混合发作的处理有几个原则：

- **先评估自杀和伤人风险**，不是先调药。有没有计划、有没有手段、家里有没有人陪，这些比“今天心情几分”更重要。
- **避免抗抑郁药**，包括原本在吃的抗抑郁药，是否需要减停由医生决定。
- **丙戊酸盐和抗精神病药常被优先考虑**，锂盐在混合发作中的证据相对弱一些，但并非不能用。【指南】【研究】
- **不要用酒精、安眠药、大麻“自己镇静”**，这些会加重冲动、脱水和意识混乱。
- **电休克治疗对严重混合发作有效**，尤其是伴精神病性症状、拒食或高自杀风险时，不必等到“所有药都试过”。

家属要特别注意：混合发作的人可能看起来“还能上班、还能说话”，但内心的冲动控制已经很差。**“看起来还行”不等于安全。**

四、激越怎么处理：先环境，后药物

激越是指明显的坐立不安、来回走动、大声喊叫、推搡、拒绝配合。处理顺序应该是：**降低刺激 → 语言安抚 → 提供基本需要 → 必要时药物 → 最后才考虑约束。** 约束和隔离是最后手段，不是首选，而且必须由受过训练的人员在医疗监护下进行。

家属和陪护可以做的：

- ☐ 减少围观的人，关掉刺眼的灯和嘈杂的电视，说话放慢、放低。
- ☐ 不争辩、不讽刺、不威胁，也不轻易承诺做不到的事。
- ☐ 递水、递吃的，问“要不要坐一会儿”，把选择权还给他一点。
- ☐ 保持出口通畅，自己也站在能退开的位置，不去堵门。
- ☐ 把可能伤人的东西（刀、玻璃、钥匙、车钥匙）收好，但不要当面“搜身”激化冲突。

☐ 记录从什么时候开始不睡、吃了什么药、喝了酒没有，这些对医生很有用。

医院里，激越明显时可能会用短效的注射药物快速控制，同时监测血压、心率、体温和血氧。**这不是“惩罚”，目的是防止人伤到自己或别人。** 注射后要观察镇静程度和呼吸，尤其是同时用了酒精、苯二氮䓬类或其他镇静药的人。

五、什么时候必须住院

急性躁狂的住院判断，核心看三件事：**有没有危险、能不能自己照顾自己、门诊方案还撑不撑得住。**

维度	需要考虑住院的情况
人身安全	有伤人威胁或行为、危险驾驶、纵火、持械、明显攻击性
自杀风险	有自杀计划或准备行为，混合发作中尤其要警惕
基本生活	连续多日几乎不睡、不吃不喝、脱水、体力耗尽
精神症状	幻觉、妄想、严重思维紊乱、无法配合门诊治疗
躯体情况	高热、感染、电解质紊乱、甲状腺危象、物质中毒或戒断
支持系统	家中无人看护，或家属已无法保证安全
治疗反应	门诊调整无效，症状仍在加重

住院不是“关起来”，而是把环境变量降到最低，让药物起效、睡眠恢复、危险因素被看住。很多人住两周左右就能明显好转，具体时长因人而异。关于自愿住院与非自愿住院的法律条件，属于另一页的内容，这里只强调：**当危险已经迫在眉睫，先保证安全，再讨论程序。**

六、家属能做什么、不能做什么

能做的：陪诊、记录、把家里的药收好并按医嘱发放、保证有人轮班陪护、减少访客和刺激、准备好既往用药清单和过敏史、在医生问“最近有没有不睡”时如实回答。

不能做的：劝酒“助眠”、把自己的安眠药给患者吃、因为“他太吵了”而锁门关灯、用激将法、在患者面前讨论“要不要送精神病院”、把车钥匙和银行卡留在随手可拿的地方。

立即去急诊或拨打 120（必要时 110）：

- 明确威胁要伤害自己或他人，或已经动手；
- 连续多日几乎不睡、不吃不喝，出现脱水、虚弱、意识模糊；
- 高热、肌肉僵硬、大汗、心跳很快（警惕恶性综合征或躯体急症）；
- 严重激越无法安抚，或出现幻觉驱使的危险行为；
- 木僵、拒食、不说话、保持奇怪姿势不动（警惕紧张症）；
- 混合发作中出现自杀念头或计划。

尽快联系医生（当天）：

- 睡眠时间明显减少、话变多、花钱变多，但还没失控；

- 门诊加药后出现严重嗜睡、走路不稳、手抖；
- 情绪在抑郁和兴奋之间快速切换；
- 患者拒绝吃药，或家属已经无法保证其安全。

常见问题

“能不能在家吃药，不住院？” 如果危险可控、有人看护、能配合吃药和复诊，部分人可以门诊治疗。但只要出现伤人、自杀、脱水或严重精神病性症状，住院是更安全的选择。

“医生为什么同时开两种药？是不是太多了？” 急性期联合用药是常见做法，目的是一个快、一个稳。等急性症状控制后，医生通常会简化方案。可以问清楚每种药的角色，但不要自己减掉其中一种。

“躁狂期说的话、签的字算数吗？” 这是法律问题，判断标准是当时是否具备相应的辨认和控制能力，需要具体评估，不能一概而论。涉及合同、转账、离婚等重大事项，建议尽快咨询专业人士并保留医疗记录。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.9 双相抑郁的用药

双相抑郁是双相障碍里最“像抑郁”的阶段，也是最容易被治错的一段：按单相抑郁的思路加抗抑郁药，可能抑郁没好透，人却转躁了。这一页讲双相抑郁的用药顺序：哪些药是一线、拉莫三嗪和锂盐各自站在什么位置、抗抑郁药的红线在哪、效果不好时还有哪些选择。读完你能和医生讨论“为什么先选这个、下一步可能是什么”，而不是只在“吃不吃抗抑郁药”上纠结。

一、双相抑郁和单相抑郁，用药逻辑不同

单相抑郁的治疗目标是“把这一次抑郁治好，再防下一次”；双相抑郁除了治当前，还必须防“治过头”——防转躁、防混合、防快速循环。所以同一盒抗抑郁药，在单相抑郁里可能是一线，在双相抑郁里就要往后排，甚至不用。

另一个差别是“基线”。双相抑郁的人往往已经有一套维持用药（锂盐、丙戊酸盐、抗精神病药），治抑郁时不能把原有方案推倒重来，而是要在稳住基线的前提下加或调。**这也是为什么双相抑郁的用药看起来更“复杂”：不是医生不会简化，而是不能只盯着抑郁一个方向。**

还要提醒：抑郁期的人容易把一切归因于“我不够努力”，家属也容易只盯着“振作一点”。但双相抑郁的乏力、嗜睡、注意力差、食欲改变，是疾病和药物共同作用的结果，不是态度问题。治疗起效需要时间，通常以周为单位，不是以天。

二、一线选择：几个名字和它们的分工

不同指南的排序略有差异，但大致有一组共同的“第一梯队”。CANMAT/ISBD 2018 把喹硫平、锂盐、鲁拉西酮（部分地区可用）列为双相抑郁的一线选择；拉莫三嗪更多用于维持期预防抑郁复发，急性期单药力度有限，常作为联合或二线。【指南】中国指南的框架相近，具体到某个人，还要看发作类型、既往反应、躯体情况和是否备孕。

药物	主要位置	优点	需要留意
喹硫平	急性双相抑郁、维持	证据较多，兼顾睡眠和焦虑	镇静、体重、代谢、体位性低血压
锂盐	急性期与维持，尤其防自杀	长期证据扎实，防躁狂和自杀	血锂监测、肾功能、甲状腺、脱水
鲁拉西酮	双相抑郁（可及性因地区而异）	代谢影响相对小	静坐不能、恶心，需随餐
拉莫三嗪	维持期防抑郁复发	不长体重，耐受性好	皮疹风险，必须缓慢加量
丙戊酸盐	二线，混合特征时常用	对混合、快速循环有一定作用	肝功能、体重、血小板、孕期致畸
抗抑郁药	联合使用，非单药首选	对部分人有效	转躁、混合、快速循环风险

这张表最想传达的是：**双相抑郁不是“没有药”，而是“有药，但要选对和配好”。** 喹硫平常被用于抑郁伴明显失眠、焦虑的人；锂盐适合有躁狂史、自杀风险较高、愿意规律复查的人；拉莫三嗪适合抑郁反复、又受不了体重增加的人。没有“最好的药”，只有“当下更适合的药”。

三、抗抑郁药的红线

抗抑郁药在双相抑郁里不是绝对禁用，但有几条红线不该踩：

- **不单用**。没有心境稳定剂保护的单用抗抑郁药，转躁、混合和快速循环风险明显升高。【指南】
- **不在混合状态用**。抑郁伴明显的激越、易怒、思维奔逸、睡眠减少时，加抗抑郁药可能让情况更糟。
- **不在快速循环背景上随意加**。一年内多次发作者，抗抑郁药可能让循环更快。
- **不因为“上次有效”就长期吃**。双相抑郁里的抗抑郁药通常是阶段性的，用多久、什么时候减，要由医生评估。
- **不自行加量、换药、停药**。起效需要时间，加量不会让今天更舒服，却可能让转躁来得更早。

如果医生确实开了抗抑郁药，你可以问三个问题：它和哪个心境稳定剂搭配？准备用多久？出现哪些信号要立刻联系？这三个问题问清楚，比自己在网上查“能不能吃”有用得多。关于转躁的具体表现和识别，另一页有更细的清单。

四、效果不好时，医生还会考虑什么

一线方案用足疗程仍无效，不等于“没救了”，而是进入“下一步选择”。常见思路包括：

换药或联合。比如从喹硫平换到锂盐，或在锂盐基础上加拉莫三嗪；也可能在心境稳定剂基础上短期联合抗抑郁药。联合用药的原则是“机制互补、副作用不叠加”，不是药越多越好。

评估诊断和共病。甲状腺功能减退、贫血、睡眠呼吸暂停、慢性疼痛、酒精或镇静药使用，都可能让抑郁“治不动”。查一遍躯体因素，比盲目加药更划算。

心理治疗。人际与社会节律治疗（IPSRT）、认知行为治疗（CBT）、家庭聚焦治疗，对双相抑郁有辅助作用，能改善依从性和复发。【指南】药物解决生理层面，心理治疗解决节律、认知和关系层面，两者不冲突。

物理治疗。严重、伴精神病性症状、拒食、高自杀风险或药物无效时，电休克治疗是有效选择；重复经颅磁刺激在部分双相抑郁中有研究支持，但不是常规首选。这些属于模块 7 的内容，这里只说明它们的位置：**不是“最后的惩罚”，而是有明确适应证的医学手段。**

五、怎么判断“有没有效”

抗抑郁治疗最怕两件事：一是吃三天没感觉就放弃，二是吃了两个月没变化还在硬撑。判断需要节奏。

- ☐ 开始治疗前，记录基线：睡眠时长、精力、兴趣、食欲、注意力、自杀念头。
- ☐ 前两周重点看副作用和转躁信号，不急着判“无效”。
- ☐ 第 4 到 6 周评估核心症状有没有实质性变化，而不只是“感觉好一点”。
- ☐ 有效但没完全缓解，可以和医生讨论继续观察还是调整。
- ☐ 完全没变化，带着记录复诊，讨论换药、联合或物理治疗。
- ☐ 任何时候出现转躁、混合、自杀念头加重，不等复诊，立刻联系。
- ☐ 不自行叠加“助眠”“提神”的保健品或酒精。
- ☐ 女性说明避孕、备孕、怀孕、哺乳情况，这些会改变用药选择。

“有效”不等于“回到从前”。有些人症状轻了七成，仍然容易累、注意力不如以前，这可能是残留症状，也可能是药物副作用，需要区分。**残留症状是复发的风险因素，值得继续治疗，而不是“忍一忍就过去了”。**

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 出现自杀念头、计划或准备行为，尤其是同时感到激越、坐立不安；
- 突然话多、整夜不睡、冲动消费或危险驾驶（转躁）；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（警惕恶性综合征或血清素综合征）；
- 拒食、不喝水、木僵不动、意识模糊（警惕紧张症或躯体衰竭）；
- 抽搐、晕厥、心悸持续不缓解。

尽快联系医生（当天或次日）：

- 情绪低落加重，或出现“活着没意思”的念头；
- 用药后烦躁、坐不住、失眠加重；
- 皮疹、手抖、走路不稳、频繁呕吐腹泻；
- 抑郁好转但睡眠需求明显减少、话变多；
- 漏服、停药后不舒服；
- 计划怀孕、已怀孕或哺乳；
- 想自行调整药物。

常见问题

“双相抑郁是不是只能靠抗精神病药？” 不是。锂盐、拉莫三嗪、丙戊酸盐都是选项，喹硫平只是其中证据较多的一种。选药看发作类型、既往反应和身体条件。

“拉莫三嗪不是治抑郁的吗，为什么医生说我不能单用它？” 拉莫三嗪在维持期预防抑郁复发方面有价值，但对正在发生的抑郁发作，单药起效慢、力度有限，常需要联合或换用其他方案。

“抑郁好了是不是可以停锂盐？” 锂盐的作用是防躁狂、防复发、降低自杀风险，不只是在抑郁期“托一把”。停药要由医生评估，突然停可能增加复发风险。

“吃药后胖了很多，能不能换药？” 可以讨论，但不要自己停。体重问题有替代方案（换代谢影响小的药、调整饮食运动、必要时联合干预），突然停药的风险通常更大。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.10 维持治疗、联合用药与停药

急性期过去、情绪稳定下来之后，治疗才进入最漫长也最容易松懈的阶段。很多人在这时候想：“我已经好了，是不是可以停了？”停药本身不是错，错在“自己决定、说停就停”。这一页讲维持治疗在防什么、要吃多久、联合用药怎么权衡、血药浓度什么时候查，以及减药停药时最容易出事的环节。读完你能分清“症状缓解”和“可以停药”不是一回事。

一、维持治疗到底在维持什么

双相障碍的病程有一个特点：发作次数越多，下一次越容易被小事触发，间隔也可能越短。这个现象常被叫作“kindling”，意思是像柴火一样，第一次难点的火，后面越来越容易着。维持治疗的目标不是“让你一直吃药”，而是**把复发概率压下来，保护大脑、工作和关系不被一次次发作磨掉。**

维持治疗保护的东西比“情绪”更具体：

- **防躁狂复发**：锂盐、丙戊酸盐、部分抗精神病药在这方面证据明确。
- **防抑郁复发**：拉莫三嗪、喹硫平、锂盐各有位置。
- **降低自杀风险**：锂盐在长期治疗中与较低的自杀风险相关，这是它难以被完全替代的原因之一。【指南】
- **保住功能**：每次发作都可能带来工作、学业、关系和经济上的损失，维持治疗是在保这些。
- **减少住院**：反复住院不仅花钱，也会打断治疗关系和生活节奏。

所以“我现在很好”恰恰可能是维持治疗有效的结果，而不是可以停的理由。这句话听起来像绕口令，但它是这个病最容易被误解的地方。

二、维持多久：没有统一答案，但有判断框架

“要吃多久”是门诊里被问得最多的问题，也是最不该给统一答案的问题。有人一次躁狂后再没复发，有人在减药后几个月就再次发作。指南给出的不是一条硬线，而是一个判断框架。

你的情况	通常的倾向	说明
首次发作、完全缓解、生活稳定	维持较长时间后再讨论减药	不建议刚稳定就停【指南】
多次发作，尤其有躁狂史	多建议长期维持	停药后复发风险高
有快速循环、混合发作史	更倾向长期	复发代价大，方案要简化稳定
有自杀企图或严重抑郁史	更倾向长期	锂盐的长期保护价值要纳入考虑
孕期、备孕、哺乳	个体化重新评估	不是简单“停”或“继续”【指南】
副作用难以耐受	调整方案，而非直接停	换药、减量、联合对症处理

不少指南把“情绪稳定两年以上”作为可以开始认真讨论减药的前提之一，但这不是自动生效的许可，具体要看发作次数、严重度、支持系统和既往减药经历。**减药是一个需要计划、需要随访的医疗决定，不是一次谈话就能完成的动作。**

三、联合用药：什么时候需要，怎么避免越加越多

双相障碍用到两种以上精神科药物很常见，原因通常不是“病情重”，而是单药覆盖不了两个方向：比如锂盐防躁狂和自杀，拉莫三嗪防抑郁；或者心境稳定剂打底，抗精神病药控制残余的兴奋或失眠。

合理的联合有几个特征：**每种药都有明确目标、剂量与副作用不重复叠加、有明确的“什么时候评估要不要减”的计划。** 不合理的联合则常常是“症状多、药就多”，最后人很困、很胖、很木，却说不清每种药在治什么。

常见组合	目的	需要留意
锂盐 + 拉莫三嗪	兼顾防躁狂与防抑郁	拉莫三嗪需缓慢加量，注意皮疹
锂盐 + 喹硫平	急性期与维持，兼顾睡眠	镇静、体重、代谢、体位性低血压
丙戊酸盐 + 抗精神病药	混合发作、躁狂控制	体重、肝功能、血小板、镇静
心境稳定剂 + 抗抑郁药	难治性双相抑郁的短期联合	转躁风险，需密切监测
口服药 + 长效针剂	依从性差、反复复发	注射部位反应、按时复诊

联合用药最怕两件事：一是**自行叠加**，把家里剩下的药翻出来一起吃；二是**只加不减**，几年下来方案越来越重，却没人回顾。每次复诊可以问一句：“现在这些药，各自是治什么的？有没有可以减的？”这不是质疑医生，而是让治疗保持清醒。

还要注意相互作用。卡马西平会降低很多药的浓度；氟西汀等会抑制肝酶，抬高其他药的水平；部分抗生素、抗真菌药、止痛药会影响锂盐和抗精神病药的浓度。**任何新加的药，包括中草药和保健品，都值得让医生或药师核一遍。**

四、血药浓度监测：查什么、什么时候查

血药浓度（治疗药物监测）不是“抽个血看看”，而是判断“这个剂量在你身上够不够、有没有过量”的工具。不同药的必要性不一样。

- **锂盐**：必须定期监测，是安全使用的底线。脱水、呕吐、腹泻、发热、低盐饮食、加用利尿剂或降压药，都可能让血锂升高。
- **丙戊酸盐**：在疗效不佳、怀疑不依从、出现副作用、合并用药时查，同时要看肝功能、血氨、血常规。
- **卡马西平**：在疗效变化、加用新药、怀疑毒性时查，注意自身诱导导致浓度下降。
- **氯氮平**：一旦使用，血常规监测是强制的，不是可选项。
- **其他抗精神病药和抗抑郁药**：并非常规，但在疗效异常、副作用明显、怀疑不依从时可以查。

抽血时间有讲究，通常按医生要求，在下次服药前采血，这样比较的是“谷浓度”。**不要因为怕麻烦而跳过复查**，也不要拿着一次结果自己调药。结果要结合症状、副作用、肝肾功能和合并用药一起看，单看数字容易误判。

五、停药与撤药：最容易出事的一步

突然停药是双相障碍治疗中最常见、也最可避免的失误之一。原因很直接：

- **锂盐突然停**，躁狂复发风险明显上升，且可能比逐渐减量更高；撤药期间还可能出现焦虑、失眠、出汗。
- **抗精神病药突然停**，可能出现失眠、烦躁、恶心、撤药性运动障碍，复发风险也上升。
- **抗抑郁药突然停**，会出现头晕、触电感、恶心、易怒等停药反应，容易被误认为“病又回来了”。
- **拉莫三嗪停一段时间再吃**，不能按原来的量直接恢复，需要重新缓慢加量，否则皮疹风险上升。
- **苯二氮䓬类突然停**，可能反跳性失眠、焦虑，严重时抽搐，必须由医生安排逐渐减。

减药的正确姿势是：**先有计划，再有动作。** 计划包括——为什么减、减哪一种、减完之后怎么观察、出现什么信号要恢复、下一次复诊什么时候。减药通常分阶段进行，以周或月为单位，由医生根据反应调整；不选在考试、换工作、搬家、季节交替这些压力大的时候；减药期间睡眠要格外规律，酒和熬夜要避免。

准备减药前，可以先过一遍这份清单：

- ☐ 和医生确认：现在是否到了可以讨论减药的阶段，依据是什么。
- ☐ 明确这次减的是哪一种药，其他药是否保持不变。
- ☐ 写下未来三个月的复诊时间，以及出现问题时怎么联系。
- ☐ 和家人/同伴说明：接下来几个月要重点观察睡眠和情绪。
- ☐ 准备好心境日记，记录睡眠时长、情绪、花钱、冲动。
- ☐ 把“复发早期信号”写在一张纸上，贴在家里显眼处。
- ☐ 确认家里没有人会“劝你干脆全停了”。
- ☐ 知道一旦出现转躁或自杀念头，立即联系医生或去急诊，不等复诊。

停药不等于失败，长期服药也不等于软弱。 它们都是根据病情做出的选择，区别只在于：这个选择是不是在充分评估之后做的。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 出现自杀念头、计划或准备行为；
- 突然话多、整夜不睡、冲动消费、危险驾驶、伤人威胁；
- 严重手抖、走路不稳、频繁呕吐腹泻、意识模糊（警惕锂中毒）；
- 高热、肌肉僵硬、大汗、心跳很快（警惕恶性综合征）；
- 抽搐、晕厥、胸痛、呼吸困难；
- 停药或减药后症状迅速反弹，无法自控。

尽快联系医生（当天或次日）：

> - 睡眠时间明显减少，但精力反而变好；
> - 情绪低落加重、兴趣明显下降；
> - 减药后出现头晕、恶心、触电感、烦躁；
> - 发热、呕吐、腹泻、吃不下东西（可能影响血药浓度）；
> - 需要加用新药、抗生素、止痛药或中草药；
> - 计划怀孕、已怀孕或哺乳；
> - 想自行调整方案。

常见问题

“稳定三年了，能不能停？” 可以讨论，但不能自己停。医生会看发作次数、严重度、上次减药的结果、目前的支持系统，再决定是否减、减多少、减多快。

“吃药期间怀孕了怎么办？” 立即联系精神科和产科，不要自行停药。突然停药导致的复发，对母亲和胎儿同样是风险。具体方案需要两边医生一起定。

“血药浓度正常，是不是就说明药量刚好？” 不一定。浓度只是参考，还要看症状控制、副作用和个体差异。有些人浓度在参考范围内仍有效，有些人需要更低或更高，判断权在医生。

“能不能用保健品代替一部分药？” 不能。目前没有哪种保健品被证实可以替代心境稳定剂，某些产品还会影响药物浓度或诱发转躁。具体见模块 7 中关于补充剂的内容。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 6：心理社会治疗与康复

药物稳定情绪，心理社会干预帮助识别早期信号、稳定节律、改善关系和生活。

6.1 心理社会干预总览

这一页把双相障碍的心理社会干预放回整张治疗地图：心理教育、认知行为治疗（CBT）、辩证行为治疗（DBT）、人际与社会节律治疗（IPSRT）、家庭聚焦治疗（FFT）、职业康复与同伴支持，各自解决什么问题、在什么阶段用、为什么都不能替代药物。它适合刚被诊断、想弄明白“除了吃药还能做什么”的患者，也适合想帮忙又怕帮倒忙的家属。读完你应该能判断自己现在最需要哪一类支持，以及怎样向医生开口。

一、先把位置摆正：药物是地基，心理社会干预是结构

药物治疗负责把情绪的高低起伏压在一个相对安全的范围里，减少发作的频率和强度。但药物解决不了另外一些问题：患者怎么理解自己得的病，怎么在睡眠刚开始变少时察觉，怎么跟家人说“我需要休息”，怎么在抑郁期启动一件小事，怎么在稳定之后重新上班上学。这些属于心理社会干预的范围。

两者不是竞争关系。把心理社会干预当成药物的替代品，在中重度躁狂、混合状态、有精神病性症状或高自杀风险时会非常危险；反过来，把心理社会干预贬低成“聊聊天、可有可无”，也会让很多本来可以避免的复发发生。【指南】

还需要说清楚：心理社会干预降低的是复发风险和功能损害，不是“治愈”。它让人更早发现波动、更快求助、更少在冲动下做出难以挽回的决定，但不会让双相障碍消失。【指南】

二、六类干预各自的位置

干预	主要解决什么	常见形式与节奏	证据位置
心理教育	理解疾病、治疗与早期信号；提高依从性；让家属知道怎么配合	个体或团体，数次到十余次	指南普遍推荐，几乎所有患者都适用【指南】
认知行为治疗（CBT）	抑郁与焦虑的残留症状、负性自动思维、回避行为、复发预防	个体，结构化，通常十余次	缓解期复发预防有指南推荐；急性躁狂期不作为主力【指南】【研究】
辩证行为治疗（DBT）	情绪失控、冲动、自伤、人际冲突	技能团体加个体会谈，周期较长	双相领域的证据少于边缘型人格障碍，对情绪失调有帮助【研究】【待验证】
人际与社会节律治疗（IPSRT）	作息与社会节律紊乱、角色转换、人际冲突、哀伤	个体，分阶段进行，常配合心境日记	指南推荐用于复发预防【指南】【研究】
家庭聚焦治疗（FFT）	家庭沟通、冲突升级、高情	家庭会谈，十余次到二十余	指南推荐，尤其适用于冲突较多的家庭【指南】【研

干预	主要解决什么	常见形式与节奏	证据位置
	感表达、照护负担	次	究】
职业康复、同伴支持、个案管理	复工复学、功能恢复、资源连接、社会孤立	支持性就业、同伴小组、社区随访	支持性就业证据较强；同伴支持证据仍在积累【研究】【临床经验】

这张表容易让人误解成“六样都要做”。实际上多数人不需要全套，也不该同时开始。选择依据是当前分期、最影响生活的那一个问题、以及当地有没有可用的资源。

三、按分期和当前问题来选，而不是“全都做一遍”

急性期以药物、环境调整和安全为主。此阶段心理社会干预的任务很轻：让患者和家属听懂诊断与治疗方案，减少刺激，配合服药，必要时安排住院。这时候硬拉着人做认知重构或家庭沟通训练，往往适得其反。【临床经验】

巩固期与维持期才是结构化干预的主场。情绪相对稳定、能坐下来谈、能完成作业的时候，心理教育、CBT、IPSRT、FFT 的效果最好。指南通常建议对反复复发、仍有残留症状或家庭冲突明显的人，在这一阶段安排结构化心理干预。【指南】

按问题匹配比按名称匹配更实用：

- 睡眠和作息一乱就复发，跨时区、倒班、熬夜后明显波动：优先考虑 IPSRT，或至少学会使用社会节律表。
- 家里一说话就吵，复发前总有激烈冲突：优先考虑家庭聚焦治疗，同时给家属做心理教育。
- 抑郁拖很久，长期自责、回避社交、什么都不想做：优先考虑 CBT。
- 情绪上来时控制不住，冲动消费、自伤、和人起冲突：可考虑 DBT 技能训练，同时评估是否共病边缘型人格障碍。
- 症状稳定但上不了班、回不了学校：优先考虑职业康复与个案管理，而不是继续加心理治疗次数。

共病要单独处理。合并焦虑、物质使用、创伤后应激、进食问题时，需要相应的专门治疗，不能指望一套双相的心理教育解决全部。【指南】

四、在中国大陆，这些资源通常在哪里

- **精神专科医院与综合医院精神心理科**：部分医院设有心理治疗门诊、团体心理教育、家属课堂。挂号时可以直接问“有没有针对双相的结构化心理治疗”。
- **社区卫生服务中心的精神卫生防治医生**：负责随访、服药管理、转介，部分地区对包括双相障碍在内的严重精神障碍有社区随访管理，具体以当地规定为准。【指南】
- **社区康复机构**：一些城市有日间康复站、辅助性就业工场、家属互助组织，名称和覆盖范围各地差别很大。

- **社会心理咨询机构**：可以作为补充，但心理咨询师不能诊断、不能开药，遇到需要调药或病情波动时要回到精神科。
- **线上课程与自助工具**：适合学习和记录，不适合替代面谈治疗，尤其不适合急性期。

选择时看三件事：对方有没有受过系统的心理治疗训练、是否愿意和精神科医生沟通、是否明确边界（不劝停药、不承诺治愈）。【临床经验】

五、清单：第一次谈心理社会治疗时可以问什么

- ☐ 我现在的分期适合做哪一类干预？急性期还是维持期？
- ☐ 这个治疗大概多少次、多长时间一次、总共要几个月？
- ☐ 主要目标是减少复发、改善情绪，还是恢复工作学习？
- ☐ 需要家属参与吗？以什么形式参与？
- ☐ 治疗期间如果睡眠明显减少、情绪突然变高，怎么调整安排？
- ☐ 有没有团体形式，费用大概多少，医保能不能报一部分？
- ☐ 和我现在吃的药有没有需要特别注意的配合点？
- ☐ 如果做了几次觉得没用，怎么判断是“还没起效”还是“不合适”？

六、常见问题与容易踩的坑

“心理治疗能代替吃药吗？” 不能。对双相障碍，心理社会干预是加在药物治疗之上的，不是替换。停药要在医生安排下进行，不能因为“最近心情不错、治疗有效”就自行减停。【指南】

“做几次能好？” 结构化干预通常以“十余次、持续数月”为一个基本单位，效果体现在复发次数、住院次数、功能恢复上，不是几周内心情变好。期待值定得太高，容易在第二三次就放弃。【临床经验】

“我现在挺好的，不需要做。” 缓解期恰恰是预防复发干预最有效的时候。等到复发再学，学习能力会被症状打断。

“是不是家里人有问题，我才得病？” 不是。家庭沟通可以影响病程，但不是病因。家庭聚焦治疗的目标是让沟通更有效，不是追责。【指南】

“看几个视频、买个自助 App 就够了。” 自助工具能帮忙记录和提醒，但缺少评估、反馈和个体化调整，不能替代专业治疗。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在想具体方法：不要独处，联系信任的人陪伴，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 连续几天睡眠明显减少、话变多停不下来、冲动消费或投资、危险驾驶：尽快精神科急诊评估，必要时拨打 120 或 110。

> - 抑郁加重到无法起床、无法进食、无法工作生活，或出现幻觉、妄想。
> - 心理治疗过程里情绪剧烈波动，或出现强烈的愤怒、羞耻、被抛弃感而难以承受。
> - 家庭冲突升级到威胁、摔东西、动手，或有人身安全风险。
> - 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变、严重腹泻呕吐：立即急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. 链接

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.2 心理教育

心理教育是双相障碍心理社会干预里最基础、也最容易被做坏的一环：内容不难，难的是怎么讲。这一页写给两类人——想弄明白自己到底得了什么、该怎么配合治疗的患者，以及想帮忙却一开口就吵起来的家属。读完你可以拿到一份“该讲什么”的清单、几种把话说得不伤人的方法，以及一张可以自己填的早期信号表。

一、心理教育到底教什么

心理教育不是把诊断书念一遍，也不是劝人“想开点”。它通常包含四块内容，缺一块效果都会打折。【指南】

第一块，疾病本身。 双相障碍有躁狂或轻躁狂发作，也有抑郁发作，两者可以分开出现，也可以混在一起。它是发作性、容易复发的疾病，不是性格缺陷，也不是意志力问题。多数人经过规范治疗可以回到工作和生活，但“根治”这个说法不准确，更合适的词是缓解、稳定、康复。【指南】

第二块，治疗为什么这样安排。 为什么情绪好了还要继续吃药，为什么医生不肯单用抗抑郁药，为什么要查血药浓度、甲状腺和肾功能。把这些讲清楚，依从性往往比反复叮嘱“记得吃药”更稳。【指南】

第三块，复发的早期信号。 每个人不一样，但常见的有睡眠需求减少、话变多、想法特别快、突然特别有把握、花钱变多、易怒、社交突然增多；抑郁前兆则是睡不好或睡太多、提不起劲、回避人、觉得自己没用。重点是让患者和家属都知道“这个人”的前兆是什么，而不是背教科书。【临床经验】

第四块，生活里哪些事会推高风险。 熬夜、倒班、跨时区旅行、睡眠剥夺、酒精和兴奋剂、重大生活变故、停药或自行减量。这些不是“注意身体”的空话，而是可以具体安排的：固定起床时间、提前倒时差、聚会时怎么拒绝酒。【指南】

二、给患者的版本：把“你得了什么”讲清楚

患者最需要的往往不是安慰，而是解释。可以用“天气预报”作比：情绪本来就有起伏，双相的问题是起伏的幅度和持续时间超出了可调节的范围，所以需要药物把幅度压住，需要作息把节律稳住。比喻只是帮助理解，不能代替诊断标准。

要明确告诉患者三件事：

1. **这不是你的错，但需要你参与。** 疾病有生物学基础，不是“想太多”。同时治疗需要患者记录睡眠、按时复诊、在波动时求助，这些是能做的事。
2. **副作用可以说，不要自己扛。** 手抖、发胖、嗜睡、口干都值得讲，多数可以调整。自己偷偷减药，风险比副作用大得多。【指南】
3. **稳定期是学东西的时候。** 等到复发再学识别信号，学习能力已经被症状打断。

对刚确诊的人，一次讲太多会记不住。可以分两三次，每次聚焦一个问题，给一份写下来的要点，下次复诊再核对。【临床经验】

三、给家属的版本：能做什么、不做什么

家属最常见的两个极端，一是把患者当病人全权代管，二是把波动当成“不努力、作”。心理教育想帮家属找到中间位置：**观察而不监视，支持而不代替，提醒而不训话。**

主题	对患者讲什么	对家属讲什么
疾病性质	发作性疾病，不是性格问题，可以稳定	波动是症状，不是针对你；不要用“你就是懒”解释一切
治疗	药物需要长期维持，副作用可以谈	不要劝停药、不要推荐偏方；帮忙记服药和复诊
早期信号	你自己的前兆是什么，出现时找谁	观察睡眠、话量、花钱、易怒的具体变化，记录而不是质问
生活节律	固定起床、少熬夜、限酒	家庭作息一起稳定；不要把聚会都安排在深夜
危机	有自杀念头要说出来	直接问、认真听、收好危险物品、必要时送急诊

家属也需要被教育的一件事是：**照护很累，累到发脾气是正常的**，但需要有自己的支持，而不是把全部精力压在患者身上。照护者耗竭之后，家庭氛围往往更紧张，反而增加复发风险。【临床经验】

四、怎么讲才不像说教

说教的特点是：讲道理、下判断、给命令、反复重复。它的效果通常是把对方推远。下面这些替换句，可以直接拿去用。【临床经验】

容易说出口、但没什么用的话	换成合作式的说法
“你就是不肯吃药，才老复发。”	“上次停药后大概两周就睡不好了，我们要不要跟医生聊聊怎么让吃药这件事没那么麻烦？”
“你又在乱花钱。”	“这个月有两笔大额支出，我有点担心，我们一起看看账单好吗？”
“你想开点，别整天躺着。”	“我看你这一周都没出门，是没力气，还是不想见人？”
“你就是熬夜熬的。”	“这三天你都是两点后睡，我们要不要把起床时间先固定下来？”
“我都是为你好。”	“我担心的是……你希望我怎么帮你？”

几条原则比句子本身更重要：

- **说具体行为，不说人格标签。** “这周有三天没睡好”比“你最近很不稳定”有用。
- **一次只谈一件事。** 把吃药、花钱、作息、态度一起翻出来，必然吵起来。
- **选时机。** 争吵中、酒后、深夜都不适合谈。约一个双方都不赶时间的白天。
- **先承认感受，再谈事实。** “我知道你觉得被管着很难受”不等于同意对方，但能让对话继续。

- **给选择，不给命令。** “你想自己设闹钟，还是我提醒你？”比“你必须按时吃”更容易被接受。
- **允许对方拒绝。** 说不通就先停下，改成写下来、下次复诊一起说。逼到墙角只会加深对抗。

五、早期信号：一起做一张自己的表

早期信号的价值在于“提前几天到几周”争取到调整治疗的时间。做法是：回顾过去两三次复发，找出最早出现、家属也能看到的两三个变化，写下来，标好第一步该做什么。

信号	可能意味着	第一步做什么
连续两三天只睡四五个小时仍不困	可能进入轻躁狂前期	当晚减活动、固定上床时间，48 小时内联系医生
话明显变多、语速加快、别人插不上话	躁狂谱系波动	减少刺激和社交安排，避免做重大决定，尽快复诊
突然要投资、要大额消费、要辞职	冲动风险上升	暂缓决定，家人共同管理大额支出，联系医生
一周内回避所有社交、起床困难	抑郁前兆	记录睡眠与活动，预约复诊，不逼着“振作”
易怒、为小事爆发、摔东西	混合或躁狂前期	降低对话强度，先保证安全，必要时急诊

这张表建议每半年和医生一起更新一次。人的前兆会变，旧表不一定一直准。【临床经验】

可以用下面几条自查，看看心理教育有没有真正做到位：

- ☐ 我能说出自己的诊断名称，以及它和单相抑郁的区别。
- ☐ 我能说出自己最常见的两个早期信号，家属也知道。
- ☐ 我知道现在每种药的作用和主要副作用，副作用出现时该找谁。
- ☐ 我知道睡眠明显变少时，第一步联系谁、多久之内联系。
- ☐ 家里至少有三句“不容易吵起来”的替换说法。
- ☐ 全家对“什么情况打 120、什么情况去急诊”有共识。

六、常见问题

“讲太多会不会吓到人？” 会，所以分次讲。但完全不讲，患者会把复发当成“自己失败”，家属会把波动当成“故意作对”，代价更大。

“患者不承认自己有病，怎么讲？” 先不谈诊断，谈具体困扰：“你最近睡不好、脾气大，这本身很难受，我们去看看怎么改善睡眠。”在急性躁狂、缺乏自知力时，说服往往无效，重点是保证安全和就医，而不是赢得辩论。【指南】

“家属该不该看病历和诊断？” 患者有隐私权。成年患者在清醒时可以自己决定告诉谁；涉及照护和安全时，可以商量一个双方都能接受的共享范围。具体权利义务以《中华人民共和国精神卫生法》和当地规定为准。

“一次心理教育就够了吗？” 不够。疾病阶段会变，问题会变，建议在确诊时、每次调整方案时、每次复发后各回顾一次。

“青少年怎么讲？” 用他们能懂的语言，保留自主感，同时让家长参与作息和安全管理。学校和老师知道多少，由青少年和家长共同决定。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 连续几天睡眠显著减少、话多停不下来、冲动消费或危险驾驶：尽快精神科急诊，必要时拨打 120 或 110。
- 家属发现患者出现新的、持续加重的异常想法（被监视、被针对、听到别人听不到的声音）。
- 家庭沟通反复失败、冲突升级到威胁或动手：先保证安全，再寻求家庭治疗或社区帮助。
- 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变、剧烈呕吐腹泻：立即急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. 链接

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.3 CBT 与 DBT 情绪调节

认知行为治疗（CBT）和辩证行为治疗（DBT）经常被一起提到，但它们解决的问题不太一样：CBT 更擅长处理“想法怎么把情绪越推越低”，DBT 更擅长处理“情绪一下子冲上来、马上就要做点什么”的时刻。这一页讲清两者的核心技术和分工，给出一套可以本周就开始练的最小版本，也说明它们各自在什么阶段不该硬做。适合已经进入稳定期、想做点结构化练习的患者和家属。

一、两种治疗在双相里分别管什么

维度	CBT（认知行为治疗）	DBT（辩证行为治疗）
主要目标	识别并修正失真的想法，减少回避，恢复活动	提高情绪耐受与调节能力，减少冲动和自伤
典型问题	反复抑郁、焦虑、自责、社交回避、拖延	情绪爆发、自伤、冲动消费、人际冲突、空虚感
核心假设	想法影响情绪和行为，改变想法与行为能改善情绪	情绪敏感加上长期不被理解的环境，会让人用极端方式调节情绪
主要技术	思维记录、行为实验、行为激活、复发预防计划	正念、痛苦耐受、情绪调节、人际效能
在双相中的位置	缓解期抑郁与焦虑的残留症状、复发预防【指南】【研究】	共病边缘型人格、自伤、情绪失调时的补充【研究】【待验证】
什么时候不宜做	急性躁狂、注意力无法集中、判断力明显受损时	严重躁狂或混合状态、无法安坐完成练习时

两者都是“加在药物治疗之上”的，不是替代。差别在于：CBT 更偏“想清楚再行动”，DBT 更偏“先撑过这一波，再想办法”。

二、CBT：把“想法—情绪—行为”拆开

CBT 的基本功是把一个模糊的难受，拆成三个可以观察的部分：当时脑子里闪过什么念头、情绪是什么、接下来做了什么。这三者互相喂养，抑郁时尤其明显：觉得自己没用，于是推掉聚会，推掉之后更确信自己没用。

认知重构不是“往好处想”，而是检验想法是否站得住。常用的一步是问自己几个问题：

- 支持这个想法的证据是什么？反对的证据是什么？
- 有没有别的解释？
- 如果朋友遇到同样的事，我会怎么跟他说？
- 这个想法对我有帮助吗，还是让我更动不了？

常见想法模式	例子	可以问自己
全或无	“这次没做好，我就是个失败者。”	这件事有多少是全部，有多少只是一部分？
灾难化	“这次复发肯定又要住院，工作保不住	最坏会怎样？最可能怎样？我能做的是

常见想法模式	例子	可以问自己
	了。”	什么？
读心	“他们没叫我，肯定是嫌我麻烦。”	还有没有别的可能？我有没有问过？
应该式	“我应该一直保持高效。”	这个标准对病人也成立吗？是谁定的？
情绪化推理	“我觉得没希望，所以就是没希望。”	感觉是信息，还是事实？

行为实验是把想法当假设去检验，而不是靠说服。比如抑郁期认定“我去了也没人理我”，可以约定：去待二十分钟，记录三个人有没有跟我说话、我的情绪从几分变到几分。结果常常是“没有想象中好，但也没有想象中糟”，这个真实的差别比任何鼓励都有用。

行为激活的核心是“按计划行动，而不是等心情好了再行动”。把目标拆到很小：不是“恢复运动”，而是“周二下午下楼走十分钟”。完成后打勾，不评价好坏。

复发预防部分通常包括：写下自己的早期信号、列出触发情境、准备一张“当睡眠开始变少时我做什么”的应对卡。这部分和 6.4 的社会节律内容可以配合使用。

需要提醒的是，CBT 在双相里的证据主要集中在缓解期的抑郁症状和复发预防，对急性躁狂没有多少用武之地。躁狂期做认知作业，既做不到，也容易变成新的挫败。【指南】

三、DBT：情绪冲上来的时候先撑住

DBT 把技能分成四组，顺序有讲究：先能稳住自己，再谈改变。

正念是基础，练的是“注意到自己现在在想什么、感觉什么，但不立刻反应”。最简单的是三分钟呼吸空间：注意呼吸，注意身体感觉，注意念头的来去，然后回到当下。

痛苦耐受用于“现在很难受，但暂时改变不了”的时刻。常用技能包括：

- **STOP**：停下来（Stop）、退一步（Take a step back）、观察（Observe）、继续有意识地行动（Proceed）。
- **改变身体状态**：用冷水洗脸、短时剧烈运动、缓慢呼吸，先把生理唤醒降下来。
- **转移注意**：用活动、付出、比较、换个情绪、推开念头、想象、身体感觉等方式，暂时离开痛苦的漩涡。
- **自我安抚**：用五感——看、听、触、闻、尝，找一件当下能做到的小事。
- **权衡利弊**：写下“冲动行事”和“忍住不做”各自的短期与长期后果。

情绪调节包括：给情绪命名（是愤怒、羞耻，还是被抛弃的恐惧）、减少情绪脆弱性（睡眠、饮食、运动、规律服药）、积累正性体验、反其道而行（情绪想让你躲起来时，做一点相反的小动作）。

人际效能分两套：一套是提出请求或拒绝（把事实说清楚、表达感受、提出具体要求、说明好处、保持自信）；另一套是维持关系（认真听、认可对方、温和表达）。对双相患者来说，这套技能在家庭冲突和职场沟通里很实用。

DBT 在双相领域的直接研究比 CBT 少，样本通常较小，结论也不完全一致；目前更常见的做法是用它处理情绪失调、自伤和共病人格障碍，而不是当作双相的核心治疗。【研究】【待验证】

四、CBT 和 DBT 怎么分工

- **主要问题是“越想越低落”**：反复自责、回避、对什么都没兴趣——先做 CBT 的行为激活和认知重构。
- **主要问题是“一下子炸掉”**：情绪几秒钟冲到顶点、摔东西、自伤、说完就后悔——先做 DBT 的痛苦耐受和情绪调节。
- **两者都有**：可以先学 DBT 的稳定技能，再进入 CBT 的认知工作；顺序反过来也常见，取决于当前最危险的问题。
- **共病边缘型人格障碍**：DBT 的证据更充分，通常需要更长周期和团体加个体组合。【研究】
- **急性期**：先药物和休息，技能训练推迟到能坐下来的时候。硬推作业会让人觉得“连治疗都做不好”。

五、一周可以怎么练：一个最小版本

- ☐ 每天睡前用两分钟记：今天情绪最高几分、最低几分，睡眠几小时，有没有吃药。
- ☐ 一周做一次思维记录，只挑一个最难受的瞬间，不用写满整页。
- ☐ 一周做一次小的行为实验，提前写下预测，事后记录真实结果。
- ☐ 把 STOP 写在手机备忘录第一行，情绪上来时先停十秒。
- ☐ 给自己列三个五分钟内能做完的“安抚动作”，难受时不用现想。
- ☐ 周末花十分钟回顾：哪一条有用，哪一条做不到，下周只保留一条继续练。

六、容易踩的坑

把 CBT 变成自我批评的新工具。 思维记录不是“找出自己哪里想错了再骂自己一遍”，而是好奇地看看想法有没有别的可能。

把“正面思考”当目标。 否认症状、强行乐观，往往让情绪反弹得更厉害。CBT 要的是更准确的想法，不是更开心的想法。

在躁狂期硬做认知作业。 这个阶段注意力、判断力都受影响，做了也记不住，还容易起冲突。

用 DBT 压住所有情绪。 痛苦耐受是“撑过这一波”，不是“从此不许难受”。长期压抑反而增加爆发风险。

只上课不练。 技能是练出来的，不是听会的。每周一次会谈、其余六天不练，效果通常有限。【临床经验】

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

- 出现自杀念头、自伤冲动，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 自伤后伤口较深、出血不止、意识不清：立即急诊。
- 练习中反复出现强烈的创伤画面闪回、解离、惊恐，难以自行平复：暂停练习并联系治疗师。
- 睡眠连续几天显著减少、话多、冲动加重：先处理病情，暂停认知作业。
- 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变：立即急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- Lam DH, et al. A randomized controlled study of cognitive therapy for relapse prevention for bipolar affective disorder. Archives of General Psychiatry, 2003.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.4 人际与社会节律治疗 IPSRT

人际与社会节律治疗（Interpersonal and Social Rhythm Therapy，简称 IPSRT）是专门为双相障碍发展出来的一种心理治疗。它有两个抓手：一是把每天的作息、睡眠和社交活动变得规律，二是处理打乱这些规律的人际事件——换工作、升学、分手、生育、丧亲。这一页讲清楚它为什么对双相特别重要、社会节律表怎么记、睡眠该怎么稳，以及角色转换和人际冲突可以怎么提前安排。适合作息一乱就波动、或者每次生活一变就复发的患者。

一、IPSRT 的基本想法：情绪对“节律”特别敏感

人的身体里有一套近似二十四小时的生物钟，它靠外界线索来校准：光线、吃饭时间、活动时间、和人打交道的时间。这些线索在学术上叫“授时因子”，意思是“给钟对时的东西”。对大多数人来说，最强的对时信号是睡眠与觉醒的节律，其次是工作、学习和社交的固定安排。

IPSRT 的出发点是：双相障碍的人，生物钟对节律改变比一般人更敏感。一次熬夜、一次跨时区飞行、一段连续加班、一场持续到凌晨的争吵，都可能让生物钟错位，接着出现睡眠减少、情绪升高，最后发展成一次发作。【研究】

所以 IPSRT 不把作息当成“养生建议”，而当成治疗的一部分：把每天的关键时间点固定下来，让生物钟有一个稳定的参照；同时在生活必然发生变化时，提前给节律留出缓冲。

二、社会节律表：把“规律”变成看得见的东西

IPSRT 最常用的工具是“社会节律表”。做法很简单：每天记录几个固定时间点，再给当天的规律程度打一个分。

记录项	记什么	为什么重要
起床时间	实际离床的时间，不是闹钟时间	起床时间是校准生物钟最强的锚点
第一次与人接触	几点、和谁、面对面还是线上	社交是重要的对时信号
开始工作或学习	几点进入状态	固定“开始”比固定“结束”更容易做到
正餐时间	早、中、晚大概几点	进食时间也在给身体对时
晚上的活动	几点结束、是否兴奋	夜间强光和高唤醒活动会推迟入睡
上床与入睡	分开记，躺下不等于睡着	入睡困难往往比“睡得晚”更早出现
规律评分	1 分最乱，5 分最规律	用趋势看变化，不用单日评判自己

这张表不需要写得很细，每天两三分钟就够。连续记两周，通常能看出“哪一项最先崩”：有人是起床时间一乱就出事，有人是晚上社交一多就睡不着，有人是周末补觉把整周节奏带偏。

记录的目的不是拿满分，而是提前发现偏离。比如这周有三天的起床时间比平时晚了两个小时，就是一个值得跟医生说的信号，而不是“我又没坚持住”。【临床经验】

三、睡眠稳定：最该守住的那一根柱子

在双相障碍里，睡眠减少不只是发作的结果，很多时候是发作的前兆。连续几天睡得少却仍然精力充沛、不觉得困，是轻躁狂最典型的早期表现之一。【指南】

几条具体做法：

- **先固定起床时间，再谈早睡。** 起床时间是自己能控制的，入睡时间受情绪和身体影响大。固定起床、白天见光，晚上自然更容易困。
- **周末不要大补觉。** 周六睡到中午，相当于每周给自己一次“跨时区”。最多比平时晚一小时。
- **白天要有光和活动。** 上午出门走一段、把窗帘拉开，比晚上提前躺下更有用。
- **睡前留出降速带。** 睡前一小时不处理工作、不吵架、不刷刺激性的内容，把灯调暗。
- **不要用酒精助眠。** 酒能让人更快睡着，但会破坏后半夜的睡眠结构，还和很多药物相互作用。
- **倒班与跨时区要提前规划。** 尽量少排连续夜班；长途飞行后给自己留几天缓冲，按目的地时间吃饭和见光，而不是靠补觉硬扛。
- **睡眠明显变少时，先联系医生，不要自己加助眠药或加心境稳定剂。** 用药调整必须由医生决定。

可以直接照着做的睡眠清单：

- ☐ 每天同一时间起床，误差尽量不超过一小时。
- ☐ 周末最多比平时晚起一小时，不靠补觉还债。
- ☐ 上午出门见光至少二十分钟，阴天也算。
- ☐ 睡前一小时把灯调暗，停止工作和争论。
- ☐ 不用酒精助眠，也不靠加量镇静药自己解决失眠。
- ☐ 连续两晚睡眠明显减少，或白天不困反而不累，联系医生。

四、角色转换：生活一变，节律先乱

IPSRT 把容易引发波动的人际情境归成几类，其中最常见的是“角色转换”：从学生到上班族、换城市、升职、失业、结婚、生育、退休、成为照顾者。角色一变，作息、身份感、人际圈子同时变，节律最容易被打散。

可以做的事：

1. **提前一两周开始调作息。** 新工作八点上班，就不要等到第一天再改起床时间。
2. **一次只变一件事。** 换工作、搬家、生孩子尽量不要挤在同一个月。
3. **给新阶段设一个“节律缓冲期”。** 前一两个月减少夜间社交，把睡眠当成硬任务。
4. **提前告诉一两个可信的人。** 让同事、室友或家人知道“我睡眠乱了可能会生病”，比事后解释容易。
5. **允许自己哀伤。** 失去健康、失去原来的工作能力、失去一段关系，都是真实的丧失。IPSRT 会专门留出空间谈这些，而不是要求“赶紧往前看”。

五、人际冲突：把话说清楚，也是在稳节律

IPSRT 的另一半是人际关系。它关注的不是“谁对谁错”，而是冲突怎样持续消耗睡眠和情绪。常见的四类主题是：哀伤与丧失、角色转换、角色争议（和重要的人长期争执）、人际上的孤立与技巧不足。

几个可操作的调整：

- **把冲突挪出深夜。** 晚上十一点后的争执，代价通常是整夜睡不着。可以约定“这件事明天白天再谈”。
- **说具体请求，不说人格评价。** “你能不能十一点后戴耳机”比“你从来不管别人”更容易被接受。
- **事后修复比当场赢更重要。** 吵完之后一句“我昨天话说重了”，能显著降低后续的紧张。
- **识别“高唤醒”话题。** 钱、家务、双方父母、孩子教育，这些话题容易升级，可以限定时间、限定一次只谈一个。

IPSRT 通常以个体形式进行，家庭聚焦治疗则以家庭为单位，两者可以配合：先用 IPSRT 把自己的节律稳住，再用家庭治疗处理互动模式。

六、为什么对双相特别重要

第一，双相的复发和睡眠-觉醒节律关系非常紧密。睡眠剥夺可以诱发躁狂样表现，这一点在实验研究和临床观察中方向比较一致。【研究】

第二，双相的人即使情绪稳定，社会节律也常常比一般人乱：晚上活动多、起床时间漂移、周末补觉。节律一乱，早期信号就容易被掩盖。

第三，IPSRT 的随机对照研究显示，接受 IPSRT 的人在两年随访中社会节律更稳定、到复发的时间更长；社会节律的改善和复发风险的下降有关联。【研究】指南也把 IPSRT 列为缓解期复发预防的可选心理干预之一。【指南】

需要说清楚的是，IPSRT 不能替代药物，也不能保证不复发。它的作用是让波动更早被发现、让生活结构更稳，从而减少发作的机会和代价。

七、常见问题

“我上夜班，做不到规律怎么办？” 完全规律不现实，但可以做到“相对固定”：固定白天补觉的时段、固定吃饭时间、下班路上戴墨镜减少强光、避免频繁在夜班和白班之间切换。具体安排可以和医生、单位一起商量。

“记了几天就忘了。” 把表放在牙刷旁边，或者设一个每晚固定时间的手机提醒。忘了就补记大概时间，不要因为“记得不完整”就整周放弃。

“周末补觉真的不行吗？” 偶尔一次影响不大，但每周都补，等于每周给自己制造一次时差。比平时晚一小时以内比较安全。

“换了新工作，作息暂时乱一点没关系吧？” 短期的乱可以接受，但要主动安排恢复，并在这段时间更频繁地记录睡眠和情绪。

“IPSRT 要做多久？” 通常是数月、十余次以上的结构化会谈，分阶段进行；具体次数取决于病程、问题和资源。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

- 连续两三天睡眠明显减少，仍然不困、精力特别好：尽快联系医生，这可能是躁狂前期。
- 连续几天几乎不睡，伴话多、冲动、易怒、行为失控：尽快精神科急诊，必要时拨打 120 或 110。
- 出现自杀念头、自伤行为：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 跨时区旅行或倒班后情绪明显波动，自己调整不过来。
- 角色转换期（生育、失业、丧亲）出现持续两周以上的严重失眠或情绪低落。
- 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变、剧烈呕吐腹泻：立即急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- Frank E, et al. Two-year outcomes for bipolar disorder patients treated with interpersonal and social rhythm therapy. Archives of General Psychiatry, 2005.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.5 家庭聚焦治疗

家庭聚焦治疗（Family-Focused Therapy，简称 FFT）是给双相障碍患者和家属一起做的结构化心理治疗。它不追问“这个家哪里出了问题”，而是教一家人怎么把话说清楚、怎么一起解决具体麻烦、怎么在帮忙和放手之间找到边界。这一页讲 FFT 的三个组成部分、高情感表达是什么意思、家庭会议怎么开，也专门谈照护者的负担。适合关系紧张、一说话就吵、或者家属不知道该怎么帮的家庭。

一、家庭聚焦治疗是什么

FFT 一般包含三块内容，按顺序推进：先做心理教育，让全家对疾病有共同的理解；再练沟通，减少批评、打断和回避；最后练问题解决，把“总是吵的那件事”拆成可以执行的步骤。完整疗程通常十余次到二十余次，持续数月，可以是一个家庭单独做，也可以是几个家庭一起的团体形式。【指南】

它有一个明确的前提：**家庭不是病因。** 双相障碍有很强的生物学基础，任何家庭都不可能“把孩子逼出双相”。但家庭互动会影响病程：冲突多、批评多、过度卷入的环境，和更高的复发率相关；稳定、清楚、有支持的环境，则有助于恢复。FFT 改的是后者，不是追究前者。【研究】

所以家属听到“家庭治疗”不必紧张，它不是审判，也不要求谁认错。它的目标很具体：让一家人少吵几场、早发现几天、在危机时不乱。

二、高情感表达：不是爱太多，是批评和卷入太多

研究里常提到“高情感表达”这个概念，指的是家属对患者的批评多、敌意明显，或者过度卷入患者的生活。它不等于“关心得多”，也不等于家庭不和睦。很多高情感表达的家庭非常爱孩子，只是表达方式让患者时刻感到被评判。【研究】

需要强调的是，这不是在怪家属。长期照护一个情绪起伏的人，任何人都会疲惫、急躁、说话变冲。高情感表达是可以改变的互动模式，不是人格缺陷。

常见表现	患者接收到的信息	可以换成
“你又这样，你就是不肯配合。”	我是个累赘、我做什么都错	“我看你这周睡得少，要不要一起找医生调一下？”
反复追问“你今天到底怎么了”	我被监视、我没有空间	“你想说的时候我在，不想说也没关系。”
替患者推掉所有社交和工作	我什么都做不了	“这次你想自己去，还是我陪你去？”
当着外人讲患者的病情细节	我被当成病例	先问“这件事我可以跟谁说？”
一吵架就翻出过去的账	我永远洗不清	一次只谈这一件事

降低高情感表达，不是让家属变得冷淡，而是把“评价人”换成“描述事”，把“替你做”换成“和你一起做”。

三、沟通训练：先说感受，再说请求

FFT 的沟通练习通常从三段式开始：**当……发生时，我感到……，我希望……。** 例如：“当你凌晨还在客厅放很大声的音乐时，我会睡不好，也担心你，我希望十一点后能戴耳机。”

三个要点：

1. **说具体行为和时间，不说人格。** “这周有三个晚上两点后才睡”比“你太不自律了”更容易被听进去。
2. **说自己的感受，不替对方下结论。** “我担心”是安全的，“你就是故意的”会立刻引发防御。
3. **提一个具体、可做到、有时限的请求。** “明天开始十一点戴耳机”比“你以后注意点”有用。

倾听同样需要练。最简单的做法是复述：“你的意思是，你觉得我老盯着你吃药，让你很有压力，是吗？”复述不是同意，而是让对方确认“你有没有听懂”。很多争吵其实是因为双方都在准备反驳，没人真的在听。

还有几条规则能显著降低冲突：不打断、不翻旧账、不读心（“你不说我也知道你怎么想”）、不在深夜和酒后谈重要的事、情绪过热时约定暂停二十分钟再回来。

四、问题解决：一次只解决一个

FFT 的问题解决有固定步骤，看起来笨，但能防止讨论滑回吵架：

1. **定义问题**：用一句话说清，具体、可观察。不是“家里气氛不好”，而是“早上叫起床要吵二十分钟”。
2. **头脑风暴**：先不评价，能想到的都写下来，包括看起来不现实的。
3. **评估**：每条方案的好处、代价、可行性。
4. **选一个**：不选最完美的，选最可能执行的。
5. **分工与时间**：谁做什么、什么时候开始、做多久。
6. **回顾**：约定一周后看效果，不行就换，不追责。

问题	方案	谁负责	什么时候回顾
早上起床冲突	患者自己设两个闹钟；家属只叫一次	患者为主	一周后
大额消费	超过约定金额先放 24 小时再决定	双方	两周后
复诊总忘	把复诊日写进家庭日历，提前一天提醒	家属	下次复诊
夜间音乐声	十一点后戴耳机	患者	一周后

家庭会议可以固定下来：每周一次、不超过半小时、有简单的记录。时间固定比内容完美更重要。

五、边界：帮忙不等于接管

双相障碍会让人在某些阶段判断力下降，家属自然会想多管一点。但长期接管会让患者失去自主感，也让家属耗竭。边界不是冷漠，是把“我能负责的”和“你要负责的”分开。

- ☐ 钱：约定一个需要商量的金额上限，急用时怎么办，写下来。
- ☐ 服药：家属可以提醒、可以帮忙分装，但不代替患者决定吃不吃、吃多少。
- ☐ 隐私：哪些情况可以告诉亲戚、单位、学校，由患者在稳定时决定。
- ☐ 同住：作息、噪音、访客的规则，双方都要遵守，不是只约束患者。
- ☐ 照护分工：谁陪诊、谁管钱、谁值夜，写清楚，别默认由一个人扛。
- ☐ 危机边界：什么情况打 120、什么情况报警、什么情况送急诊，提前说好，避免当场争执。

边界也要有弹性。急性期需要更多代管，稳定期要逐步交还。可以每次复诊后重新讨论一次。

六、照护负担：家属也需要被照顾

照护者的负担是真实的：请假陪诊、夜里不敢睡熟、担心钱、被亲戚指责“没管好”、朋友渐渐不联系、自己也睡不好。很多家属会说“我没事”，然后在一两年后突然垮掉。

几件值得做的事：

- **分工，而不是一个人全包。** 哪怕只是把“陪诊”和“管钱”分给两个人。
- **安排喘息。** 每周有半天完全属于自己的时间，不是奢侈，是维持照护能力的必要条件。
- **找同伴。** 家属互助团体里，别人听得懂你在说什么，这种理解很难从别处获得。
- **自己也要看医生。** 长期失眠、焦虑、抑郁不是“想开点”能解决的。
- **允许自己生气。** 对患者发火不代表你不爱他，压抑的愤怒最后往往以更伤人的方式出来。
- **不把全部身份变成“照护者”。** 保留工作、朋友、爱好，哪怕缩减。

七、常见问题

“家庭治疗是不是说明我们家有问题？” 不是。它假设家庭是重要的支持系统，目标是让支持更有效，而不是找责任人。

“患者不肯参加怎么办？” 先由家属单独和医生或治疗师谈，学习沟通和边界；等患者愿意时再加入。强迫参加往往效果不好。

“家里人对病情的看法不一致。” 很常见。可以请医生给全家做一次统一的心理教育，把分歧放在“怎么执行”而不是“谁对谁错”上。

“要不要告诉亲戚和单位？” 由患者在稳定时决定，家属尊重这个决定。涉及照护和安全的部分，可以商量一个共享范围。

“要做多久？” 通常数月。危机期频率高一些，稳定后可以拉长间隔或改成定期复诊。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

- 家里有人出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 患者连续几天睡眠显著减少、话多、冲动、易怒，家庭已经无法保证安全：尽快精神科急诊，必要时拨打 120 或 110。
- 家庭冲突升级到威胁、摔东西、动手，或有人身安全风险：先离开现场、保证安全，必要时报警。
- 照护者自己出现持续失眠、绝望感、无法坚持日常：这需要被当成问题处理，而不是硬扛。
- 患者或家属遭受言语、经济、身体层面的虐待：联系社区、警方或法律途径。
- 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变：立即急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- Miklowitz DJ, et al. A randomized study of family-focused psychoeducation and pharmacotherapy in the outpatient management of bipolar disorder. Archives of General Psychiatry, 2003.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.6 职业康复、同伴支持与个案管理

症状稳定不等于生活恢复。很多人停药、复诊都做到了，却卡在“回不去工作”“不敢回学校”“不知道该找谁帮忙”上。这一页讲三件常被忽略的事：怎样分阶段复工复学，支持性就业和同伴支持分别能提供什么，个案管理怎样把医院、社区、单位之间的碎片连起来。适合病情已相对稳定、正在考虑回归工作学习的患者，以及想帮忙找资源的家属。

一、康复的目标不是“回到病前”，而是找到能持续的生活

很多人把康复理解成“变回生病前的样子”。这个目标听起来合理，实际上常常做不到，也没必要：生病这几年，人的年龄、体力、家庭责任、职业环境都变了。

更现实的目标是：有一份自己能承受的工作或学习节奏，有几位能说真话的人，能照顾好自己的吃睡和吃药，遇到波动知道找谁。这四项里任何一项改善，都是康复的进展。【临床经验】

工作对康复有明确的好处：它提供结构（每天有事做）、身份（我不只是病人）、收入、社交。但工作也是压力源，尤其是夜班、频繁出差、高压考核、人际复杂的岗位。所以问题不是“要不要工作”，而是“什么样的工作、以什么节奏、配什么支持”。

二、复工复学：先评估，再分阶段

什么时候可以考虑。 通常需要症状稳定一段时间、睡眠相对规律、药物方案稳定（最近没有频繁调整）、精力和注意力能支撑几小时的活动。具体多久由医生结合病程判断，没有统一标准。【临床经验】

先做一次功能评估。 和医生一起看几件事：注意力能不能连续集中半小时以上、有没有明显的镇静或手抖影响操作、体力能撑多久、情绪波动会不会被特定场景触发。这些比“我感觉好多了”更能预测能不能撑住。

分阶段回去，而不是一步到位。 常见的路径是：先做志愿者或兼职，每周几个小时；适应后再增加天数；最后恢复全职。复学可以先修少量课程、申请缓考或延长学制。阶梯式回归的复发风险通常低于直接满负荷。【临床经验】

和单位或学校怎么谈。 没有标准答案，取决于环境、关系和个人意愿。可以只谈“需要什么安排”，不必完整交代诊断：

- 固定的白班，尽量不排连续夜班；
- 减少频繁出差和跨时区飞行；
- 允许定期请假复诊；
- 一段时间的弹性工时或部分工作量；

- 安静一些的工位，减少持续高强度的人际消耗。

如果单位或学校愿意配合，把这些安排写下来，约定试行多久、怎么评估。口头承诺容易在忙起来之后消失。

关于要不要告知。 法律禁止基于精神障碍的就业歧视，患者也有隐私权，但现实中歧视仍然存在。是否告知、告知多少、什么时候告知，需要结合岗位、单位文化、病情稳定程度来权衡，没有统一建议。可以先把“需要什么便利”想清楚，再决定说到什么程度。涉及法律权益时，以《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国残疾人保障法》和当地规定为准。

复工前的准备	具体做什么
医疗评估	和医生确认稳定程度、副作用对工作的影响、复诊频率
节奏设计	先兼职或部分课程，设定每周上限，留出恢复日
睡眠安排	固定起床时间，避免夜班和跨时区，提前和单位沟通
支持人选	指定一位同事或同学，在状态不对时能提醒你
预警方案	写好睡眠、情绪、花钱的早期信号，出现时怎么处理
经济预案	算清收入变化、医保和补贴是否受影响，留出缓冲

动手之前，先过一遍这份自查：

- ☐ 最近一个月睡眠基本规律，没有连续熬夜。
- ☐ 药物方案稳定，最近没有频繁调整。
- ☐ 能连续专注半小时以上，副作用不影响操作和通勤。
- ☐ 已经和医生讨论过工作强度、复诊频率和夜班问题。
- ☐ 有一份写下来的早期信号和应对办法，家人或朋友也知道。
- ☐ 算过收入变化对医保、低保或其他补助的影响。

三、支持性就业：先上岗，再训练

传统做法是“先长期培训、等能力够了再找工作”，支持性就业反过来：先按本人的意愿找到真实岗位，再在工作中提供持续支持。国际上比较成熟的是“个体安置与支持”模式，几条原则很清楚：以竞争性就业为目标、快速上岗、尊重本人意愿、把就业服务和治疗团队结合起来、提供长期跟进。【研究】

在严重精神障碍人群中，这类模式的就业率通常高于“先训练后就业”的传统路径；专门针对双相障碍的研究相对少一些，但结果方向一致。【研究】国内一些地区有辅助性就业、按比例就业、残疾人就业服务机构，具体形式和覆盖范围差异很大，需要向当地残联和人社部门确认。

支持性就业不是“随便找个活干”。它强调岗位和人的匹配：避开连续夜班和高压销售，优先考虑节奏可控、任务清楚、允许请假的岗位。收入增加可能影响低保或其他补助，复工前要算清楚，必要时咨询当地民政或残联。

四、同伴支持：过来人的作用与边界

同伴支持是受过培训的康复者，用自己的经历提供陪伴、信息和希望。形式包括医院里的康复小组、社区同伴支持员、线上互助群、家属互助组织。

它最独特的作用是“你不需要解释，对方就懂”。这种被理解的感觉，很难从医生或家人那里完全获得。同伴还能提供非常具体的信息：怎么跟单位请假、哪家医院复诊排队短、哪种副作用别人是怎么熬过去的。【个人体验】

但同伴支持有明确边界：

能做	不能做
分享自己的经历和应对办法	替你判断该吃什么药、该不该停药
陪你去看诊、帮你整理问题	替代医生做诊断
在低谷时提供陪伴和希望	承诺“照我的方法就能好”
介绍资源和政策信息	推荐偏方、保健品、收费疗程

遇到劝你停药、减药、换医生的“同伴”，要警惕。经验可以参考，处方只能由医生开。【指南】

五、个案管理：有人帮你把碎片连起来

双相障碍的治疗常常散在不同地方：医院开药、社区随访、心理治疗、康复训练、就业服务、医保报销。个案管理的作用是找一个人（社工、社区精防医生、医院个案管理师）把这些连起来：评估需求、制定计划、陪同转介、定期跟进、危机时协调。

适合考虑个案管理的情况：反复住院、同时跑好几个科室、独居或家庭支持薄弱、经常漏诊漏药、经济或住房困难。

在中国大陆，社区卫生服务中心的精神卫生防治医生通常承担随访和服药管理；部分地区对包括双相障碍在内的严重精神障碍有规范化的社区管理，具体内容和频率以当地规定为准。【指南】

六、社区资源地图：遇到问题可以找谁

你需要什么	通常可以找
调药、急性期处理	精神专科医院或综合医院精神心理科
日常随访、服药管理	社区卫生服务中心精防医生
结构化心理治疗	医院心理治疗门诊、有资质的心理治疗师
康复训练、日间活动	社区康复站、日间医院、阳光家园等
找工作、职业培训	当地残联就业服务机构、公共就业服务
经济困难	民政低保、临时救助、残联补贴
家属支持	家属互助组织、医院家属课堂
危机	120、110、12356 心理援助热线

政策各地差异很大，同一个城市不同区也可能不同。最省事的办法是问社区精防医生或医院社工：“我这个情况，本地能申请什么？”

七、常见问题与容易踩的坑

“等我完全好了再工作。” 完全好的标准很难达到，等待本身会让人更退缩。更现实的做法是从很小的量开始试。

“一复工就上全职。” 这是复发的常见诱因。前三个月按七成负荷安排，往往比满负荷撑得更久。

“把同伴支持当治疗。” 同伴能陪你走一段，但不能替代药物和复诊。

“复发一次就再也不敢找工作。” 复发是疾病的一部分，不是能力的判决。可以和医生、就业服务一起分析上次是什么触发了，下次怎么改。

“不知道有补贴，白扛了几年。” 主动问。很多政策不会主动找上门。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，立即拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 复工复学后连续几天睡眠明显减少、话多、冲动、无法完成任务：尽快联系医生，必要时暂停工作或学习。
- 工作或学校里遭遇歧视、霸凌、被强制透露病情：保留证据，向单位人事、学校或法律途径求助。
- 出现严重的职场恐慌、无法出门、持续回避：这可能是焦虑共病，需要评估而不是硬撑。
- 经济困难到影响吃饭、住房、买药：联系社区、民政或社工，不要自行减药。
- 服药后出现严重皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变：立即急诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. 链接

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 7：物理与其他治疗

物理治疗在严重躁狂、紧张症、难治性抑郁和特定人群中有一席之地，但不是“电击惩罚”。

7.1 无抽搐电休克 ECT

“电休克”这三个字，可能是精神科里被误解最深的词。很多人一听就想到电影里的惩罚场面：人被按住、电流穿过身体、痛苦抽搐。现代的无抽搐电休克（ECT）完全不是那样——它在全身麻醉和肌肉松弛下进行，患者睡着、不抽搐、没有疼痛。这一页讲清 ECT 到底怎么做、对哪些双相情况最有用、记忆受影响到底有多大，以及知情同意意味着什么。读完你能判断：当医生建议 ECT 时，这是在冒什么险、换什么收益。

一、ECT 到底是什么

ECT 的做法是：在短暂的全身麻醉下，用经过精确控制的微弱电流诱发一次大脑的癫痫样放电，人为地“重启”一部分神经环路。因为同时用了肌肉松弛剂，身体不会出现明显的抽搐，所以叫“无抽搐电休克”或“改良电休克”。整个治疗过程通常只有几分钟，患者醒来时对治疗本身没有记忆。

它常被误认为“最后的手段”或“惩罚性治疗”，这两个印象都不准确。ECT 是目前精神科里起效最快的物理治疗之一，对严重躁狂、紧张症、高自杀风险的抑郁，往往在几天到一两周内就能看到明显变化，而药物起效通常要更久。对某些人来说，它不是“没招了才用”，而是“越早用越安全”。【指南】

当然，它不是万能，也不是没有代价。ECT 需要麻醉、需要评估躯体风险、可能影响记忆，也需要患者或监护人的知情同意。把它讲清楚，比简单地说“很安全”或“很可怕”都更有用。

二、谁适合：几类最常考虑的情况

情况	为什么会考虑 ECT	需要知道的事
严重躁狂，药物控制不住	起效快，能迅速降低兴奋和耗竭风险	常需联合药物，之后进入维持治疗
混合发作，自杀风险高	对混合症状和自杀意念有较快作用	需要严密监护，防止冲动
紧张症（木僵、拒食、不动）	是一线治疗，延误可能危及生命	同时要排查躯体病因
严重抑郁，伴精神病性症状	对幻觉妄想和抑郁同时有效	常作为首选之一，而非最后选择
高自杀风险，需要尽快起效	比药物更快降低风险	不能替代环境安全管理
药物治疗无效或不耐受	是难治性病例的重要选项	需要评估既往治疗是否足够
孕期、老年、躯体病多	在严密评估下可考虑	需产科、麻醉、内科共同参与

这张表里最需要划重点的是**紧张症**。紧张症不是“闹脾气不说话”，而是可以出现木僵、拒食、保持奇怪姿势、缄默、模仿动作，严重时高热、脱水、电解质紊乱，甚至致命。遇到这种情况，ECT 不是“试试看”，而是应当尽快评估的救命手段。【指南】

对严重躁狂也一样。躁狂本身很少直接致命，但连续几天不睡、不吃不喝、极度兴奋导致的体力耗竭、脱水、冲动受伤，是可以致命的。当药物需要几天才起效，而人已经撑不住时，ECT 的价值就出来了。

三、一次治疗是什么流程

ECT 通常在专门的治疗室进行，流程大致如下：

1. **治疗前评估**：查心电图、血液化验、胸片等，麻醉医生评估气道和心肺风险；有假牙、松动牙齿、青光眼、近期心梗、颅内压增高等情况要提前说明。
2. **禁食禁水**：按麻醉要求空腹，具体时间由医生交代。
3. **建立静脉通路、连接监护**：监测心电、血压、血氧，贴上脑电电极记录放电情况。
4. **麻醉与肌肉松弛**：患者几秒钟内入睡，肌肉放松，不会感到电流，也不会剧烈抽搐。
5. **给予刺激**：医生根据癫痫样放电是否足够来调整方案。
6. **苏醒与观察**：在恢复室观察血压、心率、意识，完全清醒后回病房。当天可能有头痛、肌肉酸痛、恶心、短暂的意识混乱。
7. **疗程安排**：通常需要连续多次，频率和总次数根据疗效和耐受调整；症状控制后可能改为间隔更长的维持治疗。

治疗当天最好有人陪同，不要自己开车。麻醉后 24 小时内不要做需要高度注意力的工作，不要签重要文件，不要独自照顾小孩。

四、记忆和认知：最需要说清楚的部分

ECT 最常被担心的是“会不会变傻”。准确的说法是：**ECT 会引起记忆和认知方面的副作用，多数是暂时的，但少数人会有较长时间的影响。** 这和“把脑子电坏”是两回事——目前没有证据表明 ECT 会造成脑组织的结构性损伤。

常见的影响有三类：

- **治疗后即刻的混乱**：刚醒来的几十分钟到几小时，可能不知道自己在哪、说话重复，通常会很快恢复。
- **顺行性遗忘**：对治疗前后一段时间的新事情记不住，比如治疗那几天吃了什么、谁来看过。多数在几周内改善。
- **逆行性遗忘**：对治疗前一段时间的事情记忆变模糊，越靠近治疗的时间越明显。多数人逐渐恢复，但有些人会留下部分空白，尤其是治疗次数多、双侧刺激、既往认知功能较差的人。

医疗团队通常会做认知监测，比如重复词语记忆、注意力测试，用来发现变化并调整方案。患者和家属也可以自己记录：治疗前把重要的事情写下来，治疗后如果发现“记性明显变差、找不到路、算不清账”持续不改善，要告诉医生。

需要权衡的是：**不治疗的风险也在伤害认知。** 严重抑郁、躁狂和紧张症本身就会造成注意力、记忆和执行功能的下降，反复发作还与认知功能变差相关。ECT 的记忆副作用，通常要和“疾病继续拖着”的代价放在一起看。

五、知情同意与你的权利

按《中华人民共和国精神卫生法》和医院制度，ECT 属于有创、有风险的物理治疗，需要知情同意。可以理解为三件事：**被告知、被允许提问、被允许拒绝。**

- 医生应当说明：为什么建议 ECT、替代方案有哪些、可能的获益和风险（包括记忆影响）、大概需要多少次。
- 你有权问：能不能先试药物？能不能只用一侧刺激？能不能减少次数？做完记忆会怎么样？谁来评估我的记忆？
- 你有权拒绝，也有权在疗程中途退出。拒绝不会导致“被放弃治疗”，医生仍有义务提供其他方案。
- 对无法表达意愿的患者（比如木僵、严重谵妄），通常需要监护人同意，并经过医院规定的审核程序。具体以现行法律和医院制度为准。

家属常问“要不要替患者签字”。这不是一个可以替别人轻易决定的事。能做的是：把患者的既往意愿、价值观、对记忆的看重程度告诉医生，要求充分解释，必要时寻求第二诊疗意见。**知情同意的核心不是“签个字”，而是“真的听懂了”。**

六、风险、急诊边界与常见问题

ECT 的严重并发症发生率很低，但不是零。麻醉相关风险（过敏、误吸、心律失常）、治疗后血压升高、头痛、肌肉酸痛、恶心、短暂的意识混乱都可能出现。少数人会出现癫痫发作时间过长，需要药物终止。有近期心梗、未控制的颅内压增高、主动脉瘤等情况，通常不宜做，需要麻醉和专科评估。

需要立即联系医生或去急诊：

- 治疗后持续几小时意识不清、叫不醒、说话混乱不恢复；
- 剧烈头痛、呕吐、视物模糊、一侧肢体无力（警惕脑血管问题）；
- 胸痛、心悸、呼吸困难；
- 抽搐持续不停止，或短时间内反复抽搐；
- 治疗后出现高热、肌肉僵硬；
- 出现自杀念头、自伤行为，或躁狂症状明显加重。

尽快联系治疗团队：

- 记忆减退持续两周以上没有改善，影响工作或生活；
- 情绪从抑郁突然转为异常兴奋、话多、睡得少；
- 治疗后持续头痛、恶心、乏力；
- 对治疗有疑问，或想调整后续安排。

常见问题

“ECT 是不是会让人变傻？” 它会影响记忆，多数是暂时的，但确实有人会有较长久的空白。医生会通过选择刺激方式、控制次数、做认知监测来减少影响。把它当成“完全没有代价”是不诚实的，当成“一定会毁掉脑子”也不符合证据。

“做几次能好？” 因人而异，取决于病情严重度、对治疗的反应和既往发作史。有人几次就明显改善，有人需要更多次，之后还可能需要维持治疗。具体次数由治疗团队根据反应决定。

“做完 ECT 还要吃药吗？” 通常要。ECT 控制急性症状，药物负责维持，两者不是替代关系。停不停药、怎么维持，要由医生安排。

“ECT 能根治双相吗？” 不能。它控制的是这一次发作，降低当下的危险，不改变双相障碍需要长期管理的事实。

“为什么医生不先试药，直接建议 ECT？” 在紧张症、高自杀风险、严重躁狂伴耗竭的情况下，等药物起效可能来不及。这时 ECT 是“更快更安全”的选择，不是跳过步骤。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. 链接

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.2 rTMS 与 tDCS

在药物和电休克之外，还有两类“用物理方式调节大脑”的治疗：重复经颅磁刺激（rTMS）和经颅直流电刺激（tDCS）。它们不需要麻醉，不用住院，听起来比 ECT “温和”，因此常被寄予很高期待。但温和不等于适合所有人，也不等于可以替代药物。这一页讲清它们是什么、对双相抑郁的证据到哪一步、转躁风险有多大，以及为什么现在还不是常规首选。读完你能判断：医生提到这两种治疗时，是在什么位置上考虑它们。

一、rTMS 是什么：不用麻醉的“磁刺激”

rTMS 的做法是：把一个磁线圈放在头皮特定位置，通过快速变化的磁场在大脑皮层诱发微弱电流，从而调节局部神经活动。治疗时人是清醒的，坐在治疗椅上，不需要麻醉，也不需要肌肉松弛。治疗结束后可以正常活动，通常不需要人陪。

它和 ECT 的区别很关键：ECT 是诱发一次全面癫痫样放电，需要麻醉，起效快，对严重躁狂、紧张症、高自杀风险有明确地位；rTMS 是局部、清醒、温和的皮层调节，起效通常以周计，对急性危险状态没有 ECT 那样的快速作用。**把 rTMS 当成“更安全的 ECT”是误解，它们的适应证和强度不在一个层级。**

tDCS 则是用很弱的直流电，通过头皮电极改变神经细胞的兴奋性。它更简单、更便宜，但证据也更少，目前主要用于研究场景，临床上远不如 rTMS 成熟。

二、证据到哪一步：有效信号，但不是常规首选

rTMS 在单相抑郁中的证据相对多，在双相抑郁中的研究则少得多：样本量小、设计不完全一致、随访时间短。已有的一些随机对照试验和荟萃分析提示，rTMS 对双相抑郁可能有效，尤其是作为药物的辅助治疗；但结果并不一致，也不是所有指南都把它列为一线。【研究】

CANMAT/ISBD 2018 把 rTMS 列为双相抑郁在药物治疗效果不佳时可以考虑的选项之一，位置在 ECT 之后、常规药物之前或之间，取决于具体病情。【指南】换句话说：**它不是起点，也不是“没药可吃才用”，而是介于两者之间的一个备选。** 对不能耐受药物副作用、或药物效果不理想但又不至于做 ECT 的人，它可能有用。

还有几点现实限制：rTMS 通常需要连续多天到诊所治疗，前后数周；效果不是立竿见影，常在第 2 到 4 周才逐渐显现；停止治疗后，如果不继续药物维持，复发并不少见；不同医院设备、方案和经验差别较大；费用和可及性因地区而异。

三、转躁风险：低，但不是零

这是双相患者最该问的问题。rTMS 确实可能诱发轻躁狂或躁狂，文献中有个案报告，也有人群研究提示风险存在但不高。【研究】机制上可以理解：它和抗抑郁药一样，是在“往上托”情绪，双相的大脑可能被推过头。

所以做 rTMS 时，监测和用抗抑郁药时一样重要：睡眠时长、话量、活动量、花钱、易怒、冲动，都要记录。如果治疗期间出现“睡得少但精力好、话变多、停不下来”，要立刻告诉治疗团队，而不是觉得“治疗起效了，我终于有精神了”。

风险高低和几个因素有关：双相 I 型、既往有药物诱发转躁史、混合特征、快速循环、没有同时使用心境稳定剂。**做 rTMS 不等于可以停掉心境稳定剂**，这一点常被忽略。多数研究里，rTMS 是加在原有治疗之上的，而不是替代。

四、谁适合、谁要慎重

情况	是否适合考虑 rTMS	说明
双相抑郁，药物效果不佳	可以考虑	通常作为辅助，不是单打独斗【指南】
不能耐受药物副作用	可以考虑	仍需评估转躁风险
严重抑郁伴精神病性症状	不作为首选	ECT 更合适
急性躁狂	证据不足	不用 rTMS 控制躁狂
高自杀风险、需要快速起效	不作为首选	起效以周计，来不及
有癫痫史、颅内金属植入物	需严格评估	可能不适合，由医生判断
孕期	谨慎	数据有限，需多学科评估
混合状态、快速循环	谨慎	转躁和病情波动风险更高

绝对禁忌和相对禁忌由医生根据设备说明和个人情况判断。植入式心脏起搏器、耳蜗植入、颅内电极、近期脑卒中或心肌梗死、未控制的癫痫、严重头痛病史，都需要提前说明。治疗时通常要戴耳塞，因为磁线圈工作时会发出较响的敲击声，长时间暴露可能影响听力。

五、tDCS：证据更少，别急着买家用设备

tDCS 的原理是用很弱的电流改变皮层兴奋性，设备便宜、操作简单，因此网上出现了大量“家用抑郁治疗仪”。这里需要非常明确地说：**目前 tDCS 对双相抑郁的证据很有限，不足以支持自行购买、自行使用。**

已发表的研究多为小样本、短疗程，结果不一致；对双相的专门研究更少；刺激位置、电流强度、疗程都缺乏统一标准；长期效果和转躁风险也没有足够数据。家用设备还带来额外风险：电极放置不当可能造成皮肤灼伤，电流不稳定可能引发不适，使用者往往同时吃药却不告诉医生，出了问题也难以追溯。【待验证】

如果医生在正规医疗机构建议 tDCS，通常是在研究或特定临床条件下，有明确的评估和随访。除此之外，不建议自己买设备“试试看”。省下的钱和避免的风险，比“可能有用”的期待更实在。

六、流程、花费、急诊边界与常见问题

rTMS 的典型流程是：精神科评估 → 确认适应证和禁忌 → 签知情同意 → 连续多天到院治疗 → 定期评估情绪、睡眠、认知和副作用 → 疗程结束后进入维持方案。治疗本身不痛，但会有敲击感、头皮发麻，部分人治疗后头痛或头皮不适。

可以照做的清单：

- ☐ 治疗前把所有的药、植入物、癫痫史、偏头痛史、怀孕可能告诉医生。
- ☐ 确认治疗期间继续原有的心境稳定剂，不自行减停。
- ☐ 每次治疗前后记录睡眠时长和情绪，尤其是睡眠需求减少。
- ☐ 治疗期间避免熬夜、跨时区旅行、大量咖啡因和酒精。
- ☐ 出现头痛、耳鸣、头晕、记忆变差，及时告诉治疗团队。
- ☐ 不因为“做了 rTMS”就放松复诊和药物管理。
- ☐ 对家用 tDCS 设备保持警惕，不自行购买使用。

需要立即联系医生或去急诊：

- 治疗中或治疗后出现抽搐、意识丧失；
- 剧烈头痛、呕吐、视物模糊、一侧肢体无力；
- 治疗后情绪突然异常高涨、整夜不睡、冲动消费或行为失控；
- 出现自杀念头、自伤行为；
- 头皮灼伤、水疱、持续疼痛；
- 心悸、胸痛、晕厥。

尽快联系治疗团队：

- 头痛、头皮不适持续超过一天；
- 耳鸣或听力变化；
- 记忆、注意力明显下降；
- 情绪低落加重，或出现混合症状；
- 治疗费用、疗程安排与预期不符，想调整方案。

常见问题

“rTMS 能替代药物吗？” 多数情况下不能。它常作为辅助治疗，原有药物通常要继续。适不适合减药，要由医生在疗程结束后评估。

“rTMS 比 ECT 安全，是不是应该先做 rTMS？” 取决于病情。高自杀风险、紧张症、严重躁狂需要快速起效时，ECT 更合适；病情相对稳定、药物效果不佳时，rTMS 可以作为备选。安全性和有效性要一起看。

“做一次就能好吗？” 不能。rTMS 通常需要连续多次，效果逐渐累积，停止后还可能复发。把它当成一个疗程，而不是一次性的“修理”。

“tDCS 家用仪靠谱吗？” 目前证据不足，不建议自行购买使用。正规研究中的 tDCS 有严格参数和监测，和网上卖的家用设备不是一回事。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.3 光照治疗、睡眠剥夺与补充剂证据

在药物和心理治疗之外，光照治疗、睡眠剥夺和各类补充剂是患者最常自己尝试的三类方法。它们有一个共同点：听起来“自然、无害、可以自己来”，但对双相障碍的人来说，恰恰可能因为“自己来”而诱发转躁。这一页讲清每种方法的证据到什么程度、可能带来什么好处、风险在哪，以及为什么它们都不能替代药物。读完你能分辨：哪些值得和医生讨论，哪些应该直接放弃。

一、为什么它们只能“辅助”

双相障碍的核心治疗是心境稳定剂、抗精神病药和心理社会干预。光照、睡眠调整、营养补充之所以被归为“辅助”，不是因为它们没用，而是因为：**证据强度不足以单独撑起治疗，作用幅度通常中等，而且对双相患者有特殊的“转躁”风险。**

这一点和单相抑郁不同。单相抑郁的人做光照治疗、熬一夜，最坏的结果是没效果；双相障碍的人做同样的事，可能把情绪推向轻躁狂甚至躁狂。睡眠减少本身就是躁狂的早期信号，也是诱因之一。所以这类方法在双相里必须“有人看着做”，而不是“网上看到就试”。

还有一层现实：补充剂市场几乎没有监管，标签上的成分和实际含量可能不符，和处方药的相互作用也常被忽略。**“天然”不等于“安全”，更不等于“可以和药一起吃”。**

二、光照治疗：证据、做法与转躁

光照治疗的原理是模拟自然光，通过眼睛影响生物钟和情绪调节系统。它在季节性情感障碍中的证据比较充分，在非季节性的双相抑郁中也有一些研究支持，常作为药物的辅助。【研究】部分指南把它列为双相抑郁的辅助选项，但证据质量参差，研究样本通常不大。【指南】

做法上，通常是在早晨使用专门的光疗设备，坐着接受一段时间的光照，期间可以看书、吃早饭，但不要直视光源。具体设备、时长和时段由医生指导，不建议自己买一台“看着亮”的灯就用。设备应当带紫外线过滤，避免晒伤和眼损伤；不要用普通台灯、浴霸或太阳光凑合。

方面	说明
可能获益	改善抑郁情绪、睡眠节律和精力，尤其对季节性加重的人
证据强度	中等，研究质量不一，双相专门研究较少【研究】
主要风险	诱发轻躁狂或躁狂、眼疲劳、头痛、皮肤光敏反应
不适合的人	视网膜疾病、光敏性疾病、正在用光敏药物的人

转躁是光照治疗最需要警惕的问题。研究里确实有诱发轻躁狂的报告，尤其在双相 I 型、没有同时使用心境稳定剂、或光照时间安排在傍晚的人身上。【研究】所以治疗期间要记录睡眠和情绪，一旦出现“睡得少但精力好、话变多、停不下来”，要立刻告诉医生。**不要因为“这是自然疗法”就放松监测。**

光敏风险也常被忽略。某些药物（如部分抗生素、利尿剂、维 A 酸类、某些抗精神病药和抗抑郁药）会让皮肤和眼睛对光更敏感；红斑狼疮、卟啉病等疾病也属于光敏性疾病。开始前把这些情况告诉医生。

三、睡眠剥夺：起效快，也最容易“翻车”

睡眠剥夺（也叫觉醒治疗）是指有意减少或取消一晚睡眠，用来快速改善抑郁。它的特点是**起效极快**：有些人一夜不睡，第二天抑郁就明显减轻，效果在几小时内出现，比任何抗抑郁药都快。【研究】

但它的缺点同样突出：**效果短暂**，补一觉后往往回落；**转躁风险高**，尤其在双相障碍中，睡眠剥夺本身就是诱发躁狂的经典因素；**操作不当有害**，连续多日不睡可能导致极度疲劳、注意力下降、判断力受损，甚至诱发精神病性症状。

因此，睡眠剥夺在双相抑郁里绝不是“自己在家熬一晚”的方法。正规做法通常是在医院或严密随访下进行，配合心境稳定剂、随后安排睡眠相位前移（把入睡和起床时间整体提前），并密切监测转躁。即便如此，它的证据仍有限，不属于常规一线治疗。【待验证】

需要特别提醒：**如果已经连续几天睡得很少、却越来精神，那不是“治疗起效”，而可能是转躁的开始。** 这时要做的是联系医生，而不是继续“保持这个状态”。

四、Omega-3 与其他补充剂

Omega-3 脂肪酸（尤其是 EPA）是研究最多的补充剂之一。一些随机对照试验和荟萃分析提示，它可能对抑郁症状有轻度改善，作为辅助治疗时作用不大但相对安全；也有研究没有发现明显效果，结果并不一致。【研究】它**不能替代心境稳定剂**，对躁狂没有治疗作用，也不能用来“预防复发”。

其他常见补充剂的证据更弱：

补充剂	证据强度	可能的获益	主要风险
Omega-3（EPA 为主）	中等偏弱，结果不一致	辅助改善抑郁症状	高剂量可能增加出血风险，与抗凝药同用需谨慎
N-乙酰半胱氨酸	弱，初步研究	辅助改善抑郁、冲动	胃肠道不适，长期安全性数据不足
维生素 D	取决于是否缺乏	缺乏者补充有益骨骼和整体健康	过量可致高钙血症
叶酸	弱，缺乏者有意义	缺乏者辅助改善情绪	一般安全，需注意与某些药物相互作用
圣约翰草	不推荐	无	诱导肝酶、降低多种药物浓度、血清素综合征、诱发转躁
SAMe	不推荐自行使用	研究集中在单相抑郁	可能诱发躁狂，与抗抑郁药合用风险更高

圣约翰草（贯叶连翘）值得单独说：它是很强的肝酶诱导剂，会让避孕药、抗凝药、部分抗精神病药和免疫抑制剂的效果下降；和 SSRI 类抗抑郁药合用可能引起血清素综合征；本身也可能诱发转躁。**在双相障碍里，它不是一个“温和的草药”，而是一个需要避开的相互作用源。**

褪黑素常被用来调整睡眠时相，对倒时差可能有帮助，但对双相复发预防的证据不足，且可能与部分药物相互作用。想用的话，先问医生。

五、怎么安全尝试：清单

- ☐ 先和医生说明想尝试什么、为什么想试、期望是什么。
- ☐ 确认它不会和正在吃的药相互作用（包括避孕药、抗凝药）。
- ☐ 确认自己目前不是混合状态、快速循环期，或近期有转躁。
- ☐ 从低强度、短时间开始，不追求“越强越好”。
- ☐ 同时坚持原有药物，不因为“加了新方法”就减药。
- ☐ 每天记录睡眠时长、情绪、精力、话量和冲动。
- ☐ 设定停止规则：出现转躁信号、睡眠明显减少、情绪异常高涨，立即停并联系医生。
- ☐ 不购买来源不明、宣称“根治双相”的产品。
- ☐ 孕期、哺乳期、肝肾功能不全、正在抗凝治疗，先咨询医生。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 光照或睡眠剥夺后出现整夜不睡、话多、冲动消费、行为失控（转躁）；
- 出现自杀念头、自伤行为；
- 高热、大汗、肌肉抽动、意识改变（警惕血清素综合征，尤其合用圣约翰草或多种抗抑郁药）；
- 剧烈眼痛、视力突然下降、皮肤大面积红肿水疱（光损伤或光敏反应）；
- 心悸、胸痛、晕厥。

尽快联系医生：

- 情绪明显转向兴奋、易怒，睡眠需求减少；
- 抑郁加重，或出现混合症状；
- 头痛、眼疲劳、皮肤发红持续不缓解；
- 准备开始或停止任何补充剂；
- 正在服用抗凝药、避孕药、抗癫痫药，想加补充剂；
- 计划怀孕、已怀孕或哺乳。

常见问题

“光照治疗能代替抗抑郁药吗？” 不能。它是辅助手段，证据强度不足以单独治疗双相抑郁，也不能替代心境稳定剂。

“熬一夜真的能治抑郁吗？” 有些人会短暂好转，但效果通常只维持到下一次睡眠，而且转躁风险高。不要把“不睡”当成自助疗法。

“Omega-3 是不是多吃点更好？” 不是。研究用的剂量不等于“越多越好”，高剂量可能增加出血风险，与抗凝药同用尤其要小心。

“保健品是天然的，应该比药安全吧？” 不一定。天然不等于无害，圣约翰草就是典型例子：它会改变多种药物的浓度，还可能诱发转躁。

“我能不能只靠光照和运动，不吃药？” 对少数轻症、稳定期的人，医生可能会讨论减少药物负担，但这必须建立在充分评估和随访之上。自行停药的风险通常远大于收益。

参考来源

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 8：特殊人群

儿童青少年、老年、孕产期、躯体疾病患者的治疗重点不同。这一模块讲原则，不替代专科面诊。

8.1 儿童青少年双相障碍

> 这一页写给刚被诊断为双相障碍的孩子家长，也写给已经确诊、想弄明白“为什么这么难判断”的青少年本人。孩子身上的双相，样子常常和成人不一样：发作界限模糊、易激惹比兴高采烈更常见，还容易和 ADHD、孤独症、创伤反应、抑郁搅在一起。读完这一页，你会知道为什么要找儿童精神科评估、家庭和学校能做什么、吃药要盯哪些指标，以及哪些情况一分钟都不能等。

一、先弄懂几个词，再看孩子

儿童青少年双相障碍的讨论里，最容易吵起来的就是“这到底算不算双相”。先把词说清楚，后面的判断才有落点。

- **躁狂与轻躁狂**：一段时间里情绪异常高涨，或者异常易怒，同时出现睡得少却不困、话比平时多、脑子转得飞快、觉得自己特别有本事、做事不计后果。轻躁狂程度轻一些，身边人看得出“像换了个人”，但还没到完全失控。
- **易激惹**：一点小事就炸，摔东西、骂人、动手。很多人以为躁狂就是开心，其实孩子身上更常见的是“一点就着”。
- **混合特征**：抑郁的绝望和躁狂的激越同时在场。比如一边说“活着没意思”，一边坐不住、整夜不睡、冲动发火。这种状态最危险，自杀和冲动风险都高。【指南】
- **快速循环**：情绪在高涨和低落之间频繁切换，中间恢复得不充分。孩子身上比成人多见。【研究】
- **发作性**：症状是一段一段出现的，有起点、有终点，而不是天天都这样。这一点是区分双相和很多其他问题的关键。

孩子身上的双相有几个特点，值得家长先放在心里：

1. **界限不清**。成人常常能说出“从哪天开始不对”，孩子往往是慢慢变糟，家长回想起来只能说“这个学期一直不对劲”。
2. **混合和快速循环多**。同一天里又绝望又亢奋，或者一周里高高低低好几轮，容易被当成“青春期情绪化”。
3. **易激惹打头**。发脾气、砸门、和老师对着干，比“兴奋得睡不着”更早被注意到。
4. **和发育阶段缠在一起**。青春期本来就睡得晚、爱冒险、和父母顶嘴，判断“是不是症状”需要看变化幅度、持续时间和功能受损。

5. **诊断争议大**。低龄儿童诊断双相在学界一直有争论，很多指南主张非常谨慎，尤其是学龄前儿童。【指南】这也意味着：孩子被下这个诊断时，值得找儿童青少年精神科医生复核，而不是在普通门诊一锤定音。

起病越早，复发和功能受损往往越明显，诊断被延迟也很常见。延迟的原因不神秘：孩子不会描述“心境高涨”，家长更关注成绩和打架，医生在有限的门诊时间里很难拼出完整病程。

二、先分清：是双相，还是别的

儿童青少年期，好几件事看起来都像双相。弄错方向的代价不小：把双相当成 ADHD 只用兴奋剂，可能让情绪更不稳定；把创伤反应当成双相长期用药，可能错过真正需要的心理治疗。

容易被当成双相的情况	关键区别	下一步
ADHD（注意缺陷多动障碍）	注意困难、多动、冲动是长期底色，从小就有，不是一段一段发作；没有明显的“心境高涨期”	由专科判断是否共病、治疗先后顺序
孤独症谱系（ASD）	情绪爆发常由感官过载、常规被打破触发；社交沟通困难、兴趣狭窄是长期特征	发育行为评估，调整环境与沟通方式
创伤后应激（PTSD）	有明确的创伤或长期忽视史；闯入性回忆、回避、过度警觉；情绪爆发多与触发线索有关	创伤知情评估，心理治疗为主
单相抑郁	只有低落，没有过持续几天的高涨或易激惹；抗抑郁药后突然“变了一个人”要高度警惕	主动追问轻躁狂史，重新评估
破坏性心境失调障碍（DMDD）	慢性、几乎天天易激惹，发脾气频繁，但不符合发作性的高涨	儿童精神科鉴别，治疗路径不同
物质或药物所致	近期使用大麻、兴奋剂、激素、某些感冒药或减肥药；停药后好转	如实告诉医生所有在用物质
躯体疾病	甲状腺功能异常、癫痫、睡眠严重不足、感染后状态	查体与必要的化验

这张表不是让人自己对号入座，而是提醒：**“像双相”不等于“就是双相”**，需要把病程、触发因素、家族史、发育史放在一起看。【指南】

有两个坑特别常见。

第一个坑是**共病**。ADHD 和双相可以同时存在，不是二选一。合并 ADHD 时是否用兴奋剂、什么时候用、怎么监测情绪，必须由儿童精神科医生决定，家长不要自行找药或自行停。

第二个坑是**只问家长，不问孩子**。青少年可能瞒着自伤、幻听、用药，也可能在家长面前表现得“没事”。单独给孩子说话的时间，往往才是信息的入口。

三、评估：为什么一定要找儿童精神科

儿童青少年双相的评估，比成人更依赖“多方拼图”，一次门诊很难完成。【指南】

- **多来源信息**：孩子本人、父母（最好两位）、班主任或心理老师。同一件事在三方眼里的样子常常不同，差异本身就是信息。
- **纵向病程**：什么时候开始、持续多久、之间有没有完全正常的时期、有没有诱发事件（转学、被欺凌、亲人去世、熬夜备考）。
- **发育与学校史**：发育里程碑、成绩变化、同伴关系、被欺凌史、旷课。
- **家族史**：父母双方三代内的双相、抑郁、自杀、物质使用、精神分裂症。家族史不是命运，但会影响评估。
- **躯体与化验**：身高体重、血压、甲状腺功能，必要时药物筛查。不要跳过躯体检查。
- **量表只是辅助**：YMRS 有儿童版本，HAMD、MDQ 也有相应使用场景，但它们不能代替面诊，更不能自测确诊。【指南】
- **用药史要细**：用过什么、用了多久、有没有“吃完更兴奋”、有没有皮疹、有没有突然停药。

第一次就诊可以带上这些

- ☐ 孩子最近三个月的睡眠记录（几点睡、几点醒、夜里醒几次）
- ☐ 情绪与行为的简单日记（哪天特别高涨、哪天特别低落、持续几天）
- ☐ 学校表现与老师反馈（成绩、纪律、同伴冲突、旷课）
- ☐ 既往诊断、用药清单、化验单、心理测评报告
- ☐ 家族史清单（三代内精神疾病、自杀、物质使用）
- ☐ 孩子自己写的一段话：最近最难受的是什么、有没有不想活的时候
- ☐ 家长想问的三个问题，写在纸上，避免进诊室就忘

四、家庭和学校能做什么

药物稳定情绪，环境和关系决定孩子能不能把稳定维持下去。

家庭这边，最有用的不是讲道理，而是四件事：

1. **把病和惩罚分开**。发作期的冲动、顶撞、乱花钱是症状的一部分，事后算总账、羞辱、断生活费，通常只会让下一次隐瞒得更彻底。边界仍然要有，但要提前约定、平静执行。
2. **降低高情感表达**。家里长期高压、频繁指责、过度卷入，和复发风险升高有关。【研究】具体做法是：说具体行为，不贴人格标签；少用“你总是”“你就是”；冲突升级时先离开十分钟。
3. **守住作息**。睡眠是双相的开关之一。熬夜打游戏、通宵刷题、周末补觉到中午，都可能把节律推乱。固定起床时间比固定入睡时间更可行。【指南】
4. **家长自己要有支持**。照护是长期消耗，父母一方崩溃，孩子往往最先受影响。找家长互助团体、心理咨询、轮流值守，都不是矫情。

学校这边，可以谈的合理便利包括：座位调整、考试分段或延时、作业量弹性、允许在情绪失控时去安静的地方缓一缓、心理老师定期跟进、复学时的渐进安排。这些不是“特殊照顾”，而是让孩子能留在学校里的具体条件。同时要留意校园欺凌，被欺凌既可能是诱因，也可能是复发的维持因素。

五、药物与监测：孩子不是“缩小版成人”

儿童青少年用药有几个必须知道的原则，具体用哪种药、用多少，只能由医生定。

- **很多药属于超说明书使用**。也就是说，药品说明书上没有写这个年龄段，但临床证据和指南支持使用。这不等于“拿孩子做实验”，但医生有义务把理由、预期收益、已知风险讲清楚，家长有权利问明白。【指南】
- **从低剂量开始，缓慢调整**。加量速度由医生安排，家长不要因为“看起来没好”自行加，也不要因为“看起来好了”自行减。
- **要盯的指标比成人多**：身高、体重、腰围、血压、血糖血脂、泌乳素、甲状腺功能、肝功能；用锂盐还要查血锂、肾功能；用抗精神病药要观察手抖、走路僵、坐不住、眼球上翻等锥体外系反应。
- **发育与认知要长期看**。药物对发育中大脑的长期影响，目前证据有限，不能拍胸脯说“完全没影响”，也不能因此拒绝必要的治疗。【待验证】可行的做法是每半年到一年评估一次学习能力、社交和身高体重曲线。
- **心理社会治疗不是可选项**。心理教育、家庭聚焦治疗、CBT、人际与社会节律治疗（IPSRT），在青少年里都有应用；药物解决症状，心理社会干预解决识别信号、沟通和节律。【指南】
- **依从性要靠合作，不靠搜查**。青少年藏药、吐药，常常是因为“不想被当成病人”“吃了变胖”“同学会问”。把选择权还给他一部分（比如自己设提醒、自己选服药时间），比翻书包有效。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 说“不想活了”、写遗书、把心爱的东西送人、突然异常平静地道别——**不要独处，立即联系医生；有明确计划或已动手，拨打 120，必要时 110**。
- 出现自伤（划手臂、撞头、掐自己），即使伤口不深，也要当天联系医生。
- 连续几天几乎不睡、话停不下来、冲动乱花钱、攻击家人或同学——尽快精神科急诊评估；有伤人威胁时拨打 110。
- 说听到别人听不到的声音、坚信有人要害自己、行为明显紊乱——立即急诊。
- 服药后出现皮疹，尤其伴发热、口腔溃疡、眼睛红、皮肤起疱或脱皮——**立即停药并急诊**。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识不清、大汗、心跳很快——**立即拨打 120**。
- 手抖明显加重、走路不稳、反复呕吐、意识模糊（用锂盐的孩子）——立即急诊查血锂。
- 拒绝吃喝、尿量明显减少、抽搐、意识不清——立即急诊。

拿不准算不算严重时，按严重处理。也可以拨打 12356 心理援助热线先问清楚。

六、容易踩的坑

- **把青春期当双相**：熬夜、叛逆、追星、和父母吵架，本身不是病。看的是持续时间、功能受损和发作性。
- **把双相当叛逆**：反复的彻夜不睡、夸大、冲动消费、突然的成绩崩塌，不该只用“管教”解决。
- **只治孩子，不治环境**：家庭冲突、校园欺凌、长期睡眠不足不改变，药效会打折扣。
- **自行停药**：觉得“好两个月了”就停，复发风险很高；停药要在医生安排下缓慢进行。
- **隐瞒发作**：怕住院、怕被贴标签而少说，医生拿不到真实病程，方案就会偏。
- **忽略孩子自己的叙述**：孩子说“那种感觉又来了”，往往比量表更早。
- **一次门诊定终身**：儿童青少年诊断会随发育和病程修正，定期复核是正常的，不是医生不靠谱。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.2 老年双相障碍

> 这一页写给 60 岁以上确诊双相障碍的人，也写给他们的子女和主要照护者。老年双相不是把成年人的方案照搬过来就行：晚发的人要先查有没有别的躯体原因，共病多、吃的药多、跌倒和记性变差的风险都更高，锂盐的安全窗口也更窄。读完这一页，你会知道晚发和早发有什么不同、复诊要带什么、家里怎么防跌倒，以及哪些变化必须立刻去医院。

一、晚发还是早发：两条不同的路

同样是双相，六七十岁第一次发病，和二十岁发病一直治到老，背后的东西差别很大。

早发、进入老年的人，通常已经有多年病程：可能发作过很多次，工作、婚姻、经济都受影响，长期在吃药。到了老年，发作的形态可能变：躁狂变少、抑郁变多，或者情绪高低切换得更频繁；也可能因为退休、丧偶、身体变差而复发。这类人的重点往往是“维持治疗 + 减少药物负担 + 处理共病”。

晚发的人，一般指中老年以后第一次出现躁狂或轻躁狂。这时第一件事不是加心境稳定剂，而是先排除“别的原因”。【指南】

需要排查的方向包括：

- **脑血管病**：卒中、小血管病变可以引起类似躁狂的表现，常伴执行功能下降、走路不稳、情绪控制变差。【待验证】有研究提出“血管性躁狂”的说法，但目前还不能当成一个独立诊断。
- **痴呆早期**：额颞叶痴呆、路易体痴呆早期可能出现情绪失控、冲动、幻觉，容易被当成双相。
- **甲状腺功能异常**：甲亢可以表现得像躁狂，甲减可以表现得像抑郁。
- **药物或物质**：激素、某些抗抑郁药、左旋多巴、感冒药里的成分、酒精、镇静催眠药过量或戒断。
- **感染、疼痛、便秘、脱水、睡眠剥夺**：在老年人身上，这些都能把情绪推乱。
- **谵妄**：一种急性的意识混乱，注意力集中不了、话前言不搭后语、白天晚上颠倒、时好时坏。谵妄是急症，不是“老了就这样”。

所以，老年人第一次出现躁狂，值得做一次完整的躯体与神经系统评估，包括必要的化验和影像。**晚发不等于“就是双相”，早发也不等于“老了会自己好”。**

二、共病与多重用药：一张必须自己维护的清单

老年人身上很少只有一个病。双相之外，常见高血压、糖尿病、冠心病、慢性肾病、甲状腺病、骨质疏松、白内障、前列腺增生、认知障碍。病多，药就多；药多，相互作用和副作用就多。

共病	对双相治疗的影响	平时要盯什么
高血压、冠心病、心衰	抗精神病药可能引起体位性低血压、心率变化；部分药影响心电图 QT 间期	起身慢一点、量血压、必要时查心电图
慢性肾病	锂盐靠肾排出，肾功能下降时血锂更容易升高	肾功能、血锂、尿量、饮水
糖尿病	部分抗精神病药增加体重和血糖；感染	血糖、体重、足部皮肤

共病	对双相治疗的影响	平时要盯什么
	会诱发谵妄	
甲状腺疾病	锂盐可引起甲状腺功能减退或甲状腺肿	促甲状腺激素（TSH）定期查
认知障碍	与双相互相混淆；抗胆碱能作用强的药可能加重糊涂	记性、注意力、走失风险
帕金森病、手抖	手抖可能来自病本身、锂盐或抗精神病药，来源不同处理不同	手抖是粗大还是细小、是否伴走路不稳
青光眼、前列腺增生	部分药有抗胆碱能作用，可能诱发眼压升高、排尿困难	眼痛眼胀、排尿
骨质疏松、跌倒史	镇静、低血压、低钠都会增加跌倒和骨折	步态、夜起、家里地面

关于多重用药，有五件事值得做：

1. **维护一张用药清单**：药名、剂量、为什么吃、谁开的、吃了多久。包括中药、保健品、外用药、偶尔吃的止痛药和感冒药。
2. **尽量固定一个主要开药医生**，或者请药师做一次用药审核。不同专科各开各的，是重复用药和相互作用的温床。
3. **警惕“处方瀑布”**：用一种药去治另一种药的副作用，结果药越加越多。比如用镇静药治失眠，失眠又来自另一个药的副作用。
4. **不要自行加保健品和中草药**。有些会影响凝血、血压、肝酶，甚至干扰血锂。
5. **每次复诊都更新清单**，把停掉的药划掉，别让旧清单一直流传。

三、跌倒、认知和日常生活

跌倒是老年双相最容易被低估的风险。原因往往是叠加的：镇静药让人反应慢，降压药和抗精神病药让起身时血压掉下去，锂盐让手抖、走路不稳，夜尿多、视力差、地面滑，任何一条都足以让人摔一跤。跌倒的后果不只是骨折，还有硬膜下血肿——老年人摔到头以后，可能过几天才出现头痛、嗜睡、呕吐、意识变化，这时候要立刻查 CT，不能等。

家里可以做的事：

- ☐ 卧室到卫生间装夜灯，走廊不留杂物，地面防滑
- ☐ 卫生间装扶手，马桶旁、淋浴区都要有
- ☐ 床边放便器，减少夜里摸黑走远路
- ☐ 起身分三步：先坐起来，坐一会儿，再站，站稳再走
- ☐ 鞋子合脚、防滑，不穿拖鞋走远路
- ☐ 视力、听力该配的配，听不清会加重猜疑和冲突
- ☐ 每年复核一次“让人犯困、让人站起来发晕”的药
- ☐ 手机设紧急联系人，独居者考虑佩戴呼叫设备

认知方面，双相本身和注意力、记忆、执行功能下降有关，老年期又要和痴呆鉴别。区分点包括：波动性（双相更随情绪波动）、起病方式、是否伴人格改变、影像和量表结果。锂盐可能让一些人觉得反应变慢、记忆变差，这需要和医生讨论，而不是自己停药。电休克在老年严重躁狂、抑郁、紧张症里仍然有效，但要做心血管和认知评估，短期内可能影响记忆，这些都要在知情同意里谈清楚。【指南】

日常生活还有几件事值得提前安排：驾驶是否还安全、大额理财谁把关、独居时谁每天联系、家里燃气电器谁检查、紧急情况下谁有权做医疗决定。这些不是“咒老人出事”，而是把不确定变成约定。

四、锂盐在老年身上：窗口更窄

锂盐是双相维持治疗的重要药物，但在老年人身上，安全范围更窄。【指南】

原因很直接：肾功能随年龄下降，锂排出变慢，同样的剂量可能得到更高的血锂；老年人口渴感减退、饮水少；很多人同时在吃利尿剂、降压药、止痛药。

会让血锂升高的常见情况：

- 发热、腹泻、呕吐、大汗、夏天高温
- 吃得太淡、刻意低盐饮食、减肥
- 噻嗪类利尿剂、部分降压药、某些止痛药（如非甾体抗炎药）、部分抗生素
- 肾功能下降、脱水、手术前后
- 不小心吃多了

要警惕的表现：手抖比平时明显变粗、走路不稳、反复呕吐或腹泻、嗜睡、说话含糊、意识模糊、抽搐。在老年人身上，“这两天有点糊涂”可能就是中毒的开始，不要当成“年纪大了”。

家属能做的是：把“喝水、吃盐正常、别自行加药”这三件事当成日常；发热、拉肚子、吃不下饭时，当天联系医生问要不要调整；按医生安排复查血锂和肾功能，不要因为“最近挺好”就不查。**任何减量、停药都由医生决定，自行停锂盐的复发风险很高。**

五、照护：家属能做的具体事

照护老年双相的人，最累的往往不是病情本身，而是“什么都要管”。

- **用药**：用分药盒，按天分好；每次换药后重新核对；不“帮忙减半片”。发现漏服，不要一次补两倍，联系医生问怎么处理。
- **记录**：睡眠、情绪、步态、便秘、饮水、有没有说“活着没意思”。一页纸、一周一行就够，复诊时非常有用。
- **陪诊**：带上用药清单、最近的化验单、记录本；进诊室前把最想问的三个问题写下来；经医生和老人同意可以录音，回家再听。
- **预先计划**：万一病情急转，谁陪同、去哪家医院、老人自己希望怎么治，提前聊一次，比在急诊走廊里吵要好。

- **照护者自己**：轮流值守、申请社区居家服务、参加家属团体。照护者倒下，老人往往跟着出问题。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 突然变得糊涂、注意力散、白天晚上颠倒、时好时坏——警惕谵妄，**立即就医**。
- 跌倒撞到头，之后出现头痛、嗜睡、呕吐、走路不稳、意识变化——**立即急诊查头颅 CT**。
- 呕吐、腹泻、吃不下、发热、尿量明显减少，同时在吃锂盐——**当天联系医生，必要时急诊查血锂**。
- 手抖明显加重、走路不稳、说话含糊、嗜睡、抽搐——**立即拨打 120**。
- 说“不想活了”、拒绝进食饮水、把东西送人、写遗书——**不要独处，立即联系医生；有明确计划时拨打 120，必要时 110**。
- 出现幻觉、坚信有人害自己、半夜往外走、走失——尽快精神科急诊评估，走失时拨打 110。
- 胸痛、胸闷、心跳很快或很乱、晕倒——**立即拨打 120**。

判断不了的时候，按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线咨询。

六、容易踩的坑

- **把晚发躁狂当“老糊涂”或“脾气变坏”**：第一次躁狂在老年出现，必须查躯体原因。
- **把老年抑郁当“正常衰老”**：不想动、不吃、说没意思，不是“人老了都这样”，可能是可治的抑郁。
- **药越多越安心**：没人统管的多种用药，本身就是风险。
- **怕伤肾就自己停锂盐**：停药后的复发和自杀风险，往往比监测下的用药更大。
- **只管情绪不管步态**：跌倒在老年人身上是可以致命的。
- **忽略听力和视力**：听不清会加重猜疑、争吵和不配合。
- **只盯着老人，不看照护者**：照护者耗竭时，最先被牺牲的往往是规律服药和复诊。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.3 孕产期双相障碍

> 这一页写给正在备孕、已经怀孕、或者刚生完孩子的双相障碍女性，也写给她们的伴侣和家人。孕期和产后是复发风险很高的阶段，而用药又牵涉到胎儿和婴儿，很多人卡在“吃药怕伤孩子、不吃怕复发”之间，怎么选都害怕。读完这一页，你会知道孕前该谈清楚什么、哪些风险必须由精神科和产科一起评估、产后精神病长什么样、哺乳要怎么权衡，以及哪些情况必须马上急诊。

一、先记住一句：这不是一个人能决定的事

孕产期双相的治疗决策，本质上是一道“风险比较题”，而不是“有没有安全药”的判断题。

- **要一起评估的人**：精神科医生、产科医生；情况复杂时还需要母胎医学、临床药师、新生儿科。只有一方拍板，容易漏掉另一半风险。【指南】
- **两个极端都危险**：一个是发现怀孕就自行停掉所有药，另一个是隐瞒怀孕、继续按原方案吃，两边都可能出事。
- **没有零风险选项**：不吃药有复发风险，吃药有药物暴露风险，差别在于风险的大小、可控性和个人承受度。
- **决定要写下来**：方案、复诊时间、出现什么情况要改，写在产检本或手机备忘录里，家人也知道。

有一个常见误解要先拆掉：**“怀孕了就必须停药”是错的，“怀孕了也不能调药”也是错的。** 正确说法是：孕前就要谈，孕期要监测，产后要盯紧，每一步都由精神科和产科共同决定。

二、孕前：最好在“还没怀”的时候谈

如果治疗稳定、正在考虑要孩子，最理想的时机是**计划妊娠**：先咨询，再怀孕。这样医生有时间把方案调整到相对可控的状态，而不是等验孕棒两条杠了才紧急处理。【指南】

孕前咨询通常会问这些：

要谈的问题	为什么重要
过去发作过几次、最近一次什么时候、有没有停药后复发的经历	停药后很快复发的人，孕期复发的可能性更高
以前怀孕、分娩、产后有没有情绪崩溃	有过产后精神病或产后严重发作的人，再次产后的风险明显升高
现在吃哪些药、有没有合并用药	有些药在孕期需要提前换或提前停，不能临时抱佛脚
家族里有没有双相、产后精神病、自杀	影响风险评估和产后监测强度
有没有其他病：甲状腺、高血压、糖尿病、肾病	影响孕期监测和用药选择
家里有谁能帮忙、夜间谁轮班	睡眠剥夺是复发的强力诱因，人手是真资源

同时可以做的事：提前补充叶酸（具体用法问产科）、戒烟戒酒、把作息尽量固定、把体重血压记个基线、完成该做的孕前检查。**药怎么调，一定在孕前由医生安排，不要自己先减一半“试试看”。**

如果已经怀孕、还没咨询过，也没关系，尽快约一次精神科，把孕周、现在吃的药、最近的状态说清楚。越早越好，但不是“晚了就没救”。

三、孕期：药物风险和复发风险要一起算

先说复发风险。 孕期并不是情绪的保护区。相反，停药的女性在孕期复发的比例不低，睡眠被打断、孕吐脱水、产检压力、家庭关系变化，都可能成为诱因。【指南】复发本身对胎儿也有影响：严重抑郁时吃不下、睡不好、不产检；躁狂时冲动、冒险、不配合产检；严重时还可能自伤。

再说药物风险。 下面只讲已知的风险点，不推荐任何一种药，具体用哪个、用多少，必须由医生结合你的病史决定。

- **丙戊酸盐**：这是孕期风险最明确的一类。它与胎儿神经管缺陷等出生缺陷相关，也可能影响孩子后期的神经发育。因此育龄女性一般不被作为首选，除非病情确实没有其他选择；正在使用的人需要严格的避孕咨询，万一怀孕要尽快找医生，**但不能自己突然停**——突然停药的躁狂复发和撤药风险同样真实。【指南】
- **锂盐**：与先天性心脏畸形（如 Ebstein 异常）存在关联，但绝对风险不高，需要产前超声和胎儿心脏评估。孕期血容量和肾清除率会变化，孕吐、脱水、合并用药都可能让血锂波动，所以监测要比平时更勤；分娩前后是风险窗口，需要产科和精神科一起安排。【指南】
- **拉莫三嗪**：孕期代谢加快，血药浓度可能下降，医生可能需要在监测下调整；皮疹风险仍然存在，加量必须慢。是否调整、怎么调整，由医生定。【指南】
- **抗精神病药**：要考虑体重增加、妊娠糖尿病、血压、锥体外系反应；部分药物在分娩前后可能让新生儿出现短暂的嗜睡、吃奶差、肌张力变化，产科和儿科需要提前知道你在用什么。
- **抗抑郁药**：双相抑郁单用抗抑郁药有转躁、混合、快速循环的风险，孕期更不该自行加用；孕晚期使用与新生儿短暂适应问题相关，需要权衡。【研究】

孕期还要盯的：体重、血压、血糖、甲状腺功能、肾功能、血锂（如果在用）、情绪和睡眠。每次产检主动说“我在吃精神科药，这是清单”，别等医生问。

四、产后：最危险的窗口

产后是双相女性风险最高的阶段，没有之一。**产后精神病**通常在分娩后几天到几周内出现，表现是：极度兴奋或极度混乱、几乎不睡、幻觉（听到或看到不存在的东西）、妄想（坚信孩子被掉包、有人要害孩子）、情绪在几分钟内剧烈变化、行为紊乱、对婴儿出现奇怪或可怕的想法。这是**精神科急症**，可能伴随自杀和伤害婴儿的风险，必须立即就医，不能在家“观察两天看看”。【指南】

产后风险更高的人包括：以前有过产后精神病、双相 I 型、过去因双相住过院、孕期停药、产后严重失眠、缺乏支持。

产后能做的具体事：

- ☐ 产后尽早复诊，不要等到“满月再说”；风险高的人出院前就约好
- ☐ 夜间喂养排班，保证有一段连续 4 小时以上的睡眠
- ☐ 家人知道早期信号：话变多、睡变少、异常兴奋或异常沉默、说奇怪的话
- ☐ 家里有人能每天看一眼她的状态，而不是只问“奶够不够”
- ☐ 把精神科急诊电话、12356 热线存在手机里
- ☐ 不把“产后情绪低落”和“产后精神病”混为一谈：前者常见、通常较轻，后者是急症

五、哺乳：可以谈，但别一个人扛

哺乳不是非黑即白的选择题。药物会进入乳汁，但不同药物进入的量差别很大；婴儿的敏感度也不同，早产儿、低体重儿、有病的婴儿更敏感。【指南】

值得和医生讨论的问题：

- 我现在吃的药，进入乳汁的情况大概是什么样？
- 如果我选择哺乳，婴儿需要观察什么（嗜睡、吃奶差、体重不增、皮疹、肌张力异常）？
- 如果我选择配方奶，会不会有人说我不爱孩子？——不会，喂养方式不等于母爱多少。
- 混合喂养能不能作为过渡？
- 如果我需要调整药物，调整后多久需要复查？

有一点要写清楚：**锂盐进入乳汁的比例相对较高，婴儿的肾功能还不成熟，选择哺乳时需要医生评估和儿科随访。** 这不是“绝对不能喂”，而是“必须有人盯着”。

同样，**不哺乳、用配方奶，是可以的**。在复发风险和喂养方式之间，优先保证母亲能睡、能治、能稳定，孩子才有一个稳定的照护者。

六、和家人怎么说，以及容易踩的坑

伴侣能做的三件事：陪同就诊、承担夜班、学会识别早期信号。长辈常说“怀孕哪能吃这些药”，这时候最有用的不是争论，而是把医生的话带回来：“这是精神科和产科一起定的方案，我们下次复诊一起去问。”把“要不要吃药”变成“我们一起去找医生确认”，冲突会小很多。

- **一怀孕就自行停掉所有药**：最常见的错误，也是复发最常见的起点。
- **隐瞒怀孕继续吃**：医生不知道，就没法帮你调整监测。
- **把产后失眠当成“当妈都这样”**：连续几天几乎不睡、话多、异常兴奋，是信号，不是勤劳。
- **产后出现幻觉妄想还拖着**：这是急症，越早治越好。
- **哺乳期自行吃“偏方”“调理药”**：成分不明，可能影响情绪和婴儿。
- **只关注孩子，不关注母亲**：产后复查只查伤口和子宫，不查情绪，是常见的漏网。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 产后出现幻觉、妄想、说话前言不搭后语、行为紊乱、几乎不睡——**立即精神科急诊，拨打 120。**

- 出现伤害自己或伤害婴儿的念头、画面、冲动——**不要让孩子和母亲单独相处，立即拨打 120，必要时 110**。
- 孕期或产后情绪突然高涨、冲动、整夜不睡、话停不下来——尽快精神科急诊评估。
- 严重抑郁、不吃不喝、说“不想活了”——**立即联系医生，有计划时拨打 120**。
- 孕期剧烈呕吐、腹泻、吃不下、发热，同时在用锂盐——**当天联系医生，必要时急诊查血锂**。
- 服药后出现皮疹，尤其伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮——**立即停药并急诊**。
- 高热、肌肉僵硬、意识不清、大汗——**立即拨打 120**。
- 孕晚期或产后出现剧烈头痛、看东西模糊、上腹疼痛、抽搐——**立即拨打 120**（警惕子痫前期等产科急症）。

拿不准时按严重处理。可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.4 躯体疾病与物质使用共病

> 这一页写给同时患有心血管病、肾病、肝病、甲状腺疾病，或者有酒精、兴奋剂、大麻使用问题的双相障碍患者和家属。躯体病和物质使用会让双相的药更难用、风险更高，也最容易被“心内科管心、精神科管情绪”切成两半。读完这一页，你会知道为什么要有一个医生统筹、哪些组合要特别小心、物质使用为什么不能只靠“下决心”，以及哪些情况必须立刻去急诊。

一、为什么共病会让治疗变复杂

双相障碍很少单独出现。临床上常见的是“双相 + 高血压 + 脂肪肝 + 失眠药 + 偶尔喝酒”这样的组合。共病让治疗变复杂，主要有四条路径：

1. **药物代谢相互影响**。肝酶被诱导或被抑制，会让另一种药的血药浓度忽高忽低。卡马西平是典型的“诱导剂”，会让很多药变得不够用；丙戊酸盐会抑制别人的代谢，让别人的浓度升上去。
2. **药物可能加重躯体病**。锂盐靠肾排，肾功能不好时容易蓄积；丙戊酸盐有肝毒性和高氨血症风险；部分抗精神病药影响体重、血糖、血脂和心电图 QT 间期。
3. **躯体病会模拟或诱发情绪发作**。甲亢可以像躁狂，甲减可以像抑郁，感染、疼痛、激素、睡眠剥夺都能把情绪推乱。
4. **物质使用同时踩好几脚**。它诱发发作、破坏睡眠、降低服药依从性、和药物直接相互作用，戒断本身还可能是急症。

面对共病，原则不是“先治哪个”，而是**先处理当下最危险的那个问题，同时不让另一边失控**。因为“有肝病”就停掉所有精神科药，和“只治情绪”不管心肝肾功能，同样会出事。

二、四个躯体系统：心脏、肾脏、肝脏、甲状腺

双相的治疗方案要跟着躯体情况走。下面四个系统的问题，最常在复诊时被漏掉，值得逐个过一遍。

心血管：先看心电图和血压

心脏问题和双相治疗的交集，主要在三点：心律、血压、代谢。

- **QT 间期延长**。心电图上的 QT 间期反映心脏复极时间，部分抗精神病药和卡马西平可能让它变长；低钾、低镁、同时用其他延长 QT 的药、先天性长 QT，都会放大风险。开始这类药前做一次心电图，之后按医生安排复查，是常规做法。【指南】出现心悸、头晕、眼前发黑、晕倒，要立刻就医。
- **体位性低血压**。起身时血压骤降，眼前发黑、站不稳，老年人、脱水、同时吃降压药的人更明显。对策很朴素：起身分三步、别空腹洗热水澡、告诉医生你站起来会晕。
- **锂盐与心电图**。锂盐可能引起 T 波改变、窦性心律不齐，多数是良性的，但需要基线心电图和定期复查。

- **抗凝与抗血小板**。卡马西平会加快华法林代谢，让抗凝效果打折；换药、停药时凝血指标会波动，必须让开抗凝药的医生知道。
- **心衰、冠心病**。部分药引起水钠潴留、体重增加，会加重心脏负担；反过来，心功能差时用药要更保守。

心血管问题	需要特别留意的方向	平时盯什么
心律失常、长 QT	部分抗精神病药、卡马西平	心电图、血钾血镁、有没有晕厥
高血压	体重增加、水钠潴留、镇静	家庭血压、体重腰围
冠心病、心衰	体位性低血压、心率	胸闷气短、下肢水肿、夜间憋醒
用抗凝药	卡马西平等诱导肝酶	凝血指标、牙龈出血、黑便

肾脏：锂盐的主战场

锂盐几乎全部经肾排出，所以肾功能是锂盐治疗的“基础设施”。

- **肾功能下降时**，锂排出变慢，同样的剂量会产生更高的血锂。老年人、糖尿病肾病、高血压肾损害的人尤其要小心。
- **长期用锂盐**可能影响肾小管的浓缩功能，表现为多尿、口渴、夜尿增多；少数人会出现肾性尿崩症，也就是肾脏“关不住水”。【研究】这些变化需要定期查肾功能、尿常规，并和医生讨论。
- **会让血锂升高的常见药**：噻嗪类利尿剂、部分降压药、非甾体抗炎药（很多止痛药和感冒药里都有）、部分抗生素。加任何新药前，告诉医生你在吃锂盐。
- **脱水是加速器**：发热、腹泻、呕吐、大汗、夏天户外工作、刻意低盐饮食，都会让血锂上去。
- **透析的人**：锂会被透析清除，用药和监测需要肾内科与精神科一起安排，不能按普通人的节奏来。

肝脏：丙戊酸盐要特别小心

肝脏负责代谢很多精神科药物，肝病会改变药物在体内的浓度和毒性。

- **丙戊酸盐**有明确的肝毒性风险，尤其在儿童、有代谢病或线粒体病的人身上；它还可能引起高氨血症——血里氨升高，表现为呕吐、乏力、意识模糊、手抖加重，严重时昏迷。用丙戊酸盐的人出现“莫名其妙的糊涂和呕吐”，要查血氨。【指南】
- **卡马西平**也可能引起肝损伤，并且是强肝酶诱导剂，会让口服避孕药、抗凝药、部分抗癫痫药失效。
- **脂肪肝、酒精性肝病**在双相患者里并不少见，会让代谢更乱、药物负担更重。
- **严重肝病**时，蛋白合成下降、凝血变差，用药要更保守，必要时调整方案。
- 出现**黄疸（眼白和皮肤发黄）、深色尿、右上腹持续疼痛、皮肤瘙痒、容易出血**，不要等复诊，直接就医。

五、甲状腺：一个常被漏掉的方向

甲状腺和情绪的关系非常直接：甲亢可以表现得像躁狂——心跳快、怕热、手抖、话多、睡不着、体重下降；甲减可以表现得像抑郁——乏力、怕冷、反应慢、记性差、情绪低。

- **锂盐**可能引起甲状腺功能减退、甲状腺肿，少数人出现甲亢。所以用锂盐的人要定期查促甲状腺激素（TSH）。【指南】
- 甲状腺功能异常被纠正后，情绪常常跟着改善；反过来，情绪长期不稳的人，值得查一次甲状腺。
- **胺碘酮**含碘量高，可能引起甲亢或甲减，也会影响锂盐的浓度，用这类药的人要更勤地复查。
- 怀孕和产后甲状腺功能会波动，这段时期的监测见8.3 孕产期双相障碍。

六、物质使用：酒精、兴奋剂、大麻

双相和物质使用常常同时出现，而且互相加重：情绪发作时用酒或药“自救”，物质又让发作更频繁、更难治。【指南】

酒精是最常见的一种。它会让抑郁加重、睡眠变浅、判断力下降，长期喝伤肝、伤胃、伤神经；和镇静类药物一起用，可能抑制呼吸。更危险的是**戒断**：长期大量饮酒的人突然停酒，可能出现手抖、出汗、心跳快、幻觉，严重时癫痫发作或震颤谵妄——这是可以致命的急症，**不能在家硬扛，需要医疗监护下戒断**。

兴奋剂（冰毒、可卡因、部分来路不明的“减肥药”“提神药”）能直接诱发躁狂、幻觉、冲动和心血管事件。它和双相的症状可以长得一模一样，医生有时需要先按物质所致来处理，观察一段时间才能分清。

大麻的问题更微妙。有人用它助眠、缓解焦虑，但大麻可能加重焦虑、诱发精神病性症状，长期使用还与动机下降、注意力变差有关；证据并不一致，但“用大麻治双相”没有依据。【待验证】尤其是有过幻觉、妄想的人，风险更高。

尼古丁和咖啡因也值得说一句：吸烟会诱导肝酶，突然戒烟时某些药的血药浓度会上升；咖啡因过量会加重失眠、心悸和焦虑。

面对物质使用，有几条比“讲道理”更有用：

1. **别指望一次戒断**。复发是这个过程的一部分，不是道德失败。
2. **减少伤害**：先减少量、减少频率、不混用、不空腹喝、家里不放酒、把药和酒分开管理。
3. **整合治疗**：精神科和成瘾治疗在同一个团队里做，比“先戒了再来治情绪”有效。分开治，往往两边都掉。
4. **动机访谈**比训话有效：问“你觉得它给你带来了什么、又拿走了什么”，比“你再喝就完了”更能让人动。
5. **戒断要安全**：酒精和镇静催眠药的戒断需要医疗监护，不要自己在家突然硬停。

七、把治疗整合起来：就诊前准备

共病最怕的是“没人看全局”。可以做的事：

- ☐ 一张完整的用药清单：药名、剂量、谁开的、吃了多久，包括中药、保健品、外用药
- ☐ 一张躯体病清单：诊断、目前控制情况、最近一次化验日期
- ☐ 每次看新科室，主动说“我在吃精神科药，这是清单”
- ☐ 固定一个主要开药医生，或请药师做一次用药审核
- ☐ 化验单按时间归档，复诊时带上
- ☐ 如实告诉医生喝了多少酒、用了什么物质，不要因为怕被说而隐瞒
- ☐ 家里备一个血压计，必要时备血糖仪

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 胸痛、胸闷持续不缓解、心跳极快或很乱、晕倒——**立即拨打 120**。
- 眼白或皮肤发黄、深色尿、右上腹剧痛、呕血、黑便——**立即急诊**。
- 尿量明显减少甚至无尿、下肢明显水肿、气短——**立即急诊**。
- 呕吐、乏力、意识模糊、手抖加重（尤其在用丙戊酸盐）——**立即就医查血氨和肝功能**。
- 发热、腹泻、呕吐、吃不下，同时在用锂盐——**当天联系医生，必要时急诊查血锂**。
- 突然停酒或停镇静药后出现手抖、大汗、心跳快、幻觉、抽搐——**立即拨打 120**，这是戒断急症。
- 使用兴奋剂后出现极度兴奋、幻觉、胸痛、高热——**立即急诊**。
- 说“不想活了”、自伤、冲动到可能出事——**不要独处，立即联系医生；有计划时拨打 120，必要时 110**。

判断不了时按严重处理。可拨打 12356 心理援助热线。

八、容易踩的坑

- **隐瞒喝酒或用物质**：医生按“没喝”来开药，风险就落到你身上。
- **怕伤肝伤肾就自行停精神科药**：突然停药的复发风险往往更大，调整要由医生做。
- **用酒或大麻“自我治疗”失眠和焦虑**：短期像有效，长期把睡眠和情绪一起拖坏。
- **各科各开各的药，没人核对**：重复用药和相互作用就是这样来的。
- **把戒断当意志力问题**：酒精和镇静药戒断是医学问题，可能需要住院。
- **只查情绪不查甲状腺**：一个简单的化验，可能改变整个方案。
- **认为“躯体病太重，精神科先放一放”**：没有被控制的躁狂或抑郁，会让躯体病更难管。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 9：风险管理

双相障碍的风险不止抑郁。混合状态、躁狂冲动、锂中毒和严重药物反应同样可能致命。

9.1 自杀风险

> 这一页写给有自杀念头的双相障碍患者，也写给发现家人状态不对、却不知道怎么开口的家属。自杀不是“想不开”或“意志薄弱”，在双相里它常常和抑郁、混合状态、冲动、失眠、停药绑在一起，是可以提前识别、提前布防的。读完这一页，你会知道哪些信号要当回事、怎么直接问而不伤人、风险怎么分层、安全计划怎么写、家里怎么限制手段，以及那一刻该说什么、不该说什么。

一、先把几个误解拆掉

误解一：问“你有没有想过自杀”会把人问出病来。 现有研究不支持这种担心：直接、平静地询问，不会增加自杀念头，反而常常让人松一口气——终于有人愿意听。【研究】

误解二：说“我想死”的人只是想要关注。 说出来可能是求助，也可能是在试探有没有人拦；无论哪种，都值得认真对待。真正的危险有时恰恰是“什么都不说”。

误解三：看起来好起来就安全了。 有两段时间要特别小心：一是**刚出院的一两周**，环境变了、支持变少、动力恢复但问题还在；二是**突然变得异常平静**，尤其之前一直很痛苦的人，这种平静可能是已经做了决定，而不是好了。

误解四：自杀是“他自己的选择”，别人做不了什么。 手段是否容易拿到、身边有没有人、能不能及时看上医生，都会改变结局。这些是可以改变的。

还要说清楚：**双相的自杀风险不只在抑郁期。** 混合状态（抑郁的绝望 + 躁狂的激越和冲动）往往是最危险的组合，因为人既有想死的念头，又有行动的能量。【指南】躁狂期的冲动、冒险、精神病性症状，同样可能带来致命后果。

二、风险因素：哪些情况要认真布防

风险因素不是“判决书”，而是提示“这一段要多上心”。

类别	具体内容
最重要的既往因素	以前有过自杀未遂（尤其近期、多次、方式较危险）；家族中有人自杀
临床状态	抑郁发作、混合特征、明显激越、绝望感、严重失眠、精神病性症状（尤其听到命令自己去死的声音）、共病焦虑、物质使用、创伤、边缘型人格特征
治疗相关	刚停药或自行减药；抗抑郁药单用后转躁或混合；刚出院；换医生、治疗中断

类别	具体内容
心理与性格	冲动、攻击性、完美主义、觉得自己是别人的负担、问题解决能力下降
社会处境	独居、丧偶或分手、失业、债务、被羞辱或被欺凌、缺乏支持、家中容易拿到危险物品
时间窗口	深夜、酒后、节假日、纪念日、季节变化、月经前

保护因素同样重要：稳定的家人朋友、对子女或宠物的责任感、愿意看医生、有活下去的理由、信仰、还能工作或学习、过去遇到难事能扛过来。评估风险时，保护因素不是“抵消”，而是“可以加固的地方”。

三、怎么直接问：问句是可以准备的

很多人卡在“怕问错”。其实不需要说得漂亮，需要的是**直接、平静、不评判**。

可以按这个顺序往下问，一层一层来：

1. **打开话题**：“最近有没有觉得活着太累、不想撑了？”
2. **确认念头**：“有没有想过不想活了？大概多久一次？”
3. **问到计划**：“有没有想过具体怎么做？”
4. **问到准备**：“有没有准备东西，或者查过方法？”
5. **问到既往**：“以前有没有做过？那次是怎么回事？”
6. **问到控制力**：“现在这种念头来的时候，你觉得自己能控制住吗？”
7. **问到身边**：“如果今晚特别难受，你会找谁？”

几个技巧：

- **不要用“你不会想不开吧”这种带答案的问法**，对方顺着说“不会”就过去了。
- **不要在同一次对话里又问又劝**。先问完、听完，再谈怎么办。
- **对方沉默不等于否认**。可以补一句：“你不用现在回答，我等你想说的时候。”
- **问完要接住**：“谢谢你告诉我，这需要很大的力气。”
- **不承诺保密**。生命有危险时，保密要让位；可以提前说：“如果你有危险，我会联系医生，这不是出卖你。”

对青少年也一样要直接问。孩子不会因为被问就“学会”自杀，反而常常因为被认真对待而愿意说。

四、风险分级：不同情况，不同动作

分级不是为了贴标签，而是为了决定“现在要不要立刻行动”。

风险等级	常见表现	该做什么
低	偶尔有“活着没意思”的念头，没有计	尽快看门诊，做安全计划，缩短复诊间

风险等级	常见表现	该做什么
	划，能正常生活，有支持	隔，家属保持联系
中	经常有念头，有模糊计划但没有准备，或冲动上来时难控制	**当天**联系医生；不独处；移除家中危险物品；48 小时内面诊评估
高	有明确计划、有准备（攒药、看地点、写告别信）、有意图，或近期有过尝试	**立即急诊**，必要时住院；全程有人陪；拨打 120，必要时 110
极高	正在实施，或已经服药、受伤	**立即拨打 120**，必要时 110；现场急救，不要让其独处

判断时看三件事：**有没有计划、有没有准备、能不能控制冲动**。三条里中两条，就按高风险管理。拿不准时，按更严重的一级处理——宁可白跑一趟急诊，不要赌。

五、安全计划：一张可以照着做的纸

安全计划不是“保证不自杀”的承诺书。承诺书（让对方签“我保证不自杀”）没有可靠证据支持，还可能让家属误以为安全了。【研究】真正有用的是**具体到“难受时做什么、找谁”的计划**。

可以按六步写，写在一张纸上，复印一份给家属，复诊时带给医生：

- ☐ **第一步：我的预警信号**（比如连续两晚睡不着、开始觉得“我是累赘”、把自己关起来）
- ☐ **第二步：我自己能做的事**（洗热水澡、出门走十分钟、听固定的歌单、写下来但不发出去）
- ☐ **第三步：能让我分心的地方和人**（便利店、朋友家、家人房间，不要求对方会安慰）
- ☐ **第四步：我可以找的人**（两个名字 + 电话，提前说好“我难受时可能半夜打给你”）
- ☐ **第五步：专业资源**（精神科医生、最近医院急诊、12356 心理援助热线、120）
- ☐ **第六步：让环境变安全**（药由家人保管、家里不留危险物品、酒锁起来）
- ☐ **第七步：我活下去的理由**（孩子、父母、宠物、没看完的剧、想去的城市，越具体越好）

写完之后，和家人对一遍：真到了那一步，谁负责陪着、谁负责打电话、去哪里。**计划要练过，才在慌乱时用得上。**

手段限制：最具体、也最有效的一环

想自杀的那一刻，人往往冲动而短视。**让危险物品“拿不到”，就是给冲动留出冷却时间。** 这一点在指南里被认为很重要。【指南】

家里可以做的：

- **药物**：由家属保管，按次发放；不在床头、抽屉、包里囤药；复诊时和医生商量处方量；过期的药及时处理。
- **酒精**：锁起来或家里不放。酒后冲动控制下降，是常见的引爆点。
- **刀具、绳索、农药、燃气**：收进上锁的柜子；农村家庭尤其注意农药存放。
- **高处**：检查窗户、阳台、天台的可及性，必要时加装限位。
- **车辆**：病情不稳时由家人保管钥匙。

- **网络**：退出鼓励自杀的群组和账号，算法会不断推送同类内容。

做这些事时，最好**提前说清楚**：“这不是监视你，是我们一起把危险的东西挪远一点，等这段过去。”如果偷偷做又被发现，容易变成“你们不信任我”的争吵。同时，家属不必为此道歉——保护生命比面子重要。

六、家属怎么接话：说与不说

那一刻，家属最常犯的错不是“说错话”，而是**急着解决问题**。对方需要的是先被听见。

容易伤人的说法	可以换成
“你想太多了”“别矫情”	“你现在很难受，我听得出来”
“你想想你爸妈，你这么做对得起谁”	“我很怕失去你，所以我在这儿陪着你”
“别人比你惨多了”	“我不知道你有多痛，但我想知道”
“你要敢做我就……”	“我们一起想办法，先保证今晚安全”
“你答应我绝对不做”	“难受的时候，我们能做点什么让你撑过去”
“这是威胁我吗”	“你说这些，是不是已经到了很难撑的时候”

几句可以直接用的话：

- “谢谢你告诉我，这很不容易。”
- “你现在安全吗？身边有没有会伤到自己的东西？”
- “今晚我不走，我们一起待到明天，明天去联系医生。”
- “我不评判你，也不会到处说，但如果你有危险，我会联系医生。”

还要注意：**不争辩“活着有没有意义”**，那是一场赢不了的辩论；**不追问细节到像审讯**；**不表现出手足无措的惊恐**——你可以害怕，但先把声音放慢。家属自己也需要支持，长期绷着的人撑不到最后。

长期看：把防线放在平时

- **按医嘱服药、不自行停药**：停药后复发和自杀风险都会上升。
- **守住睡眠**：连续失眠是重要的预警信号，比情绪更早。
- **戒酒**：酒精是最常见的“最后一步”催化剂。
- **出院后两周内加强陪护**，复诊不要拖。
- **把资源贴在冰箱上**：医生电话、最近医院急诊、**12356**、120。
- **每年更新一次安全计划**，因为人会变、处境会变。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 说“不想活了”“想解脱”，或反复说“活着没意思”——**当天联系医生**，不要独处。
- 已经在做计划：攒药、看地方、写告别信、把东西送人、突然异常平静地道别——**立即急诊，拨打 120，必要时 110**。
- 已经服药、割伤、吞食异物——**立即拨打 120**，不要催吐，不要让其独处。

- 听到有声音命令自己去死，或坚信自己该死——**立即急诊**。
- 混合状态：一边绝望一边坐不住、冲动、整夜不睡——**立即急诊**，这种状态风险最高。
- 酒后说要去死、往外冲——**不要讲道理，先拦住、陪着，必要时拨打 110**。
- 青少年自伤、写遗书、突然把账号密码交给别人——**立即联系医生，当天面诊**。

> 拿不准时按严重处理。**12356** 心理援助热线可以 24 小时咨询；紧急情况直接拨打 **120**，有人身危险时拨打 **110**。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.2 躁狂混合状态与冲动风险

> 这一页写给正在躁狂或混合状态里的人，也写给被卷进这场风暴的家属。躁狂期的冲动不是“性格问题”，而是判断力和刹车同时失灵：钱、车、性、脾气，哪一样都可能在一周内出大事。读完这一页，你会知道混合状态为什么最危险、四类冲动风险现场怎么处理、哪些话现在说没用、哪些事现在做有用，以及什么时候必须打 120、什么时候必须打 110。

一、混合状态：最容易被看错的高危状态

先说清楚混合状态是什么：**抑郁的绝望和躁狂的激越同时在场**。不是“心情不好”，也不是“有点兴奋”，而是两套症状叠在一起。【指南】

典型的样子：

- 一边说“活着没意思、我是累赘”，一边整夜不睡、坐不住、话停不下来。
- 一边哭，一边疯狂做计划、打电话、下单、约人。
- 一边极度自责，一边暴怒、砸东西、觉得所有人都对不起自己。
- 思维奔逸，但想的内容全是绝望的；精力恢复了一点，恰好够用来实施计划。

为什么它最危险？ 因为抑郁提供“想死”的念头，躁狂提供“能做”的能量和冲动。这两样加在一起，自杀和冲动行为的风险都比单纯的抑郁或单纯的躁狂更高。【指南】而它最常被误判成“抑郁加重”，于是加抗抑郁药——这可能让混合和快速循环更糟。【指南】

还有一个容易被忽略的点：**躁狂期的冲动，是症状，不是人品。** 大脑的抑制控制在那段时间是打折的，当事人事后常常自己也说不清“当时怎么会那样”。理解这一点，不是替他免责，而是让家属知道：**讲道理、算后果、羞辱，在这个阶段基本无效**，有效的是把环境和手段先管住。

二、四类冲动风险：钱、车、性、伤人

躁狂和混合状态下的冲动，通常集中在四个方向。它们的现场处理有共同点，也有各自的门道。

钱：冲动消费、投资与借贷

这是最常见的“事后才发现”的损失。表现包括：大额转账、突然要创业、炒币炒股加杠杆、网络赌博、网贷、买一堆用不上的东西、请客摆阔、相信“稳赚不赔”的项目、被诈骗分子盯上。

家属在现场常常做错一件事：**跟他辩论“这个项目不靠谱”**。在躁狂状态下，他的自信是病理性升高的，辩论只会变成争吵，然后他换个渠道继续。

更有效的做法：

- **先冷却，不签字**。任何合同、转账、借款、担保，一律拖 24 到 48 小时；就说“我们家规矩是大额支出隔天再定”，不评价对错。

- **临时保管关键物品**：身份证、银行卡、U 盾、支付密码、股票账户。做之前说清楚：“这是临时的安全措施，等你稳定了我们再一起管。”这不是没收，是代管。
- **联系银行**：设转账限额、关闭大额免密、必要时临时冻结。可以说明家里有病人、需要防诈骗。
- **保留证据**：聊天记录、转账记录、合同。被骗了打 110 报案，越早越好。
- **不要“以贷养贷”**，也不要替他向亲友借钱填坑，那会把一个人拖成一家人的债务。

有一点要提前知道：**躁狂期签下的合同、做出的处分，事后可能涉及民事行为能力的问题**，但这需要法律程序认定，不是家属一句话就能作废。所以“事前拦住”永远比“事后追回”划算。相关法律问题见11.3 精神卫生法与权益。

车与身体：危险驾驶和冒险行为

躁狂期的人常觉得自己“反应快、技术好、不会出事”。真实情况是：注意力涣散、冲动、低估风险、可能还喝了酒。

需要盯的行为：超速、闯红灯、逆行、疲劳驾驶、酒后驾驶、深夜独自开车出门、突然去玩极限运动、独自远行、在工地或高处逞能。

家属能做的很具体：

- **车钥匙由家人保管**，不要放在玄关、包里、外套口袋。
- **不争论“我开车没问题”**，改成“这段时间我接送你，等复诊后再说”。
- **把出行的替代方案准备好**：打车、公交、家人送。
- **提醒法律后果**：酒驾、肇事逃逸都是要担责的，病情不是免责理由。
- **如果他坚持出门**，至少确认有没有人陪、去哪里、什么时候回；失联及时报警。

性行为：不羞辱，但要讲安全

躁狂期的性冲动升高，可能表现为：主动约陌生人、多性伴、不使用保护措施、在网上发露骨内容、大额打赏、被别有用心的人利用。

这件事家属最难开口，但回避的代价更大：意外妊娠、性传播感染、被敲诈、被性侵，都可能在几周内发生。

可以这样说：不说“你怎么这么不要脸”，而是“我担心的是安全，不是评判你”。具体能做的：

- 提供避孕套、陪同做性传播感染筛查和妊娠检测。
- 提醒“现在你的判断可能不可靠”，把决定往后拖。
- 如果遭遇性侵或被利用，**保留证据、不要洗澡换衣、立即报警 110 并就医**。
- 网络上的露骨内容、转账打赏，尽量截图留存，必要时联系平台。

五、伤人风险：先保人，再讲病

躁狂或混合状态下的伤人风险，通常有几个信号：极度易激惹、偏执（坚信有人害自己）、听到命令自己攻击的声音、喝酒、有过暴力史。

现场要快速判断三件事：**有没有具体对象、有没有计划或武器、是不是已经动过手**。有其中两样，就不要试图自己“制服”，直接打 110。

冲动类型	现场能做什么	什么时候报警或急诊
乱花钱、投资、借贷	冷却 24–48 小时、代管证件、联系银行	已被诈骗、被威胁、签下大额合同 → 报警 110
危险驾驶	保管车钥匙、安排接送	已酒驾、已出事故、坚持上路 → 报警 110
高风险性行为	讲安全、提供保护、陪同筛查	被性侵、被敲诈 → 报警 110 并就医
伤人威胁	保持距离、减少刺激、转移老人小孩	有具体对象或武器、已动手 → 110；受伤 → 120
自伤、自杀	不独处、移走危险物品	有计划或已实施 → 120，必要时 110

六、现场降风险：说话的方式比内容重要

躁狂状态下，人的注意力窄、易被激惹、对刺激敏感。现场原则是**降刺激、给空间、少说话、给选择**。

可以做的：

- ☐ 减少人数，只留一两个他信任的人
- ☐ 关掉电视、音乐，调暗灯光，把场面安静下来
- ☐ 说话短、慢、低声：一次一句，不超过十个字
- ☐ 给两个选项，而不是命令：“先坐下，还是先喝口水？”
- ☐ 满足基本需求：水、食物、烟、上厕所、躺一会儿
- ☐ 保持一臂以上的距离，站在靠近门口的位置，不背对
- ☐ 把老人、孩子先带到别的房间或邻居家
- ☐ 记录时间线：几天没睡、吃了什么药、喝了多少酒、说了什么
- ☐ 一旦开始砸东西、找武器、锁门，立刻退出并报警

不要做的：

- 不要争辩、嘲笑、激将（“你敢动我试试”）
- 不要围堵、按住、抢夺（除非有人正在受伤）
- 不要当众羞辱、翻旧账、叫一群人来看
- 不要承诺“我不告诉你爸妈/医生”，事后做不到会彻底失去信任
- 不要在孩子面前动手或对骂

七、什么时候必须急诊或住院

以下情况不是“再观察一晚”的范围：

- 有具体的伤人威胁，或已经动手、持械。
- 有明确的自杀计划，或已经自伤。
- 出现幻觉、妄想、行为完全紊乱，无法沟通。
- 极度激越，家人已经无法保证安全。
- 连续多日几乎不睡、不吃不喝，出现脱水、意识模糊。
- 混合状态，一边绝望一边冲动。
- 合并高热、外伤、酒精或药物中毒。

120 和 110 的分工：有人受伤、意识不清、需要医疗处置，打 120；有人身危险、持械、需要现场控制，打 110。两者可以同时打。不要因为“怕留记录”“怕邻居知道”而拖着不送医——急性期的及时处理，恰恰是减少长期损害的办法。

关于非自愿住院的条件和流程，见11.2 住院指征与自愿非自愿。

八、事后：修复比追责有用

急性期过去后，家里最容易发生的是一场“清算”：翻账单、骂一顿、逼着道歉。这往往让当事人更羞耻、更隐瞒，下一次发作来得更隐蔽。

更有用的顺序是：

1. **先处理实际问题**：债务、报案、退单、法律咨询、性传播感染筛查。
2. **再做一次不带审判的复盘**：那几天最早出现的信号是什么？睡眠？话多？花钱？把它写进复发预警表。
3. **调整治疗**：复诊、按医嘱用药，不自行停；把这次发作告诉医生，剂量和方案由医生改。
4. **补上环境防线**：账户限额、车钥匙、家中药物保管、紧急联系人。
5. **照顾家属**：经历一次躁狂发作，家人也会耗竭、愤怒、内疚，这些都需要出口。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 有具体的伤人威胁、已经动手、手持器械——**立即拨打 110**；有人受伤同时拨打 120。
- 有明确自杀计划、正在自伤——**立即拨打 120**，不要独处。
- 连续几天几乎不睡、完全无法沟通、行为紊乱——**立即精神科急诊**。
- 出现幻觉、坚信有人要害自己——**立即急诊**。
- 大额转账正在进行、被诈骗、被敲诈——**立即拨打 110**，同时联系银行止付。
- 酒后驾车、坚持危险驾驶——**立即拨打 110**。
- 高热、外伤、意识不清、抽搐——**立即拨打 120**。

- 自己拿不准是否到了急诊程度——按严重处理，先联系医生或拨打 12356。

记住：这一页说的所有“现场处理”，都是为了争取时间送到医生手里，不是替代就医。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.3 锂中毒

> 这一页写给所有正在吃锂盐的人，和帮他们管药的家属。锂盐是双相维持治疗里很重要的药，但它有一个特点：**有效和中毒之间的距离比较近**。发烧、拉肚子、吃得太淡、加了别的药，都可能让血里的锂升上去。读完这一页，你会知道哪些情况会让血锂升高、轻中重度中毒各长什么样、出现什么必须立刻查血锂、在到急诊之前能做什么和绝对不能做什么，以及平时怎么防。

一、为什么锂盐容易中毒

锂盐和很多药不一样，它在体内的“安全走廊”比较窄。医生给你定的目标血锂范围，是靠定期抽血维持的，不是一个固定不变的数。

几个基本事实：

- **锂几乎全部由肾排出**。肾功能好，锂排得快；肾功能差、脱水，锂就积在体内。
- **身体缺钠时，肾会把锂留下来**。因为锂和钠在肾小管里“走同一条路”，身体以为缺盐，就会回收钠，顺手把锂也回收了。所以吃得太淡、出汗太多、拉肚子，都可能让血锂升高。
- **很多常见药会影响锂的排出**，包括一些利尿剂、部分降压药、某些止痛药和抗生素。
- **老年人风险更高**：肾功能随年龄下降，体重轻、喝水少、口渴感迟钝。
- **中毒不一定和血锂数字完全对应**。有的人血锂在“正常范围”里已经有症状，尤其是长期服药的人和老年人。所以**症状比数字更要紧**。

二、哪些情况会让血锂升高

类别	具体情况
丢水丢盐	发烧、大量出汗、腹泻、呕吐、吃不下饭、夏天高温、户外作业、桑拿
吃得太淡	刻意低盐饮食、减肥、只吃水煮菜、大量喝白开水不补充电解质
合并用药	噻嗪类利尿剂、部分降压药、非甾体抗炎药（布洛芬、双氯芬酸等止痛药）、部分抗生素、部分抗癫痫药
肾功能	肾功能下降、脱水、手术前后、造影检查前后
剂量问题	自行加量、误服、一次吞服大量（可能是自杀行为）

这里有一条临床上的做法，叫“病日规则”：**发烧、呕吐、腹泻、吃不下饭的时候，不要照常吃锂盐，当天联系医生，问要不要暂停、要不要查血锂。** 具体怎么处理必须由医生说，但“照常吃、等复诊”是危险的。【临床经验】

还有几个容易被忽略的细节：

- 感冒发烧时吃的退烧止痛药，很多属于非甾体抗炎药，会让血锂升高。
- 中草药、保健品、减肥茶，成分不明，也可能影响水盐平衡。
- 夏天运动大量出汗，只喝白开水不补盐，反而可能把血锂推上去。

- 腹泻两天以上、吃不下东西，是常见的入院诱因。

三、中毒长什么样：从轻到重

锂中毒的症状是渐进的，早期很容易被当成“累了”“上火了”“年纪大了”。

程度	常见表现	该做什么
轻度	手抖比平时明显、恶心、拉肚子、没力气、特别渴、尿多、不想吃饭	当天联系医生，尽快查血锂
中度	手抖变成粗大（端杯子会洒）、走路不稳像喝醉、反复呕吐、说话含糊、嗜睡、意识模糊、肌肉抽动	**立即急诊**，不要等
重度	抽搐、昏迷、心跳很乱、血压不稳、尿很少甚至没尿、高热	**立即拨打 120**，这是可以致命的

三个最值得记住的“红灯”：

1. **手抖从细变粗**。平时只是写字有点抖，现在端碗、端杯子会洒出来。
2. **走路不稳**。像喝醉酒一样，脚底下发飘，走不直。
3. **意识改变**。反应变慢、说话含糊、叫不太应、白天也迷迷糊糊。

这三个出现任何一个，都不要再观察，直接去急诊查血锂。

还要注意**慢性中毒**：不是一下子发生的，而是几天到几周里慢慢变得手抖、走路差、记性差、人变糊涂。家里人常常以为是“老了”或者“抑郁加重”，一查血锂才发现高了。老年人尤其容易这样。

四、怀疑中毒时：立刻做什么

第一步：停掉下一次锂盐，然后立刻就医。 这是急症情况下的例外——怀疑锂中毒时，先不要再吃下一次，同时马上联系医生或去急诊；之后是否恢复、怎么恢复，由医生决定。不要自己“减半片试试”，也不要“先停几天看看”。

第二步：不要做这些事。

- 不要催吐。
- 不要大量灌白开水或盐水“冲淡”。
- 不要自己吃利尿剂“排出去”。
- 不要等到明天门诊。
- 不要自己开车去医院（意识可能突然变差）。

第三步：带上这些东西。

- 药盒或药瓶（医生要知道你吃的是哪种锂盐、每片多少）。
- 最近的化验单（血锂、肾功能、电解质）。

- 一张纸，写清楚：从哪天开始不舒服、有没有发烧腹泻、这几天吃了什么药、最后一次吃锂盐是什么时候。

第四步：到医院后会发生什么。 医生通常会急查血锂、肾功能、电解质、心电图，评估意识状态。轻度可能只需停药、补液、观察；中重度需要住院补液，极重度可能需要血液透析把锂清出去。**透析是有效的，但前提是来得够快。**

五、平时怎么防

- ☐ 正常喝水，不刻意少喝，也不狂灌白开水
- ☐ 正常吃盐，不搞无盐饮食、不长期只吃水煮菜
- ☐ 发烧、呕吐、腹泻、吃不下饭，**当天**联系医生，不要照常吃药硬扛
- ☐ 新增任何药之前问一句“我在吃锂盐，这个能一起用吗”，包括止痛药、感冒药、中药、保健品
- ☐ 按医生安排查血锂、肾功能、甲状腺，不因为“最近挺好”就跳过
- ☐ 不自行加量、减量、停药
- ☐ 夏天、运动、桑拿、长途旅行，注意补水和电解质
- ☐ 家里锂盐单独存放、上锁，防止老人误服、孩子误拿
- ☐ 家属知道“手抖变粗、走路不稳、人变糊涂”这三个红灯
- ☐ 把“最后一次吃药时间”和“最近的化验值”记在手机里

六、常见问题

“血锂在正常范围，是不是就没事？”不一定。症状比数字重要，尤其是老年人、长期服药的人、慢性中毒的人。有症状就要告诉医生，必要时复查。

“多喝水是不是能解毒？”不能。大量喝白水可能进一步稀释血钠，反而让情况复杂。正确做法是就医，由医生决定补什么、补多少。

“手抖是吃锂盐的正常反应吧？”轻微手抖确实常见，但**加重、变粗、影响端杯子**，就不是“正常”了，要查血锂。

“我拉肚子两天，药还照吃吗？”不要自己决定。当天联系医生，把腹泻次数、能不能进食、有没有发烧说清楚。

“夏天出汗多，我多喝点水就行了吧？”出汗丢的不只是水，还有盐。只灌白水、吃得很淡，反而可能让血锂升高。正常饮食、适当补充电解质，有不适及时问医生。

“我自己减半片，是不是就不容易中毒？”自行减量会让情绪不稳、复发风险上升，而且血锂波动更难判断。任何调整都让医生来做。

“中药和保健品没关系吧？”不一定。成分不明的东西可能影响水盐代谢或肝肾功能，用之前告诉医生。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 手抖明显加重、端杯子会洒、走路不稳、说话含糊——**立即急诊查血锂**。
- 反复呕吐、腹泻、吃不下饭，同时在吃锂盐——**当天联系医生；出现意识变化立即急诊**。
- 嗜睡、叫不太应、反应明显变慢、白天也迷糊——**立即拨打 120**。
- 抽搐、昏迷、心跳很乱、尿量明显减少——**立即拨打 120**。
- 发烧、大汗、脱水后出现上述任何症状——**立即急诊**，不要等。
- 误服或一次吞服大量锂盐（包括自杀行为）——**立即拨打 120**，带上药瓶。
- 老年人“突然变糊涂”，而家里有人在吃锂盐——**查血锂**，不要只当成“老了”。

拿不准时按严重处理。**宁可白跑一趟急诊，也不要在家观察一夜。**

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.4 药物急症：NMS、血清素综合征与 SJS

> 这一页写给正在吃药的双相障碍患者和家属。有三种药物急症，起病快、进展快、可以致命：恶性综合征（NMS）、血清素综合征、Stevens-Johnson 综合征与中毒性表皮坏死松解症（SJS/TEN）。它们的样子完全不同，但共同点是——**越早停掉可疑的药、越早到急诊，后果越轻**。读完这一页，你会认出这三种急症各长什么样、现场第一步做什么、它们怎么区分，以及哪些药物组合要格外小心。

一、先认脸：三种急症，三张不同的脸

这三种情况经常被混淆，因为都可能出现发热。但它们的“主角”不一样：NMS 的主角是**肌肉僵硬**，血清素综合征的主角是**震颤和反射亢进**，SJS/TEN 的主角是**皮肤和黏膜**。

项目	恶性综合征（NMS）	血清素综合征	SJS/TEN
常见诱因	抗精神病药（含长效针剂）、部分止吐药	两种以上增加 5-羟色胺的药同用	拉莫三嗪、卡马西平、别嘌醇、部分抗生素、止痛药
核心表现	高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗	精神状态改变、心跳快出汗、震颤与反射亢进	皮疹、黏膜糜烂、起疱脱皮
起病速度	数小时到数天	数小时到一天，较快	数天到数周，先有发热流感样
关键动作	**立即停抗精神病药，急诊**	**立即停相关药，急诊**	**立即停可疑药，急诊**

下面分开讲。

二、恶性综合征（NMS）：高热加僵硬

NMS 是一种少见但严重的药物反应，主要和抗精神病药有关，包括典型和非典型抗精神病药，也包括长效针剂；部分止吐药（如甲氧氯普胺）也可能引起。它通常在开始用药、加量、换药、联用多种抗精神病药，或者身体脱水、中暑、极度兴奋之后出现。

典型表现是四件事凑在一起：

1. **高热**：体温明显升高，退烧药往往效果不好。
2. **肌肉僵硬**：像铅管一样硬，四肢、脖子、下巴都可能僵，吞咽困难、说话不清。
3. **意识改变**：迷糊、嗜睡、叫不太应，严重时昏迷。
4. **自主神经不稳定**：大汗、心跳很快、血压忽高忽低、流口水、呼吸急促。

化验常有肌酸激酶（CK）明显升高、白细胞升高、肝功能异常、电解质紊乱。病情重时可以出现肾衰竭、肺栓塞、心律失常，甚至死亡。

现场怎么做：

- **立即停掉可疑的抗精神病药**，这是急症下的第一步。
- **立即拨打 120 或送急诊**，不要在家观察，不要用退烧药“压一压”再看。
- 不要强行喂水喂药，意识不清时容易呛。

- 带上所有药的清单和药盒，告诉医生最近有没有加量、换药、打长效针。
- 到医院后，治疗以停药、降温、补液、纠正电解质、保护器官为主，医生可能使用特定药物（如溴隐亭、丹曲林）和重症监护。

一个常见误判：把 NMS 当成“中暑”“感冒发烧”“太累了”。区别在于**僵硬**和**意识改变**——中暑一般不会全身僵硬，感冒不会让人叫不醒。

三、血清素综合征：震颤、反射亢进、躁动

血清素综合征是体内 5-羟色胺（一种神经递质）过多引起的。最常见的原因是**两种以上增加 5-羟色胺的药一起用**，或者擅自加量。

在双相治疗里，常见的组合包括：抗抑郁药与锂盐同用、抗抑郁药与曲马多等止痛药同用、抗抑郁药与某些抗生素（如利奈唑胺）同用、抗抑郁药与圣约翰草等草药同用。可卡因、摇头丸等物质也会推高风险。

它的典型表现是三组症状：

- **精神状态改变**：躁动、坐立不安、意识模糊、话多。
- **自主神经亢进**：发热、大汗、心跳快、瞳孔放大、腹泻、恶心。
- **神经肌肉异常**：震颤、肌肉阵挛（肌肉突然抽一下）、反射亢进（医生敲膝盖，腿弹得特别大）、眼阵挛（眼球快速抽动）、下肢僵硬。

和 NMS 最大的区别：血清素综合征的**反射亢进和阵挛**更突出，肌肉是“抽”和“抖”，不是“整体僵住”；起病往往更快，常在加药或换药后一天内出现；而 NMS 的僵硬更明显，起病相对慢一些。

现场怎么做：

- **立即停掉所有可能相关的药**（抗抑郁药、止痛药、草药、止吐药），并**立即急诊**。
- 不要自己吃退烧药、止吐药、抗过敏药来“顶一顶”，那会掩盖病情。
- 不要喝大量水硬灌，也不要自行催吐。
- 带上药盒和清单，特别是最近新加的药、感冒药、止痛药、中成药。
- 到医院后，轻症以停药、镇静、降温、补液为主，重症需要监护，医生可能使用特定拮抗药物。

一个常见误判：把血清素综合征当成“焦虑发作”“躁狂加重”。如果同时有发热、大汗、心跳快、肌肉抽动，就要想到它，而不是只调情绪药。

四、SJS/TEN：皮疹、黏膜糜烂、起疱脱皮

SJS（Stevens-Johnson 综合征）和 TEN（中毒性表皮坏死松解症）是同一类严重皮肤药物反应的不同严重程度。它本质上是免疫系统对药物产生了过激反应，把皮肤和黏膜当成攻击目标。

在双相治疗里，最需要警惕的是**拉莫三嗪**，尤其是加量过快、或者同时使用丙戊酸盐（会让拉莫三嗪血药浓度升高）的时候。卡马西平、别嘌醇、部分抗生素（如磺胺类）、部分止痛药也可能引起。中草药和成分不明的保健品同样有报道。

它的发展通常有顺序：

1. **前驱期**：发热、咽痛、乏力、眼睛红、嘴巴里溃疡，像感冒。
2. **皮疹**：开始是紫红色或暗红色的斑，可能不典型，不一定像“靶子”。
3. **皮肤疼痛**：这是重要信号，皮疹摸上去疼，而不是单纯痒。
4. **起疱、脱皮**：皮肤出现水疱、大片剥脱，像被烫伤。
5. **黏膜受累**：口腔、眼睛、生殖器黏膜糜烂，吃东西疼、睁眼困难、排尿痛。

普通药疹（多数情况）	要高度警惕 SJS/TEN
以痒为主，皮疹小而散	皮肤疼痛、触痛明显
没有发热，或只有低热	发热、咽痛、流感样前驱
没有黏膜糜烂	口腔、眼睛、生殖器糜烂
没有水疱	起疱、脱皮、表皮可以推掉
停药后逐渐好转	停药后仍在加重

现场怎么做：

- **立即停掉可疑药物**，这是最关键的一步，越早越好。
- **立即去急诊**，最好去有烧伤科或皮肤科重症救治能力的医院。
- **不要自己吃抗过敏药在家观察**，不要涂药膏遮盖皮疹，不要挑破水疱。
- 保留药盒、药品清单，记下什么时候开始吃药、什么时候出疹。
- 眼睛红、睁眼困难要主动告诉医生，眼部受累需要专科处理。
- 不要自行恢复使用同一种药，这类反应再次使用可能更严重。

五、现场第一步：一张可以照着做的清单

- ☐ 停掉可疑药物（这三种情况都属于“先停再送”的急症例外）
- ☐ 拨打 120，或立即送最近的有急诊能力的医院
- ☐ 不要自行用退烧药、抗过敏药、止吐药“对冲”
- ☐ 不要催吐、不要强行灌水
- ☐ 带上所有药盒、药品清单、最近的化验单
- ☐ 记下症状开始时间、体温、最近有没有加量或换药
- ☐ 告诉医生所有在用的东西：处方药、感冒药、止痛药、中药、保健品
- ☐ 意识不清、抽搐、呼吸困难时，保持侧卧、不要喂东西，等急救人员
- ☐ 皮疹不要挑破、不要热敷、不要抹偏方

哪些组合要格外小心

- **抗抑郁药 + 曲马多、利奈唑胺、亚甲蓝、圣约翰草**：血清素综合征风险升高。
- **抗抑郁药 + 锂盐**：也可能增加血清素综合征风险，需要医生评估。
- **拉莫三嗪 + 丙戊酸盐**：拉莫三嗪浓度升高，皮疹风险增加，医生会放慢加量速度。加量必须按医生安排，不能“想快点好”就自己加。
- **多种抗精神病药联用、长效针剂、脱水或高温环境**：NMS 风险升高。
- **自行叠加感冒药、止痛药、中成药**：成分可能重复或相互作用。
- **停药后自行恢复原剂量**：尤其是拉莫三嗪，重新使用通常要从低剂量重新开始，由医生安排。

六、容易踩的坑

- **把 NMS 当感冒**：吃退烧药、捂汗、等一晚，可能错过时机。
- **把血清素综合征当焦虑**：只加镇静药，不查药物组合。
- **皮疹先吃抗过敏药观察两天**：SJS 进展可以很快，拖延代价很大。
- **症状好转就自行恢复原药**：这三种急症都可能再次发生，且可能更重。
- **不告诉医生在吃中药和保健品**：这是最常见的信息缺口。
- **认为“吃了很久没事就永远没事”**：拉莫三嗪的皮疹可以在用药数周后才出现，加量期尤其要盯。
- **一个人扛**：出现高热、僵硬、皮疹，不要独自在家，先让身边人知道。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 服药后出现**高热 + 全身僵硬 + 意识改变 + 大汗——立即拨打 120**，考虑 NMS。
> - 加用或加量抗抑郁药、止痛药、抗生素后出现**震颤、肌肉抽动、反射亢进、躁动、大汗、心跳快——立即停药并急诊**，考虑血清素综合征。
> - 出现**皮疹伴发热、口腔溃疡、眼睛红、皮肤疼痛、起疱或脱皮——立即停药并急诊**，警惕 SJS/TEN。
> - 皮疹范围快速扩大、皮肤一碰就疼、大片脱皮——**立即拨打 120**，不要自行处理。
> - 意识不清、抽搐、呼吸困难、尿量明显减少——**立即拨打 120**。
> - 不确定是不是药物引起，但人明显不对劲——**先停药、先就医，再讨论**。
>
> 记住：这三种情况都不适合“在家观察一晚”。**停药 + 急诊**是唯一正确的第一反应。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 10：复发预防与长期管理

双相障碍容易复发。睡眠、昼夜节律、维持治疗和早期识别，是长期稳定的四根柱子。

10.1 复发预警信号

这一页讲双相障碍复发之前，睡眠、精力、说话、花钱和情绪通常会先出现哪些变化，怎么把这些变化整理成一份属于自己的预警清单，以及家属在旁边能看到什么、该怎么开口。它适合已经经历过至少一次发作、想把下一次尽量拦在前面的人，也适合想帮忙又怕说错话的家属。读完你可以带走一张能直接填写的表，下次复诊时和医生一起改。

复发大多有前兆，但不是人人都有

多数人的复发不是“昨天还好好的，今天突然发作”。在正式达到发作标准之前，常常有一段几天到几周的前驱期：睡眠先变、精力先变、说话和做事的方式先变，情绪的变化反而排在后面。【指南】NICE 和 CANMAT/ISBD 都把识别早期预警信号列为心理教育和复发预防的核心内容，而不是等发作了再处理。

前驱期有两个特点，值得先说清楚。

第一，它很个人化。有人每次都是从“睡三个小时就够”开始，有人先从“特别想找人聊天”开始，有人先出现莫名其妙的烦躁、对家人挑刺。别人的清单只能参考，不能照抄。

第二，它不一定次次一样，也不是人人都有。有一部分人是突然起病的，没有明显前兆；也有人前驱期很短，只有一两天。所以清单的作用是提高警觉，不是给你一个“没信号就安全”的保证。【临床经验】

还有一个容易被忽略的点：睡眠减少本身就是复发的推手，不只是复发的信号。睡得太少会进一步把昼夜节律往前推，让躁狂更容易被点燃。信号和处理之间要快，原因就在这里。

往上走：躁狂和轻躁狂的早期信号

下面这些变化，单独看每一条都不像“病”，放在一起、并且和本人平时的样子明显不同，才值得警惕。

睡眠需求减少：注意区分“睡不着”和“不需要睡”。抑郁性失眠是想睡睡不着、白天疲惫；躁狂前兆是睡四五个小时就自然醒，白天不困，甚至更清醒、更有劲。后者更值得警惕。

话变多、语速变快：电话打得久，话题跳来跳去，别人插不上嘴，自己觉得“思路特别清楚”。

计划和花钱变多：突然要创业、投资、报很多课、买平时舍不得买的东西；刷卡不看余额，开始借钱或动用存款。

易怒：对小事反应大，和家人、同事、陌生人起冲突，路怒，在网上跟人吵架。

夸大和特殊感：觉得自己被选中、有特殊使命、能看穿别人、和名人有某种关联。

社交和性欲增加：突然频繁约人、熬夜社交、性行为明显增多或变得轻率。

感官变敏锐：觉得颜色更鲜、声音更响、别人的话都“有含义”。

物质使用增加：喝酒变多，或者开始用兴奋剂、大麻“提神”“助眠”。

信号	早期常见样子	再往前走可能出现	家里人能做什么
睡眠	睡四五小时就够，白天不困	通宵不睡仍精力旺盛	记录入睡和起床时间，连续三晚异常就联系医生
说话	话多、语速快、爱打电话	别人完全插不上话，内容跳脱	不打断每一句，用短句慢慢降速
花钱	突然大额消费、谈投资	借钱、刷爆卡、被骗	不当场争抢，先记下金额和时间，联系医生
情绪	一点就着、挑刺	砸东西、与人冲突	降低音量、拉开距离，避免对骂
想法	觉得自己有特殊使命	坚信被监视、被选中	不争辩内容，只谈安全和具体安排

这些变化单独出现一两条，可能只是最近状态好。如果几条同时出现、持续几天、并且和三个月前的基线明显不同，才更像前驱期。判断的关键不是“有没有好心情”，而是“和平时比，变了多少”。

往下走：抑郁前兆，以及更危险的混合状态

抑郁的前兆常常被当成“最近累了”“工作压力大”，因为它的变化更慢、更不显眼。

- 早醒：比平时早一两个小时醒，醒了就再也睡不着。
- 睡很多却还是累，白天也想躺着。
- 兴趣下降：推掉聚会、不想出门、以前喜欢的事提不起劲。
- 说话和动作变慢，回复消息越来越短。
- 自责、无价值感，反复想过去的错误。
- 注意力下降，工作效率明显变差，容易出错。
- 食欲和体重变化，或者对吃饭完全没兴趣。
- 各种身体不舒服：头痛、胃痛、腰背痛、胸闷，查不出明确原因。
- 开始说“没意思”“拖累别人”“活着很累”。

最后一条要单独说。出现这类话，不要当成情绪化的抱怨，也不要急着安慰“别想太多”。可以直接问：“你最近有没有想过不活了，或者想过怎么结束？”问了不会把人问坏，反而常常让人松一口气，也让你知道下一步该多紧。【指南】

混合状态更危险。它的样子是抑郁的心境加上躁狂的精力：心里绝望，身体却坐立不安、睡不着、脑子里转个不停，容易烦躁、冲动。这种状态下自杀和冲动的风险都更高，不能当成“情绪波动”扛过去，也不是“过两天就好了”。【指南】

如果抑郁前兆里出现“烦躁 + 睡不着 + 冲动”的组合，按混合状态处理：当天联系医生，不要独处，把药物、刀具、车钥匙等交由信任的人暂管。

把信号变成一张能用的清单

做清单的方法并不复杂，关键是具体到别人也能看见。

1. 回想最近一两次发作前两到四周，写下所有变化。
2. 问一位家人或朋友：“那段时间你觉得我哪里不一样？”别人的观察常常比自己准。
3. 从中挑三到五条，优先挑能被客观观察的，比如睡眠时长、消费、说话速度，而不是“感觉不对”。
4. 给每条写一个可观察的标准。例如“连续三晚睡眠明显少于平时，白天仍然不困”，比“睡不好”有用得多。
5. 给每条配一个动作：打给谁、多久之内、要不要加一次门诊。
6. 抄一份给家人，一份放在病历本里，复诊时带给医生看。

我的预警信号	具体到什么程度	出现后 24 小时内做什么	谁负责
睡眠变少	连续三晚少于平时两小时，白天不困	打电话给门诊医生，约加急号	本人 + 家属提醒
花钱变多	一周内出现平时不会做的大额消费	暂停大额支付，把账单给家人看	本人 + 家属
易怒	一天内和两个人以上起冲突	减少社交，避免开车，联系医生	本人
想消失	连续三天说“没意思”	当天复诊，不独处	家属陪同

- ☐ 我写下了三条以上自己的早期信号
- ☐ 每条都有一个别人也能看见的标准
- ☐ 每条都配了一个具体动作和联系人
- ☐ 至少一位家人知道这张清单放在哪
- ☐ 清单上写了医生电话、医院急诊地址、12356
- ☐ 我打算下次复诊时和医生一起核对
- ☐ 我知道清单会变，准备每半年改一次

清单不是“复发诊断书”。出现信号不等于一定复发；它的价值是让你早一点联系医生，而不是自己下结论、自己改药。自行加药、自行加抗抑郁药、喝酒助眠，都可能把局面弄得更复杂。

家属能观察什么，怎么开口

家属的位置很特殊：你比医生更早看到变化，但也最容易因为担心而变成监视和指责。

可以观察的方面：

- 睡眠：几点进房间、几点熄灯、夜里有没有起来、早上几点起。
- 话量和语速：是不是突然特别能说，电话特别多。
- 消费：快递变多、账单变大、开始谈投资。
- 情绪：是不是一点就着，是不是突然特别兴奋或特别低沉。
- 社交：突然频繁外出、夜不归宿、喝酒。
- 工作学习：效率、缺勤、熬夜赶工。
- 外表：突然打扮得很夸张，或者完全不管。
- 网络：深夜长时间刷手机、发很多动态、跟人争论。

怎么开口，比说什么更重要。描述事实，不贴标签；说担心，不下判断；选平静的时候，不在冲突中说；一次只说一两件事；给对方回应的空间。

可以试试这样说：

- “我注意到你这三天都是凌晨三点睡、六点起，白天还挺有精神，我有点担心。”
- “这个月信用卡比平时多了不少，是有什么大计划吗？我想听听。”
- “你最近说话特别快，我有点跟不上，也有点担心你。”

尽量少说：

- “你又犯了。”
- “你是不是疯了。”
- “你就是不想吃药。”

隐私边界也要说清楚。成年患者的手机、日记、就诊记录属于隐私，家属的观察应该建立在日常共同生活上，而不是翻查。只有在判断有紧迫危险时，才以安全为先，并尽量让本人知道你在做什么、为什么。

容易踩的坑

- 只盯情绪，不看睡眠。睡眠往往是最早、最客观的信号。
- 把“感觉特别好”当成康复。轻躁狂的“好”常常是复发的一部分。
- 出现信号就自己加药，或翻出旧药吃。药物调整要由医生做。
- 家属发现了却不说，怕“刺激他”。平静、具体地说，通常比憋着好。
- 一次信号就断定复发，全家进入戒备。这样会让患者更不愿意沟通。
- 只记录坏消息，不记录基线。没有“平时是什么样”，就判断不了“变了多少”。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下任何一条，当天联系精神科医生；联系不上或情况在升级，直接去精神科急诊，必要时拨打 120；有伤人毁物或危险驾驶时拨打 110。**

- 连续三晚睡眠明显减少，白天不困、精力反而更旺。
- 出现幻觉、妄想、说话别人听不懂、行为明显紊乱。
- 有自杀念头、自杀计划、自伤行为，或说出“不想活了”“解脱了”。
- 出现伤人威胁、砸东西、持械、危险驾驶。
- 烦躁、抑郁、睡不着同时出现，坐立不安，像“绷不住”。
- 连续几天几乎不吃不喝，明显虚弱、发热、意识不清。
- 正在服锂盐，出现严重手抖、走路不稳、反复呕吐腹泻、意识改变。

> 不确定算不算严重时，按严重处理。也可以拨打 12356 心理援助热线，先找人一起判断。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.2 维持治疗与依从性

这一页讲维持治疗要维持多久、为什么“感觉好了”也不能自己停、依从性差通常卡在哪里，以及有哪些工具能减少漏服、家属可以怎么帮忙。它适合正在服药、曾经想过停药、或者反复漏服的人，也适合替家人盯着药盒却越盯越僵的家属。读完你能带走一套减少漏服的安排，和一份和医生谈“能不能减”的准备清单。

维持治疗要维持多久

急性期治疗的目标是把这一次发作压下去；维持治疗的目标是让下一次不来，或者来得轻一点、短一点。两者的用药逻辑不一样，不能“好了就停”。

指南的方向比较一致：在急性期缓解之后，继续使用心境稳定剂进行维持治疗，通常至少两年；如果复发风险高，时间要更长，部分人需要长期甚至终身维持。【指南】NICE、CANMAT/ISBD 和国内指南在这一点上说法接近，具体到个人由医生根据病程决定。

“复发风险高”通常包括这些情况：

- 过去发作次数多，间隔越来越短。
- 有过严重躁狂、混合发作或快速循环。
- 有过自杀尝试或严重冲动行为。
- 曾经停药后很快复发。
- 家族史明显，或者起病年龄很早。
- 合并物质使用，睡眠长期不规律。
- 发作后有残留症状，功能恢复不完全。

反过来，减药或停药也不是绝对不能谈。有些人在稳定多年、副作用明显、有生育计划或出现躯体疾病时，会和医生讨论逐步调整。关键是“讨论”和“计划”，不是某天自己决定不吃了。【指南】

阶段	目标	大致时间	重点
急性期	控制这次发作	数周至数月	症状、安全、躯体监测
巩固期	防止刚缓解就反弹	缓解后数月	方案稳定、观察副作用
维持期	预防下一次发作	至少数年，个体化	依从性、节律、早期信号

需要说明：表中的“时间”是大致范围，不是每个人都一样。有人维持两三年可以在医生指导下尝试调整，有人需要很多年，这取决于发作史、严重度、家族史和生活环境，不是意志力问题。

为什么“感觉好了”不能停药

这是临床上最常见、也最可惜的一种停药理由：吃药半年，睡得好、情绪稳、工作也顺，于是觉得“我好了，不需要了”。

问题是，稳定本身很可能就是药物在起作用。双相障碍在停药后的复发风险明显上升，而且停药后的复发不一定温和，可能直接是一次严重躁狂或混合发作，甚至伴随自杀风险。【指南】【研究】

还有几个具体的机制值得知道：

- 突然停用锂盐，复发风险会在短时间内升高，所以锂盐的调整通常要慢慢来，由医生安排。【指南】
- 突然停用抗精神病药，可能出现撤药症状、睡眠反弹、焦虑加重，也会增加复发风险。
- 停药后如果复发，原来有效的方案不一定还能原样奏效，调整会更麻烦。
- 每一次发作都可能带来功能损害、关系破裂、经济后果，这些代价往往比吃药大。

也要说清楚：药物不是万能的，维持治疗不能保证不复发。它降低的是概率和严重程度。把吃药理解成“买保险”，比理解成“买痊愈”更接近事实。

另一个常见误区是“我现在的剂量很低，说明我可以停了”。剂量低可能是医生根据你的情况做的调整，也可能是血药浓度、体重、合并用药的结果，不代表疾病消失了。减不减、怎么减，要由医生判断。

依从性差，通常不是“不听话”

“依从性”这个词有点居高临下，它说的其实就是“能不能按商量好的方案把药吃下去”。在双相障碍里，漏服和自行调整很常见，原因往往很具体，不是简单的“不听话”。【研究】

常见原因	心里在想什么	实际发生了什么	可以怎么处理
副作用	吃了难受，不如不吃	手抖、发胖、困、口干、掉头发	记下具体感受，复诊逐条说，多数有调整空间
病耻感	吃药就说明我是病人	躲着吃、在外不敢拿药	把吃药看成慢病管理；只在必要的人面前披露
感觉好了	我已经好了	自行停药，随后复发	和医生谈维持时间，不自行决定
费用	长期吃太贵	减量、隔天吃、断药	问医保门特、社区项目、仿制药
忘记	太忙、作息乱	血药浓度忽高忽低	固定触发点、分装药盒、闹钟
方案复杂	一天好几次，记不住	漏服、重复服	和医生讨论能否简化
信息冲突	网上说这药伤肝伤肾	害怕，偷偷停	拿具体说法问医生，不用帖子做决定
物质使用	喝酒、用大麻助眠	干扰药效和睡眠	单独处理，如实告诉医生

逐一展开几项。

副作用是最需要认真对待的一项。手抖、体重增加、犯困、口干、便秘、掉头发、性功能受影响、记性变差，这些都会真实地影响生活，不是“忍忍就过去了”。但正确的动作是“带着记录去复诊”，

不是“自己减量”。医生可以通过调整服药时间、换剂型、处理副作用、换药来改善，很多问题有办法。【临床经验】

病耻感也很常见。有人在外人面前不敢吃药，把药装在维生素瓶里；有人觉得吃药等于承认自己“有问题”。这些感受值得被理解，但不必被它牵着走。双相障碍和高血压、糖尿病一样，是需要长期管理的慢性病，吃药是管理手段，不是人格评价。

费用是现实问题。长期复诊、化验、药费加在一起，对很多家庭是负担。可以主动问医生和医保办：有没有进入门诊慢特病、有没有价格更低的同类药、社区有没有免费服药或补助项目。不要用“减量”“隔天吃”来省钱，那样可能省下药费、花掉住院费。

忘记则更像一个工程问题，而不是道德问题。下一节讲工具。

可以用的工具，和家属的位置

工具的原则是：把“记得吃”从意志力变成环境设计。意志力会波动，环境不会。

- 固定触发点：刷牙后、早饭时、睡前关灯前。把药放在触发点看得见的地方。
- 分装药盒：一周一格，周日晚上装好；格子空了就说明吃过了，减少“我到底吃没吃”的焦虑。
- 手机闹钟：设两个，一个提醒，一个十分钟后确认。
- 服药记录：日历打勾，或用手机应用记录；复诊时带给医生看。
- 备份：包里放一次的量，办公室放一次的量，注意储存安全和儿童拿不到。
- 续方提醒：在还剩一周药量时就去挂号或联系医生，不要等到最后一粒。
- 副作用记录：写下“什么时候出现、多严重、影响什么”，比“我不舒服”有用得多。
- 复诊前清单：这一个月漏了几次、哪几天、为什么；有没有想停药的念头；副作用；睡眠；月经或怀孕计划。

漏服了怎么办：不要自行加倍补服，也不要把两次并成一次。查看药品说明书，或联系医生、药师，按建议处理。如果经常漏，说明方案需要改，而不是需要更强的意志。

- ☐ 我的药放在每天必经的位置
- ☐ 我用分装药盒或闹钟
- ☐ 我知道漏服后该问谁，不自己加倍
- ☐ 我能说出我吃的每种药是做什么的
- ☐ 我知道哪些副作用要立刻报告
- ☐ 我在药还剩一周时就续方
- ☐ 我有一个“想停药时先找谁”的名字
- ☐ 我的家人知道哪些事该帮、哪些事不该替我做

家属的位置：帮忙，不接管

可以做的：

- 提醒，但不反复追问，不把药举到面前。
- 帮忙续方、记复诊日期、准备问题清单。
- 观察效果和副作用，如实告诉医生。
- 在患者想停药时，先听完理由，再一起约医生，而不是直接说“不行”。
- 把“吃药”和“控制”分开：吃药是患者的事，家属提供的是支持。

不建议做的：

- 把药藏起来、偷偷换药，或者把药说成“维生素”。
- 用“你不吃药就会疯”来威胁。
- 在争吵中谈吃药。
- 替成年患者做所有医疗决定，除非法律上已经确定监护关系。

一个实用的家庭约定是：不问“你今天吃药了吗”，而是问“这周有没有哪次差点忘了？要不要把药盒挪个位置？”前者像查岗，后者像合作。

容易踩的坑

- 把“没副作用”当成“可以停”。
- 把“最近状态好”归功于自己调整得好，而不是治疗。
- 副作用一出现就自行减量，而不是联系医生。
- 用喝酒、熬夜、加大工作量来“测试自己还行不行”。
- 只在复诊时说保健品、中药，却不说自己停了精神科药。
- 家属替患者保管药物，却没有约定什么时候归还自主权。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下情况，尽快联系开药医生；联系不上或情况紧急，去精神科急诊，必要时拨打 120。**

- 自行停药或连续多日漏服后，出现失眠、话多、烦躁、精力异常旺盛。
- 停药后情绪急转直下，出现强烈绝望感或自杀念头。
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、频繁呕吐腹泻、发热、意识模糊，警惕锂中毒。
- 服丙戊酸盐后严重腹痛、持续呕吐、意识改变、皮肤或眼睛发黄。
- 服拉莫三嗪后出现皮疹，尤其伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮，立即停药并急诊。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快。
- 副作用严重到影响工作、生活，或者让你想自行停药。

> 想停药本身就是一个应该告诉医生的信号，不需要羞耻。可以和医生说：“我最近在想要不要停，能不能一起看看为什么。”也可以拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.3 昼夜节律与生活方式管理

这一页讲为什么作息对双相障碍不只是“养生”，而是治疗的一部分；固定起床、光照、运动、咖啡因和酒精分别怎么影响节律；倒班和跨时区怎么减少风险；以及怎么用一张社会节律表把一周看出来。它适合作息乱、反复失眠、工作需要倒班或经常出差的人，也适合想帮忙但只会说“早点睡”的家属。

为什么作息会影响双相

人体有一套大约 24 小时的内部时钟，管睡眠、体温、激素、精力、食欲和情绪。它每天靠外部线索校准，最重要的是光线和活动时间。这套系统叫昼夜节律。

双相障碍和昼夜节律的关系很紧：

- 睡眠减少常常出现在躁狂之前，也会反过来加重躁狂，形成循环。
- 抑郁时常见早醒，或者整天困倦、日间节律变平。
- 跨时区、倒班、通宵会打乱节律，被列为复发的诱因。【指南】
- 人际与社会节律治疗（IPSRT）就是针对这一点设计的：把每天的关键活动时间稳定下来，减少节律波动。【指南】【研究】

所以“规律作息”不是道德要求，也不是“自律的人不会生病”。它是一种具体的、可以操作的治疗手段，和吃药、复诊并列。反过来说，作息乱也不是“懒”，很多时候是疾病、工作或照护现实造成的。

固定起床：最重要的一根锚

在所有作息规则里，最值得守住的是起床时间。

原因很实际：起床时间决定了一天第一次见光、第一次活动、第一次吃饭的时间，也间接决定晚上什么时候困。晚上几点睡很难直接控制，早上几点起却可以。把起床时间固定住，睡眠压力会自己在晚上积累起来。

做法可以很具体：

- 选一个你能在一周七天都做到的起床时间，包括周末。周末补觉两三个小时，等于每周给自己一次小型时差。
- 醒来后尽快见光：拉开窗帘、出门走十分钟、在窗边吃早饭。阴天的户外光也比室内亮得多。
- 不要反复按“再睡五分钟”。闹钟放远一点，逼自己站起来关。
- 如果前一晚睡得很差，白天可以短睡，但尽量安排在下午早些时候，时间短一些，不要睡到傍晚。
- 起床后先做一件固定的小事，比如喝水、洗澡、拉伸，把它当成“白天开始”的信号。

起床时间也不是越早越好。值夜班的人、照顾婴儿的人、有躯体疾病的人，需要的是“在现有条件下尽量固定”，不是硬套一个标准。如果固定起床让你长期睡眠不足，那是方案要改，不是意志不够。

时间	可以固定的锚点	为什么重要	做不到时的替代
起床后 1 小时内	见光、吃早饭	校准生物钟	在窗边坐十分钟
上午	开始工作或学习	给身体活动信号	固定时间做家务
中午	午饭、短暂休息	维持日间节律	固定时间离开屏幕
傍晚	晚饭、散步	区分白天和夜晚	固定时间收工
睡前 1 小时	调暗灯光、停止工作	让睡意上来	洗澡、听轻音乐
上床时间	固定上床	稳定睡眠窗口	困了再上床，但不要拖太晚

光、运动、咖啡因和酒精

光：早上要亮，晚上要暗。白天尽量有户外光；晚上把大灯换成小灯，屏幕调暗，睡前一小时减少强光。对双相抑郁的光照治疗有研究，但可能诱发转躁，必须在医生指导下进行，不要自己买灯照。【研究】【待验证】

运动：规律的中等强度运动对情绪和睡眠都有帮助，可以作为辅助治疗。【研究】时间上，多数人适合在白天或傍晚早些时候；临睡前剧烈运动可能让人更清醒。开始运动时从少量开始，别在躁狂前兆期突然加大运动量，那可能是在顺着发作走。

咖啡因：咖啡、浓茶、可乐、能量饮料都含咖啡因，作用能持续好几个小时。下午晚些时候和晚上摄入，会让入睡变难、睡眠变浅。对双相患者，比较稳妥的做法是把咖啡因集中在上午，并注意能量饮料里常还有别的刺激成分。【临床经验】

酒精：酒精能让人更快入睡，但会破坏后半夜的睡眠结构，加重打鼾和早醒；它还会和许多精神科药物相互作用，影响肝功能、加重镇静。用酒助眠是个陷阱。如果已经形成“每天要喝一点才能睡”的模式，需要和医生说明，突然停酒也可能有风险。

大麻和其他物质：常被用来“缓解焦虑”“帮助睡眠”，但会扰乱节律、增加复发和认知损害的风险，也可能与药物相互作用。不要用它们替代治疗。

因素	对节律的影响	建议
咖啡因	延迟入睡、睡眠变浅	集中在上午，下午后减少
酒精	入睡快但后半夜易醒	不用来助眠，注意与药物相互作用
夜间强光与屏幕	抑制睡意、推迟入睡	睡前调暗，减少刷手机
白天户外光	校准生物钟、改善情绪	每天尽量有
临睡前剧烈运动	提高警觉、推迟入睡	改到白天或傍晚早些时候
白天长时间卧床	削弱睡眠压力	除睡眠外尽量不卧床

倒班、跨时区与社交节律表

倒班：研究提示倒班工作和心境发作有关。【研究】完全避免有时不现实，可以做的是减少伤害：

- 排班尽量固定，避免频繁在早班、晚班之间来回切换。
- 换班后给自己留出过渡时间，不要下夜班直接去应酬。
- 夜班期间的光照要安排好：工作时亮，下班路上戴墨镜，回家后把房间弄暗，帮助自己进入“夜间”。
- 夜班后不要用酒精助眠。
- 把排班表给医生看，让医生知道你的作息现实，而不是假设你朝九晚五。

跨时区：往东飞通常意味着把节律“提前”，往西飞意味着“推后”。时差本身会打乱节律，旅行也可能伴随睡眠剥夺、饮酒、兴奋和作息混乱，这些叠在一起是复发的高风险窗口。【临床经验】可以做的：

- 出发前和医生讨论，是否需要提前调整服药时间。时区变了，服药时间也要跟着变，这件事必须由医生安排。
- 飞行中多喝水、少喝酒，尽量按目的地时间安排睡眠。
- 到达后尽快按当地时间起床、见光、吃饭，不要在白天补长觉。
- 头几天把行程排松一点，重要谈判、考试、比赛不要放在到达当天。
- 回程后同样给自己两三天过渡，不要下了飞机就上班。

社会节律表：这是 IPSRT 里常用的工具，核心是记录每天五个锚点事件的时间：起床、第一次与人接触、开始工作或学习、吃晚饭、上床。连续记一两周，就能看出哪几天乱、乱在什么地方。【指南】

如果一次记五个太麻烦，可以先记最关键的三个：起床、上床、睡眠时长；有余力再把开始工作和晚饭补上。

日期	起床	上床	睡眠时长
周一	7:10	23:30	7.5 小时
周二	9:40	1:20	8 小时
周三	7:00	23:00	7.5 小时
周四	空白	空白	空白

看这张示例表，问题不在“睡得多不多”，而在周二整条节律往后移了两个多小时。一次两次没关系，如果每周都这样来回摆，节律就一直在倒时差。

- ☐ 这一周我有几天在同一时间起床，前后差不超过一小时
- ☐ 我有几天在起床后一小时内见到户外光
- ☐ 我有几天在睡前一小时还在看亮屏或工作
- ☐ 我这周最晚一次上床是几点

- ☐ 我这周有几天靠酒精或药物助眠
- ☐ 我这周有几天白天卧床超过一小时，但不是为了睡觉
- ☐ 我下周准备先改哪一件事

先改一件就好。通常从“固定起床”开始，比从“强迫自己早睡”容易，也更有效。

容易踩的坑

- 平时熬夜、周末补觉，以为总时长够了就行。节律看的是时间点，不只是总时长。
- 把“累了就能睡”当成规律。累过头反而更难入睡。
- 用酒精、褪黑素、安眠药自己解决失眠，不告诉医生。
- 一听说运动好，就在轻躁狂期突然每天跑十公里。
- 出差回来当天就满负荷上班。
- 把作息表当成考核，某天没做到就全盘放弃。记录是为了看见模式，不是为了打分。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

出现以下情况，联系精神科医生；情况紧急或联系不上，去急诊，必要时拨打 120。

- 连续三晚睡眠明显减少，白天不困、精力反而更旺。
- 连续一周入睡困难或早醒，白天功能明显下降。
- 跨时区或倒班后出现话多、易怒、花钱增多、行为冲动。
- 白天困到影响驾驶、工作，或者打鼾伴憋醒，可能需要排查睡眠呼吸问题。
- 用酒精或安眠药助眠，而且越来越多。
- 出现自杀念头、自伤行为，或连续几天几乎不吃不喝。

睡眠问题不要硬扛，也不要自己加药。12356 心理援助热线可以作为夜间情绪支持的一个入口。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.4 康复目标与生活质量

这一页讲“好起来”除了没有症状还包括什么，症状、功能、关系、意义感四个维度怎么分开看，为什么康复不是只有“回到病前”一条路，以及怎么把目标定得由患者自己说了算。它适合已经度过急性期、开始想“以后怎么过”的人，也适合替家人着急、希望对方“赶紧恢复正常”的家属。读完你可以带走一张目标表和几个能马上用的问题。

“好起来”不只是没有症状

医学上常用几个词，它们说的不是一回事：

- 应答：症状明显减轻。
- 缓解：症状基本消失，并持续一段时间。
- 康复：不只是症状轻，还能生活、工作、与人相处，并且自己觉得日子有意义。

精神科说的“功能恢复”和康复者群体说的“个人康复”也不完全一样。前者看的是能不能上班、上学、自理、社交；后者更看“我能不能过我想过的生活”。两个都要有，也都值得被看见。【指南】【个人体验】

一个容易被忽略的事实：症状轻了，功能不一定自动回来。有人情绪已经稳定，但仍然不敢上班、不敢见朋友、不敢做决定。这不是“矫情”，而是发作之后常见的信心受损、技能生疏、关系断裂和经济压力，需要单独处理，也需要时间。

同样，功能很好也不等于过得好。有人能上班、能应酬、看起来一切正常，但每天靠硬撑，觉得自己只是在完成任务。这种“高功能”下的痛苦，同样值得在复诊时说。

四个维度：症状、功能、关系、意义感

把“康复”拆成四块，比较容易看清自己卡在哪，也方便和医生讨论。

症状：睡眠、情绪波动、焦虑、幻觉妄想、注意力。目标是“稳定”和“可控”，不是“永远没有任何波动”。正常人也有情绪起伏，双相患者的波动可以存在，只要不升级成发作。

功能：自理、家务、学习、工作、理财、就医、出行。功能恢复常常是渐进的，需要台阶，不是“要么全好，要么全废”。

关系：和家人、伴侣、朋友、同事的连接；冲突的处理；边界；是否敢告诉别人自己的病。关系既是支持，也可能是压力源。

意义感：我为什么起床、我在意什么、我想成为什么样的人。这一块最容易被诊室里的量表漏掉，但它常常决定一个人愿不愿意长期治疗。

维度	可以问自己的问题	一个可执行的小目标
症状	我的睡眠和情绪这一个月稳吗	连续两周记录睡眠和心境
功能	我现在能承担多少	先从每周两天半日工作或学习开始
关系	我和谁断了联系，想不想接回来	这周约一个朋友喝咖啡
意义感	什么让我觉得这一天值得过	每周留两小时做一件“没用但喜欢”的事

四个维度不是考试科目，不需要同时满分。有人先恢复睡眠，有人先恢复工作，有人先恢复一段关系。顺序因人而异，重要的是知道自己现在在补哪一块。

康复不是“回到病前”那一条路

“回到生病前的样子”是很自然的愿望，但它未必现实，也未必是唯一的好结果。

原因有几个：

- 生病前的“样子”可能本身就带着问题：长期熬夜、过度工作、用酒精应付社交、待在消耗性的关系里。回到那个状态，可能只是回到下一次复发的前夜。
- 发作会带来真实的改变：学业中断、工作变动、经济压力、关系破裂。这些需要重新规划，而不是假装没发生。
- 年龄和人生阶段也在变。二十岁的目标和三十五岁的目标本来就不一样。

所以康复的路线至少有三条，可以同时走，也可以中途换：

1. 回到病前：在条件允许时，恢复原来的学习、工作、生活。这是很多人想要的，也常常能做到一部分。
2. 调整后继续：换一个节奏更稳的岗位、减少工作量、换专业、搬去支持更多的城市。不是“退而求其次”，是重新匹配。
3. 重新定义：把经历变成新的方向，比如做同伴支持、做公益、写作、换一种更在意健康的生活。这条不是每个人都想要，但它确实存在。【个人体验】

三条路没有高下。重要的是这条路是不是你自己选的，而不是被“应该”推着走。

也要说清楚：康复不是线性的。有反复、有回退、有“明明好了又不行了”的阶段，这很常见，不代表前功尽弃。【临床经验】判断进步，不只看“有没有症状”，也看“遇到波动时恢复得快不快、求助得顺不顺”。

目标由患者主导：怎么定、怎么改

“患者主导”不等于“医生和家属什么都不管”，而是说：目标由患者提出和确认，专业者提供信息、风险和选项，家属提供支持。这在指南里叫“共享决策”。【指南】

一个可用的目标写法：具体、可观察、有时间、有台阶、允许调整。

不太有用的写法：“我要彻底好起来。”

好一点的写法：“接下来三个月，我想把起床时间稳定在八点，每周去三次健身房，先试两个月兼职。”

定目标的步骤：

1. 选一个维度，先别四个一起上。
2. 写一个“最小可行版本”，小到今天就能做一点。
3. 写下可能挡路的事：失眠、副作用、通勤、钱、家人的态度。
4. 写下谁能帮忙，帮什么。
5. 定一个复查时间，四周后或下次复诊。
6. 到时间就问：做到了吗？哪里卡住？目标要不要改？

- [ ] 我现在最想改善的是哪一个维度
- [ ] 我这个月的目标具体是什么，能不能被观察
- [ ] 最小的一步是什么，今天或本周能做
- [ ] 可能挡路的三件事是什么
- [ ] 谁能帮我，具体帮什么
- [ ] 我什么时候复查这个目标
- [ ] 如果做不到，我允许自己怎么调整
- [ ] 这个目标是我想要的，还是别人希望我做的

家属的角色：支持自主，不替对方活

- 可以问“你希望我怎么帮”，而不是“你应该……”。
- 把“恢复工作”当成选项之一，不是唯一标准。
- 允许“慢”，但关注是不是在往某个方向走。
- 不把每一次退步解读为“不努力”。
- 照顾好自己的生活。长期照护需要可持续，家属垮了，支持也会断。

有些话听起来是鼓励，实际是压力：“你看别人都能上班了”“你就是想太多”“再坚持一下就好了”。这些话会让患者更不敢说自己的困难。换成“你现在最想先解决哪一件”“要不要我陪你去复诊”，会更有用。

容易踩的坑

- 把“没有症状”当成康复的全部，忽略了功能、关系和意义感。
- 把“回到病前”当成唯一目标，做不到就认为自己失败。
- 目标定得太大，比如“一个月内恢复全职”，做不到就全盘放弃。
- 家属替患者定目标，患者只是执行者。

- 在抑郁期做重大人生决定，比如辞职、离婚、退学。
- 用“高功能”掩盖痛苦，直到撑不住。

关于最后一点要多说一句：抑郁的时候，意义感会消失，这是症状的一部分，不是人生的结论。在抑郁期不要急着做重大决定，尽量等到状态稳定后再看。如果出现“活着没意思”“没有我大家更好”，按自杀风险处理，不要只当成情绪低落。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下任何一条，联系精神科医生；有即时危险时去急诊或拨打 120。**

- 觉得活着没意思，有自杀念头、计划或自伤行为。
- 目标完全推不动，连起床、吃饭、洗漱都困难。
- 情绪突然高涨、话多、几天不睡，开始制定庞大计划。
- 想通过停药来“证明自己好了”。
- 功能突然明显下降，不能上班、上学或自理。
- 出现幻觉、妄想，或坚信自己“已经彻底好了，不需要任何人”。

> 康复目标可以慢慢调，安全不能等。也可以拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 11：危机、住院与法律

急性躁狂、混合状态、自杀/伤人风险，可能需要住院。这一模块讲现场处理、住院指征和法律权益。

11.1 急性躁狂混合发作的现场处理

这一页讲家人或同伴在躁狂、混合发作现场可以做什么：怎么减少刺激、怎么说话、什么时候打 120 或 110、哪些事绝对不要做。它不教你“制服”任何人，也不鼓励强行按压或捆绑。目标是让场面先安全下来，把人送到能处理的地方。适合正在面对发作的家属，也适合提前做准备的本人和同伴。

先处理环境，再处理对话

躁狂发作时，人的感官常常是过载的：声音显得更响，灯光更刺眼，别人的动作更快，信息涌进来却很难筛选。这时候讲道理、争论、围一圈人看着，都会让情况更糟。

先做的是“减法”：

- 减少人数：只留一两个本人信任、说话能听进去的人，其他人先离开房间。
- 降低声音：关掉电视、音乐，说话放低、放慢。
- 降低光：拉上窗帘或调暗灯光，避免闪光和强光。
- 清出空间：把易碎、可投掷、可伤人的东西收走，包括刀具、玻璃杯、酒瓶、工具、车钥匙，但不要当着面大动作地搜。
- 保留出口：确保本人和你都有可以离开的通道，不要把人堵在角落。
- 不要围堵、不要按住、不要几个人同时说话。

如果场面已经失控，比如砸东西、持械、打人、自伤，环境处理让位给安全撤离：其他人先离开，报警，不要试图用身体挡住。财物可以再买，人受伤了很难补。

先判断这是不是医疗急症

有些躁狂样表现其实是躯体问题：高热、感染、脱水、甲状腺危象、药物中毒、谵妄、低血糖。这些会要命，处理顺序完全不同。

出现以下情况，不要在家“观察”，直接打 120：

- 高热、大汗、意识模糊、抽搐。
- 几天几乎不吃不喝，站不稳、眼窝凹陷、尿很少。
- 正在服锂盐，出现严重手抖、走路不稳、反复呕吐腹泻。
- 突然变得非常安静、不动不说话、维持奇怪姿势，可能是紧张症。

- 误服或过量服药。

怎么说话：短、慢、具体、给选择

急性躁狂时，抽象的劝说基本无效。“你冷静一点”“你这样不对”“你生病了”这类话，容易被听成否定和挑衅。

可以用的原则：

- 句子短：一句话一个意思，不超过十几二十个字。
- 语速慢、音量低：比对方慢半拍，音量比对方低一点。
- 说感受，不说诊断：“我看你现在很烦躁”比“你在躁狂”更容易被接住。
- 认可情绪，不认可危险内容：“我知道你现在觉得这件事特别重要”，不必附和“你必须马上投这笔钱”。
- 给两个具体选择：“你想在客厅坐一会儿，还是去阳台透透气？”比“你去休息”有效。
- 一次只问一件事，给时间等回答。
- 保持距离：一臂半到两臂，不背对，不突然伸手。
- 提前说明动作：“我要把桌上的杯子拿走，避免打碎。”不要突然抢东西。

不要争辩。争论妄想内容，比如“你说的那个人根本不存在”，通常只会升级冲突。你不需要同意，也不需要驳倒，只需要把话题带回安全和具体的事：“这件事我们记下来，等医生来了再说。”

也不要用激将、嘲讽、威胁。“你再这样我就报警”“你就是作”这类话，可能暂时压住，也可能直接点燃。报警可以是必要措施，但不该被当作吓唬人的筹码。

情形	不建议	可以试
说话很快、停不下来	打断、纠正每一句	听一会儿，用短句回应，慢慢降速
坚信被针对、被监视	争论“没人害你”	“我知道你有这种感觉，在这里你是安全的”
要求马上出门、开车	抢钥匙、堵门	先拖时间，提议坐下谈，必要时报警
砸东西	冲上去夺、几个人按住	撤到安全处，清场，报警
拒绝吃药	强行灌药、把药混进饮料	不硬来，联系医生或急诊
自伤	抢工具、指责	移除危险物，保持陪伴，去急诊
辱骂、推搡	对骂、还手	后退、离开房间、求助

说话的目标不是“说服他承认有病”，而是“让接下来的十分钟更安全”。这两件事经常被混在一起，结果两件都做不到。

什么时候打 120、什么时候打 110

这是最容易犹豫的一步。原则是：**只要有即时的人身危险，就先打电话，不要先想着“再劝劝”。**

打 120，急救：

- 意识不清、昏迷、抽搐、高热、严重脱水、虚弱到站不住。
- 疑似药物中毒、过量服药、严重过敏、胸痛、呼吸困难。
- 自伤或伤人后有明显外伤、出血。
- 紧张症表现：不吃不动不说话、维持奇怪姿势、对外界反应很差。
- 需要医疗转运才能安全到达医院。

打 110，报警：

- 持械、威胁伤人、已经动手、砸毁财物、纵火。
- 危险驾驶、要开车上路、在马路中间、高处、水边等危险位置。
- 有明确的伤人计划或目标。
- 你无法靠近，无法保证自己和他人安全。
- 需要协助送医时，警方是现场处置的力量。

顺序上：有人受伤或意识问题，先 120；有暴力或持械，先 110，必要时两个都打。打电话时说清楚：地址、几个人、有没有武器、有没有人受伤、对方现在的状态、有没有孩子在场。

注意：报警的目的是“让现场安全、让人得到评估”，不是“惩罚”。跟接线员说“他生病了，现在有危险”，比说“他疯了”更有用，也更不容易让现场对抗升级。

如果本人还愿意配合，让他自己走出门、自己上车，通常比被抬走好。可以这样说：“我们去医院让医生看看，先把现在这个难受劲处理一下。”不要承诺“看完就回来”这类你做不到的事，也不要在车上继续争论。

不要做的事

- **不要强行制服。** 几个人按住、压在地上、用绳子或胶带捆绑，可能导致窒息、骨折、肌肉损伤，尤其在被按压胸背时；也会极大增加对方的恐惧和反抗，让冲突升级。约束是医疗行为，应在医疗机构由受过训练的人按规范实施，不是家属在现场该做的事。
- 不要扇耳光、泼冷水，或者用“打醒”的方式。
- 不要围一圈人盯着看，不要拿手机拍。
- 不要争辩妄想，不要嘲笑，不要模仿对方的语速。
- 不要强行灌药，不要把药混进饮料里。
- 不要在对方激动时突然触碰，或者从背后靠近。
- 不要拿走手机、钥匙、钱包作为“惩罚”。因安全原因暂管可以，但要说明，并尽快归还。
- 不要让本人开车，也不要自己一边吵架一边开车。
- 不要用酒精“让他冷静”。
- 不要独自处理有武器、有暴力史的场面。
- 不要在发作现场讨论“你到底有没有病”“要不要住院”这类大问题。

关于“不要强行制服”，值得再解释一句。很多家属是出于爱和害怕才按住对方，但现场按压的风险被严重低估：人在剧烈挣扎时，胸腹受压几分钟就可能缺氧；有心脏病、肥胖、喝酒的人风险更高。而且一旦动手，信任很难修复，下一次发作时对方会更抗拒求助。真正专业的做法是降级、撤离、求助，而不是比力气。

等急救到来之前，家里可以做的准备

- 一个人负责沟通，其他人退到安全距离。
- 把其他家人、孩子、宠物带到另一个房间或邻居家。
- 清出通道，把门口的车挪开，方便急救人员进出。
- 准备好信息：姓名、年龄、诊断、正在吃的药（拍照或带药盒）、过敏史、既往住院医院、主治医生电话、医保卡和身份证。
- 记录时间线：从哪天开始睡不好、说了什么、做了什么，医生会问。
- 如果本人愿意，让他自己走出去、上车。
- 保持电话畅通，把 120、110、医生、12356 的号码放在手边。

- ☐ 只留一两个人，声音和灯都调低
- ☐ 危险物品和车钥匙已移开
- ☐ 我站在能退出的位置，没有堵住对方
- ☐ 我说话短、慢、低，没有争辩
- ☐ 我已经判断要不要打 120 或 110
- ☐ 证件、药盒、医生电话在手边
- ☐ 孩子和老人已转移到安全处
- ☐ 我没有试图按压或捆绑对方

容易踩的坑

- 觉得“家丑不可外扬”，拖到出事才求助。
- 把“他在骂人”当成“他不会伤人”，忽略升级的可能。
- 为了让他吃药，把药混进饭里，结果信任彻底破裂。
- 在楼道里大声争执，围观的人越多，越难下台。
- 报警时只说“他疯了”，没有说清有没有武器、有没有人受伤。
- 事后不复盘，也不和医生讨论这次是怎么升级的。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下任何一条，立即呼叫 120，必要时拨打 110：**
>
> - 持械、伤人、纵火、危险驾驶。

- 明确的自杀计划或自伤行为。
- 意识不清、抽搐、高热、几天几乎不吃不喝。
- 疑似中毒或过量服药。
- 紧张症表现：不吃不动不说话、维持奇怪姿势。
- 你无法保证任何人的安全。

> 如果还没有到立即危险，但已经连续几天睡很少、话多、花钱失控、和家人冲突升级，当天联系精神科医生，要求加急评估，不要等到“明天看看”。不确定时按严重处理，也可以拨打 **12356** 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

11.2 住院指征与自愿非自愿

这一页讲什么情况需要住院、自愿住院和非自愿住院在法律上分别是什么条件、病房里大概会发生什么、出院前要准备什么。它只讲原则，不替代法律条文，具体认定和程序以现行法律和当地规定为准。适合正在犹豫“要不要送医院”的家属，也适合担心“被关起来”的患者。

什么情况需要住院

住院不是因为“病得丢人”，而是因为门诊条件不够：需要 24 小时观察、需要快速调整治疗、需要把危险因素从环境里拿掉。

常见的住院理由可以分几类。

安全类：

- 有自杀念头、计划、准备行为，或近期有自杀尝试。
- 有伤人、纵火、危险驾驶等风险。
- 严重自伤，比如割伤、烧伤、吞异物。
- 无法保证基本安全，比如在马路中间、高处、水边徘徊。

精神症状类：

- 幻觉、妄想明显，影响判断和行为。
- 严重躁狂：几天不睡、行为紊乱、无法自理、冲动失控。
- 混合状态，烦躁到坐立不安，冲动和绝望同时存在。
- 紧张症：不吃不动不说话、木僵、维持奇怪姿势。
- 需要与躯体疾病、物质使用、谵妄鉴别，门诊做不完。

躯体与治疗类：

- 需要监测药物不良反应，比如锂盐、丙戊酸盐相关问题。
- 需要电休克治疗等只能在医院完成的治疗。
- 门诊调整失败，症状持续加重。
- 严重的共病：感染、脱水、拒食、体重骤降。

支持系统类：

- 家里没有人能看护，或者家庭环境本身就是高风险，比如持续冲突、暴力、家里有可得的危险物品。
- 居住地离医院很远，无法及时复诊。

情况	门诊能不能处理	是否考虑住院
轻躁狂、能自理、有家人看护	多半可以	加急门诊，密切随访
躁狂伴冲动消费、彻夜不眠	风险高	建议住院评估

情况	门诊能不能处理	是否考虑住院
有自杀计划但能配合	需要立即评估	通常需要住院
拒食拒水、意识不清	不能	急诊，可能需要住院
紧张症	不能	住院，可能需要电休克
药物不良反应需监测	视情况	可能需要住院

“要不要住院”不是一个非黑即白的问题。可以和医生讨论：能不能加急门诊、能不能增加随访、能不能先调整家里环境、有没有日间病房或社区支持。把选项摆出来，比只问“必须住吗”更有用。

自愿与非自愿：法律上的两条路径

中国《精神卫生法》确立了一个总原则：**精神障碍的住院治疗实行自愿原则。** 也就是说，患者自己同意，是住院的默认前提。

在这个原则之外，法律规定了可以对严重精神障碍患者实施非自愿住院的情形，通常概括为两类：

1. 已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险。
2. 已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险。

这两类的共同前提是：**诊断为严重精神障碍，并且有相应的行为或危险。** 不是“家属觉得需要”，也不是“医生觉得麻烦”，更不是“不听话”。

几个容易误解的点：

- “严重精神障碍”有特定的医学和法律含义，不等于日常说的“病得比较重”。
- 非自愿住院需要符合法定条件的诊断和评估，并按程序办理，不是家属签字就能把人留下。
- 伤害自身的情形，通常还涉及监护人是否同意的问题；法律对监护人不同意时的处理有规定。危害他人安全的情形，法律规定了再次诊断、鉴定等程序，监护人阻碍治疗时也可能需要公安机关协助。具体以现行法律条文和当地实施规定为准。
- 即使是非自愿住院，患者仍然享有通信、会见、申诉等权利，具体范围按法律和医院规定执行。
- 不同地区在送诊主体、复核流程、社区衔接上可能有细化规定。

对比项	自愿住院	非自愿住院
谁提出	本人同意并签署	符合法定情形，由相关主体送诊或决定
核心条件	本人自愿	严重精神障碍，加上伤害自身或危害他人安全的行为或危险
知情同意	本人签署	按法定程序，保障告知与救济
主要目的	治疗与合作	安全保护与治疗
权利	通信、会见、申诉等	同样享有法定权利，程序上有额外保障

家属能做什么

- 把观察到的行为具体写下来：哪天、几点、做了什么、有没有伤人或者自伤。
- 不要夸大，也不要隐瞒。夸大可能让患者失去信任，隐瞒可能耽误评估。

- 了解医院的急诊评估流程，问清楚“接下来会发生什么”。
- 如果患者拒绝，先问医生：现在是否符合非自愿的条件？依据是什么？程序怎么走？
- 保留好病历、告知书、决定书等材料。

家属最容易犯的错，是把“住院”当成惩罚或者抛弃。可以换一种说法：“这段时间我们一起把它处理好，等你稳定了我们再商量下一步。”这不是欺骗，而是把住院放回治疗的位置。

病房流程：从入院到出院

不同医院细节不同，但大致会经历这些环节：

1. 急诊或门诊评估：精神检查、风险评估、躯体检查、必要的化验和影像。
2. 入院手续：身份核验、医保登记、签署知情同意，或者按程序办理非自愿手续。
3. 物品管理：危险物品通常由病房保管，包括刀具、打火机、绳索、玻璃制品、部分电子设备；现金和证件建议家属带回。
4. 入院初期观察：记录睡眠、进食、行为、情绪、服药反应，可能需要一段时间的密切观察。
5. 治疗调整：药物、心理支持、必要时的物理治疗；医生查房，护士做日常评估。
6. 家属探视与沟通：按病房规定时间探视，可以提前准备想问的问题。
7. 出院评估：症状、风险、自理能力、家庭支持、复诊安排。
8. 出院：带药、出院小结、复诊预约、危机联系方式。

病房里可能让人不适的事，提前知道会好一些：

- 不能随便使用手机，不同病房规定不同，联系外界会受限。
- 随身物品被检查、保管。
- 作息统一，活动空间有限。
- 同病房有其他病情不同的患者。
- 在极少数必要情况下，可能实施保护性约束或隔离。这有严格的医学和法律条件，不是惩罚。

家属可以问的问题：

- 诊断是什么？依据是什么？
- 现在主要的风险是什么？
- 治疗方案是什么？需要监测什么？
- 预计住多久？取决于什么指标？
- 探视、通话怎么安排？
- 如果对住院有异议，走什么程序？

不用一次问完。可以写在一张纸上，查房或探视时逐条问，把答案记下来。住院期间信息多、情绪重，很容易听完就忘。

出院计划：出院不是结束

出院是风险最高的时间点之一：环境变了、随访还没接上、药可能还没完全起效、家属以为“好了”。所以出院计划要和住院治疗一起做，而不是出院当天才想。

一份可用的出院计划包括：

- 药物：名称、作用、怎么吃、可能副作用、漏服怎么办、多久续方。
- 复诊：出院后几天内？找谁？怎么挂号？
- 监测：需要查血、查心电图、查体重的时间。
- 预警信号：个人的前三条，出现后找谁。
- 睡眠与作息：起床时间、见光、避免熬夜。
- 危机预案：谁能陪着、去哪个急诊、120、110、12356。
- 工作学习：病假、复工节奏、需要单位配合什么。
- 家庭分工：谁提醒药、谁陪同复诊、谁负责钱和钥匙。
- 物质使用：酒、大麻、兴奋剂的处理。
- 出院带药的数量和续方时间，避免断药。

- ☐ 出院诊断和这次住院的主要原因
- ☐ 每种药的作用和主要副作用
- ☐ 出院后多久复诊、找谁
- ☐ 需要复查的化验和大概时间
- ☐ 出现哪些情况要提前回来
- ☐ 危机时打哪个电话、去哪个急诊
- ☐ 病假条、出院小结、费用清单是否拿到
- ☐ 家里谁负责什么

容易踩的坑

- 把住院当成“关起来”，不告诉患者实情，导致信任破裂。
- 出院当天就恢复全职工作，或者安排一整天应酬。
- 出院后觉得“好了”，自行停药。
- 家属把所有药收走，却不约定什么时候交还。
- 不复诊，或者复诊一次就再也不去。
- 出院计划只写在纸上，家里没人知道放在哪。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下情况，联系病房或门诊医生；情况紧急去急诊，必要时拨打 120。**

- 住院期间或出院后出现自杀念头、自伤行为。
- 出院后几天内失眠加重、话多、烦躁、行为冲动。
- 拒绝吃药、拒绝进食饮水。
- 出现高热、意识改变、严重僵硬、不能坐、眼球上翻、皮疹。
- 出院后无法复诊、断药，或者家里没人看护。

> 如果对住院有异议，先走医院沟通和法律规定的复核渠道，不要用冲突代替程序。情绪支持可以拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，具体住院与法律程序以现行法律、当地规定和面诊医生判断为准。

11.3 精神卫生法与权益

这一页用大白话讲《精神卫生法》里和患者最相关的几件事：自愿原则、非自愿住院的两类情形、知情同意、隐私、约束隔离，以及觉得权益受损时可以走哪些渠道。它只讲原则，不构成法律意见；具体条文、程序和地方规定，请以现行法律和当地政策为准，必要时咨询律师或法律援助机构。适合患者本人，也适合想替家人把关的家属。

自愿原则：住院的第一原则

《精神卫生法》2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行，确立了精神障碍住院治疗的自愿原则。翻成大白话：**要不要住院，首先由患者自己决定。** 医院不能因为家属要求、单位要求，或者“看起来不正常”，就把人收进去。

自愿原则的意义不只是程序。它承认患者有决定自己治疗的能力，也承认“被关起来”这件事本身会带来伤害和恐惧。一个人即使生病，也不自动失去说话的权利。

但自愿原则不是绝对的。法律同时规定，在特定情形下，可以对严重精神障碍患者实施非自愿住院。这是下一节的内容。

需要区分几个概念：

- 自愿住院：本人同意并签署知情同意。
- 非自愿住院：符合法定情形，按法定程序实施。
- 急诊留观：急诊情况下的短期评估与处理，具体时限和程序按法律和地方规定。
- 保护性约束：医疗过程中为防止即时伤害而采取的临时措施，不是惩罚，也不是“关起来”。

非自愿住院：两类情形与程序保障

法律规定的两类情形，通常概括为：

1. 严重精神障碍患者，已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险。
2. 严重精神障碍患者，已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险。

两个要件必须同时具备：

- 医学要件：诊断为严重精神障碍。
- 危险要件：有相应的行为或危险，而不是“可能会”“家属担心”。

程序上通常包括：精神科执业医师的诊断与评估、告知患者和家属、办理住院手续、记录在病历中。对诊断结论有异议的，法律规定了再次诊断、精神障碍司法鉴定等渠道；具体怎么申请、多久内提出、由谁受理，按现行法律和当地规定执行。

几个常见误解：

- “家属签字就能强制住院”——不是。家属的同意不能替代法定条件。
- “只要诊断了双相就能强制住院”——不是。双相障碍不等于“严重精神障碍”的法定情形，也不是有诊断就满足危险要件。
- “住院了就出不来”——不是。是否符合继续住院的条件需要持续评估，患者和家属有申诉和救济渠道。
- “非自愿住院就没有权利”——不是。法律对通信、会见、申诉等权利有规定，具体范围按法律和医院管理执行。

概念	大白话	谁来决定
自愿住院	我自己同意住	本人
非自愿住院（伤害自身）	有自伤行为或危险，需要保护	按法定条件和程序，通常涉及监护人意见
非自愿住院（危害他人）	有伤人行为或危险，需要保护他人	按法定条件和程序，含再次诊断、鉴定
急诊留观	先评估、先保安全	急诊医生，按医疗规范
保护性约束	临时防止即时伤害	医疗团队，按医疗规范

表格只能帮助理解，不能替代法律条文。实际遇到时，直接问医院“依据是哪一条、程序怎么走”，比背概念有用。

知情同意、隐私、约束与隔离

知情同意不是签个字

知情同意是医疗行为合法性的基础。它至少包括四件事：

- 知情：知道诊断、病情、建议的治疗、可能的获益和风险、有没有别的选择。
- 理解：用能听懂的话解释，不是丢一张纸让人签。
- 自愿：没有胁迫、欺骗，没有被家属或单位施压。
- 同意：本人或法定代理人明确表示同意，并签字。

在双相障碍的治疗里，知情同意常见于：

- 开始或更换药物。
- 电休克治疗，需要单独、详细的知情同意。
- 参与研究。
- 涉及隐私的信息披露。

需要特别注意：

- 患者在急性躁狂、严重抑郁、谵妄、意识障碍时，决策能力可能受影响。这时候的同意是否有效，需要医生评估；紧急情况下有特殊的处理规则。
- 即使已经同意，患者也可以随时撤回。撤回后医生要重新评估风险，并告知后果。
- “同意”不等于“永远同意”。治疗方案变了、风险变了，需要重新谈。

- 家属可以参与讨论，但不能替有决策能力的成年患者做决定，除非法律上已经确定了监护或代理关系。

隐私

精神障碍的诊断和治疗信息属于敏感个人信息。医院和有关机构应当保密；未经本人同意，不得向无关的人披露，法律另有规定的除外。

现实里要注意：

- 单位、学校、亲戚不一定需要知道你的诊断。
- 病历复印、保险理赔、残疾评定，都会涉及信息提供，先问清楚“给谁、给多少、用来做什么”。
- 网络分享时注意去标识化：不要同时暴露姓名、单位、就诊医院、时间。
- 住院期间，病房可能限制拍照、录音，具体按医院规定；这不等于你的隐私不受保护。

约束与隔离

这是最容易引发争议的部分。

- 约束，比如把患者固定在床上或椅子上，以及隔离，比如单独安置，不是治疗手段，而是在其他方法无效、为防止即时伤害时的临时保护措施。
- 应当由医生评估、开具医嘱，按规范实施，尽量短时间，持续观察，记录原因和过程。
- 不应作为惩罚、报复、方便管理的手段；不应随意延长；不应在没有必要的情况下使用。
- 约束期间要关注呼吸、循环、皮肤、心理状态，防止窒息、压疮、血栓等并发症。
- 患者和家属有权询问：为什么约束、要多久、什么时候评估、能不能解除。

如果你或家人在住院期间遇到约束或隔离，可以：

- 要求医生解释理由和预计时长。
- 要求记录在病历中。
- 观察是否有持续监护。
- 如果认为使用不当，保留证据，包括时间、地点、在场人员、身体痕迹的照片，通过医院投诉、卫生健康行政部门等渠道反映。

约束本身不是“虐待”的同义词，但滥用约束是。判断的关键是：有没有必要、有没有医嘱、有没有监护、有没有记录、有没有尽快解除。

权益受损时，可以走哪些渠道

先说明：以下是一般性的渠道介绍，不构成法律意见。具体走哪条、怎么走、时效多久，请咨询律师、当地法律援助机构或卫生健康行政部门。

院内渠道：

- 找主治医生、科主任沟通，要求解释诊断、治疗和约束的理由。

- 医院医务科、投诉管理部门、伦理委员会。
- 要求复印、封存病历，按医院规定办理。

行政渠道：

- 当地卫生健康行政部门投诉。
- 医保问题找参保地医保局。
- 对非自愿住院有异议，按法律规定的再次诊断、鉴定程序走。
- 12345 政务服务热线，可以转办。

法律渠道：

- 法律援助中心：符合条件的可以申请免费法律援助。
- 行政复议、行政诉讼：针对行政机关的行为。
- 民事诉讼：涉及人身损害、隐私泄露等。
- 报警：涉及殴打、非法拘禁、虐待等涉嫌违法的行为。

社会支持：

- 残联及其精神残疾人亲友协会。
- 精神卫生防治机构、社区精防医生。
- 患者组织、同伴支持团体。
- 12356 心理援助热线，主要提供情绪支持，不是法律咨询。

遇到的问题	可以先找谁	需要留什么
觉得诊断或住院依据不清	主治医生、科主任、医务科	病历、告知书、决定书
认为约束使用不当	医务科、伦理委员会、卫健委	时间、时长、在场人员、照片
隐私被泄露	医院投诉部门、卫健委	截图、录音、知情人信息
费用或医保争议	医院医保办、参保地医保局	发票、清单、结算单
想申请法律援助	当地法律援助中心	身份证明、病历、经济情况材料

- ☐ 记下时间、地点、在场人员、发生了什么
- ☐ 保留病历、告知书、费用清单、照片等材料
- ☐ 要求医生解释理由，并做记录
- ☐ 先走院内沟通，同时了解院外渠道
- ☐ 咨询法律援助，确认时效和证据要求
- ☐ 找一位信任的人陪同，不要独自应对
- ☐ 照顾好自己的情绪，这件事很耗人

容易踩的坑

- 以为“签了字就放弃所有权利”。签字是知情同意的证明，不是卖身契。
- 以为“非自愿住院等于终身记录，什么都完了”。住院记录有保密要求，也有救济渠道。

- 在网络上曝光他人隐私来“维权”，反而可能侵权。
- 只靠情绪对抗，不留证据。
- 把医生的解释当成“打发”，没有具体问清依据。
- 该走法律程序时只找医院吵，该找医院沟通时直接起诉，成本都很高。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下情况，联系医生或医院；有即时危险时去急诊，必要时拨打 120，涉嫌暴力伤害时拨打 110。**
>
> - 出现自杀念头、自伤行为，或明确的自杀计划。
> - 被约束后出现呼吸困难、意识改变、皮肤破损、持续疼痛。
> - 住院期间被殴打、威胁、侮辱，或目睹其他患者受到不当对待。
> - 拒绝进食饮水超过一天，或出现高热、意识模糊。
> - 出院后断药、无法复诊，情绪或行为明显恶化。
>
> 维权和治病可以同时进行，但安全永远排在第一。情绪支持可以拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成法律意见或个体化医疗建议；具体权利、程序与治疗方案以现行法律、当地政策和面诊医生判断为准。

11.4 监护、残疾、病假与医保

这一页讲双相障碍患者在生活里常遇到的四件“手续”：监护人怎么定、精神残疾怎么评、病假和医疗期怎么处理、医保和社区补助有哪些入口。它只讲一般原则和办理思路，不写具体比例和金额；各地政策差别很大，以现行法律和当地政策为准。适合需要长期治疗、正在为费用或工作发愁的患者和家属。

监护：不是所有患者都需要监护人

先破除一个误解：**确诊双相障碍，不等于自动成为“无民事行为能力人”，也不等于自动需要监护人。** 绝大多数患者在稳定期有完全的民事行为能力，可以自己签字、自己决定治疗、自己管钱。

监护针对的是因疾病等原因不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人。法律上的路径大致是：

- 由利害关系人或者有关组织向法院申请，宣告其为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。
- 然后按法律规定的顺序确定监护人，通常是配偶，父母、子女，其他近亲属，以及其他愿意担任且经有关组织同意的个人或组织。
- 对监护人的确定有争议的，可以由有关组织指定，也可以向法院申请指定。
- 成年人在有完全民事行为能力时，可以事先以书面形式确定自己的监护人，这叫意定监护。在自己丧失或者部分丧失行为能力时，由该监护人履行职责。

监护人的职责，是代理被监护人实施民事法律行为，保护其人身权利、财产权利以及其他合法权益。履行职责应当遵循最有利于被监护人的原则，不得损害被监护人利益；对被监护人有能力独立处理的事务，应当尊重其真实意愿。

实际建议：

- 稳定期就把事情想清楚：如果哪天自己判断力下降，希望谁来做决定？可以写下来，做意定监护公证。
- 家属不要自行“宣布”自己是监护人，也不要在没有法律依据的情况下接管患者的银行卡、手机、证件。
- 监护不等于“什么都替对方决定”。能自己决定的事，仍然应当尊重本人意愿。
- 涉及住院、手术、财产处分等重大事项，按法律和医院要求办理。

情形	谁能做决定	注意
稳定期、有判断力	本人	家属可参与讨论，不替代
判断力受影响、尚未宣告	需要医生评估；重大事项按法律	不要自行接管财产
已宣告无或限制行为能力	监护人代理	最有利于本人原则
事先做了意定监护	意定监护人	以书面协议为准
紧急抢救	按紧急救治规则	医院按规定处理

精神残疾评定：评的是什么

“精神残疾”是一个法律和福利意义上的分类，不是临床诊断的替代品。它评的是精神障碍导致的社会功能损害程度，通常结合病史、精神检查、适应行为和社会功能评定量表综合判断，分为不同等级。

几个要点：

- 不是所有双相患者都符合残疾标准。稳定期功能良好的人通常不符合。
- 评定需要本人或家属申请，到户籍地或居住地的残联咨询，由指定机构评定。
- 常见材料包括身份证、户口本、病历、诊断证明、用药记录、照片等，各地要求不同。
- 评定结论有等级，等级影响能享受的补贴和服务，但不等于“病情轻重”的全部。
- 对结论有异议，通常可以申请复评；具体期限和程序问当地残联。
- 残疾证是自愿办理的。它会带来一些福利，也可能带来隐私和病耻感方面的顾虑，需要本人权衡。

残疾证可能带来的东西，各地不同：

- 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，通常合称“两项补贴”。
- 医保缴费资助、医疗救助。
- 免费或补贴的服药、康复训练、辅助器具。
- 公共交通、景区等优惠。
- 就业支持和按比例就业相关安排。

也要说清楚：残疾评定不是“贴标签”，也不影响一个人是否能有工作、有家庭、有生活。是否办理，是可以自己决定的事。有人办证是为了减轻负担，有人不办是为了不被定义，两种选择都值得尊重。

病假与医疗期：怎么开口、留什么材料

病假是劳动法领域的事，不是医生单方面能决定的。一般流程：

1. 到医院就诊，由医生根据病情出具诊断证明和病假建议，有的医院有专门的病假条。
2. 按单位规定的流程提交：请假单、诊断证明、病假条、病历复印件等。
3. 单位按规章制度和法律规定审批。
4. 需要延长时，提前复诊、提前申请，不要等到假期结束才说。

医疗期：职工患病或者非因工负伤需要停止工作治疗时，法律规定了“医疗期”制度，在此期间单位不能随意解除劳动合同。医疗期的长短与本人实际工作年限、在本单位工作年限有关，具体按国家和当地规定执行。医疗期内的病假工资、社保缴纳等也有相应规定，各地标准不同。

实际建议：

- 保留好每一次就诊记录、病假条、缴费凭证。

- 了解单位的人事制度和集体合同，必要时问工会或当地人社部门。
- 病假条上写清建议休息的时间，避免“建议休息”这种模糊表述。
- 如果单位要求说明病情，可以只提供必要的诊断和休息建议，不必披露全部病历；具体边界可以咨询法律专业人士。
- 复工时可以考虑渐进式：先半日、先轻岗、先不加班，和医生、单位一起定。
- 不要用病假掩盖实际上需要住院的情况。该住院就住院，出院后再安排病假。

事项	找谁	一般需要什么	备注
病假审批	单位人事	诊断证明、病假条	按单位制度
医疗期与解除保护	单位人事、人社部门	病历、工作年限证明	各地细则不同
病假工资	单位、人社部门	病假条、工资记录	按当地规定
复工安排	单位、医生	复工建议	可渐进式
劳动仲裁	劳动人事争议仲裁机构	合同、工资记录、病历	注意时效

医保与社区补助：先弄清自己有哪些

医保的基本结构，各地细节不同：

- 职工基本医疗保险：由单位和个人缴费，通常有个人账户和统筹基金。
- 城乡居民基本医疗保险：按年缴费，财政补助。
- 大病保险：对高额医疗费用进行二次报销。
- 医疗救助：面向困难人群，按当地政策申请。
- 门诊慢特病、门诊特殊病种：很多地区把严重精神障碍纳入门诊保障，具体病种、认定标准、报销范围以参保地医保局公布为准。
- 住院报销：起付线、报销比例、封顶线各地不同，这里不写具体数字。

实际建议：

- 先确认自己参加的是哪种医保、参保地在哪、有没有门诊慢特病资格。
- 问医院医保办：哪些药在目录内、哪些需要自费、门诊和住院怎么报。
- 长期用药可以问医生：有没有疗效相当、价格更低的选择；不要自行换药。
- 保留发票、费用清单、出院小结；异地就医要提前备案。
- 困难时可以问：医疗救助、慈善项目、医院社工、社区精防医生。

社区与其他支持：

- 严重精神障碍患者管理服务：社区精防医生会做随访、评估、服药指导，部分地区有免费服药或补贴。
- 社区康复站、日间康复：技能训练、社交活动、职业康复。
- 残联：残疾评定、两项补贴、康复服务、就业支持。
- 民政：低保、特困供养、临时救助。

- 工会、妇联、共青团：困难帮扶、心理服务。
- 12345：不知道找谁时，可以先打这个问。

事项	找谁	一般需要什么	备注
医保报销	参保地医保局、医院医保办	医保卡、发票、清单	比例各地不同
门诊慢特病	参保地医保局	诊断证明、申请表	病种目录各地不同
精神残疾评定	户籍地残联	病历、诊断证明、申请表	指定机构评定
两项补贴	残联、民政	残疾证、收入证明	按当地政策
社区随访	社区精防医生	确诊信息、联系方式	注意隐私边界
困难救助	民政、社区	收入证明、病历	按当地政策

- ☐ 身份证、户口本或居住证
- ☐ 医保卡或电子医保凭证
- ☐ 最近一次出院小结和诊断证明
- ☐ 近三个月的用药清单
- ☐ 门诊病历和检查报告
- ☐ 病假条或休假证明
- ☐ 费用发票和清单
- ☐ 一张纸写下“我要办什么、找哪个窗口、电话是多少”

容易踩的坑

- 以为确诊就自动有监护人，或者家属自行接管财产。
- 为了办补贴夸大病情，和病历对不上，后面更麻烦。
- 为了省钱自行减药、隔天吃药，最后住院花得更多。
- 病假条一直开“建议休息”，没有具体时间，单位不认。
- 异地就医不备案，报销比例受影响。
- 把残疾证当成“终身判定”，不知道可以复评。
- 只问病友群，不去问当地医保局和残联的正式口径。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

出现以下情况，联系精神科医生；有即时危险时去急诊或拨打 120。

- 出现自杀念头、自伤行为，或明确的计划。
- 停药、漏服或为了省钱减药后，失眠、话多、烦躁、冲动。
- 出现严重药物反应：锂中毒表现、皮疹、高热、肌肉僵硬。
- 因为费用问题打算停药，或已经断药。
- 病假、复工、评残过程中情绪明显恶化。

> 手续可以慢慢办，安全不能等。费用困难可以问医院社工、医保办和社区，不要用停药来解决。情绪支持可以拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成法律、劳动或医保意见；具体办理条件、比例和程序以现行法律、当地政策和经办部门口径为准。

模块 12：家庭、社会与污名

家庭不是病因，但可以是重要的支持系统。这一模块讲照护、沟通、边界、病耻感和社会融入。

12.1 家属照护手册

家人确诊双相障碍后，很多家属会陷入两种极端：要么什么都不敢管，要么想把对方的一天全部安排住。这一页把家属能做的事拆成五块：日常照护、服药提醒、复发观察、危机准备、照护者自我照顾。它适合刚接手照护的人，也适合已经照顾多年、感到疲惫的人。读完后，你可以照着文中的清单，做一份适合自家的照护表。

照护的边界：补位，不接管

照护的目标是帮患者把治疗和生活稳住，而不是替他活。【指南】NICE 与国内指南都把家属的心理教育、沟通支持和照护者需求评估写进治疗框架，但前提是家属和患者站在同一边，而不是变成监督者。

可以把家里的事分三档：

- 患者自己能做的：按医嘱服药、记录睡眠、按时复诊、安排日常。
- 需要家属搭把手的：提醒、陪诊、整理药盒、观察变化、在经济上设一道缓冲。
- 只能由专业人员做的：诊断、开药、调剂量、判断要不要住院。

三档写清楚，能减少很多拉扯。家属越俎代庖去调药，既危险，也会让患者觉得“我不被信任”；反过来，把复诊和服药全推给患者，在他状态差的时候又容易断档。照护的难点不在“管不管”，而在“管到哪一步”。

还有一条常被忽略：家属不是治疗师，也不是警察。你能做的是提供稳定的环境和可靠的信息，不能保证不复发，也不该为每一次复发背锅。把这一点想清楚，后面的具体做法才不容易变形。

日常照护：把稳定拆成每天能做的事

睡眠是第一根柱子。双相障碍的复发常从睡眠变化开始：睡得越来越少却越来越有精神，或者整夜不睡、白天补觉、作息整体后移。【指南】比起反复叮嘱“早点睡”，更有效的是守住一个固定的起床时间。哪怕前一晚没睡好，也尽量在同一时间起床、拉开窗帘、吃早饭。起床时间稳了，入睡时间才有机会稳。

饮食、运动和光照是第二层。规律三餐、白天有户外光照、每周有中等强度活动，听起来像普通的养生建议，对双相障碍却是节律治疗的一部分。【指南】咖啡因和酒精要留意：下午后的浓茶咖啡可能推迟入睡，酒精会让后半夜睡眠变浅，也可能与药物相互作用。

家务和角色是第三层。让患者承担一部分具体、短、能完成的家务，比“你好好休息，什么都别管”更能保住功能感。【临床经验】任务要具体到“把碗洗了”“去楼下取快递”，而不是“你把家里收拾一下”。做完就过去，不检查、不返工、不点评。

钱要提前商量。躁狂期的消费和投资冲动很难靠当场讲道理拦住，比较可行的做法是提前约定：大额支出延迟一两天再决定、共同账户设限额、证件由本人保管但加一道提醒。【临床经验】这不是没收财产，而是给冲动加一个缓冲带。约定要在状态稳定时谈，别等到已经刷爆卡才立规矩。

事情	主要谁做	频率	备注
固定起床、拉开窗帘	患者	每天	家属只提醒，不掀被子
记录睡眠	患者或家属	每天	记上床、起床、夜醒
服药	患者	每天	家属递水、问一句
复诊	家属陪同	按医嘱	提前写好要问的问题
大额支出	全家	单次	延迟一两天再定
危机联系人	家属	常备	存进手机并贴在冰箱上

服药提醒与复发观察

服药提醒最容易变成家庭冲突的引爆点。有效的提醒通常有三个特点：时间固定、方式固定、语气不带评判。把药盒放在牙刷旁边，设一个手机闹钟，问“今天的药吃了吗，要不要我递水”，比“你又没吃药吧”更容易被接受。

几条具体做法：

- 漏服一次，不要自行补双倍，记下来，下次复诊问医生或药师怎么处理。
- 副作用要记：手抖、困倦、体重变化、皮疹、发热、呕吐、腹泻、心慌。服锂盐的人还要留意脱水、发热、呕吐腹泻和低盐饮食，这些都可能让血锂升高。
- 不自行加量、减量、停药，也不要用保健品替代处方药。
- 不把吃药当成奖惩，不说“你不听话就不管你了”。
- 拒药时先找原因：副作用难受、觉得病好了、怕被贴标签、经济压力、吞咽困难。找到原因，才有得谈。

有些药需要特别盯：丙戊酸盐可能伤肝、影响血氨和血小板，育龄女性还有致畸风险；拉莫三嗪的皮疹可能很严重，出现发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮要立即停药急诊；抗精神病药可能引起高热、肌肉僵硬，要想到恶性综合征。具体监测项目由医生安排，家属能做的是把异常记下来、及时报告。

如果患者把药藏起来或吐掉，先确保安全，再联系医生。急性躁狂期不要硬掰嘴、不要几个人按住喂药，这种对抗可能升级成伤害，直接走急诊流程更稳妥。

复发往往不是一夜之间发生的。家属常比患者更早察觉“哪里不对”，但说出口的方式决定了对方是配合还是防御。观察的重点是变化：跟本人平时比，睡眠、语速、花钱、脾气、社交、工作节奏有没有明显偏移。

信号	可以观察到的样子	家属先做什么
睡眠需求减少	睡三四个小时仍精力充沛，半夜收拾屋子	记录，减少刺激，联系医生
话多、思维快	停不下来、跳话题、别人插不上嘴	短句回应，不争辩，避开人多的场合
花钱或投资	突然大额消费、借钱、同时开几个项目	延迟决定，设限额，保管好证件
易怒	一点小事就爆发，指责家人	降低音量，先离开现场，保证安全
抑郁	早醒、吃不下、退缩、说“没意思”	陪着，直接问有没有自杀念头，联系医生
混合	烦躁、绝望、冲动同时出现	自杀和冲动风险高，尽快就医

记录建议只记事实，不写评价：几点上床、几点醒、睡了多久、当天有没有异常消费、有没有说“活着没意思”。一页纸或手机备忘录都行，复诊时给医生看。记录是给治疗用的，不是攒着以后跟患者算账。

危机准备：一张纸、一个电话、一条路线

危机真正发生时，人容易慌。提前准备能省下最宝贵的几十分钟。

- ☐ 主治医生和医院的联系方式、门诊时间
- ☐ 最近的精神科急诊地址、夜间路线
- ☐ 药物清单：药名、剂量、过敏史
- ☐ 既往发作和住院的简要记录
- ☐ 医保卡、身份证、少量现金
- ☐ 两位能立刻到场的亲友
- ☐ 120、110、12356 存进手机，并教会家里老人使用
- ☐ 家中过量药物、刀具、酒精的管理方案
- ☐ 孩子或老人临时由谁照看
- ☐ 紧急时谁陪同、谁签字（以医院要求和现行法律为准）

有几件事不要做：把患者反锁在家里、没收手机、当众数落、用“再闹就把你送精神病院”吓唬。这些做法会让患者把家人当成敌人，下一次真正需要求助时，他可能什么都不说。限制人身自由还可能涉及法律问题，遇到失控场面，优先打 120 或 110，让专业人员到场。

照护者自我照顾与容易踩的坑

长期照护的疲惫是真实的，不是“不够爱”。【研究】照护者出现焦虑、抑郁、失眠的比例并不低，而这些状态会反过来影响沟通质量。把自己照顾好，不是自私，是让照护能持续下去。

可以做的：每周留出固定的休息时段，哪怕只有半天；把照护任务分给其他家人，列清楚谁负责什么；参加家属支持团体，听听别人的做法；自己睡够、按时体检；允许自己说“我做不到”。如果持续两周以上情绪低落、失眠、对什么都提不起劲，建议自己也去看医生。

还有一条很重要：不要把复发全部归咎于自己。“如果我当时盯紧一点就好了”这种想法很常见，但双相障碍的复发由生物、节律、环境、治疗多种因素共同决定，家属的提醒只是其中一环。

容易踩的坑：

- 把轻躁狂期的“效率高、状态好”当成康复，跟着减少复诊。
- 只盯着吃药，不记录睡眠和消费。
- 在躁狂期用争吵解决分歧，越吵越僵。
- 一次性收走所有钱和证件，引发对抗和隐瞒。
- 认为“只要我盯得够紧，就不会复发”，把自己熬垮。
- 只照顾患者，完全放弃自己的工作、朋友和睡眠。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下情况，不要等下次门诊：**
>
> - 连续几天睡眠明显减少，同时话多、活动增多、花钱变冲。
> - 出现幻觉、被害感、坚信自己有特殊能力，或扬言伤害别人。
> - 说出自杀想法、写下计划、分发贵重物品、突然“看开了”。
> - 拒绝进食饮水，或连续多日几乎不睡。
> - 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快。
> - 皮疹迅速扩大，伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮。
> - 同时使用多种药物后出现震颤、腹泻、躁动、高热，警惕血清素综合征。
> - 服锂盐后出现呕吐、腹泻、严重手抖、走路不稳、意识模糊。
> - 抽搐、晕厥、呼吸困难、胸痛。
>
> 上述情况请立即拨打 120，必要时拨打 110，或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线求助。不要独自把患者留在家里观察。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185

- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.2 沟通与边界

家里有人处于躁狂或抑郁时，最伤人的往往不是病本身，而是彼此说话的方式。这一页讲三件事：躁狂时怎么说不激化，边界怎么设才不变成控制，怎样避免“高情感表达”把家变成压力源。它适合每天和患者打交道的家属，也适合想改善关系的患者本人。文中有可以直接照着说的话，也有可以打印出来贴在冰箱上的约定。

躁狂时，争辩通常没有用

躁狂或轻躁狂时，人的判断力、风险感和对他人感受的觉察都会下降。【指南】这不是“故意气人”，而是状态的一部分。此时跟他逐条辩论“这个投资不靠谱”“你没病”，通常只会升级冲突：他越被否定，越要证明自己；家属越说越急，最后两败俱伤。

急性期沟通的目标不是“说服”，而是“降速、保安全、把人带到医生面前”。可以记住四句话：句子短、内容具体、态度稳、给台阶。

- 句子短：一次只说一件事，不超过两句话。
- 内容具体：说看到的行为，不说人格评价。“你这三天只睡了两小时”比“你太不正常了”更容易被听进去。
- 态度稳：音量放低，语速放慢，不追着说。
- 给台阶：给一个不丢面子的选择。“先吃点东西，再去医院看看，行不行？”

还要选时机。人在高速运转时听不进长解释，等他从外面回来、坐下来、吃了点东西，再谈下一步。不要在电梯里、饭桌上、亲戚面前谈病情，也不要在深夜他正兴奋时讲道理。减少刺激本身就是在帮忙：关掉吵人的电视、把客厅灯调暗、一次只来一个人说话。

话术对照：把“指责”换成“我担心”

场景	容易出口的话	可以试着说
连续不睡	“你就是玩手机玩的”	“我注意到你这几天睡得很少，我有点担心，我们一起给医生打个电话。”
大额投资	“你疯了，绝对不行”	“这个决定很大，我们等两天，把账算清楚再定，好吗？”
发脾气、指责	“你怎么这么没良心”	“你现在很烦，我先出去十分钟，等你缓一缓我们再谈。”
拒绝吃药	“不吃药你就完了”	“你不想吃，是副作用难受，还是觉得没必要？我们跟医生说说。”
说“我没病”	“你病得不轻”	“你觉得现在挺好，我听到了。但睡眠和花钱的变化让我担心，我们去做一次复诊，让医生判断。”
抑郁时说“没意思”	“想开点，比你惨的人多了”	“我在这儿。你不用马上好起来，要不要我陪你坐一会儿？”
提到自杀	“你别吓我”	“你这么说我很重视。你现在有具体的

场景	容易出口的话	可以试着说
		想法吗？我们一起联系医生。”

表里的句子不是万能钥匙。对方拒绝时，不要追着重复，可以换成“那我先不说了，你需要的时候叫我”，然后去联系医生、调整环境、找其他家人接力。沟通的目标是把人留在求助的通道里，不是赢下这一场对话。

关于自杀的问法，很多家属怕“问了会提醒他”。目前的证据不支持“直接询问会增加自杀风险”这种担心；相反，直接、平静地问，往往能让对方说出真实想法。【研究】问的时候不要带评判，也不要急着保证“一切都会好”，先听他把话说完。

边界：不纵容，也不把人推开

不争辩是沟通技术，不是放弃原则。急性躁狂期，可以先把分歧挂起，等状态稳定再讨论；但涉及安全的事，比如动手、酒驾、把家里钱转走、带孩子做危险行为，需要当场设限。

设限时尽量做到三点：

1. 说自己的行为，不说对方的品格。“如果你动手，我会离开房间并拨打 110”，这是边界；“你就是个暴力狂”，这是攻击。
2. 提前说、平静说、说到做到。边界只有在稳定执行时才有意义，反复威胁又反复退让，会让对方学会“闹一闹就没事”。
3. 全家口径一致。父母一个唱红脸一个唱白脸，边界会立刻失效。

家属常出于心疼替患者兜底：替他还冲动消费的账、替他向单位撒谎、替他隐瞒停药。短期看是息事宁人，长期看会让后果全部由家人承担，患者反而缺少面对问题的机会。

可以帮的：陪诊、提醒、做饭、接送、在医生面前补充观察。不宜帮的：替躁狂期的大额借贷签字、帮忙圆“没生病”的谎、把停药说成“医生同意”、用“他病了”解释所有伤人的行为。

不纵容也不等于冷处理。比较稳妥的说法是：“这件事我不会替你处理，但我可以陪你去面对。”既守住边界，也不把人推开。边界不是惩罚，它的作用是让双方都知道什么可以商量、什么不能。

高情感表达：家庭气氛可以被调整

家庭研究里有一个概念叫“高情感表达”，主要指三样东西：频繁的批评、明显的敌意、过度卷入和保护。【研究】多项研究提示，高情感表达与复发风险升高有关，但这不是说“家属说错话才害他生病”。更准确的理解是：家庭气氛是复发的一个环境因素，可以被调整，而不该被用来追责。

降低高情感表达，不是让家属憋着。可以试试：

- 减少“你总是”“你从来”这类概括性批评，改成具体事件加具体请求。

- 把“你怎么又这样”换成“这次我们怎么处理”。
- 给彼此留空间，不追问每一个细节，不翻旧账。
- 家属自己找出口：朋友、支持团体、心理咨询，而不是把全部情绪倒回家里。
- 开家庭会议，一次只解决一个问题，有结论就写下来。

下面这些约定，可以在状态稳定时一家人坐下来逐条谈，谈成几条算几条：

- ☐ 急性期不讨论宏大计划，只谈今天和明天的具体安排
- ☐ 一次只处理一个问题，不翻旧账
- ☐ 不使用侮辱性称呼，不拿病当武器
- ☐ 不动手、不砸东西、不限制人身自由
- ☐ 大额支出延迟决定，全家提前约定
- ☐ 每周固定一次家庭会议，控制在半小时内
- ☐ 家属轮流休息，不把照护压给一个人
- ☐ 有分歧时先暂停，等情绪降下来再谈
- ☐ 危机联系人和就医路线贴在冰箱上
- ☐ 复诊后一起对一下医生说了什么

抑郁期与自杀话题：少讲道理，多问一句

抑郁期的患者常被“鼓励”压得更累。“你要坚强”“你要走出来”这类话，听在耳朵里像“你连这个都做不到”。【临床经验】更有效的是具体、低负担的陪伴：一起吃顿饭、下楼走十分钟、把窗帘拉开、帮忙预约复诊。不要催他“快点好”，也不要拿别人比较。

也不要因为怕刺激而回避自杀话题。可以直接问：“最近有没有觉得活着没意思，有没有想过伤害自己？”如果对方说有，接着问有没有计划、有没有手段，并尽快联系医生；情况紧急时拨打 120 或 110，或拨打 12356。把家里的过量药物、刀具、绳索收好，是具体的安全措施，不是不信任。

容易踩的坑：

- 在躁狂高峰期讲道理，越讲越僵。
- 边界说得很狠，执行时每次都退。
- 用“他有病”合理化所有伤害，包括暴力和财务风险。
- 把家庭气氛当成唯一病因，全家陷入自责。
- 只盯患者，没人管家属的情绪。
- 把“不争辩”理解成“什么都答应”。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **出现以下情况，沟通先放一边，优先处理安全：**

- 躁狂加重：连续多日几乎不睡、话多停不下、出现幻觉或被害感。
- 有伤人威胁、已经动手、持械、堵门不让走。
- 明确说想死、有计划，或已经开始准备。
- 拒绝进食饮水、意识模糊、高热、肌肉僵硬。
- 酒后驾车、带着孩子做危险行为、失联。

> 立即拨打 120，必要时拨打 110；也可拨打 12356 心理援助热线。不要在这类情况下继续讲道理或刺激对方。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.3 病耻感与社交

很多患者不怕吃药，怕的是被人知道自己在吃药。病耻感会让人隐瞒、退缩、拖延就医，也会让家属在亲戚面前抬不起头。这一页讲病耻感从哪里来、它在心里怎么运转、要不要告诉别人、怎样一点点把社交捡回来。它不劝你“勇敢公开”，也不把保密说成懦弱。读完你可以自己决定，对谁、说到什么程度。

病耻感不是“想太多”

病耻感是指因为患有某种疾病而被贴上负面标签，进而被歧视、被回避，或者自己瞧不起自己。【研究】它不是一个心理学名词的装饰，而是会实实在在影响就医、就业、亲密关系和自我评价。

双相障碍身上叠着好几层标签。一层是“危险”：新闻里的暴力事件常被归因于“精神病”，让人以为患者都可能伤人。一层是“不稳定”：情绪化、靠不住、不能托付工作。还有一层是“天才病”的浪漫化想象：把躁狂期的效率当成才华，忽略了后面的崩溃。这些说法彼此矛盾，却共同构成了一种模糊的恐惧。

病耻感至少有四种形态：

- 公众污名：社会上多数人对这个病的负面看法。
- 自我污名：把这些看法内化成“我就是不行”。
- 连带污名：家属因为亲人的病而被议论、被回避。
- 结构性污名：制度、流程、表格、体检和保险规则带来的排斥。

四种形态互相喂养。别人怎么看你，会影响你怎么看自己；你怎么看自己，又会影响你敢不敢出现在别人面前。

病耻感从哪里来，又怎么留在心里

病耻感不是凭空长出来的。它来自影视剧里夸张的角色，来自新闻里被放大处理的极端个案，也来自生活里真实的经历：请假被追问、相亲被拒绝、单位体检后被调岗、邻居在背后议论。一次具体的受伤，往往比一百句道理更有分量。

它留在心里，通常走这样一条路：先听到“双相的人很危险/很作”，于是预期“说出来会被看不起”；为了避免被拒绝，开始少说、少出门、少联系朋友；社交越少，越没有机会遇到接纳自己的人；最后得出结论“果然不能说”。这是一个自我应验的循环，不是性格缺陷。

自我污名还有几种常见表现：把一次工作失误解释成“我脑子坏了”；不敢争取升职，觉得“我不配”；停药，想证明“我没有病”；或者反过来，用“我是病人”回避所有责任。两种极端都在把一个人压缩成一个标签。

打破循环，不一定从“向所有人公开”开始。更现实的做法是：先把“我有病”和“我是失败者”分开，再把病的影响缩小到具体范围——我需要规律睡眠、需要定期复诊、压力大时容易波动，而不是“我什么都做不了”。然后找一个相对安全的人，试着说一点点，看看会发生什么。【研究】心理教育、认知行为治疗和同伴支持，都被用于处理自我污名；它们不承诺消除羞耻，但能让人不再被羞耻支配。

要不要告诉别人：分层披露

披露是选择，不是诚实测试。没有人有义务向所有人公开自己的诊断，也没有人有资格用“你不坦诚”来逼你交代。法律原则上保护患者的隐私和个人信息，但现实中的泄露风险确实存在，做决定时要把两者都算进去；具体以现行法律和当地政策为准。

可以把披露想成几个同心圆，每个圈说不同的话：

对象	可以说到什么程度	可能的好处	需要注意
自己	全部	理解自己、接住情绪	不必急着接受，允许反复
伴侣、父母、子女	诊断、用药、预警信号、危机联系人	有人接力照护	说清“我需要什么”，别只丢一个病名
一两个密友	需要知道的照护信息	应急支持、减少孤立	先试探对方对精神疾病的态度
同事、同学	功能层面的需要，如复诊、作息	争取一点便利	不必说诊断，除非你愿意
单位、学校	按政策提供必要证明	病假、合理便利	书面提交，限定范围，留底
公开平台	谨慎	可能帮到同路人	一旦发布很难收回，截图会流转

决定说之前，先问自己四个问题：

- ☐ 我为什么现在要说？是为了获得具体帮助，还是一时冲动？
- ☐ 对方需要知道到什么程度，才帮得上忙？
- ☐ 如果这话传出去，最坏的情况我能不能承受？
- ☐ 有没有更小、更安全的说法？

一些可以直接用的话：

- “我有个健康问题，需要定期复诊，想跟你确认一下请假安排。”
- “我最近在调整药物，可能会有一两次下午不在，工作我会提前安排好。”
- “谢谢你关心，具体病情是我的隐私，我不太想展开。”
- “我在规律治疗，状态稳定。你如果担心，我们可以聊具体的工作安排。”

如果对方反应不好，不代表你做错了。你有权收回话题，也有权重新评估这段关系。披露不是一次性的考试，说错了可以不再说。

重建社交：从低风险场景开始

社交退缩常常不是“不想”，而是“怕”。怕被问、怕被看出来、怕冷场、怕自己状态不好扫兴。恢复社交要像恢复体力一样，从轻的负荷开始，而不是第一天就回到人群中央。

- ☐ 每周和一位信任的人联系一次，哪怕只是发条消息
- ☐ 恢复一个固定的小组：运动、读书、手工、合唱都可以
- ☐ 约一位老朋友吃顿短的饭，提前说好可以早走
- ☐ 参加一次社区活动，待够半小时就算完成
- ☐ 尝试半天的志愿活动，做具体的事，不必负责全局
- ☐ 逐步恢复工作或学习中的社交，先从一对一聊起

选择场景时记住四个原则：可预测、时间短、有退出方案、不靠酒精。通宵聚会、陌生人的大型饭局、需要大量寒暄的场合，可以暂时跳过。固定时间的活动还有额外好处：它帮你把作息和社交节律稳住，而节律稳定本身就是双相障碍复发预防的一部分。【指南】

不必把社交当成“证明自己正常”的任务。有时候最好的社交，是和一个知道你情况的人安静地走一段路。质量比数量重要，可持续比热闹重要。

遇到歧视、连带病耻感与常见坑

被问到时，可以先判断对方是好奇、担心，还是恶意。好奇和担心可以简单回应，恶意不必解释。

- “你得的是精神病吧？”——“我在规律治疗，状态稳定。具体病情是我的隐私。”
- “你会不会突然发疯？”——“双相障碍不等于暴力。我的治疗里就包括识别和预防复发。你担心的话，我们可以谈具体的工作安排。”
- “你们家是不是遗传？”——“这是我家的事，我不太想聊。”

如果遭遇就业、就学中的歧视，原则上可以保留书面记录、要求书面理由、向工会或主管部门反映，必要时咨询法律援助；具体能怎么做，以现行法律和当地政策为准，本页不提供法律意见。先稳住睡眠和情绪，再处理纠纷，别在崩溃边缘去硬碰。

家属也会承受连带病耻感。亲戚说“都是你们惯的”，邻居打听，单位旁敲侧击，都会让人想躲。可以做的：家里统一一个简单口径，只告诉必要的人；不替患者向所有人解释；找家属支持团体，把委屈说出来；不把孩子或患者当成“家里的秘密”藏起来，也不把隐私变成羞耻。

容易踩的坑：

- 为了证明自己“正常”而自行停药。
- 刚稳定就向所有人公开，包括社交媒体。
- 把每一次社交失败都归因于“我有病”。
- 强迫家人保密，或反过来强迫家人公开。

- 用“我只是病了”回避所有责任和后果。
- 把病耻感当成“意志薄弱”，不肯求助。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **病耻感本身不是急症，但它带来的后果可能是：**

- 因为羞耻而停药、躲起来、拒绝复诊，状态明显下滑。
- 被歧视、被辞退、被分手后，持续失眠、绝望，说自己“撑不下去”。
- 出现自杀念头、自伤行为，或开始安排后事。
- 完全不敢出门、不敢见人，连基本生活都维持不了。

> 出现这些情况，请尽快联系主治医生；有立即危险时拨打 120，必要时拨打 110，也可拨打 12356 心理援助热线。不要一个人扛着。

参考来源

- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder
- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Bipolar Disorder. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.4 工作、学习与社区融入

稳定之后，很多人最想知道的不是“还要吃多久药”，而是“我还能不能上班、能不能回去上学”。这一页按阶段讲复工、复学、职业支持和社区融入，也给家属一份可以照着准备的清单。它不承诺“回到病前”，而是帮你找到一个能长期维持的节奏。涉及法律权益的部分只讲原则，具体以现行法律和当地政策为准。

先看阶段：不同时期目标不同

复工复学最常见的失误，是把“症状轻了”当成“可以满负荷了”。双相障碍的功能恢复通常是波浪式的：先能起床，再能出门，再能处理几小时的事，最后才是稳定的工作或学业。每个阶段的目标不一样，节奏也不一样。

阶段	主要目标	工作或学习安排	提醒
急性期	控制症状、保证安全	请假或休学，暂不安排任务	不急着证明自己，治疗优先
巩固期	稳住情绪、恢复节律	半日、轻任务、旁听、线上课	避免夜班、出差、高压项目
维持期	逐步恢复功能	增加工时或课程，试探性承担	每次只加一档，观察睡眠
长期	找到可持续的节奏	调整岗位、专业或工作方式	接受波动，允许自己慢一点

判断能不能往前一步，看三个指标：睡眠是否稳定、注意力能否持续、情绪波动是否在可承受范围。任何一项明显变差，就先退回上一档，而不是硬撑。退回一档不是失败，是避免大退步。

复工：分阶段，不一步到位

返岗前，先和医生评估一次：现在的睡眠、注意力、药物带来的困倦、抗压能力，适合半日还是全日，适合轻任务还是原岗位。这个评估最好在复诊时做，不要自己拍脑袋，也不要因为“不好意思再请假”而提前返岗。

和单位沟通时，只谈功能层面的需要，不必全盘披露诊断。可以找直属上级或人事，说明“我需要先按半日恢复一段时间”“我每周有一个下午需要复诊”“暂时不适合连续夜班”。病假、调岗、工时安排按单位制度和法律规定办理，具体以当地政策为准。

一个相对稳妥的复工路径：

1. 先半天或隔天上班，做熟悉、可控、不需要大量临场决策的事。
2. 稳定两到四周后，再增加到接近全职，避免同时叠加新项目、出差和夜班。
3. 把复诊时间提前写进日程，不把复诊当成旷工。
4. 每天记一句睡眠和情绪，出现连续失眠、话多、花钱变冲，及时减负荷并联系医生。
5. 和一位可信的同事保持简单沟通，需要时能帮你递个话。

不要一上来就接“证明自己”的项目。躁狂期的自信和抑郁期的自责都会影响判断，前者容易过度承诺，后者容易全盘否定自己。重大职业决定，比如辞职、换城市、创业，建议等状态稳定一段时间再定。

复学：和学校谈什么

休学、复学、缓考、转专业的具体政策，以学校和教育部门的规定为准，不同学校差异很大。通常需要诊断证明和医生关于休息、复学时间的建议，办理有时限，提前问清楚，别拖到开学前一周。

和学校谈的时候，重点不是“我得了什么病”，而是“我需要什么支持”：

- 合理便利：调整考试时间或考场、减少同时修读的课程、允许请假复诊、调整宿舍到相对安静的位置、使用学校心理咨询资源。
- 沟通范围：只告诉辅导员、班主任或学院负责老师中必要的人，并说明希望保密的范围。
- 学业节奏：先补核心课，设定一个“最低完成线”，比如这学期只求通过两门，而不是一次修满。
- 同伴关系：不必公开诊断。可以准备一句通用说法，比如“之前身体不太好，休息了一段时间，现在慢慢补回来”。

家长可以协助办理手续、陪同沟通，但尽量让本人参与决定。复学是患者重新拿回生活主导权的过程，全部代劳会让他更难适应。

职业支持、合理便利与权益原则

职业康复不是“赶紧找份工作”，而是评估能力、匹配岗位、训练技能、提供工作试用和就业辅导，目标是可持续的就业。【研究】支持性就业在严重精神障碍人群中有一批研究支持：先安置、再训练，配合持续支持，比“培训好了再上岗”更有效。国内各地残联、人社部门和社区康复机构提供的服务不同，可以逐家问。

合理便利是在不改变工作核心要求的前提下，移除不必要的障碍。常见的形式包括：弹性上下班、减少夜班、安静一些的工位、任务分阶段交付、书面而不是口头交代、允许请假复诊、短期降低工作量。它不是降低标准，也不是特殊照顾，而是让能干活的人干得下去。

权益方面只讲原则：精神障碍患者的人格尊严、隐私和平等就业等权益受法律保护；用人单位不应以患病为由随意辞退或歧视；具体争议的处理，以现行法律和当地政策为准，必要时咨询工会、残联或法律援助，本页不提供法律意见。需要向单位提交材料时，先问清楚用途和流转范围，能只写功能建议就不写详细诊断。

自由职业和创业看起来时间自由，实际上很容易把作息打乱。如果没有外部结构，建议自己设固定起床、固定工作时段和每周复盘，必要时请家人或同伴帮忙盯节律。

社区融入与被劝退时怎么办

社区融入不只是“多参加活动”，而是重新拥有固定的去处、角色和可预测的社交。可以使用的资源包括社区康复站、日间康复、同伴支持小组、志愿服务、兴趣小组、图书馆、运动队和社区医生。刚开始不必追求热闹，先做到“每周有一个固定去处、待上一小时”。

- ☐ 和医生确认目前适合的工作或学习负荷
- ☐ 查清单位或学校的请假、复学、调岗政策
- ☐ 准备一份只写功能需要的说明，而不是完整病历
- ☐ 先排半日或轻任务，留出复诊时间
- ☐ 设定一个最低完成线，不接“证明自己”的任务
- ☐ 找到一位可求助的同事、同学或老师
- ☐ 把睡眠和情绪记录带到复诊
- ☐ 出现连续失眠、话多、冲动时，先减负荷再就医

要避免两个极端：一是只待在病友圈里，生活半径越来越小；二是完全切断与同类的联系，觉得自己“不能和病人混在一起”。比较健康的状态是，既有理解你处境的人，也有因为兴趣、工作、邻里而认识的人。

如果被劝退、被调岗或被同学孤立，先保留证据：书面通知、聊天记录、时间地点和在场的人。要求对方给出书面理由，不签看不懂的文件，不冲动辞职或退学。可以咨询工会、残联、劳动监察或法律援助，具体以现行法律和当地政策为准。处理纠纷之前，先保证睡眠和情绪，必要时请医生出具功能说明；状态很差时，先治病，再维权，顺序别反。

家属能做的，是先听、少替对方做决定，在办理手续和陪同沟通上搭把手。不要冲到单位替患者吵架，也不要劝“忍一忍就过去了”。被歧视带来的羞耻和愤怒是真实的，先接住情绪，再谈下一步。

容易踩的坑：

- 一稳定就恢复全职满负荷，几周后崩掉。
- 为了保住工作，隐瞒到连复诊都不敢去。
- 把“回归社会”理解成必须和生病前一模一样。
- 家人替患者去谈判、去辞职、去办复学。
- 把一次失败当成“我不行”，从此不再尝试。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

复工复学期间，出现以下情况要停下来处理：

- 连续几天睡眠明显减少，话多、活动增多、花钱变冲。
- 出现自杀念头、自伤行为，或说“撑不下去”。

> - 严重焦虑、惊恐，连续多日无法出门或上班。
> - 药物导致明显嗜睡、手抖、头晕，影响驾驶、操作机械或高空作业。
> - 被歧视、被辞退后严重失眠、冲动，或出现报复念头。
>
> 先联系主治医生调整方案；有立即危险时拨打 120，必要时拨打 110，也可拨打 12356 心理援助热线。不要靠自行停药来“撑过这段时间”。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 13：误区、问答与工具

这一模块是可以直接打印/照抄的工具页，也集中拆掉最常见的误解。

13.1 心境日记与复发预警表

心境日记不是给医生交的作业，也不是用来证明自己“够不够努力”。它的用处很具体：把“我最近不太好”这种模糊的感觉，换成“我从周三开始每天只睡四小时，话变多，花了两笔计划外的钱”这样能被医生用上的信息。这一页给你一份可以照抄的每日记录表、一张可以填自己信号的复发预警表，以及把它们带进诊室的用法。每天花两分钟，比发作后回忆两周可靠得多。

一、为什么值得记

双相障碍的复发往往不是一夜之间发生的。在明显发作之前，常有一段“前驱期”：睡眠先变、脾气先变、花钱先变，本人觉得“还行”，旁人已经看出不对。问题在于，人对自己的变化最不敏感，尤其是轻躁狂——那种状态主观上很舒服，很难被自己识别。【指南】

日记解决的正是这个盲区。它有三个作用：

- **把主观感觉变成可比较的数字。** “今天情绪 7 分”比“今天还行”更能看出趋势。
- **让家属的观察有落点。** 家人说“你最近不对”，可以翻到具体哪几天睡少了、话多了。
- **让复诊更有效率。** 医生最缺的是时间，一份两三行的摘要，胜过十分钟的回忆。

要说明的是，日记不能替代就诊，也不能用来自己诊断、自己调药。它只是把信息攒起来，交给专业判断。【临床经验】

二、每天记什么

记太多会坚持不下去，记太少又看不出趋势。下面这几项是性价比最高的。

项目	怎么记	为什么值得记
入睡与起床时间	写具体钟点，不写“早/晚”	睡眠是躁狂最早、最可靠的信号之一
实际睡眠时长	估算总小时数	区分“睡得少但不困”和“失眠后很累”
情绪方向	低落 / 平稳 / 偏高 / 又高又低	混合特征常表现为“又高又低”
情绪强度	0 到 10 分，自己定标准	单看方向会漏掉“程度在加重”
精力与活动量	0 到 10 分，或今天做了几件事	活动量骤增常早于情绪被察觉
冲动念头	有无，具体是哪一类	花钱、辞职、飙车、争吵是最需要预警的
服药	早 / 中 / 晚各打勾，漏了哪次写清楚	漏服是复发常见的起点
副作用	手抖、恶心、皮疹、腹泻、心慌等	有些副作用需要尽快处理，不能等下次

项目	怎么记	为什么值得记
		复诊
月经周期	第几天（如适用）	激素波动与情绪、快速循环可能相关

如果只能记三项，就记**睡眠、情绪方向、服药**。这三项已经能覆盖大部分预警信息。【临床经验】

三、一张可以照抄的心境日记

下面这份表可以每天抄一遍，也可以打印一叠。用手机备忘录照着写同样可以，不必追求格式。

```
日期：____年__月__日　星期__
昨晚入睡：____　今早起床：____　实际睡眠：__小时
夜里醒了几次：__　睡眠质量（1-5）：__
今天最明显的情绪（圈一个）：低落／平稳／偏高／又高又低
情绪强度（0-10）：__　精力（0-10）：__　焦虑（0-10）：__
今天完成的事（0-10）：__
有没有冲动念头：无／有（花钱／辞职／吵架／开车／其他：_____）
服药：早 □　中 □　晚 □　漏了：_____
副作用：无／有（手抖／恶心／皮疹／腹泻／心慌／其他：_____）
月经周期（如适用）：第__天
今天最想记住的一件事：_____
```

简化版（忙的时候用一行）：

```
10/21 睡 4h 偏高 7 精力 8 漏晚药 无皮疹
```

这一行已经包含了日期、睡眠、情绪方向与强度、精力、服药和副作用。坚持记一行，比三天打鱼两天晒网地写长文有用。

本周就能开始的五件事

- ☐ 把模板抄在纸上，贴在床头或牙刷旁
- ☐ 设一个固定提醒，时间选在晚上刷牙后
- ☐ 先只记睡眠、情绪、服药三项，坚持七天
- ☐ 让一位家人知道你在记，必要时可以帮你补
- ☐ 七天后回看一遍，找出“最不正常的那一天”

四、复发预警表：写你自己的信号

通用的“睡眠减少、话多、花钱”清单用处有限，因为每个人的前驱信号不一样。有人先失眠，有人先暴躁，有人先疯狂整理房间，有人先变得特别虔诚或特别爱社交。预警表要写“我自己的样子”。【临床经验】

信号类别	我自己的具体样子	家人能做什么	出现几天该联系医生
睡眠	例如：连续两晚只睡四小时还不困	不争辩，记录钟点，减少晚上刺激	两到三晚
话量与语速	例如：打电话停不下来，同时聊五个话题	缩短对话，不激化，记录下来	两天
花钱与投资	例如：突然下单大件、想借钱投资	暂管大额支付方式，不当场争吵	当天

信号类别	我自己的具体样子	家人能做什么	出现几天该联系医生
易怒	例如：为小事摔东西、骂人	降低音量，离开现场，避免正面冲突	当天
社交与活动	例如：凌晨给很多人发消息、突然要见很多人	帮忙减少安排，保证睡眠时间	两到三天
抑郁前兆	例如：开始不回消息、说“我是负担”	主动陪伴，直接问有没有轻生念头	当天
混合信号	例如：一边哭一边说脑子停不下来	不独处，收好危险物品，尽快就医	立即
躯体与药物	例如：手抖加重、皮疹、呕吐	拍照记录，联系医生，必要时急诊	当天

填写建议：不要一次写满八行。先挑三条你或家人最能识别的，写具体到“能看见的行为”，不要写“情绪不好”这种没法观察的描述。写好后复印两份，一份给家人，一份放在病历本里。

两个细节值得注意。第一，预警表要写“出现几天该行动”，否则家人容易一直等“再看看”。第二，行动要具体到人：谁打电话、谁陪着去医院、谁保管银行卡，事先说好，发作时就不用现商量。【临床经验】

五、复诊时怎么用，以及记不下去怎么办

三分钟讲完这段时间

医生时间有限，可以按这个顺序说：

1. **睡眠**：“这两周平均睡五小时，最近三天只睡四小时，白天不困。”
2. **情绪与活动**：“情绪偏高，7 分左右，话比平时多，同时开了三个项目。”
3. **服药与副作用**：“晚间的药漏了两次，手抖比以前明显。”
4. **最担心的一件事**：“我怕又像上次那样花钱失控。”

这四句比“我最近还行吧”有用得多。如果记了日记，直接把本子递过去，指着异常的那几天说。

记不下去是常态

很多人记了两周就停了，然后觉得“我又失败了”。其实记录中断本身就是信息：可能那段时间状态差、可能模板太复杂、也可能你并不需要每天记。可以这样调整：

- 把记录改成“只在异常日记录”，平时不写。
- 用手机语音，一句话说完，不用打字。
- 让家人代记睡眠和服药，你只记情绪。
- 设一个每周一次的回看，而不是每天逼自己。

隐私与边界

日记里会有很多私人的东西：冲动念头、花销、关系冲突。它默认只给医生看。给家人看之前，先说清楚范围；电子记录建议加锁，不要把内容发到公开群组。病历和诊断属于敏感信息，分享前想清楚后果。【临床经验】

容易踩的坑

“这周断了两天，干脆不记了。” 记录的价值在趋势，不在满分。断了就从今天接上，在那一行写“断了两天”，本身就是有用的信息。

“记得很细，但从来不带给医生看。” 记录如果只留在本子里，作用会少一大半。复诊时至少读出异常的那几天。

“家人为了‘关心’翻我的日记。” 这需要提前谈边界：可以约定“只看预警信号，不看内容”，或者由你每周口述一次摘要。信任比监控更能帮上忙。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 混合状态下同时绝望和“停不下来”，冲动明显
- 躁狂状态下行为失控、冲动伤人、危险驾驶、离家出走
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变，或皮疹伴发热、口腔溃疡、起疱脱皮

建议一到三天内联系医生：

- 日记显示连续三晚睡眠明显减少，白天不困
- 情绪连续多天偏高或易怒，家人说“像换了个人”
- 抑郁加重两周以上，或开始回避所有人
- 漏服药超过两三天，或出现新的、让人难受的副作用

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.2 常用量表：YMRS、HAMD、MDQ、CGI-BP

在病历或研究论文里，你可能会看到 YMRS、HAMD、MDQ、CGI-BP 这几个缩写，后面跟着一个分数。它们看起来权威，容易被当成“化验单”一样的东西——分数高就是病重，分数低就是好了。这一页讲清楚这四个工具各自测什么、谁来评、能用来干什么、不能用来干什么。最重要的一句先放在这里：**任何量表都不能代替医生面诊，也不能用来给自己确诊。**

一、量表能做什么，不能做什么

量表是“把症状变成可比较的分数”的工具。它的价值在于标准化：同一个患者在不同时间测，能看出变化趋势；不同患者之间，能有一个粗略的共同语言；研究里，能判断治疗有没有效果。【指南】

它的局限同样明显：

- **量表不看病程。** 双相的诊断关键是有没有过躁狂或轻躁狂发作、持续多久、功能影响多大，这些靠的是访谈和回顾，不是当天填一张表。
- **量表分不清原因。** 甲状腺功能亢进、药物副作用、物质使用都能让分数升高。
- **量表受填写者影响。** 同一个人，状态好时和焦虑时填出来的结果可能差很多；不同医生的评分宽严也不同。
- **分数不能跨版本比较。** 同一个量表常有不同版本、不同语言翻译，分数不能直接换算。

所以量表在临床里的位置是“辅助”：辅助评估严重度、辅助跟踪变化、辅助沟通。它不承担诊断职能。【指南】

二、四张量表的分工

量表	评什么	谁来评	主要用途
YMRS	躁狂症状的严重程度	医生或受过训练的评估者	判断躁狂有多重、治疗后有没有下降
HAMD	抑郁症状的严重程度	医生或受过训练的评估者	跟踪抑郁严重度与治疗反应
MDQ	有没有过轻躁狂/躁狂的表现	本人自填	筛查，提示“需要进一步问诊”
CGI-BP	整体病情严重度与变化	医生	快速记录“现在多严重、比上次好还是差”

可以看出分工：YMRS 和 HAMD 是“分方向测深度”，MDQ 是“撒网找线索”，CGI-BP 是“整体打个分”。它们经常一起用，互相补位。

三、他评量表：YMRS 与 HAMD

YMRS：测躁狂的那把尺

YMRS（Young 躁狂评定量表，Young 等，1978）由医生在访谈后评分，评估的是**当下或最近几天**的躁狂严重程度。条目覆盖情绪高涨、活动与精力增加、性兴趣、睡眠、易激惹、言语的速度与数量、思维奔逸、思维内容（比如夸大）、破坏性行为、外貌打扮、病识感等方面。有的条目按 0 到 4 分评，有的按 0 到 8 分评，权重不同，所以总分不是把每项简单相加就能直观比较的。【指南】

它的长处是聚焦、灵敏，适合在急性期反复测，看治疗有没有起效。短处是：它测的是“现在有多躁”，不测“以前有没有躁过”；对混合状态的捕捉不够细；对轻躁狂的区分能力有限，容易把“话多、精力好”评得偏高。因此它不能单独用来诊断双相。【指南】

HAMD：测抑郁的那把尺

HAMD（汉密尔顿抑郁量表，Hamilton，1960）同样由医生评分，评估抑郁的严重程度。它在临床和研究里用得很久，常见的有 17 项、21 项、24 项等不同版本，版本不同、条目不同，分数不能直接比较。条目覆盖情绪低落、罪恶感、自杀意念、入睡困难、睡眠不深、早醒、工作和兴趣、迟缓、激越、焦虑、躯体症状、疑病、体重减轻、病识感等。【指南】

它的短处值得特别说明：HAMD 里有不少**躯体症状条目**（食欲、体重、乏力、疼痛等），这些在躯体疾病、药物副作用、甲状腺问题的人身上也会得分，可能把“抑郁”评得偏重；它对非典型抑郁（睡眠增多、食欲增加、四肢沉重）覆盖不足，而这类表现恰恰在双相抑郁里不少见。所以 HAMD 分数高，不等于就是抑郁发作，更不等于就是双相抑郁。【研究】

量表评的是“这几天”

无论 YMRS 还是 HAMD，评的都是近期的状态。一次分数正常，不能说明没有病；一次分数很高，也不能直接定诊断。真正有价值的是同一把尺子、隔一段时间、反复测出来的**趋势**。

四、MDQ 与 CGI-BP：一个自评筛查，一个整体判断

MDQ：用来“找线索”，不是用来“下结论”

MDQ（心境障碍问卷，Hirschfeld 等，2000）是一份自填问卷，问的是**这辈子有没有过**一段时间的情绪高涨或易激惹，以及那段时间是否同时出现精力增加、话多、思维快、睡得少、易分心、活动增多、过度消费、判断力下降等表现；还会问这些表现是否同时出现、是否造成中度以上的困扰或功能问题。【指南】

它的定位非常明确：**筛查工具**。在人群里撒网，把“可能有过轻躁狂但没被识别”的人捞出来，提醒医生进一步问诊。它的敏感度不错，但特异度有限——也就是说，它会把一些不是双相的人（比如单

相抑郁、边缘型人格、物质使用者、甲状腺问题）也标成“阳性”。在普通人群里自填，假阳性会更明显。所以 MDQ 阳性只说明“值得找医生认真问一问”，不说明“你有双相”。【研究】

CGI-BP：医生的一句总评

CGI-BP（双相障碍临床总体印象量表，Spearing 等，1997）是在经典 CGI 基础上为双相修改的版本。它让医生分别对**躁狂症状、抑郁症状和整体病情**给出严重度评分，并给出“与上一阶段相比”的变化评分。它不逐条问症状，而是医生综合所有信息后的整体判断。【指南】

它的优点是快、直观，适合在繁忙的门诊里记录“这次比上次好还是差”。缺点是粗：它依赖医生的主观印象，不能细分到具体症状，也不适合作为疗效的主要指标。它更像病历里的一句摘要，而不是一把精密尺子。

五、分数怎么看，以及最常见的误用

看量表分数时，可以记住四句话。

第一，看趋势，不看单点。 同一个量表、同一个评估者、隔两到四周测一次，变化才有意义。今天 25 分、上周 18 分，比“25 分算不算重”更有信息。

第二，看方向，不看总分。 YMRS 升高提示偏躁，HAMD 升高提示偏抑郁，两个同时不低，要想到混合特征，这种组合的自杀与冲动风险更高。【指南】

第三，分数正常不等于没病。 间期、轻躁狂期、混合期的分数都可能不高；病识感差的人也可能把自己的症状评得很轻。

第四，别自己算分、自己对号。 网上流传的“双相自测量表”大多来源不明、条目被改动、没有常模。照着算出一个分数，然后据此停药或加药，是危险的。

常见误用	可能的结果	更稳妥的做法
用 MDQ 阳性给自己确诊	把单相抑郁、人格问题、物质使用误当双相	把结果带给医生，补充发作史
用一次 YMRS 排除躁狂	漏掉已经过去的发作	回顾病程，问家属
拿不同版本的 HAMD 比分数	得出错误的“好转/恶化”结论	固定同一版本、同一评估者
只看总分不看条目	漏掉自杀意念、混合特征	请医生解释关键条目

就诊时可以做的准备

- ☐ 把既往的量表结果按日期整理好，注明用的是哪个版本
- ☐ 记下每次评估前一周的睡眠和用药情况
- ☐ 如果做过自评问卷，把原始结果带给医生，不要只报一个分数
- ☐ 主动说明躯体疾病、近期用药和饮酒情况，这些会影响评分
- ☐ 问清楚这次评分是用于诊断、调药，还是研究随访

容易踩的坑

“我的 YMRS 不高，是不是可以停药？” 量表只是当下状态的快照，停药要看病程、既往复发史和医生判断。

“MDQ 我勾了很多条，肯定是双相吧？” 勾得多只说明线索多，确诊需要医生访谈和病程回顾。

“分数降了，是不是病好了？” 分数下降通常说明症状减轻，但功能恢复、复发预防是另一回事，仍需维持治疗与随访。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 混合状态下同时绝望和“停不下来”，冲动明显
- 躁狂状态下行为失控、冲动伤人、危险驾驶
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变，或皮疹伴发热、口腔溃疡、起疱脱皮

建议一到三天内联系医生：

- 量表分数在短期内明显升高，或睡眠连续三晚明显减少
- 情绪明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 抑郁加重两周以上，或出现“活着没意思”的念头
- 对量表结果有疑问，或想调整治疗方案

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- Young RC, et al. A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. Br J Psychiatry, 1978.
- Hirschfeld RM, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: the Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry, 2000.
- Spearing MK, et al. Modification of the Clinical Global Impressions (CGI) Scale for use in bipolar illness (BP): the CGI-BP. Psychiatry Res, 1997.
- Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1960.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.3 复诊沟通单与用药记录

很多人复诊时只有五分钟，坐下后脑子一片空白，最后只说了一句“还行”，拿了同样的药回家。问题不在你不会表达，而在没人教过你怎么在五分钟里说清两周的事。这一页是一份可以直接打印带走的沟通单：诊前准备什么、诊中必说哪几句、必问哪几个问题、用药和副作用怎么记，以及锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪这三类药各自要盯什么。照着填，复诊会变得具体很多。

一、诊前：把“说不清”变成“说得出”

复诊前一天花十分钟，比在候诊区临时回忆有用得多。

- ☐ 把这段时间的药盒、处方、化验单装进一个袋子
- ☐ 写下最近两周的睡眠：平均几点睡、几点起、夜里醒几次
- ☐ 写下情绪最高和最低的那两天，各发生了什么
- ☐ 写下有没有漏服药、漏了哪几次、为什么漏
- ☐ 写下让你最难受的三个副作用，以及出现的时间
- ☐ 写下这次最想问的一个问题（只能选一个，想清楚）
- ☐ 如果家属陪同，让家属也写三条观察，进诊室后交给医生

为什么要写下来？因为诊室里容易被医生的提问带着走，出来才想起“忘了说手抖”。一张纸能兜住这些。【临床经验】

家属的观察尤其重要。轻躁狂和早期复发，本人往往不觉得有问题，家人却已经看出“话变多了、晚上不睡、开始乱买东西”。把这些具体行为写下来，比说“他最近不太正常”有用得多。

二、诊中必说：四句话讲清这段时间

医生需要的信息是结构化的。可以按下面这个顺序说，每句都带具体数字或事实。

要说的	别这样说	可以这样说
睡眠	“睡得不太好”	“这两周平均睡五小时，最近三晚只睡四小时，白天不困”
情绪	“情绪不太稳定”	“上周三开始明显偏高，话多、坐不住，昨天又突然很低落”
服药	“药有在吃”	“早晚都吃了，晚上的药漏了两次，都是加班太晚”
副作用	“有点不舒服”	“手抖比以前明显，拿筷子会抖，下午更重”
功能	“还行”	“这周请了两天假，开会时注意力跟不上”
风险	（不说）	“有过不想活的念头，但没有计划”

最后一行最容易被跳过，也最重要。很多人怕说了被住院、被加药，就干脆不提自杀念头。但医生无法处理你不知道的事，而自杀风险是双相评估里必须问的一项。如果当面说不出口，可以提前写在纸上递过去。【指南】

三、诊中必问：把决定权用起来

复诊不是“听医嘱”，是双向沟通。下面这些问题可以挑两三个问，不必一次问完。

- 这次诊断或判断的依据是什么？是症状变了，还是病程有了新信息？
- 现在这个方案，主要是控制哪一个方向：躁狂、抑郁，还是预防复发？
- 如果出现什么情况，需要提前联系你，而不是等下次复诊？
- 这个药最需要我注意的副作用是什么？出现到什么程度要联系你？
- 需要多久查一次血、查哪些项目？下次复查安排在什么时候？
- 如果漏服了一次，应该怎么处理？
- 如果要减药或停药，应该怎么安排？什么情况下不适合减？
- 现在能不能喝酒？能不能熬夜？运动和出差要注意什么？
- 有没有需要同时做的心理治疗或作息调整？
- 下次复诊前，我需要记录什么带给你？

关于减药停药，一定要问清楚“怎么安排”，而不是自己决定。突然停用某些药物可能出现撤药反应、失眠反跳或复发；锂盐突然停用后复发风险会升高。这些都需要医生安排节奏。【指南】

四、用药记录表：照抄就能用

药物记录不需要复杂，能坚持才有用。下面这份可以打印成一张表，一行一天。

```
日期    药名（早）    药名（中）    药名（晚）    漏服?   副作用    睡眠
10/21   □           □           □           无      手抖      5h
10/22   □           □           □           漏晚    无        4h
```

如果同时吃几种药，建议单独列一张“用药清单”，写清楚药名、外观（颜色、形状）、每次吃几片、什么时候吃、为什么吃。这张清单在急诊、住院、换医生、出国时都能救命——尤其是意识不清、无法自己说明的时候。

记录项	为什么重要
药名与外观	急诊时能快速核对，避免重复用药
服用时间	判断漏服、判断副作用与服药的关系
漏服情况	漏服常常是复发的前奏，值得和医生讨论原因
副作用与出现时间	区分“刚加药的反应”和“需要处理的信号”
血液检查结果	锂盐、丙戊酸盐需要看趋势，不只看单次
同时使用的其他药	感冒药、止痛药、抗生素都可能与心境稳定剂相互作用

要特别提醒：很多常见的止痛药、感冒药、利尿剂会影响锂的血浓度，一些抗生素和抗癫痫药会影响拉莫三嗪和丙戊酸盐的血浓度。看其他科时，主动告诉医生你在服哪些精神科药物，别等医生问。【指南】

五、三种需要重点监测的药

这三类药在双相治疗里很常用，也各有必须盯住的风险。下面写的是“监测什么、警惕什么”，具体多久查一次、查哪些项目，由医生根据你的情况安排。

药物	常规监测	必须立即处理的信号
锂盐	血锂浓度、甲状腺功能、肾功能、体重、口渴与尿量	严重手抖、走路不稳、反复呕吐腹泻、意识模糊、抽搐
丙戊酸盐	肝功能、血氨、血常规（尤其血小板）、体重、月经与妊娠计划	严重腹痛呕吐、意识改变、皮肤或眼白发黄、异常出血
拉莫三嗪	皮疹（每次加量后尤其注意）、肝功能	皮疹伴发热、口腔溃疡、眼红、皮肤起疱脱皮

锂盐：浓度是一把双刃剑

锂盐是双相维持治疗里证据最扎实的药物之一，但它有一个很窄的安全范围，所以需要定期查血锂。抽血时间通常有讲究（多在下一次服药前），按医生和检验科的要求来，否则结果没有意义。具体的目标范围由医生判断，不要拿别人的数值套自己。【指南】

锂盐的风险常被低估，也常被夸大。真实情况是：脱水、大量出汗、发烧、呕吐、腹泻、严格低盐饮食，以及同时使用某些止痛药、降压药、利尿剂，都可能让血锂升高，引发中毒。夏天户外工作、拉肚子、吃不下饭的时候要格外小心，出现手抖加重、走路不稳、呕吐、意识改变，要立即急诊查血锂。【指南】

长期用锂盐还要关注甲状腺和肾功能，可能出现甲状腺功能减退、多尿、口渴、体重增加。这些不是“忍忍就过去”的小事，需要定期复查、及时处理。

丙戊酸盐：肝脏、血氨、胰腺和生育风险

丙戊酸盐对躁狂和混合发作有效，但需要盯的项目比较多：肝功能、血氨（高氨血症可表现为嗜睡、呕吐、意识模糊）、血常规（血小板下降、异常出血）、体重增加、脱发、手抖。急性胰腺炎虽然少见，但表现为持续加重的上腹痛、呕吐，需要急诊。【指南】

还有一条必须单独讲：**丙戊酸盐在孕期有明确的致畸风险，也会影响胎儿神经发育。** 育龄女性使用前必须和医生讨论避孕、备孕计划；已经怀孕或计划怀孕，不能自行停药，也不能自行继续用，要尽快找医生联合评估。突然停药可能导致复发，同样有风险，这个决定必须由医生和你一起做。【指南】

拉莫三嗪：皮疹是要紧事

拉莫三嗪对双相抑郁的维持治疗有帮助，它最需要警惕的是皮疹。多数皮疹是良性的，但极少数会进展为 Stevens-Johnson 综合征（SJS）或中毒性表皮坏死松解症（TEN），这类反应可能危及生命。加量必须缓慢、按医生安排，不能自己加速；与丙戊酸盐合用时加量通常更慢。【指南】

出现皮疹，尤其伴随发热、口腔溃疡、眼红、面部或颈部肿胀、皮肤起疱或脱皮，要**立即停药并急诊**，不要抱着“再看看”的心态等它自己消。停药后也不要自行恢复用药，是否再用、怎么用，必须由医生判断。【指南】

六、诊后与紧急情况

复诊结束前，做三件事：把医生说的方案复述一遍确认（“所以我早上的药不变，晚上的药做了调整，两周后复查血，对吗”）；把下次复诊时间写进日历；把这次的用药清单更新一遍。

如果诊后出现新问题，不要等到下次复诊。多数医院有电话咨询、互联网医院或复诊加号渠道，可以先问清楚。

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊、抽搐
- 服丙戊酸盐后严重腹痛呕吐、意识改变、皮肤或眼白发黄、异常出血
- 服拉莫三嗪后皮疹伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（警惕恶性综合征）
- 同时使用多种增加 5-羟色胺的药物后出现高热、震颤、反射亢进、腹泻、躁动

建议当天或次日联系医生：

- 漏服药超过两三次，或连续两天完全没吃
- 出现新的副作用，虽然不严重但让人难受
- 睡眠连续三晚明显减少，白天不困
- 情绪明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 抑郁加重两周以上，或开始回避所有人

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

容易踩的坑

“医生太忙，我不太好意思问。” 把问题写在纸上递过去，通常比开口容易。一次问两三个，比一次问十个更容易得到回答。

“副作用忍忍就过去了。” 有些副作用会随时间减轻，有些（皮疹、意识改变、严重腹泻、异常出血）必须立刻处理。分不清就问。

“血检结果我自己看不懂，反正医生会说。” 可以请医生把关键几项圈出来，写上“正常/需要关注”，下次自己也能对照。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.4 常见误区与高频问答

这一页集中处理两类问题：一类是反复被说错的说法，比如“躁狂不用治”“吃药会变傻”“抗抑郁药能治双相抑郁”；另一类是诊室里来不及问、回家又找不到人问的具体疑问。下面整理 30 条常见误区，每条给出实质澄清；再整理 20 个高频问答，按“刚确诊—用药—生活”排列。可以顺序读，也可以只看说中你的那几条。

一、30 条误区，逐条澄清

关于疾病本身

1. **“双相就是情绪化、性格问题。”** 情绪化是几小时的事，随情境变化；双相发作持续数天到数周，伴随睡眠、精力、食欲的成组改变，还会造成工作、财务、关系的实际损害。性格问题不需要心境稳定剂。【指南】

2. **“双相就是抑郁加暴躁。”** 关键在有没有躁狂或轻躁狂发作。很多双相患者并不暴躁，反而在抑郁期极度克制、过度自责。易怒也不等于躁狂。【指南】

3. **“情绪忽高忽低就是双相。”** 一天里高低起伏几次不算发作。快速循环指的是十二个月内四次以上心境发作，不是“情绪变得快”。【指南】

4. **“躁狂挺好的，不用治。”** 躁狂期判断力下降，冲动消费、冒险投资、危险驾驶、性行为失控都可能留下长期后果；之后常跟着更重的抑郁；严重时出现幻觉、妄想。它不是“状态好”，是失控。【指南】

5. **“轻躁狂不严重，不用管。”** 轻躁狂是双相 II 型的诊断核心，也是复发的重要信号。它之后的抑郁回落往往更长、更难受，冲动决定也会留下账单和关系裂痕。【研究】

6. **“双相是天才病，治好了就没灵感了。”** 少数人在轻躁狂期思维流畅、产出增多，这是真的；但疾病本身不生产才华，治疗也不消灭能力。靠透支换来的产出，通常要用几个月的抑郁偿还。【待验证】

7. **“双相 I 型比 II 型严重，II 型不用太认真。”** 分型看的是有没有躁狂，不是谁更重。II 型抑郁发作往往更频繁、持续时间更长，自杀风险不低，需要同样认真地治。【研究】

8. **“得了双相就会发疯、会伤人。”** 大多数患者不会伤人。暴力风险被影视和新闻放大了，实际更多与物质使用、精神病性症状、冲动控制受损有关，而不是诊断本身。【研究】

9. **“双相是小时候受刺激造成的。”** 遗传、神经生物学、昼夜节律和环境共同作用，童年逆境是风险因素之一，不是唯一原因。把病因归给某个人，既不准确，也会挡住治疗。【研究】

10. **“想开点、心态好就能好。”** 双相涉及情绪调节的生物学基础，不是意志力问题。心理治疗有用，但不能替代药物；让患者“别想太多”，通常只会增加羞耻感。【指南】

关于药物

11. **“吃药会变傻、反应变慢。”** 稳定期认知往往比反复发作时更好。部分药物确实可能带来镇静、迟钝、记忆模糊，可以和医生讨论调整时间或方案；而反复发作本身对认知的损害更值得担心。【研究】

12. **“抗抑郁药能治双相抑郁，多吃点没关系。”** 单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合状态或快速循环。规范做法是在心境稳定剂基础上评估是否联合，并密切观察睡眠和活动量的变化。【指南】

13. **“吃完抗抑郁药特别有精神，是好转了。”** 这可能是转躁的开始，尤其是睡得少、话变多、想法变多同时出现时。应尽快联系医生，而不是自行加量或继续观察。【指南】

14. **“锂盐伤肾，绝对不能吃。”** 锂盐是维持治疗证据最扎实的药物之一，风险在于需要监测，而不是不能用。肾功能、甲状腺、血锂定期复查，能把风险控制在可接受范围。【指南】

15. **“吃锂盐手抖、变胖，忍忍就行。”** 轻度手抖和体重变化常见，可以调整；但手抖明显加重、走路不稳、反复呕吐腹泻、意识模糊，可能是中毒，要立即急诊查血锂。【指南】

16. **“丙戊酸盐孕妇不能吃，所以一怀孕就得立刻停。”** 它在孕期有明确致畸风险，但突然停药可能导致复发，对母亲和胎儿同样危险。必须由精神科与产科联合评估，不能自己决定停或继续。【指南】

17. **“拉莫三嗪起皮疹很常见，涂点药膏就好。”** 多数皮疹良性，但极少数会进展为 SJS/TEN。出现皮疹伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮，要立即停药并急诊，不要等它自己消。【指南】

18. **“症状好了就可以停药。”** 症状缓解不等于疾病消失。维持治疗是减少复发的主要手段，减停要在医生安排下缓慢进行，并做好复发监测。【指南】

19. **“停药后复发了，说明药根本没用。”** 复发恰恰说明维持治疗有必要。停药后复发的时间因人而异，有人几周，有人几个月，这不构成“药无效”的证据。【指南】

20. **“中药、保健品可以替代西药，还没有副作用。”** 目前没有证据支持某种保健品可以替代心境稳定剂。成分不明的产品可能与处方药相互作用，也会耽误正规治疗。【指南】

21. **“有副作用说明医生开错了药。”** 副作用常见，多数可控可调。正确做法是记录出现时间和程度，复诊时报告，而不是自行停药——突然停药的风险往往更大。【临床经验】

22. **“别人吃这个药好了，我也吃这个。”** 同一诊断下，发作类型、共病、肝肾功能、既往反应都不同。照搬别人的方案，可能无效，也可能诱发转躁或中毒。【指南】

关于生活与家庭

23. **“得了双相就不能工作、不能上学了。”** 多数人在治疗稳定后可以维持工作或学业，可能需要调整节奏、减少夜班、申请合理便利。把“能不能”换成“怎么安排”。【临床经验】

24. **“双相不能结婚、不能生孩子。”** 可以，但需要提前规划：孕前评估用药、孕期监测、产后风险预案。遗传风险存在，但大多数孩子不会发病。【指南】

25. **“喝酒能帮助入睡、缓解情绪。”** 酒精破坏睡眠结构，是诱发躁狂和抑郁的常见因素，还会与药物相互作用。用酒助眠，通常换来更差的睡眠。【指南】

26. **“偶尔熬一次夜没关系。”** 睡眠剥夺是最强的发作诱因之一。通宵、跨时区飞行、连续倒班都需要提前计划，事后补觉不能完全抵消影响。【指南】

27. **“咖啡提神，多喝点没关系。”** 过量咖啡因会加重失眠、焦虑、心慌和震颤；它的利尿作用带来的水分流失，对用锂盐的人也值得注意。适量、固定时间更稳妥。【临床经验】

28. **“家人应该顺着他，别刺激他。”** 不争辩是对的，纵容不是。减少刺激、保证睡眠、设定清晰边界、必要时就医，比一味顺从更有帮助。【临床经验】

29. **“跟患者提自杀，会提醒他去自杀。”** 直接问不会诱发自杀。相反，能开口问的人，往往给了对方一个说真话的机会。问完要陪着，并联系医生。【指南】

30. **“双相治不好，这辈子完了。”** 它是可以治疗、可以长期稳定的疾病。目标不是“永不波动”，而是发作更少更轻、间期更长、生活基本维持。很多人做到了。【指南】

二、饭桌上最容易吵起来的八个说法

说法	更准确的说法
“你就是想太多。”	发作有生理基础，不是想出来的
“别吃药，伤身体。”	不治疗的复发风险往往更大
“你都好了还吃药？”	维持治疗正是为了不再复发
“躁狂时你多能干。”	那是失控，代价在后面
“抑郁就是懒。”	动力下降是症状，不是品格
“生孩子会遗传，别生。”	风险升高，但多数孩子不发病，可做孕前规划
“他发病时说的话别当真。”	病中的表达仍需要被听见，但不必据此做重大决定
“看开点就好了。”	需要治疗、节律和支持，不需要口号

三、20 个高频问答

刚确诊

1. **药要吃多久？** 没有统一答案。首次发作、发作次数少的人，维持时间可能相对短；反复发作、有家族史、有残留症状的人，往往需要更长时间。具体由医生根据病程决定，不要自己按“吃满几年”计算。【指南】

2. **会遗传给孩子吗？** 风险比一般人群高，但大多数子女不会发病。遗传不是命运，睡眠、应激、物质使用等环境因素同样重要。担心的话，可以在孕前做一次遗传咨询。【研究】

3. 我需要住院吗？ 出现自杀或伤人风险、躁狂严重到无法配合治疗、出现精神病性症状、需要调整复杂用药或做躯体监测时，住院是更安全的选择。住院不是惩罚，是保护。【指南】

4. 只吃药够吗？ 对多数人不够。心理教育、人际社会节律治疗、认知行为治疗、家庭聚焦治疗都能帮助识别早期信号、稳定作息、改善关系。药物是地基，不是全部。【指南】

5. 我还能正常上班上学吗？ 多数人可以。关键是稳定作息、避免长期夜班、在复发早期及时调整工作量。必要时可以申请合理便利或短期病假。【临床经验】

用药

6. 漏服了一次怎么办？ 不要一次补两倍。看距离下次服药还有多久，按医生事先给的说明处理；如果经常漏服，问题在方案或提醒方式，值得复诊时讨论。【临床经验】

7. 能不能喝酒？ 不建议。酒精干扰睡眠、诱发发作、加重抑郁，还可能与药物相互作用。偶尔少量是否可行，请问自己的医生，不要用别人的经验判断。

8. 药会影响性功能或月经吗？ 有些药物可能影响性欲、勃起、射精或月经周期，这类问题很常见但常被忽略。不要自行停药，把情况告诉医生，通常有调整空间。【临床经验】

9. 血锂要多久查一次？ 开始用药和调整阶段查得较密，稳定后间隔会拉长，具体由医生安排。发烧、腹泻、呕吐、大量出汗、换了其他药时，可能需要提前查。【指南】

10. 能不能同时看中医、吃保健品？ 可以告知医生你在用什么，但不要自行用它们替代处方药。部分草药和保健品会影响药物代谢或出血风险，需要医生知情。【临床经验】

11. 副作用太大，能不能自己减一点？ 不建议。突然减量可能引起撤药反应或复发。把副作用的具体表现、出现时间记下来，联系医生调整，通常比自行减量安全。【指南】

12. 怀孕了怎么办？ 尽快联系精神科和产科，不要自行停药。需要评估的是“继续用药的风险”和“停药后复发的风险”，这两者都要算，必须一起决定。【指南】

生活

13. 能不能熬夜、倒班、跨时区？ 尽量避免长期夜班和频繁跨时区。无法避免时，提前和医生讨论作息方案，落地后尽快固定起床时间，并加强前两周的观察。【指南】

14. 情绪不好时要不要自己加药？ 不要。加药需要判断是抑郁、混合还是转躁，方向错了会加重病情。可以先记录睡眠和情绪，联系医生。【指南】

15. 家人怎么判断是复发还是心情不好？ 看三件事：睡眠有没有明显减少且不困、变化持续了几天、有没有出现平时不会做的冲动决定。三条都中，尽快联系医生。【临床经验】

16. 要不要告诉同事、朋友？ 没有标准答案。可以先告诉一两个信得过的人，明确你需要什么帮助（比如“我请假时帮我挡一下”）。公开诊断前，想清楚可能的后果和你的边界。【个人体验】

17. 能运动吗？ 能，规律运动对情绪和睡眠有帮助。避免在躁狂早期做高强度、熬夜式的训练；夏天户外运动注意补水和防晒，用锂盐的人尤其要防脱水。【临床经验】

18. 能喝咖啡、茶吗？ 适量通常可以，但要注意时间和量。下午之后的咖啡因可能影响入睡，而睡眠稳定对双相格外重要。

19. 换季时要注意什么？ 一部分人的发作与季节相关。记录自己哪几个月容易高涨或低落，提前和医生商量复诊频率，并注意日照变化对睡眠的影响。【研究】

20. 复发了是不是前功尽弃？ 不是。已经建立的作息、对信号的认识、和医生的配合都还在。复发更像一次需要处理的急性事件，处理得早，恢复通常更快。

四、复诊前自查清单

- ☐ 这一个月睡眠有没有连续三晚明显减少、白天不困
- ☐ 有没有一段时间话明显变多、停不下来
- ☐ 有没有做过平时不会做的冲动决定
- ☐ 有没有漏服药，漏了几次，原因是什么
- ☐ 有没有新的副作用，出现多久了
- ☐ 抑郁有没有加重，有没有轻生念头
- ☐ 这次最想问医生的一个问题是什么

五、什么时候需要联系医生或去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 躁狂或混合状态下行为失控、冲动伤人、危险驾驶、离家出走
- 服锂盐后严重手抖、走路不稳、反复呕吐、意识模糊、抽搐
- 服丙戊酸盐后严重腹痛呕吐、意识改变、皮肤或眼白发黄、异常出血
- 服拉莫三嗪后皮疹伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗

建议一到三天内联系医生：

- 睡眠连续三晚明显减少，白天不困
- 情绪明显高涨或易怒，家人说“像换了个人”
- 抗抑郁药使用后出现异常兴奋、话多、睡得少
- 抑郁加重两周以上，或出现“活着没意思”的念头

拿不准时按严重处理。也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. 链接
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. 链接
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. 链接

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

附录：术语与参考文献

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

A 术语表

这份术语表收了 60 个双相障碍相关的词，按主题分组、连续编号，每个词用两三句大白话解释。它适合在门诊听到一个陌生词、或者读资料被缩写卡住时随手查。术语是拿来沟通的，不是拿来自我诊断的。看完一圈，你至少能分清“躁狂”和“轻躁狂”、“病耻感”和“自我污名”这些常被混用的说法。

怎么用这份术语表

先查最困惑的两三个词，不必从头背。医生用到某个词时，可以直接问“这个词在我身上具体指什么”，比回家上网搜更可靠。看到“最新研究”“某药最好”这类说法，先回到术语本身，弄清楚它说的是诊断、机制、疗效还是风险。

- ☐ 先查自己最困惑的三个词
- ☐ 把医生说的术语记下来，下次复诊问清楚
- ☐ 不拿术语给自己或家人下诊断
- ☐ 看到“最新研究”先看年份、样本和对象
- ☐ 涉及用药的术语，只用来提问，不用来自己改药

术语正文

一、诊断与分类（1–10）

1. **双相障碍**：以心境在高涨和低落之间反复摆动为主要特点的一类精神障碍。它不是性格问题，也不是“想开点”就能过去，需要规范治疗和长期管理。【指南】
2. **双相 I 型**：至少出现过一次完整的躁狂发作，抑郁发作可有可无。躁狂可能严重到需要住院，或伴幻觉、妄想等精神病性症状。
3. **双相 II 型**：至少一次轻躁狂发作，加至少一次抑郁发作，但从未有过完整躁狂。它常被误当成单相抑郁，因为轻躁狂不容易被认出来。
4. **环性心境障碍**：持续至少两年（儿童青少年一年）反复出现轻躁狂和抑郁症状，但都达不到完整发作标准。它像“小一号”的双相，同样会影响生活。
5. **轻躁狂**：比平常明显高涨或易怒，精力增加、话多、睡得少，但程度没到躁狂，工作和生活可能还撑得住。它常被当成“状态好”，事后才发现是一次发作。

6. **躁狂**：心境持续高涨或易怒，伴精力旺盛、睡眠需求减少、话多、夸大和冲动，明显影响工作、人际或安全。严重时出现幻觉、妄想，需要急诊。
7. **抑郁发作**：持续两周以上情绪低落、兴趣减退，伴睡眠、食欲、精力、注意力改变，可能有自杀念头。双相抑郁和单相抑郁看起来像，用药策略不同。
8. **混合特征**：一次发作里同时出现躁狂和抑郁两方面的症状，比如又烦躁又绝望、话多又想死。DSM-5-TR 用“混合特征”作标注，需要医生判断，不能自己对照下结论。
9. **快速循环**：十二个月内出现四次或更多次符合标准的心境发作。它提示治疗需要调整，也与自杀和冲动风险升高有关，不能只当成“情绪波动大”。
10. **心境发作**：症状集中出现、达到诊断标准的一段时期，包括躁狂、轻躁狂、抑郁和混合发作。两次发作之间可以完全恢复，也可能残留症状。

二、病程与评估（11–20）

11. **前驱期**：正式发作前“哪里不对”的一段时期，可能有睡眠变少、烦躁、注意力差、话变多。认出自己的前驱信号，是复发预防的起点。
12. **急性期**：症状最重、最需要控制病情和保证安全的阶段。这个阶段不宜急着复工复学，也不宜频繁换方案。
13. **巩固期**：急性症状缓解后继续治疗的一段时间，目标是防止反弹。很多人感觉“好了”就想停药，复发常发生在这个阶段。
14. **维持期**：症状稳定后长期坚持治疗的阶段，目标是预防新发作、保住功能。维持多久因人而异，由医生结合发作次数、严重度和风险决定。
15. **发作间期**：两次发作之间相对稳定的时期。有人完全没有症状，有人留下轻度情绪不稳、注意力或睡眠问题，仍需要随访。
16. **共病**：同时存在的其他疾病，比如焦虑障碍、物质使用障碍、ADHD、甲状腺疾病。共病会让诊断和治疗更复杂，需要一起评估。
17. **YMRS**：Young 躁狂评定量表，1978 年发表，由医生评定躁狂症状的严重度。它用来追踪变化，不能拿来自行确诊。
18. **HAMD**：Hamilton 抑郁量表，1960 年发表，由医生评定抑郁严重度，常见 17 项、21 项等版本。分数高低不等于诊断，也不能替代面诊。
19. **MDQ**：心境障碍问卷，2000 年发表的自评筛查工具，用来提示“是否可能有过双相谱系表现”。阳性只代表需要进一步访谈，不是诊断。
20. **CGI-BP**：双相障碍临床总体印象量表，1997 年发表，医生用整体印象评价躁狂、抑郁和总体病情。它简单好用，但比较依赖评定者的经验。

三、药物与监测（21–38）

21. **心境稳定剂**：一类以减少躁狂和抑郁发作为目标的药物，包括锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪、卡马西平等，部分抗精神病药也承担这个角色。它不是把情绪“压平”，而是降低发作的频率和强度。

22. **锂盐**：治疗双相障碍最经典的药物之一，对躁狂和维持治疗有明确证据。它需要定期查血锂、甲状腺和肾功能，不能自行加减。【指南】
23. **血药浓度**：吃药后血液里的药物浓度，通常测下次服药前的“谷浓度”。锂盐、丙戊酸盐、卡马西平等需要监测，采血时间要按医生要求。
24. **锂中毒**：锂盐在体内蓄积到有害水平，表现为严重手抖、呕吐、腹泻、走路不稳、意识模糊，严重时抽搐、昏迷。脱水、发热、呕吐腹泻、低盐饮食和部分药物都可能诱发，出现症状要立即急诊。
25. **甲状腺功能**：锂盐可能让甲状腺激素下降，出现怕冷、乏力、体重增加、便秘，也可能甲状腺肿大。通常查 TSH 等指标监测，异常由医生处理。
26. **肾功能**：锂盐主要经肾脏排出，长期使用可能影响肾小管浓缩功能。定期查肌酐和估算肾小球滤过率，是安全用药的一部分。
27. **丙戊酸盐**：一种心境稳定剂，常用于躁狂和混合发作。它可能伤肝、引起高氨血症、胰腺炎、血小板下降和体重增加；育龄女性有明确致畸风险，不能自行使用或停药。
28. **高氨血症**：血液里氨升高，可能由丙戊酸盐等药物引起，表现为嗜睡、呕吐、意识模糊、手抖，严重时昏迷。出现这些情况要停药并急诊查血氨，不能在家观察。
29. **拉莫三嗪**：一种心境稳定剂，对双相抑郁的维持治疗有证据。它最需要警惕的是皮疹，极少数会进展为严重皮肤反应，加量必须由医生缓慢安排。
30. **SJS/TEN**：Stevens-Johnson 综合征与中毒性表皮坏死松解症的合称，是严重的皮肤黏膜过敏反应，表现为皮疹、发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮。拉莫三嗪、卡马西平等可能诱发，怀疑时立即停药急诊。
31. **卡马西平**：一种抗惊厥药，也可用于双相障碍，但药物相互作用多，会影响其他药物浓度。使用时要关注血常规、肝功能、低钠，以及亚洲人群中与严重皮疹相关的基因风险。
32. **非典型抗精神病药**：喹硫平、奥氮平、利培酮、阿立哌唑等药物的统称，可用于躁狂、混合或双相抑郁。它们可能带来体重增加、血糖血脂异常、嗜睡和锥体外系反应，不能突然停。
33. **抗抑郁药**：治疗抑郁的药物，如 SSRI、SNRI 等。双相障碍单用抗抑郁药可能诱发转躁、混合或快速循环，通常需要和心境稳定剂联合，由医生评估。
34. **转躁**：抗抑郁治疗过程中出现躁狂、轻躁狂或混合症状，表现为睡眠减少、话多、活动增多、冲动。发现后要尽快联系医生，不要自行加药或硬扛。
35. **锥体外系反应（EPS）**：抗精神病药引起的运动副作用，包括肌肉僵硬、手抖、走路不稳、眼球上翻、静坐不能。多数可以处理，但要及时告诉医生，不要自行停药。
36. **迟发性运动障碍（TD）**：长期使用抗精神病药后出现的不自主运动，常见于口唇、舌头和面部，也可能影响四肢。它可能持续较久，需要早发现、早评估。
37. **NMS**：恶性综合征，是抗精神病药的严重不良反应，表现为高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳快。属于急症，必须立即停药并急诊。

38. **血清素综合征**：多种增加 5-羟色胺的药物合用后出现的毒性反应，表现为震颤、反射亢进、腹泻、出汗、躁动、高热。属于急症，需要立即就医。

四、治疗与康复（39–48）

39. **心理教育**：向患者和家属讲清疾病、治疗、复发信号和应对方法的结构化干预。它不是“上课训人”，而是让人知道发生了什么、能做什么。【指南】
40. **CBT**：认知行为治疗，帮助识别和调整与情绪相关的想法和行为，也用于处理抑郁、焦虑和病耻感。它通常作为药物治疗的补充，不是替代。
41. **DBT**：辩证行为治疗，重点训练情绪调节、痛苦耐受、人际效能和正念。对反复自伤、情绪失控的人有帮助，也用于双相障碍的辅助治疗。
42. **IPSRT**：人际与社会节律治疗，核心是稳定作息、睡眠和社交节律，并处理角色转换和人际冲突。对双相障碍的复发预防有研究支持。
43. **家庭聚焦治疗**：把患者和家属一起纳入的结构化治疗，内容包括心理教育、沟通训练和问题解决。目标不是追究谁的责任，而是降低家庭冲突、改善支持。
44. **社会节律**：每天相对固定的起床、吃饭、工作、社交和睡眠时间。节律稳定对双相障碍特别重要，倒班、跨时区、通宵都会打乱它。
45. **同伴支持**：由有相似经历、受过训练的人提供陪伴、经验和希望。它不能替代专业治疗，但能减少孤立感，帮助人重新进入生活。
46. **职业康复**：帮助患者评估工作能力、寻找合适岗位、适应工作要求的服务，包括工作试用、技能训练和就业辅导。目标是可持续的工作，而不是“赶紧上班”。
47. **个案管理**：由个案管理员协调医疗、心理和社会资源，比如预约、转介、社区支持。对反复住院、需求复杂的人尤其有用。
48. **ECT**：无抽搐电休克治疗，在麻醉和肌松下用电流诱发短暂抽搐，用于严重躁狂、紧张症、高自杀风险或难治性抑郁。它不是惩罚，但需要评估适应证和记忆影响。

五、社会、法律与安全（49–60）

49. **病耻感**：因为患有某种疾病而被贴上负面标签，进而被歧视、回避，或自己瞧不起自己。双相障碍的病耻感常来自“危险”“不稳定”“天才病”这些刻板印象。
50. **自我污名**：把外界的负面看法内化成“我就是不行”“我不配”，于是不敢就医、不敢社交、不敢争取机会。它不是性格软弱，而是可以被识别和改变的。
51. **连带病耻感**：家属因为亲人的病而被人议论、回避，感到羞耻或需要隐瞒。它会让家庭更孤立，也需要被看见和支持。
52. **披露**：把自己的病情告诉别人的过程。披露不是“全说”或“全不说”，可以按对象和需要分层，只说到对方帮得上忙的程度。
53. **非自愿住院**：在患者不自愿的情况下，依据法律程序收治入院。通常要符合严重精神障碍且有伤害自身或他人危险等法定条件，具体以现行法律和当地政策为准。

54. **知情同意**：医生就诊断、治疗方案、风险和替代方案充分说明后，患者自愿作出决定。它是医疗的基本原则，紧急情况下的例外由法律和医院程序规定。
55. **约束隔离**：极少数紧急情况下，为防止伤人、自伤或逃跑而采取的临时限制措施。它必须有必要性、有时限、有记录和评估，不能当作惩罚或常规管理手段。
56. **监护人**：依法对无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人承担照护、财产管理等职责的人。精神障碍患者的监护以《民法典》《精神卫生法》等规定为准，个案需要法律咨询。
57. **精神残疾**：精神障碍导致的社会功能受损，达到评定标准后可被认定为精神残疾。评定和待遇以当地残联、卫健和社保政策为准，地区差异较大。
58. **合理便利**：为了让有健康限制的人能完成工作或学业，在不改变核心要求的前提下做的调整，比如弹性工时、减少夜班、调整考试安排。它不是降低标准，而是移除不必要的障碍。
59. **安全计划**：在危机来临前写好的应对方案，包括预警信号、自己能做的事、可以联系的人、环境安全措施和急诊路线。最好在状态稳定时和医生、家属一起做。
60. **12356 心理援助热线**：国家卫生健康委自 2025 年起推行的全国统一心理援助热线，提供心理支持、危机干预和转介。它不能替代急诊，遇到立即危险仍应拨打 120 或 110。

几组容易混淆的词

容易混的一对	一句话区别	常见误解
躁狂 / 轻躁狂	看严重度和功能受损程度	把轻躁狂当成“状态好”
双相 I 型 / II 型	有没有出现过完整躁狂	以为 II 型更轻、不用治
混合特征 / 快速循环	一次发作内的症状组合 / 一年内的发作次数	都当成“情绪不稳”
病耻感 / 自我污名	外界的标签 / 内化后的自我否定	以为靠“想开”就能消除

什么时候需要联系医生 / 去急诊

术语看得再多，也不能替代面诊。出现以下情况请立即就医：

- 有自杀念头、计划或自伤行为。
- 连续多日几乎不睡、话多停不下、行为失控。
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗。
- 皮疹迅速扩大，伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮。
- 服锂盐后严重手抖、呕吐、腹泻、走路不稳。

立即拨打 120，必要时拨打 110，或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 于欣, 方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

B 参考文献与指南版本

这一页列出这套资料主要依据的指南和来源，说明每条来源能回答什么问题、证据分量大概如何，以及怎么判断手里的资料是不是过时。它适合想核对原文的人，也适合被网上互相矛盾的说法弄糊涂的读者。它不是学术综述，而是一张可以按图索骥的清单：先看来源，再看年份，最后看它适不适合你的问题。

这份清单怎么用

先分清你要问的是什么。诊断和分类，看 DSM-5-TR 与 ICD-11；治疗选择和药物监测，看 NICE、CANMAT/ISBD 和中国指南；心理社会干预与家属支持，看 NICE 与 CANMAT；法律与权益，看《精神卫生法》和当地政策；危机求助，看 12356 与急诊流程。

指南不是法律，也不是个体处方。同一道题，不同指南可能给出不同的一线选择，原因包括药物可及性、医保、人群差异和出版年份。中国指南更贴近国内用药习惯，NICE 和 CANMAT 的方法学与证据分级更透明。遇到不一致，不要用科普文章去否定面诊医生，也不要用指南条文要求医生必须开某种药；把差异带给医生讨论，才是正确用法。

主要指南与来源

来源	年份/版本	主要用途	证据分量
NICE CG185	2014，2020 更新	评估、急性期、维持治疗、心理社会干预、家属支持	国家级临床指南，高
CANMAT/ISBD 2018	2018	药物选择、分期治疗、特殊人群	国际指南，系统综述加专家共识，高
中国双相障碍防治指南（第二版）	2015	中国人群、药物可及性、服务体系	国家级指南，高
WHO 双相障碍实况报道	持续更新	全球视角、疾病负担、去污名	机构科普，中
NIMH 双相障碍专题	持续更新	患者教育、症状与治疗概述	机构科普，中
DSM-5-TR	2022	诊断标准、混合特征、标注	诊断分类，高（不是治疗推荐）
ICD-11 CDDG	2019 年通过，2022 年生效	国际诊断分类与卫生统计	诊断分类，高
《精神卫生法》	2012 年通过，2013 年施行	自愿与非自愿住院、隐私、权益	法律，强制
12356 心理援助热线	2025 年起推行	心理支持、危机干预、转介	公共服务，参考
量表原始文献	1960 – 2000	YMRS、HAMD、MDQ、CGI-BP	研究工具，中

NICE CG185

英国国家卫生与临床优化研究所的双相障碍指南，2014 年发布，2020 年更新。它覆盖评估、急性躁狂与抑郁的处理、长期维持、心理社会干预，以及家属和照护者的支持，方法学透明，推荐用语有强

弱之分。它写的是英国的卫生体系，药物可及性和住院流程与中国不同，适合用来理解“应该提供什么”，不适合直接照搬具体方案。

CANMAT/ISBD 2018

加拿大情绪与焦虑治疗网络与国际双相障碍学会联合发布的指南，2018 年发表。它按证据等级给药物排序，分一线、二线和三线，覆盖躁狂、抑郁、混合、快速循环和特殊人群，比较适合用来比较不同药物的位置。它的“一线”不等于“最适合你”，也不等于在中国都能报销。

中国双相障碍防治指南（第二版）

于欣、方贻儒主编，2015 年出版。它更贴近中国患者的用药习惯、药物可及性和医疗服务体系，也涉及国内常见的误诊、依从性和社会支持问题。它的出版时间早于 CANMAT 2018 和 NICE 2020 更新，读的时候要留意哪些结论已经被后来的证据修正。

WHO 与 NIMH

世界卫生组织的双相障碍实况报道提供全球视角，适合了解疾病负担、治疗缺口和去污名议题；美国国家精神卫生研究所的患者教育页面适合建立基本概念，语言平实。两者都是机构科普，不是个体化治疗建议，具体用药仍要看指南和医生。

DSM-5-TR 与 ICD-11

DSM-5-TR 由美国精神医学学会 2022 年出版，是诊断标准的主要参考，混合特征等标注写得清楚；ICD-11 由世界卫生组织主导，2019 年通过、2022 年生效，用于国际诊断分类和卫生统计。两者在分类细节上不完全一样，但都只回答“这是什么”，不回答“该吃什么药”。

《精神卫生法》与 12356

《中华人民共和国精神卫生法》2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行，确立自愿住院原则，规定非自愿住院的条件和程序，也规定隐私保护和权益保障。本资料只讲原则，不提供法律意见；具体个案以现行法律文本和当地政策为准。12356 是国家卫生健康委自 2025 年起推行的全国统一心理援助热线，地方号码和服务时间以当地卫健委公布为准。

证据等级怎么读

证据等级要分两个维度看：证据质量，说的是研究做得怎么样；推荐强度，说的是指南有多大把握建议这么做。质量高不等于推荐强，推荐强也不等于对每个人都合适。

证据类型	大概分量	怎么用
系统综述、meta 分析	高	看整体效应，也要看研究之间的差异
随机对照试验	高	看样本、盲法、终点和随访时间
队列、病例对照研究	中	提示关联，不能直接证明因果
病例系列、专家意见	低	可以参考，不宜当唯一依据

证据类型	大概分量	怎么用
机制推测、动物实验	很低	不能直接推到人身上
科普文章、机构页面	中低	建立概念，不指导具体用药

指南本身也有分量差别。国家级指南通常经过系统检索和专家讨论，但会受出版年份、编写方法和利益冲突影响；国际指南的方法学更透明，却未必贴合中国的药物供应和医保。看到“指南推荐”四个字，还要问：哪一版、针对什么人群、推荐的是哪一线。

本资料库用五种标签提示信息的分量：【指南】有明确推荐；【研究】有试验或系统综述支持，但未进入所有指南；【临床经验】是常见做法，个体差异大；【待验证】是机制推测或争议观点；【个人体验】是主观感受。标签不是真假判决，而是提醒你这条信息有多硬。

版本记录与如何判断过时

本资料库当前版本 V1.0，2026 年 10 月发布，覆盖 13 个模块、64 篇正文。建议每 12 个月复核一次，重点看 NICE CG185、CANMAT/ISBD、中国双相障碍防治指南、药品说明书和《精神卫生法》相关政策的更新。

版本	日期	变更
V1.0	2026-10	建立 13 个模块、64 篇正文，统一体例与证据标签

判断一条信息是否过时，可以逐项核对：

- ☐ 出版或更新日期是否在 3–5 年内
- ☐ 指南是否有新版、勘误或撤稿声明
- ☐ 药品说明书是否更新了适应证或安全警告
- ☐ 法律和地方政策是否修订
- ☐ 热线号码和服务时间是否仍有效
- ☐ 是否给出具体剂量方案（本资料刻意不写）
- ☐ 是否把机制推测写成了确定结论
- ☐ 引用的链接能否打开
- ☐ 是否与多位医生的说法明显冲突

年份不是唯一标准。有些老研究仍然是经典，有些新文章样本很小、结论很响。更可靠的做法是看它有没有被新版指南吸收、有没有被更大规模的研究重复、有没有利益冲突，以及能不能找到原文。找不到原文、只有二手转述的“国外最新研究”，默认降级处理。

免责声明与急症边界

本资料是科普，不构成医疗建议、诊断意见或法律意见。每个人的年龄、体重、肝肾功能、合并用药、既往反应和孕产计划都不同，同一套方案不能套给所有人。具体诊断、选药、剂量和停药，以面诊医生为准；法律与政策问题，以现行法律文本和当地主管部门的解释为准。

出现以下情况，先处理安全，再谈其他：

- 自杀念头、计划、自伤行为，或说“撑不下去”。
- 连续多日几乎不睡、行为失控、出现幻觉或被害感。
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗。
- 皮疹迅速扩大，伴发热、口腔溃疡、眼红、起疱脱皮。
- 服锂盐后严重手抖、呕吐、腹泻、走路不稳。

立即拨打 120，必要时拨打 110，或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- CANMAT/ISBD. 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. https://www.canmat.org/2019/03/27/2018-bipolar-guidelines/
- 于欣，方贻儒 主编.《中国双相障碍防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Bipolar disorder fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。